Bệnh nấm sâu Chromomycosis ở da (*F. pedrosoi/compactum, P. verrucosa*)

Biểu hiện lâm sàng: Mụn cóc/ các nốt lớn lên chậm để hình thành các mảng mụn cơm có sẹo hóa. Bệnh cũng có thể bắt đầu bằng một mụn mủ, mảng hoặc loét. Theo thời gian, các sẩn điển hình/các hạt bị loét ra và trung tâm trở nên khô/ có vẩy với bờ nhô cao khỏi mặt da. Các tổn thương này có thể có cuống/ giống súp lơ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy mẫu bệnh phẩm mô. Nấm da chromomycose vẫn khu trú ở da/ tổ chức dưới da.

Lưu ý: Có thể giống với các bệnh nấm khác. Các thể xơ trong mô và dịch xuất tiết giúp phân biệt nhiễm nấm chromomycose với các bệnh nấm liên quan khác.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ tổn thương cơ quan.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Fusarium ở da (*Fusarium solani*)

Biểu hiện lâm sàng: Được biểu hiện ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch dưới dạng nhiều sẩn hoặc nốt gây đau, khởi đầu là một dát với trung tâm nhạt màu, sau đó tổn thương dần nhô cao khỏi mặt da, viêm đỏ xung quanh và hoại tử. Được gặp chủ yếu ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch với giảm bạch cầu hạt (nhất là bệnh nhân bị bệnh loxemi cấp và sau ghép tủy xương). Nó cũng là nguyên nhân của nhiễm nấm móng/u nấm (mycetoma).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy từ máu/mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện bệnh đang lan tràn, mà không phải là một nhiễm trùng khu trú.

Tiên lượng: Tồi/ khá tồi. Liên quan đến mức độ ức chế miễn dịch. Amphotericin B dạng lipid (trang 525), yếu tố kích thích dòngbạch cầu hạt (colony-stimulating granulocyte factor) và truyền bạch cầu hạt có thể hữu ích.

Bệnh nấm Penicillium ở da (*Penicillium marneffei*)

Biểu hiện lâm sàng: Các sẩn, mụn mủ, hạt, loét hoặc ápxe. Thường gặp nhất ở bệnh nhân nhiễm HIV (cần điều trị ức chế suốt đời bằng itraconazol).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/ nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô. Tác động tới các cư dân/ khách du lịch đến vùng Đông Nam Á/ miền Nam Trung Quốc.

Lưu ý: Tổn thương thường tạo thành lỗ như lỗ rốn và giống như tổn thương da do virus poxviridae (Molluscum contagiosum). Có thể được biểu hiện như một nhiễm trùng lan tràn.

Tiên lượng: Xấu và liên quan với mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nhiễm vi tảo Prototheca ở da (*Prototheca wickermanii*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện thường gặp nhất là một mảng duy nhất hoặc tổn thương dạng sẩn-nốt của da và tổ chức dưới da. Tổn thương thường không gây đau, tiến triển chậm (to dần lên sau nhiều tuần đến nhiều tháng và không thành sẹo), có ranh giới rõ và có thể trở thành dạng loét/chàm hóa.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/ nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô. Tổn thương da ở bệnh nhân nhiễm HIV không khác biệt so với đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường.

Lưu ý: Các tổn thương thường không đau và có thể giống chàm.

Tiên lượng: Xấu/trung bình. Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch. Phẫu thuật cắt bỏ có hiệu quả.

Bệnh nấm Trichosporon ở da (*Trichosporon beigelii*)

Biểu hiện lâm sàng: Thường gặp nhất ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch giảm bạch cầu (đặc biệt ở bệnh nhân bị bệnh loxêmi, song cũng có thể gặp ở bệnh nhân nhiễm HIV, vết thương bỏng và sau ghép tạng). Thường biểu hiện bằng rất nhiều sẩn mầu đỏ nhạt/tím, các tổn thương này thường gây đau và không ngứa.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/ nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện bệnh đang lan tràn, mà không phải là một nhiễm trùng khu trú.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nấm Aspergillus ở da (*Aspergillus fumigatus*)

Biểu hiện lâm sàng: Được gặp ở vị trí luồn catheter tĩnh mạch hoặc vùng da dán băng dính ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có giảm bạch cầu hạt. Tổn thương giống như viêm mủ da -hoại tử (Pyoderma gangrenosum). Cũng có thể xâm phạm tới vết thương bỏng và gây tổn thương hoại tử tiến triển nhanh.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da dạng thâm nhiễm/loét thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tràn ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú. Có thể gây viêm da/ tổn thương da xâm lấn ở bệnh nhân nhiễm HIV.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Zygomycosis ở da (Mucor/Rhizopus/Absidia)

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương hoại tử da thứ phát do nấm xâm lấn vào mạch máu. Tác động tới lớp biểu bì hoặc hạ bì. Các tổ chức hoại tử khô mầu đen được thấy rõ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán xác định bằng cách chứng minh có các sợi nấm không chia vách, kích thước lớn với các nhánh ở góc bên phải khi nhuộm/ nuôi cấy bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tỏa ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú. Các băng chun bị nhiễm bẩn có thể liên quan với tình trạng nhiễm nấm Mucor da.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nấm Coccidioides ở da (*Coccidioides immitis*)

Biểu hiện lâm sàng: Tổn thương da có thể biểu hiện dưới nhiều dạng, bao gồm các u hạt dạng hột cơm, ápxe lạnh dưới da, các loét không đau hoặc các sẩn nhỏ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tỏa ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nấm Histoplasma ở da (*Histoplasma capsulatum*)

Biểu hiện lâm sàng: Dấu hiệu tổn thương da thường gặp bao gồm tình trạng phát ban dạng dát-sẩn, chấm xuất huyết và tụ máu. Mô bệnh học cho thấy có tình trạng hoại tử quanh các mạch máu vùng nông của da.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tỏa ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm Cryptococcus ở da (*Cryptococcus neoformans*)

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện bằng một hoặc nhiều sẩn, mụn mủ, mảng viêm đỏ da nền cứng, khối mềm dưới da, đường rò vỡ mủ hoặc loét với thành tổn thường không rõ ràng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có các cầu nấm với nội bào tử (endospores) khi nhuộm /nuôi cấy mẫu bệnh phẩm mô.

Lưu ý: Các tổn thương da thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tỏa ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú. Ở bệnh nhân bị AIDS, các sẩn có lỗ như lỗ rốn trông giống như tổn thương

da do virus Poxviridae (Molluscum contagiosum). Ở bệnh nhân sau ghép tạng, tình trạng viêm mô tế bào với viêm mạch hoại tử có thể xảy ra.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh nấm Sporothrix ở da (*Sporothrix schenckii*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh do nấm Sporotrichosis bạch mạch tiên phát ở da được bắt đầu bằng một hạt nhỏ dưới da, dễ di động và cứng chắc và tổn thương này sau đó trở nên mềm và vỡ ra để hình thành một ổ loét dễ vỡ, tiếp diễn dai dẳng. Các tổn thương thứ phát thường xuất hiện dọc theo về phía gần của đường bạch huyết, song không gây tác động tới hạch bạch huyết. Dạng mảng tổn thương không lan rộng cục bộ.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nhuộm/nuôi cấy đối với mẫu bệnh phẩm mô. Viêm da tăng lên tại các vị trí bị chấn thương nhẹ có nhiễm nấm ở da. Các tổn thương da thường biểu hiện tình trạng bệnh lan tỏa ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, mà không phải là biểu hiện của một nhiễm khuẩn khu trú.

Lưu ý: Bệnh nhân nhiễm HIV có số lượng tế bào CD4<200 có thể bị bệnh lympho da lan rộng gây loét và đi kèm với viêm khớp. Ít thường gặp ở vị trí nách do nhiệt độ ở đây cao.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng/mức độ ức chế miễn dịch.

Bệnh do Candida dạng mụn mủ/nốt/mụn ở da

(sepsis ở người dùng steroid dài ngày, xem trang 279)

Bệnh do nhiễm giun chỉ Onchocerca ở da (*Onchocerca volvulus*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện sớm là ngứa, ban sẩn với biến đổi sắc tố da. Muộn hơn, có thể xuất hiện các sẩn, sẹo, phù và mất sắc tố da. các hạt nhỏ xuất hiện ở lớp biểu bì sâu/tổ chức dưới da (nhất là ở các mỏm nhô ra của xương) hoặc ở các vị trí sâu hơn gần các khớp, cơ, xương. Bệnh có tính chất dịch địa phương ở vùng Trung Đông, Trung Phi và Trung Mỹ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng test huyết thanh hoặc/ chứng minh có ấu trùng giun chỉ ở các mảnh sinh thiết lớp mỏng của da bị tác động hoặc trong tiền phòng (bằng đèn khe) nếu mắt bị tác động. Phù trong da gây ra tình trạng " da giống như vỏ cam" với các vệt lõm quanh các nang lông/tuyến bã của da.

Lưu ý: ivermectin có hiệu quả điều trị đối với ấu trùng giun chỉ, song không có hiệu quả điều trị đối với giun chỉ trưởng thành. Đời sống của giun trưởng thành vào khoảng 18 năm.

Tiên lượng: Liên quan với khu trú/ mức độ lan rộng của tổn thương cơ quan đích.

Rickettsia (Sốt/ban da dạng chấm xuất huyết)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Sốt phát ban vùng núi đá (Rocky Mountain spotted fever)	*Rickettsia rickettsii* (do ve truyền bệnh)	Doxycyclin 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần x 3 ngày, sau đó 100mg (TM hoặc uống) x4 ngày	Bất kỳ quinolon nào (TM hoặc uống) x7 ngày ***hoặc*** Chloramphenicol 500mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần x7 ngày
Sốt phát ban thành dịch (bệnh do chấy rận), sốt phát ban do sóc bay	*Rickettsia prowazekii*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá	Giống như sốt phát ban vùng núi đá
Sốt phát ban do chuột (do bọ chét truyền bệnh)	*Rickettsia typhi*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá	Giống như sốt phát ban vùng núi đá
Sốt Tsutsugamushi hay sốt phát ban vùng bụi rậm (sốt mò/ sốt do mò mạt)	*Rickettsia tsutsugamushi*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá ***hoặc*** trong trường hợp nhẹ dùng Azithromycin 500mg (uống) x1 liều	Rifampin 600–900mg (uống) mỗi 24h/lần x7 ngày
Rickettsial pox	*Rickettsia akari*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá	Giống như sốt phát ban vùng núi đá
Sốt phát ban do ve (sốt đốm vùng Địa Trung Hải, sốt Boutonneuse , sốt đốm Israeli	*Rickettsia conorii* *Rickettsia parkeri*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá	Giống như sốt phát ban vùng núi đá
Sốt do ve châu Phi cắn	*Rickettsia africae*	Giống như sốt phát ban vùng núi đá	Giống như sốt phát ban vùng núi đá

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh sốt phát ban vùng núi đá (Rocky Mountain Spotted fever) (*Rickettsia rickettsii*)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt với nhịp tim tương đối chậm, đau đầu nhiều vùng trán, đau cơ năng ở cơ bụng/ lưng/chân sau khi bị ve đốt 3 đến 12 ngày. Ban da bắt đầu bằng các dát đỏ (erythematous macules) trên cổ tay và cổ chân xuất hiện sau khi bị ve đốt 3-5 ngày và tiến triển thành những chấm xuất huyết/ban xuất huyết có thể sờ thấy và hội tụ lại thành các vùng bầm máu. Phù quanh hố mắt, xung huyết kết mạc, điếc cấp tính và phù ở vùng mu ban tay/bàn chân là các dấu hiệu sớm chính có thể gặp. Tình trạng đau bụng có thể giống một hội chứng bụng cấp và dấu hiệu kích thích màng não và đau đầu có thể giống với viêm màng não. Gan lách to, ho và hôn mê có thể xảy ra ở giai đoạn muộn hơn. Các dấu hiệu cận lâm sàng bao gồm số lượng bạch cầu bình thường, số lượng tiểu cầu giảm, tăng men gan và tăng urê máu trước thận. Tụt huyết áp/ sốc có thể xảy ra thứ phát do viêm cơ tim và đây cũng là nguyên nhân gây tử vong thường gặp nhất. Vector truyền bệnh chính tại Hoa Kỳ là ve Dermacentor; nguồn duy trì mầm bệnh chính ở động vật là các động vật hoang dã nhỏ.

Chẩn đoán: Chẩn đoán lâm sàng quan trọng nhất là cần đặt nghi vấn cao đối với bệnh này và tiến hành điều trị sớm theo kinh nghiệm cho bệnh nhân. Chẩn đoán sớm/nhanh có thể được thực hiện bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp (DFA) đối với mẫu bệnh phẩm ban da được sinh thiết (phản ứng Weil-Felix: OX-19: + + +, OX-2: +, OX-K: –). Phương pháp xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IFA) đặc hiệu với R. rickettsii, cố định bổ thể, định lượng hiệu giá kháng thể bằng test ELISA giúp khẳng định chẩn đoán. Cần gộp bệnh sốt phát ban vùng núi đá vào chẩn đoán phân biệt đối với tất cả các bệnh nhân bị sốt và có nguy cơ tiềm tàng tiếp xúc với ve, nhất là trong những tháng mùa hè.

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp bệnh xảy ra ở phía Đông và Đông Nam nước Mỹ mà không phải ở vùng Rocky Mountain (núi đá). Nhiều trường hợp bệnh không được ghi nhận do các dấu hiệu sớm của bệnh không đặc hiệu. Điều trị kháng sinh sớm có thể làm mờ nhạt/ âm tính hóa kết quả huyết thanh học chẩn đoán bệnh. Các bệnh nhân có các dấu hiệu/triệu chứng của bệnh sốt phát ban vùng núi đá (RMSF) song không thấy phát ban cần được coi như đang bị nhiễm Ahrlichia (ehrlichiosis) hay "spotless RMSF" tới khi chứng minh có nguyên nhân khác. Điều trị sớm là điểm cốt yếu, cần bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm ngay khi nghi vấn bệnh nhân bị bệnh sốt phát ban vùng núi đá. Có thể cần tới các biện pháp điều trị bổ sung thêm.

Tiên lượng: Bắt đầu điều trị muộn (sau 5 ngày) làm tăng nguy cơ tử vong lên gấp 5 lần. Các yếu tố tiên lượng bất lợi bao gồm: viêm cơ tim và viêm não nặng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh sốt phát ban thành dịch do chấy rận (Epidermic [Louse-Borne] Typhus (*Rickettsia prowazekii*)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt cao với tình trạng nhịp tim chậm tương đối, rét run, đau đầu, xung huyết kết mạc và đau cơ. Ban da dạng dát, giống bệnh Rubella ở thân mình xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân vào ngày sốt thứ năm và tổn thương da này có thể trở thành dạng chấm xuất huyết và tác động tới các chi, song không bao giờ xuất hiện ở lòng bàn tay/bàn chân. Sưng mặt/đỏ bừng mặt xảy ra vào cuối tuần thứ nhất, cùng với các triệu chứng thần kinh trung ương (Vd: ù tai, chóng mặt, sảng) và các triệu chứng đường tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, nôn, đau bụng). Tụt huyết áp, viêm phổi, suy thận, hoại thư, nhồi máu não có thể xuất hiện muộn. Các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm số lượng bạch cầu bình thường, giảm tiểu cầu và tăng nồng độ creatinin máu/ tăng men gan. Vector truyền bệnh chính là chấy rận sống kí sinh ở thân người, ổ chứa mầm bệnh chính là người.

Chẩn đoán: Chẩn đoán lâm sàng quan trọng nhất là cần đặt nghi vấn cao đối với bệnh này và tiến hành điều trị sớm theo kinh nghiệm cho bệnh nhân (phản ứng Weil-Felix: OX-19: + + +, OX-2: +, OX-K: –). Hiệu giá kháng thể đặc hiệu đối với *R. prowazekii* giúp khẳng định chẩn đoán. Cân nhắc chẩn đoán sốt phát ban thành dịch do chấy rận ở các đối tượng là người có hoàn cảnh nghèo khổ có biểu hiện sốt bị nhiễm chấy rận, nhất là ở châu Phi và một số vùng Mỹ Latinh. Bệnh hiếm gặp ở Mỹ. Các thể tái phát bệnh ở mức nhẹ hơn (bệnh Brill-Zinsser) cũng hiếm gặp.

Lưu ý: Nhiều trường hợp bệnh không được ghi nhận do các dấu hiệu sớm của bệnh không đặc hiệu. Điều trị sớm đóng vai trò quan trọng.

Tiên lượng: Hoại thư ở mũi vành tai, bộ phận sinh dục, ngón chân, ngón tay có thể xuất hiện ở các trường hợp nặng. Tử vong xảy ra ở khoảng 10-50% các bệnh nhân không được điều trị.

Sốt phát ban do chuột (do bọ chét truyền bệnh) (Murine [Flea-Borne] Typhus (*Rickettsia typhi*)

Biểu hiện lâm sàng: Cũng tương tự như bệnh sốt phát ban thành dịch do chấy rận nhưng kém nặng hơn, với biểu hiện sốt trong hầu hết các trường hợp, một nửa số trường hợp có biểu hiện đau đầu, đau cơ và phát ban da dạng dát. Các dấu hiệu cận lâm sàng bao gồm số lượng bạch cầu bình thường, giảm tiểu cầu nhẹ và tăng nhẹ men gan.Vector truyền bệnh chính là bọ chét chuột châu Á (Xenopsylla cheopis); ổ chứa mầm bệnh chính là chuột cộng sinh trong môi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trường. Bệnh không thường gặp ở Hoa Kỳ. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở Texas, California, Florida, Hawaii.

Chẩn đoán: Chẩn đoán lâm sàng quan trọng nhất là cần đặt nghi vấn cao đối với bệnh này. Bệnh thường gặp nhất trong các tháng hè và thu (phản ứng Weil-Felix: OX-19: + + +, OX-2: +, OX-K: –). Hiệu giá kháng thể đặc hiệu đối với *R. typhi* giúp khẳng định chẩn đoán.

Lưu ý: Nhiều trường hợp bệnh không được ghi nhận do các dấu hiệu sớm của bệnh không đặc hiệu. Phát ban da trở thành dạng dát-sẩn , khi so sánh với bệnh sốt phát ban thành dịch do chấy rận với tổn thương da chỉ ở dạng dát. Một bệnh tương tự có thể gặp do *R. felis* gây ra.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm. Tỉ lệ tử vong <1%.

Sốt phát ban vùng bụi rậm do mò đốt hay bệnh sốt mò Tsutsugamushi (*Rickettsia tsutsugamushi*)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, rét run, đau đầu, đau cơ, đau khớp, các triệu chứng đường tiêu hóa và các than phiền không đặc hiệu khác. Sẹo hoại tử khô tại vị trí bị mò đốt (vẩy đen) ± hạch vùng sưng to. Ban da dạng dát ở thân mình gặp ở hầu hết các trường hợp, thường trong tuần đầu và có thể tiến triển và tác động đến các chi và mặt, ngoại trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân. Tình trạng viêm mạch có thể dẫn đến các bất thường tim-phổi, hệ thần kinh trung ương, cơ quan tạo máu vào tuần thứ 2. Bệnh nhân thường có tình trạng gan-lách to. Vector truyền bệnh/ổ chứa mầm bệnh chính là ấu trùng (mò) của ve thuộc họ trombicula. Các vùng có bệnh lưu hành thành dịch địa phương bao gồm miền Bắc nước Úc, Đông Nam Á, Ấn Độ.

Chẩn đoán: Chẩn đoán thừa nhận dựa vào lâm sàng (phản ứng Weil-Felix: OX-19: –, OX-2: –, OX-K: + + +). Huyết thanh chẩn đoán đặc hiệu đối với *R. tsutsugamushi* giúp khẳng định chẩn đoán.

Lưu ý: Điều trị không triệt để thường gây tình trạng bệnh tái phát.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt nếu được điều trị sớm.

Rickettsialpox (*Rickettsia akari*)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhẹ hơn so với những trường hợp nhiễm Rickettsia khác, với sẹo hoại tử khô tại vị trí bị đốt và biểu hiện khởi đầu bằng sốt cao

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

và phát ban toàn thân (thường dưới dạng các ban sẩn viêm đỏ da và các tổn thương này trở thành các bọng nước, ngoại trừ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân). Đỉnh sốt thường dưới 40°C, xảy ra sau khi bị mò đốt từ 1-3 tuần và kéo dài khoảng 1 tuần nếu không điều trị. Đau đầu, sợ ánh sáng, vã nhiều mồ hôi, đau họng, các than phiền về dạ dày-ruột (có thể thấy hiện tượng buồn nôn/nôn xảy ra sau đau đầu). Hầu hết các xét nghiệm cho kết quả bình thường, mặc dù số lượng bạch cầu có thể giảm. Vector truyền bệnh chính là bọ chét chuột, ổ chứa mầm bệnh ở động vật là chuột nhà. Bệnh hiếm gặp ở Mỹ.

Chẩn đoán: Chẩn đoán sơ bộ được dựa trên biểu hiện lâm sàng (phản ứng Weil-Felix: OX-19: –, OX-2: –, OX-K: ±). Huyết thanh chẩn đoán đặc hiệu đối với R. akari giúp khẳng định chẩn đoán.

Lưu ý: Không được nhầm với sốt do bị ve châu Phi cắn (African tick-bite fever), trong bệnh này bệnh nhân cũng có một phát ban dạng bọng nước.

Tiên lượng: Rất tốt, thậm chí không cần điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt phát ban do ve cắn hay Sốt đốm vùng Địa Trung Hải, Sốt Boutonneuse, sốt đốm Israeli (*Rickettsia conorii, Rickettsia parkeri*)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện lâm sàng tương tự như bệnh sốt phát ban vùng núi đá với sốt, ớn lạnh, đau cơ nhưng ở mức nhẹ hơn. Khác với bệnh sốt phát ban vùng núi đá, thường thấy có một sẹo hoại tử khô tại vị trí bị ve cắn ± nổi hạch vùng. Số lượng bạch cầu bình thường và giảm tiểu cầu thường gặp. Được lây truyền bệnh bởi ve nâu ở chó (Rhipicephalus sanguineus).

Chẩn đoán: Chẩn đoán được thừa nhận dựa trên biểu hiện lâm sàng (phản ứng Weil-Felix: OX-19: +, OX-2: +, OX-K: +). Huyết thanh học đặc hiệu đối với *R. conorii* giúp chẩn đoán xác định.

Lưu ý: Nghi ngờ chẩn đoán này ở những người đi du lịch về từ vùng có bệnh lưu hành thành dịch địa phương với bệnh cảnh giống như bệnh sốt phát ban vùng núi đá. Cần xem xét các chẩn đoán phân biệt khi không thấy có sẹo hoại tử tại ví trí ve cắn.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm. Tình trạng kiệt sức có thể kéo dài ngay cả khi bệnh nhân được điều trị đúng

Bệnh sốt do ve châu Phi cắn (African Tick Bite Fever) (*Rickettsia africae*)

Biểu hiện lâm sàng: Tương tự như sốt phát ban do chuột với biểu hiện sốt, ớn lạnh, đau cơ nhưng thường nổi hạch vùng và có nhiều sẹo hoại tử khô. Thời gian ủ bệnh khoảng 6 ngày. Vector truyền bệnh là ve Amblyomma hebreum/ Variegatum thường cắn người nhiều lần.

Chẩn đoán: Chẩn đoán được thừa nhận dựa trên biểu hiện lâm sàng (phản ứng Weil-Felix: OX-19: +, OX-2: +, OX-K: +). Huyết thanh học đặc hiệu đối với *R. africae* giúp chẩn đoán xác định.

Lưu ý: Ban da xuất hiện thoáng qua và có thể có hoặc không có bọng nước.

Tiên lượng: Tốt, ngay cả khi không được điều trị. Rất tốt nếu được điều trị.

Những tổn thương da khác

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị bôi ngoài da	Điều trị đường uống
Bệnh nấm lang ben (Tinea versicolor)/ Bệnh vảy phấn (Pityriasis)	*Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare)*	Kem bôi Clotrimazol (1%) hoặc kem bôi miconazol (2%) hoặc kem bôi Ketoconazol (2%) bôi hàng ngày ×7 ngày	Ketoconazol 200mg (uống) 1 lần/ngày ×7 ngày ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) 1 lần/ngày ×7 ngày ***hoặc*** Fluconazol 400mg (uống) ×1 liều
Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan (Eosinophilic folliculis)	*Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare)*	<u>Điều trị được ưu tiên áp dụng</u> Kem bôi Ketoconazol (2%) bôi ngoài da ×2–3 tuần ± Ketoconazol 200 mg (uống) 1 lần/ngày ×2–3 tuần	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh lang ben (Tinea vesicolor)/ Bệnh vẩy phấn (Pityriasis) (*Malassezia furfur*)

Biểu hiện lâm sàng: Các sẩn tạo vẩy tăng hoặc giảm sắc tố (0,5-1cm) có thể nối liền với nhau thành những mảng lớn hơn. Thường gặp nhất là tác động tới nửa trên cơ thể và hai tay. Có thể không có triệu chứng hoặc gây ngứa.

Xem xét chẩn đoán: *M. furfur* cũng có thể gây viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan ở bệnh nhân nhiễm HIV và tình trạng sepsis mắc phải do catheter ở trẻ sơ sinh hoặc bệnh nhân bị ức chế miễn dịch. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.

Lưu ý: Có thể cần tới nhiều tháng để các mảng sắc tố da trở lại bình thường sau khi được điều trị thỏa đáng.

Tiên lượng: Rất tốt.

Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan (Eosinophilic Folliculitis) (Malassezia furfur)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm nang lông kèm ngứa dữ dội, thường tác động tới các chi dưới.

Xem xét chẩn đoán: Sinh thiết mô cho thấy có viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan. Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi khuẩn gây bệnh khi nuôi cấy trên môi trường thạch Sabouraud có phủ lớp dầu oliu.

Lưu ý: Gần giống với viêm nang lông nhưng tổn thương dày đặc hơn ở hai chi dưới (mà không phải ở thân mình như trong trường hợp nhiễm nấm Candida da).

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch. Sử dụng điều trị theo đường uống nếu điều trị đường tại chỗ ngoài da bị thất bại.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm cơ

Phân loại	Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh nấm sâu Chromomycosis	Cladosporium/ Fonsecaea	Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh ***hoặc*** Terbinafin 250mg (uống) mỗi 24h/lần tới khi chữa khỏi bệnh
Bệnh nhiễm giun xoắn (Trichinosis)	*Trichinella spiralis*	Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần × 8–14 ngày ***hoặc*** Mebendazol 200–400 mg (uống) mỗi 8h/lần × 3 ngày, sau đó 400–500mg mỗi 8h/lần × 10 ngày

Bệnh nấm sâu Chromomycosis (Cladosuporium/Fonsecaea)

Biểu hiện lâm sàng: Các u nhỏ dưới da/ mô mềm hoặc các tổn thương dạng hột cơm.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có tác nhân gây bệnh khi nuôi cấy/ trên mẫu bệnh phẩm sinh thiết mô.

Lưu ý: Có thể giống với hình thái bàn chân Madura hoặc gây các tổn thương loét trong cơ.

Tiên lượng: Liên quan với mức độ ức chế miễn dịch của bệnh nhân.

Bệnh nhiễm giun xoắn (*Trichinella spiralis*)

Biểu hiện lâm sàng: Căng đau cơ, sốt nhẹ, tăng bạch cầu ái toan ở máu ngoại biên, xung huyết kết mạc.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên huyết thanh học đối với Trichinella hoặc bằng cách chứng minh có ấu trùng trong bệnh phẩm sinh thiết cơ.

Lưu ý: Tốc độ máu lắng rất thấp (gần như bằng 0), khác với các nguyên nhân gây viêm cơ khác thường có tăng tốc độ lắng máu.

Tiên lượng: Rất tốt nếu được điều trị sớm. Dùng corticosteroid ngắn hạn có thể hữu ích trong giai đoạn cấp tính. Điều trị này không có hiệu quả đối với các ấu trùng đã bị canxi hóa nằm trong cơ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI GỢI Ý ĐỌC THÊM

Adjei GO, Goka BQ, Kurtzhals AL. Neurotoxicity of Artemisinin Derivatives. Clin Infect Dis 43: 1616–17, 2006.

Alexander BD, Pfaller MA. Contemporary Tools for the Diagnosis and Management of Invasive Mycoses. Clin Infect Dis 43: S15–S27, 2006.

Ansart S, Perez L, Vergely O, et al. Illnesses in travelers returning from the tropics: a prospective study of 622 patients. J Travel Med 12: 312–18, 2005.

Avulunov A, Klaus S, Vardy D. Fluconazole for the treatment of cutaneous leishmaniasis. N Engl J Med 347: 370–1, 2002.

Ayeh-Kumi PF, Petri Jr. WA. Amebiasis: An Update on Diagnosis and Treatment. Infections in Medicine 23: 301–10, 2006.

Bisser S, N'Siesi FX, Lejon V, et al. Equivalence trial of melarsoprol and nifurtimox monotherapy and combination therapy for the treatment of second-stage Trypanosoma brucei gambiense sleeping sickness J Infect Dis 195: 322–9, 2007.

Chayakulkeeree M, Ghannoum MA, Perfect JR. Zygomycosis: the re-emerging fungal infection. Clin Infect Dis 25: 215–229, 2006.

Chen XM, Keithly JS, Paya CV, et al. Cryptosporidiosis. N Engl J Med 346: 1723–1731, 2002.

Cheng AC, Currie BJ. Melioidosis: epidemiology, pathophysiology, and management. Clin Microbiol Rev 18: 383–16, 2005.

Cisneros Herreros JM, Cordero Matia E. Therapeutic armamentarium against systemic fungal infections. Clin Microbiol and Infection 12: S53–64, 2006.

Croft SL, Yardley V. Chemotherapy of leishmaniasis. Curr Pharm Des 8: 319–42, 2002.

Cunha BA. Malaria vs. Typhoid Fever: A Diagnostic Dilemma? Am J Med 118: 1442–43, 2005.

DeGroote MA, Huitt G. Infections Due to Rapidly Growing Mycobacteria. Clin Infect Dis 42: 1756–63, 2006.

Galgiani JN, Ampel NM, Blair JE, Catanzaro A, et al. Coccidioidomycosis. Clin Infect Dis 41: 1217–23, 2005.

Griffith, KS; Lewis, LS; Mali, S; Parise, ME. Treatment of Malaria in the United States. JAMA 297: 2264–2277, 2007.

Haque R, Huston CD, Hughes M et al. Amebiasis. N Engl J Med 348: 1565–73, 2003.

Herbrecht R, Natarajan A, Letscher-Bru V, et al. Invasive pulmonary aspergillosis. Semin Respir Crit Care Med 25: 191–202, 2004.

International Artemisinin Study Group. Artesunate combinations for treatment of malaria: meta-analysis. Lancet 363: 9–17, 2004.

Kremsner PG, Krishna S. Antimalarial combinations. Lancet 364: 285–94, 2004.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplamosis. Lancet 363: 1965–76, 2004.

Munoz P, Guinea J, Bouza E. Update on invasive aspergillosis: clinical and diagnostic aspects. Clin Microbiol and Infection 12: S24–39, 2006.

Murray HW.Treatment of visceral leishmaniasis in 2004. Am J Trop Med Hyg 71: 787–94, 2004.

Mushatt DM, Mihm LB, Dreisbach AW, et al. Antibiotic Dosing in Slow Extended Daily Dialysis. Clin Infect Dis 49: 433–437, 2009.

Olliaro PL, Guerin PJ, Gerstl S, et al. Treatment options for visceral leishmaniasis: a systematic review of clinical studies done in India, 1980–2004. Lancet Infect Dis 5: 763–4, 2005.

Ouellette M, Drummelsmith J, Papadoupoulou B. Leishmaniasis: drugs in the clinic, resistance and new developments. Drug Resist Updat 7: 257–66, 2004.

Perea S, Patterson TF. Invasive Aspergillus infections in hematologic malignancy patients. Semin Respir Infect 17: 99–105, 2002.

Pirisi M, Salvador E, Bisoffi Z, et al. Unsuspected strongyloidiasis in hospitalized elderly patients with and without eosinophilia. Clin Microbiol Infect 12: 787–92, 2006.

Priotto G, Kasparian S, Mutombo W, et al. Nifurtimoxeflornithine combination therapy for second-stage African Trypanosoma brucei gambiense trypanosomiasis: a multicentre, randomized, phase III, noninferiority trial. Lancet 374:56–64, 2009

Ross AGP, Bartley PB, Sleigh AC, et al. Schistosomiasis. N Engl J Med 346: 1212–1220, 2002.

Segal BH, Walsh TJ. Current Approaches to Diagnosis and Treatment of Invasive Aspergillosis. Am J Respir Crit Care Med 173: 707–17, 2006.

Sinha PK, Ranjan A, Singh VP, Das VNR, et al. Visceral leishmaniasis (kala-azar)—the Bihar (India) perspective. Journal of Infection 53: 60–64, 2006.

Sobel JD.Combination therapy for invasive mycosis: evaluation of past clinical trial designs. Clin Infect Dis 15; 39 Suppl 4: S224–7, 2004.

Soto J. Miltefosine for new world cutaneous leishmaniasis. Clin Infect Dis 38: 1266–72, 2004.

Tortoli E. Clinical Manifestations of nontuberculous mycobacteria infections. Clin Microbiol Infect 15: 906–910, 2009.

Udall DN. Recent Updates on Onchocerciasis: Diagnosis and Treatment. Clin Infect Dis 44: 53–60, 2007.

Vardakas KZ, Michalopoulos A, Kiriakidou KG, et al. Candidaemia: Incidence, risk factors, characteristics and outcomes in immunocompetent critically ill patients. Clinical Microbiology and Infectious Diseases 15: 286–295, 2009.

White AC. New Developments in the Management of Neurocysticercosis. J of Infectious Diseases 199: 1261–1262, 2009.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

GUIDELINES

Chapman SW, Bradsher RW Jr, Campbell GD Jr, et al. Practice guidelines for the management of patients with blastomycosis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 679–83, 2000.

Galgiani JN, Ampel NM, Catanzaro A. et al. Practice guidelines for the treatment of coccidiomycosis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 658–61, 2000.

Hill DR, Ericsson CD, Pearson RD, Keystone JS, et al. The Practice of Travel Medicine: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 43: 1499–539, 2006.

Kauffman CA, Hajjeh R, Chapman SW. Practice guidelines for the management of patients with sporotrichosis. For the Mycoses Study Group. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 684–7, 2000.

Pappas PG, Rex JH, Sobel JD, Filler SG, et al. Guidelines for the Treatment of Candidiasis. Clin Infect Dis 38: 161–89, 2004.

Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical Practice Guidelines for the Management of Cryptococcal Disease: 2010 Update by the Infectious Disease Society of America. Clin Infect Disease 50:291–322, 2010.

Sobel JD. Practice guidelines for the treatment of fungal infections. For the Mycoses Study Group. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 652, 2000.

Walsh TH, Anaissie EJ, Denning DW, et al. Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 46: 327–60, 2008.

Wheat J, Sarosi G, McKinsey D, Hamill R, et al. Practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 30: 688–95, 2000.

Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, Halperin JJ, et al. The Clinical Assessment, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human Granulocytic Anaplasmosis, and Babesiosis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 43:1089–134, 2006.

TEXTBOOKS

Anaissie EJ, McGinnis MR. Pfaller MA (eds). Clinical Mycology, 2nd Edition, Churchill Livingston, New York, 2009.

Arikan S Rex JH. Antifungal Drugs. In: Manual of Clinical Micro biology, 8th Edition, ASM Press, Washington, D.C., 2003.

Bottone EJ (ed). An Atlas of the Clinical Microbiology of Infectious Diseases, Volume 1. Bacterial Agents. The Parthenon Publishing Group, Boca Raton, 2004.

Bottone EJ (ed). An Atlas of the Clinical Microbiology of Infectious Diseases, Volume 2. Viral, fungal, and parasitic agents. Taylor and Francis, 2006.

Bryskier A (ed). Antimicrobial Agents. ASM Press, Washington, D.C., 2005.

Calderone RA (ed). Candida and Candidiasis. ASM Press, Washington D.C., 2002.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cook GC (ed). Manson's Tropical Diseases, 23rd Edition, WB Saunders Company, Ltd., London, 2009.

Cunha BA (ed). Tick-Borne Infectious Diseases. Marcel Dekker, New York, 2000.

Despommier DD, Gwadz RW, Hotez PJ, Knirsch CA (eds). Parasitic Diseases, 4th Edition, Apple Trees Productions, LLC, New York, 2000.

Garcia LS (ed). Practical guide to Diagnostic Parasitology. ASM Press, Washington, DC, 2009.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, 3rd Edition, Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.

Guerrant RL, Walker DH, Weller PF (eds). Tropical Infectious Disease: Principles, Pathogens & Practice, 3rd Edition, Elsevier, Philadelphia, 2011.

Gutierrez Y (ed). Diagnostic Pathology of Parasitic Infections with Clinical Correlations, 2nd Edition, Oxford University Press, New York, 2000.

Howard DH (ed). Pathogenic Fungi in Humans and Animals. 2nd Edition, New York, Marcel Dekker, 2003.

Jong E, Sanford C (eds). The Travel and Tropical Medicine Manual. 4th Edition, Philadelphia: Saunders Elsevier, 2008.

Keystone JS, Kozarsky PE, Freedman DO, Nothdurft HO, Connor B. Travel Medicine 2nd Edition, Philadelphia: Mosby Elsevier, 2008.

Knipe DM, Howley PM (eds). Fields, Virology, 5th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008.

Krauss H, Weber A, Appel M (eds). Zoonoses. Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans, 3rd Edition, ASM Press, Washington, D.C. 2003.

Maertens JA, Marr KA (eds). Diagnosis of Fungal Infections.Informa Healthcare, New York, 2007.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of infectious Diseases, 7th Edition, Philadelphia, Elsevier, 2010.

Porterfield JS (ed). Exotic Viral Infections. Chapman & Hall Medical, London, 1995.

Raoult D, Parola P. Rickettsial Diseases. Informa Healthcare, New York, 2007.

Richman DD, Whitley RJ, Hayden FG (eds). Clinical Virology, 2nd Edition, ASM Press, Washington, DC, 2002.

Scholssberg DM (ed). Current Therapy of Infectious Diseases, 3rd Edition, Mosby St. Louis, 2008.

Strickland GT (ed). Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases, 8th Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2000.

Sun T (ed). Parasitic Disorders: Pathology, Diagnosis, and Management, 2nd Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 1999.

Walker DH (ed). Biology of Rickettsial Diseases. CRC Press, Boca Raton, 2000.

Warrell DA, Gilles HM. Essential Malariology, 4th Edition, Oxford University Press, New York, 2002.

Yu VL, Jr., Merigan TC, Jr., and Barriere SL (eds.). Antimicrobial Therapy & Vaccines, 2nd Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, MD, 2005

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương V

NHIỄM HIV

Paul E. Sax, MD
Jean E.hage, MD
Arthus Gran, MD

NGƯỜI DỊCH:

TS. Lương Quốc Chính
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Nguyễn Quốc Thái
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

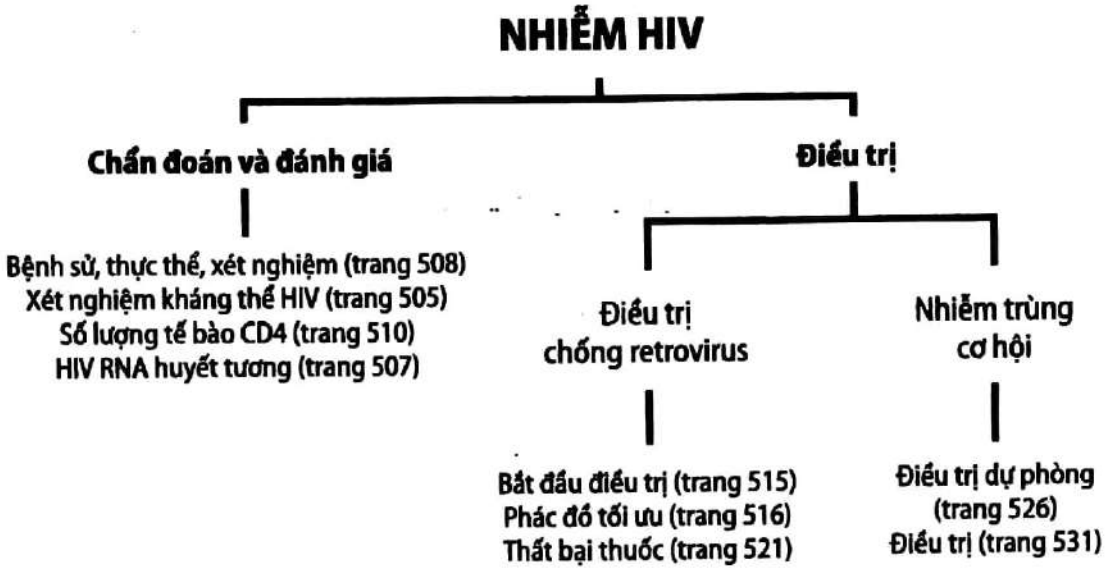
Tổng quan nhiễm HIV	501
Các giai đoạn nhiễm HIV	502
Nhiễm HIV cấp tính (tiên phát)	504
Tiếp cận các xét nghiệm chẩn đoán HIV	506
Đánh giá ban đầu nhiễm HIV	510
Các chỉ định điều trị đối với nhiễm HIV	515
Điều trị thuốc chống retrovirus	516
Thất bại điều trị bằng thuốc chống retrovirus	521
Dự phòng các nhiễm trùng cơ hội ở bệnh nhân nhiễm HIV	525
Điều trị các nhiễm trùng cơ hội ở bệnh nhân nhiễm HIV	531
Các nhiễm trùng cơ hội đường hô hấp	531
Các nhiễm trùng cơ hội ở hệ thần kinh trung ương	538
Nhiễm trùng cơ hội đường tiêu hóa	545
Điều trị các nhiễm trùng cơ hội khác trong HIV	556
Các bệnh đồng nhiễm với HIV (virus viêm gan B/ virus viêm gan C)	565
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	574

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TỔNG QUAN NHIỄM HIV

Nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV-1) dẫn đến tình trạng nhiễm trùng mạn tính, thường gây tử vong nếu không điều trị. Tình trạng nhiễm virus này có đặc điểm là gây suy giảm miễn dịch tiến triển, có một thời gian thầm lặng trên lâm sàng kéo dài và các nhiễm trùng cơ hội. Điểm đặc biệt của bệnh nhiễm HIV là virus gây nhiễm và nhân lên trong các tế bào bạch cầu lympho T có biểu lộ kháng nguyên CD_4 (các bạch cầu lympho trợ giúp-cảm ứng), một thành phần trọng yếu của tính miễn dịch bình thường qua trung gian tế bào. Các khiếm khuyết về mặt chất lượng trong đáp ứng CD_4 và số lượng tế bào CD_4 ngày càng thiếu hụt làm gia tăng nguy cơ mắc các nhiễm trùng cơ hội như viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* và các u tân sinh như u lympho và ung thư mô liên kết Kaposi. Nhiễm HIV cũng có thể làm rối loạn chức năng tế bào bạch cầu mono, đại thực bào và tế bào bạch cầu lympho B (miễn dịch thể dịch), dễ dẫn đến các nhiễm khuẩn do vi khuẩn có vỏ bọc. Sự tấn công trực tiếp các tế bào CD_4 dương tính ở hệ thần kinh trung ương và ngoại biên có thể gây viêm màng não, bệnh thần kinh ngoại vi và sa sút trí tuệ do HIV. Hơn 1 triệu người ở Mỹ và 30 triệu người trên thế giới bị nhiễm HIV. Nếu không điều trị, thời gian trung bình từ khi mắc HIV đến khi có nhiễm trùng cơ hội chỉ điểm AIDS vào khoảng 10 năm, thời gian sống sót sau đó trung bình 1-2 năm. Những khoảng thời gian đó dao động rất nhiều giữa các cá thể, trong đó một số bệnh nhân tiến triển từ nhiễm HIV cấp tính đến tử vong chỉ trong vòng 1-2 năm, trái lại một số khác không có biểu hiện ức chế miễn dịch do HIV trong vòng > 20 năm sau mắc HIV. Điều trị thuốc chống retrovirus và dự phòng các nhiễm trùng cơ hội đã cải thiện rõ rệt tiên lượng toàn thể của bệnh HIV. Cách tiếp cận với nhiễm HIV được trình bày trong *Hình 5.1*.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075



Hình 5.1. Chẩn đoán, đánh giá và điều trị nhiễm HIV

CÁC GIAI ĐOẠN NHIỄM HIV

A. Sự lây truyền virus: Nhiễm HIV chủ yếu mắc phải qua giao hợp (hậu môn, âm đạo, hiếm gặp qua đường miệng), phơi nhiễm với máu nhiễm virus (chủ yếu lây truyền qua kim tiêm) hoặc lây truyền từ mẹ sang con (giai đoạn chu sinh). Những hành vi tình dục có nguy cơ lây truyền cao nhất bao gồm người nhận giao hợp qua hậu môn không bảo vệ (đặc biệt là có rách niêm mạc), người nhận giao hợp âm đạo không bảo vệ (nhất là trong kỳ kinh) và giao hợp hậu môn/âm đạo không bảo vệ khi có loét sinh dục (Vd: giang mai sơ phát, Herpes sinh dục, hạ cam). Những hành vi tình dục nguy cơ thấp hơn bao gồm người thực hiện hành vi giao hợp hậu môn/âm đạo và tiếp xúc miệng- bộ phận sinh dục. Nguy cơ lây truyền sau một lần gặp gỡ với nguồn HIV đã được ước tính là 1/150 khi dùng chung kim tiêm, 1/300 khi phơi nhiễm nghề nghiệp qua da, 1/300-1000 khi là người nhận hành vi giao hợp hậu môn (1/500-1250 với người nhận giao hợp âm đạo, 1/1000-3000 với người thực hiện giao hợp âm đạo và 1/3000 với người thực hiện giao hợp hậu môn). Nguy cơ lây truyền tăng lên theo số lần gặp gỡ và nồng độ HIV RNA huyết tương càng cao thì nguy cơ lây truyền càng lớn. Phương thức lây truyền không ảnh hưởng đến diễn biến tự nhiên của bệnh HIV.

B. Nhiễm HIV cấp tính (tiên phát) (*trang 304*): Nhiễm HIV cấp tính xuất hiện 1-4 tuần sau lây truyền, kèm theo sự nhân lên bùng phát của virus với số lượng CD_4 bị tụt giảm. Phần lớn bệnh nhân có biểu hiện giống như

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

hội chứng tăng bạch cầu đơn nhân có triệu chứng, nhưng tình trạng này thường bị bỏ qua. Nhiễm HIV cấp tính được khẳng định khi có HIV RNA tăng cao mà không có kháng thể HIV.

C. **Chuyển đảo huyết thanh (Seroconversion):** Xét nghiệm kháng thể HIV dương tính thường xuất hiện trong vòng 4 tuần sau nhiễm virus cấp tính, thời gian này trong hầu hết các trường hợp là trong vòng 6 tháng (với ít ngoại lệ).

D. **Nhiễm HIV không triệu chứng:** Kéo dài trong khoảng thời gian không nhất định (trung bình 8-10 năm) đồng thời kèm theo giảm dần số lượng tế bào CD_4 và một nồng độ HIV RNA tương đối ổn định (đôi khi được gọi là "điểm ngưỡng" virus [viral " set point"]).

E. **Nhiễm HIV có triệu chứng:** Trước đây gọi là "Phức hợp cận AIDS" ("AIDS Related Complex" [ARC]), bao gồm các biểu hiện bệnh nấm Candida miệng (tưa miệng) hoặc âm đạo (dai dẳng, thường gặp hoặc đáp ứng kém với điều trị), loạn sản/ung thư biểu mô cổ tử cung tại chỗ, zona (các đợt tái phát hoặc tác động tới nhiều vùng thần kinh bì), bạch sản dạng lông trong miệng (oral hairy leukoplakia), bệnh thần kinh ngoại vi, ỉa chảy hoặc các triệu chứng thể tạng (Vd: như sốt nhẹ, sụt cân).

F. **Bệnh AIDS:** Được xác định khi số lượng tế bào $CD_4 < 200/mm^3$, phần trăm tế bào CD_4 trong tổng số tế bào lympho < 14% hoặc bị một trong số những nhiễm trùng cơ hội liên quan AIDS. Những nhiễm trùng cơ hội thường gặp bao gồm viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*, viêm màng não do Cryptococcus, viêm phổi do vi khuẩn tái phát, viêm thực quản Candida, bệnh do Toxoplasma hệ thần kinh trung ương, lao và u lympho không Hodgkin. Các chỉ điểm về AIDS khác ở bệnh nhân nhiễm HIV bao gồm bệnh do Candida phế quản, khí quản hoặc phổi; bệnh do nấm Coccidioides lan tỏa/ngoài phổi, bệnh nấm Cryptococcus hoặc bệnh nấm Histoplasma; bệnh do Cryptosporidium hoặc Isospora ruột mạn tính (> 1 tháng); ung thư biểu mô liên kết Kaposi; viêm phổi kẽ thâm nhiễm lympho bào/quá sản lympho bào ở phổi; nhiễm Mycobacterium (avium nội bào, kansasii, các loài khác) lan tỏa/ngoài phổi; bệnh não chất trắng đa ổ tiến triển (progressive multifocal leukoencephalopathy [PML]); nhiễm khuẩn huyết tái phát do Salmonella; hoặc hội chứng suy mòn do HIV (HIV wasting syndrome).

G. **Bệnh HIV tiến triển (Advanced HIV Disease):** Được chẩn đoán khi số lượng tế bào $CD_4 < 50/mm^3$. Hầu hết các tử vong liên quan tới AIDS xảy ra tại thời điểm này. Các nhiễm trùng cơ hội giai đoạn muộn thường gặp là do bệnh nhiễm cytomegalovirus (viêm võng mạc, viêm đại tràng) hoặc nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào (MAI) lan tỏa gây nên.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHIỄM HIV CẤP TÍNH (TIÊN PHÁT)

A. Mô tả tình trạng bệnh lâm sàng cấp tính kết hợp với mắc HIV tiên phát, xảy ra sau lây nhiễm virus từ 1-4 tuần (dao động trong khoảng thời gian từ 6 ngày đến 6 tuần). Các triệu chứng xuất hiện ở 50-90% trường hợp nhưng thường nhầm với cúm, bệnh tăng bạch cầu đơn nhân hoặc các hội chứng nhiễm virus không đặc hiệu khác. Các triệu chứng nặng hơn có thể có sự tương quan với điểm ngưỡng virus (viral set point) cao hơn và tiến triển bệnh HIV nhanh hơn. Ngay cả khi không được điều trị, hầu hết các bệnh nhân này sẽ hồi phục, tương ứng với tình trạng xuất hiện đáp ứng miễn dịch có hiệu quả một phần và mất những tế bào CD_4 mẫn cảm.

B. Chẩn đoán phân biệt bao gồm nhiễm Epstein Barr virus, cytomegalovirus, viêm gan do virus, nhiễm Enterovirus, giang mai thứ phát, bệnh do Toxoplasma, nhiễm HSV với hồng ban da đa dạng, phản ứng thuốc, bệnh Behçet, bệnh lupus cấp tính.

C. Các dấu hiệu và triệu chứng thường phản ánh tình trạng lan tràn theo đường máu của virus tới các vị trí lưới bạch huyết và thần kinh:

- Sốt (97%).
- Viêm họng (73%). Điển hình là viêm họng không xuất tiết (khác với nhiễm Epstein-Barr virus thường có xuất tiết).
- Phát ban (77%). Ngoại ban dạng dát sẩn do virus xuất hiện trên mặt và thân mình rất thường gặp, song ban da có thể tác động tới các chi, gan bàn tay và bàn chân.
- Đau khớp/đau cơ (58%).
- Các triệu chứng thần kinh (12%). Đau đầu rất hay gặp. Bệnh lý dây thần kinh, liệt Bell và viêm não-màng não hiếm gặp nhưng có thể tiên đoán kết cục tồi hơn.
- Loét miệng/sinh dục, tưa miệng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, sụt cân.

D. Các biểu hiện xét nghiệm

1. **Công thức bạch cầu**: Giảm bạch cầu lympho được tiếp theo bằng tăng bạch cầu lympho (thường gặp). Tăng bạch cầu lympho không

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

điển hình ở các mức độ khác nhau nhưng thường là ở mức độ thấp (khác với nhiễm EBV trong đó tăng bạch cầu lympho không điển hình có thể tới 20-30% hoặc cao hơn). Tình trạng giảm tiểu cầu xảy ra ở một số bệnh nhân.

2. **Tăng transaminase máu:** Ở một số mà không phải ở tất cả các bệnh nhân.

3. **Giảm số lượng tế bào CD_4:** Có thể hiếm khi giảm thấp tới mức để gây ra các nhiễm trùng cơ hội.

4. **Kháng thể HIV:** Thường âm tính, mặc dù những đối tượng có triệu chứng nhiễm HIV cấp kéo dài có thể có xét nghiệm kháng thể HIV dương tính nếu được chẩn đoán muộn trong quá trình diễn biến bệnh.

E. Khẳng định chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính

1. **Làm xét nghiệm kháng thể HIV** sau khi bệnh nhân chấp thuận (nếu luật sở tại yêu cầu) để loại trừ bị bệnh trước đó.

2. **Chỉ định xét nghiệm tải lượng virus (viral load test) (HIV RNA bằng kỹ thuật khuếch đại gen PCR)**, tốt hơn là sử dụng kỹ thuật khuếch đại gen theo thời gian thực (RT-PCR). HIV RNA khẳng định nhiễm HIV cấp tính trước khi có chuyển đảo huyết thanh. Phần lớn các đối tượng sẽ có HIV RNA rất cao (> 100.000 bản sao/mL). Cần đặt nghi vấn là xét nghiệm dương tính giả nếu HIV RNA thấp (< 20.000 bản sao/mL). Đối với tất cả các trường hợp có xét nghiệm dương tính, điều quan trọng là phải kiểm tra lại xét nghiệm HIV RNA và kháng thể HIV. Cũng có thể sử dụng kháng nguyên p24 để xác nhận chẩn đoán nhưng kém nhạy hơn so với xét nghiệm HIV RNA theo kỹ thuật PCR.

3. **Chỉ định làm các xét nghiệm khác nếu xét nghiệm HIV RNA âm tính:** Cho cấy họng tìm các tác nhân gây bệnh vi khuẩn/virus hô hấp, IgM/IgG vỏ protein bên ngoài (Viral Capsid Antigen [VCA]) đối với EBV, IgM/IgG đối với CMV, IgM/IgG đối với HHV-6 (Human Herpesvirus -6) và huyết thanh học chẩn đoán viêm gan nếu thích hợp để xác nhận chẩn đoán đối với các triệu chứng của bệnh nhân.

F. Xử trí nhiễm HIV cấp tính

1. **Bắt đầu điều trị bằng thuốc chống retrovirus:** Lý do đằng sau thay đổi này là để điều trị nhiều người nhiễm HIV hơn, bất kể bệnh ở giai đoạn nào, dựa trên những bằng chứng ngày càng nhiều về lợi ích của

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

tiến hành sớm điều trị HIV và, để chống lại nguy cơ tiềm ẩn mất kiểm soát sự nhân lên của virus và mất CD_4.

2. **Tiến hành xét nghiệm kiểu gen HIV kháng thuốc** (***xem trang 523***) do ngày càng gia tăng tỷ lệ hiện mắc lây truyền các virus kháng thuốc điều trị thuốc chống retrovirus. Xét nghiệm để kháng kiểu gen (genotype resistance test) được ưu tiên áp dụng; có thể bắt đầu tiến hành điều trị thuốc chống retrovirus cho bệnh nhân trong khi chờ kết quả xét nghiệm này.
3. **Những lợi ích mà điều trị nhiễm HIV cấp tính có thể mang lại:** Những lợi ích có thể có (nhưng chưa được chứng minh) bao gồm thúc đẩy làm hết triệu chứng nhanh hơn, giảm lây nhiễm virus, hạ thấp "điểm ngưỡng" virus học và bảo tồn đáp ứng CD_4 đặc hiệu với virus.

TIẾP CẬN CÁC XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HIV (HÌNH 5.2)

A. **Các xét nghiệm kháng thể HIV chuẩn**. Phần lớn các bệnh nhân sinh kháng thể HIV trong vòng 6-8 tuần sau phơi nhiễm; một nửa số bệnh nhân sẽ có xét nghiệm kháng thể dương tính trong 3-4 tuần và gần 100% sẽ phát hiện được kháng thể vào tháng thứ 6.

1. **ELISA**. Xét nghiệm sàng lọc thông thường. Tất cả các kết quả dương tính đều phải được khẳng định bằng test Western blot hoặc các xét nghiệm khác đặc hiệu hơn.
2. **Western blot**. Tiêu chí giải thích kết quả của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC): **Dương tính**: ít nhất có hai vạch sau: p24, gp41, gp160/120; **Âm tính**: không có vạch nào; **Không xác định được**: có bất kỳ vạch HIV nào nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn dương tính.
3. **Hiệu suất xét nghiệm:** Phương pháp chuẩn là sàng lọc bằng ELISA và khẳng định bằng Western blot.
   a. **ELISA âm tính:** Không cần Western blot (ELISA độ nhạy 99,7%, độ đặc hiệu 98,5%). Làm HIV RNA nếu nghi ngờ nhiễm HIV cấp tính.
   b. **ELISA dương tính:** Khẳng định bằng Western blot. Khả năng ELISA và Western blot cùng dương tính giả là cực thấp (< 1/140.000). Không có vạch p31 có thể gợi ý Western blot dương tính giả.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

c. **ELISA/Western blot ngoài dự kiến:** Làm lại xét nghiệm để loại trừ lỗi giấy tờ/máy tính.

4. **Western blot không xác định.** Vấn đề lâm sàng thường gặp, ảnh hưởng đến 4-20% các kết quả xét nghiệm ELISA dương tính. Thường do chỉ có vạch đơn p24 hoặc các vạch khác yếu. Nguyên nhân bao gồm đang chuyển đảo huyết thanh, bệnh HIV tiến triển mất đáp ứng kháng thể, kháng thể phản ứng chéo do có thai, truyền máu, ghép tạng, tự kháng thể của bệnh mạch máu collagen, nhiễm HIV-2, vaccin cúm hoặc được dùng vaccin HIV. Ở những bệnh nhân nguy cơ thấp, kết quả không xác định gần như không bao giờ có nhiễm HIV thực sự. Do đang xảy ra quá trình chuyển đảo huyết thanh nói chung được kết hợp với nồng độ HIV RNA cao, vì vậy tiếp cận được khuyến cáo là chỉ định làm xét nghiệm HIV RNA.

B. Định lượng HIV RNA huyết tương định (xét nghiệm tải lượng virus HIV)

1. **Mô tả:** Đo lường lượng HIV RNA trong huyết tương. Xét nghiệm có độ nhạy cao cho phép phát hiện virus ở phần lớn bệnh nhân chưa điều trị thuốc chống virus. Dùng để chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính và phổ biến hơn là để theo dõi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.

2. **Sử dụng xét nghiệm HIV RNA:**

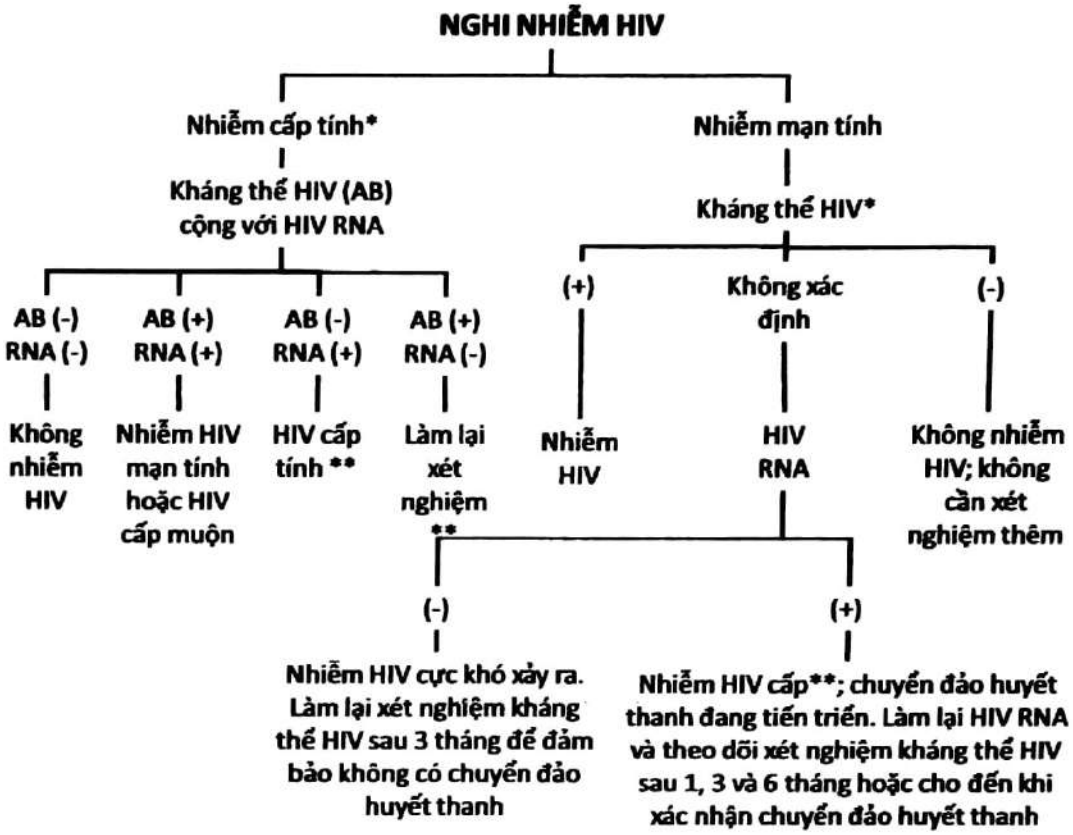
   a. **Khẳng định chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính**: HIV RNA cao với xét nghiệm kháng thể HIV âm tính khẳng định nhiễm HIV cấp tính trước khi có chuyển đảo huyết thanh.

   b. **Có ích trong đánh giá ban đầu nhiễm HIV:** Thiết lập HIV RNA nền và cùng với số lượng tế bào CD_4 sẽ giúp xác định nên bắt đầu hay trì hoãn điều trị, do HIV RNA có tương quan với tốc độ giảm số lượng tế bào CD_4.

   c. **Theo dõi đáp ứng với điều trị chống virus:** Các thay đổi HIV RNA giảm nhanh 2-4 tuần sau khi bắt đầu hoặc thay đổi điều trị thuốc chống retrovirus có hiệu quả, với tình trạng tụt giảm chậm hơn sau đó. Những bệnh nhân có đáp ứng HIV RNA nhiều nhất sẽ có kết cục lâm sàng tốt nhất. Không thay đổi về HIV RNA gợi ý điều trị sẽ không hiệu quả.

   d. **Ước lượng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội:** Đối với những bệnh nhân có cùng số lượng tế bào CD_4 thì nguy cơ nhiễm trùng cơ hội cao hơn khi HIV RNA cao hơn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075



Hình 5.2. Tiếp cận các xét nghiệm chẩn đoán HIV

(–): xét nghiệm âm tính; (+): xét nghiệm dương tính.

* *Xuất hiện 1-4 tuần sau lây truyền virus. Phần lớn bệnh nhân có hội chứng nhiễm virus (sốt, viêm họng ± phát ban/đau khớp), thường lẫn với cúm và do đó bị bỏ qua.*

** *HIV RNA trong nhiễm HIV cấp tính sẽ rất cao (thường > 100.000 bản sao/mL).*

\+ *Tất cả xét nghiệm ELISA dương tính phải được khẳng định bằng test Western blot; xét nghiệm này thường được thực hiện tự động ở các phòng xét nghiệm lâm sàng.*

++ *Có thể là người không tiến triển lâu dài hoặc do lỗi của phòng xét nghiệm.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

3. Các xét nghiệm và giải thích kết quả:

a. Xét nghiệm, độ nhạy và khoảng đo lường: Có ba xét nghiệm chính được dùng rộng rãi, trong đó mỗi xét nghiệm đều có ưu và nhược điểm. Bất kỳ xét nghiệm nào cũng có thể được dùng để chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính và để hướng dẫn/theo dõi điều trị, nhưng nên dùng cùng một xét nghiệm để theo dõi bệnh nhân dọc theo thời gian.

1. **RT-PCR Amplicor (Roche)**: Độ nhạy = 400 bản sao/mL; khoảng đo lường: 400-750.000 bản sao/mL.

2. **RT-PCR Ultrasensitive 1.5** (Roche): Độ nhạy = 50 bản sao/mL; khoảng đo lường: 50-75.000 bản sao/mL.
3. **bDNA Versant 3.0** (Bayer): Độ nhạy = 75 bản sao/mL; khoảng đo lường: 50-500.000 bản sao/mL.

b. **Mối tương quan giữa HIV RNA và CD_4:** Xét nghiệm HIV RNA có tương quan nghịch với số lượng tế bào CD_4 nhưng không phải hoàn toàn như vậy (Vd: có những bệnh nhân có số lượng CD_4 cao song lại có nồng độ HIV RNA tương đối cao và ngược lại). Đối với mỗi giá trị CD_4 được biết nồng độ HIV RNA cao hơn sẽ có mối tương quan với sự giảm sút CD_4 nhanh hơn. Trong đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus, nói chung các thay đổi HIV RNA diễn ra trước các thay đổi số lượng tế bào CD_4.

c. **Thay đổi có ý nghĩa mức HIV RNA** được định nghĩa là thay đổi ít nhất 2 lần (0,3 log) về RNA virus (có tính đến sự dao động bình thường ở các bệnh nhân ổn định lâm sàng) hoặc 3 lần (0,5 log) khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus mới (có tính đến sự biến thiên giữa các phòng xét nghiệm và ở trên bệnh nhân). Ví dụ: nếu kết quả HIV RNA = 50.000 bản sao/mL thì phạm vi thay đổi của các giá trị thực có thể gặp = 25.000-100.000 bản sao/mL và giá trị cần để chứng minh hoạt tính kháng retrovirus là ≤ 17.000 bản sao/mL.

4. **Chỉ định xét nghiệm HIV RNA:** Thường được thực hiện kết hợp cùng với đếm số lượng tế bào CD_4. Chỉ định để chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính và để đánh giá ban đầu HIV mới chẩn đoán. Cũng được khuyến cáo sau khi bắt đầu điều trị chống virus 2-8 tuần và mỗi 3-4 tháng một lần ở tất cả các bệnh nhân HIV.

5. **Khi nào nên tránh làm xét nghiệm HIV RNA:**

a. **Trong khi có các bệnh cấp tính và tiêm chủng:** Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn cấp tính (nhiễm trùng cơ hội, viêm phổi vi khuẩn, thậm chí trong đợt tái phát nhiễm virus Herpes simplex) có thể bị tăng đáng kể nồng độ HIV RNA (> 5 lần) và nồng độ này quay trở lại mức nền sau khi hồi phục 1-2 tháng. Mặc dù các dữ liệu còn mâu thuẫn, song nhiều nghiên cứu cho thấy ít nhất cũng có tăng thoáng qua nồng độ HIV RNA sau tiêm phòng vaccin phòng cúm và các tiêm chủng khác và nồng độ này sẽ trở về mức nền sau 1-2 tháng.

b. **Khi kết quả xét nghiệm sẽ không có tác động gì đến điều trị:** Kịch bản thường gặp là ở những bệnh nhân có bệnh tiến triển

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

song họ không có lựa chọn thuốc chống retrovirus hoặc không thể dung nạp được với điều trị.

c. **Như một xét nghiệm sàng lọc đối với nhiễm HIV**, ngoại trừ nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh HIV cấp tính (tiên phát) trong giai đoạn cửa sổ kháng thể HIV (tức là 3-6 tuần đầu sau khi lây truyền virus).

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU NHIỄM HIV

A. Đánh giá lâm sàng: Khai thác bệnh sử và khám lâm sàng cần tập trung vào các chẩn đoán liên quan tới nhiễm HIV. So sánh với các bệnh nhân không nhiễm HIV, mức độ nặng, tần suất và thời gian bị của những tình trạng này thường gia tăng trong bệnh HIV.

1. **Da liễu:** Nhiễm Herpes simplex nặng (miệng/ hậu môn-sinh dục); herpes zoster (đặc biệt là các đợt tái phát, tổn thương thần kinh sọ hoặc lan tỏa); u mềm lây (molluscum contagiosum); áp xe tụ cầu; nhiễm nấm móng; sarcoma Kaposi (do nhiễm HHV-8); chấm xuất huyết (do ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn [ITP]); viêm da tiết bã nhờn; vảy nến mới xuất hiện hoặc nặng lên; viêm nang lông mụn mủ tăng bạch cầu ái toan; phát ban da nặng do thuốc (nhất là khi dùng các sulfonamid).
2. **Họng miệng**: Bệnh nhiễm Candida ở miệng; bạch sản lông ở miệng (do nhiễm virus Epstein-Barr); sarcoma Kaposi (thường gặp nhất ở trên vòm miệng hoặc ở lợi); viêm lợi/viêm quanh răng; hạt cơm; các loét áp-tơ (nhất là ở thực quản/quanh hậu môn).
3. **Các triệu chứng thể tạng:** Mệt mỏi, sốt, ỉa chảy mạn tính, sụt cân.
4. **Bạch huyết:** Hạch to toàn thân kéo dài.
5. **Các biểu hiện khác**: Lao tiến triển (nhất là lao ngoài phổi), u lympho không Hodgkin (nhất là ở hệ thần kinh trung ương); giảm bạch cầu, thiếu máu, giảm tiểu cầu (nhất là ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn) không giải thích được; bệnh cơ; các tình trạng bệnh lý thần kinh khác (bệnh lý dây thần kinh sọ/ngoại biên, hội chứng Guillain-Barre, viêm một dây thần kinh nhiều chỗ (mononeuritis multiplex), viêm màng não vô khuẩn, suy giảm nhận thức).

B. Các xét nghiệm nền (Bảng 5.1)

C. Số lượng tế bào CD_4 (phân tích dưới nhóm tế bào lympho)

1. **Tổng quan.** Nhiễm HIV cấp tính có đặc điểm là giảm số lượng tế bào CD_4, sau đó các tế bào này tăng lên dần kèm theo sự hồi phục lâm sàng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm HIV mạn tính cho thấy có tình trạng giảm tiến triển số lượng tế bào CD_4 khi không điều trị (~50-80 tế bào/năm), tiếp đó giảm nhanh hơn trong 1-2 năm trước khi xảy ra các nhiễm trùng cơ hội (chẩn đoán chỉ điểm AIDS). Số lượng tế bào vẫn ổn định trong 5-10 năm ở 5% bệnh nhân, trong khi những bệnh nhân khác lại có thể thấy bị giảm nhanh (> 300 tế bào/năm). Do có dao động ở mỗi bệnh nhân và giữa các phòng xét nghiệm, kiểm tra lại các giá trị là hữu ích trước khi ra các quyết định về xử trí.

2. Sử dụng số lượng tế bào CD_4

a. **Cho biết mức độ ức chế miễn dịch** để giải thích các triệu chứng/dấu hiệu (Bảng 5.2).

b. **Được sử dụng để hướng dẫn điều trị.** Các hướng dẫn điều trị ủng hộ chọn giá trị $CD_4 < 500/mm^3$ làm ngưỡng để bắt đầu điều trị, bất kể mức HIV RNA hay triệu chứng như thế nào. Đối với điều trị dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*, bệnh do Toxoplasma, nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào (MAI)/nhiễm cytomegalovirus, số lượng tế bào CD_4 $200/mm^3$, $< 100/mm^3$ và $< 50/mm^3$ được sử dụng như các mức ngưỡng tương ứng.

c. **Đưa ra một ước tính về nguy cơ nhiễm trùng cơ hội hoặc tử vong.** Số lượng tế bào CD_4 $< 50/mm^3$ được kết hợp với gia tăng rõ rệt nguy cơ tử vong (trung vị thời gian sống là 1 năm), mặc dù một số bệnh nhân có số lượng CD_4 thấp sống được > 3 năm kể cả không điều trị thuốc chống retrovirus. Tiên lượng bị ảnh hưởng mạnh bởi HIV RNA, sự có mặt /tiền sử bị nhiễm trùng cơ hội hoặc u tân sinh, tình trạng thể lực và đáp ứng phục hồi miễn dịch với điều trị thuốc chống retrovirus.

D. Xét nghiệm HIV RNA (HIV RNA PCR) *(trang 507)*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.1. Xét nghiệm nền đối với các bệnh nhân nhiễm HIV

Xét nghiệm	Lý do cơ bản
Làm nhắc lại xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán HIV (ELISA/ test khẳng định Western blot)	Được chỉ định cho những bệnh nhân không lưu lại được xét nghiệm dương tính trước đó và cho những người "nguy cơ thấp" nhưng có xét nghiệm dương tính (để phát hiện sai sót của máy tính/giấy tờ). Hiện nay làm lại xét nghiệm huyết thanh học kém quan trọng hơn do xét nghiệm HIV RNA cung cấp biện pháp bổ sung thêm để khẳng định nhiễm HIV.
Công thức máu với các thành phần bạch cầu, tiểu cầu	Phát hiện giảm các dòng tế bào máu (VD: ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn) gặp trong HIV. Cần tính toán số lượng tế bào CD_4.
Bộ các xét nghiệm hóa sinh ("SMA 20") và bộ các xét nghiệm lipid lúc đói	Phát hiện rối loạn chức năng thận và các bất thường điện giải/chức năng gan là các bất thường này có thể đi kèm với HIV và các nhiễm khuẩn liên quan (ví dụ: bệnh thận do HIV, đồng nhiễm HCV). Cung cấp bộ các xét nghiệm lipid nền (nhiều thuốc chống retrovirus có thể có tác động đến lipid).
Số lượng tế bào CD_4	Xác định nhu cầu điều trị thuốc chống retrovirus và dự phòng nhiễm trùng cơ hội. Xét nghiệm tốt nhất để xác định nguy cơ nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng.
Xét nghiệm HIV RNA ("tải lượng virus")	Cung cấp một chỉ điểm về tốc độ tiến triển bệnh HIV. Xác định chỉ định đối với đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.
Test tuberculin da (liều chuẩn 5 đơn vị tuberculin PPD)- Phản ứng Mantoux	Phát hiện nhiễm lao ẩn và tập trung tới các bệnh nhân cần điều trị dự phòng. Test bì làm mất đáp ứng với phản ứng mantoux (Anergy skin tests) hiện không còn được chỉ định do có giá trị dự đoán thấp. HIV là đồng yếu tố mạnh nhất gây ra tình trạng phát triển của lao tiến triển.
Phiến đồ âm đạo (PAP smear)	Nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ có HIV dương tính gần như tăng gấp đôi so với nhóm chứng không nhiễm virus.
HLA-B*5701	Cần làm nếu có kế hoạch điều trị bằng abacavir, để đánh giá nguy cơ các phản ứng quá mẫn nặng với abacavir.
Huyết thanh chẩn đoán bệnh do Toxoplasma (IgG)	Nhằm phát hiện ra những bệnh nhân có nguy cơ sau này bị bệnh não/hệ thống do Toxoplasma và cần phải dự phòng. Những người có xét nghiệm âm tính cần được tư vấn tránh nhiễm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Huyết thanh chẩn đoán bệnh giang mai (VDRL hoặc RPR)	Nhằm phát hiện tình trạng đồng nhiễm giang mai là bệnh có liên quan về mặt dịch tễ với HIV. Bệnh giang mai có thể tiến triển nặng lên ở bệnh nhân HIV.
Huyết thanh chẩn đoán viêm gan C (anti-HCV)	Nhằm phát hiện nhiễm HCV và thường là người mang virus mạn tính. Nếu có thể được, cần làm tiếp xét nghiệm kiểu gen HCV và tải lượng virus HCV. Nếu bệnh nhân có kháng thể âm tính và có nguy cơ cao bị viêm gan, chỉ định xét nghiệm HCV RNA để loại trừ kết quả âm tính giả.
Huyết thanh chẩn đoán viêm gan B (HBsAb, HBcAb, HBsAg)	Nhằm phát hiện những bệnh nhân có miễn dịch với viêm gan B (HBsAb) hoặc người mang mạn tính (HBsAg). Nếu tất cả ba xét nghiệm này đều âm tính, có chỉ định vaccin viêm gan B.
Sàng lọc thiếu hụt G6PD	Nhằm phát hiện ra các bệnh nhân có nguy cơ bị tan máu liên quan với dapson hoặc primaquin.
Huyết thanh chẩn đoán CMV (IgG)	Nhằm phát hiện ra những bệnh nhân cần truyền máu CMV âm tính (CMV-negative blood) hoặc máu đã loại bỏ bạch cầu (leukocyte-depleted blood) nếu họ cần được truyền máu.
Huyết thanh chẩn đoán VZV (IgG)	Nhằm phát hiện ra những bệnh nhân có nguy cơ bị thủy đậu và những bệnh nhân cần tránh tiếp xúc với các đối tượng đang bị thủy đậu hoặc zona. Những bệnh nhân có huyết thanh học âm tính có phơi nhiễm với thủy đậu cần được dùng globulin miễn dịch thủy đậu-zona (VZIG).
Xquang ngực	Đôi khi được chỉ định thực hiện trước điều trị như một dữ liệu cơ sở để so sánh sau này. Có thể phát hiện được bệnh u hạt đã lành/các quá trình bệnh khác. Được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân có test tuberculin da dương tính.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.2. Sử dụng số lượng tế bào CD_4 để giải thích dấu hiệu/ triệu chứng của bệnh nhân

Số lượng tế bào CD_4 (tế bào/mm^3)	Các tình trạng liên quan
> 500	Phần lớn các tình trạng bệnh tương tự như các bệnh được gặp ở bệnh nhân HIV âm tính. Một số tình trạng bệnh này gây tăng nguy cơ nhiễm khuẩn (viêm phổi phế cầu, viêm xoang), zona, lao, các bệnh về da.
200-500*	Nhiễm khuẩn (nhất là viêm phổi phế cầu, viêm xoang), sarcoma da Kaposi, bệnh nấm Candida âm đạo, ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP).
50-200*	Tưa miệng, bạch sản lông ở miệng, các nhiễm trùng cơ hội kinh điển liên quan HIV (ví dụ: viêm phổi *P. [carinii] jiroveci*, viêm màng não do Cryptococcus, bệnh do Toxoplsma). Đối với các bệnh nhân được dự phòng, phần lớn nhiễm trùng cơ hội không xuất hiện cho đến khi số lượng tế bào CD_4 giảm xuống đáng kể < 100/mm^3.
< 50*	Các nhiễm trùng cơ hội "giai đoạn cuối" (nhiễm khuẩn *M. avium* nội bào lan tỏa, viêm võng mạc do CMV), suy mòn liên quan HIV, bệnh của hệ thần kinh (bệnh dây thần kinh, bệnh lý não).

* Bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị tất cả các quá trình bệnh lý được ghi nhận ở những giai đoạn sớm hơn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ ĐỐI VỚI NHIỄM HIV

Bảng 5.3. Bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus ở bệnh nhân nhiễm HIV-1 theo hướng dẫn DHHS và IAS-USA

Tình trạng lâm sàng và/hoặc số lượng CD_4	Khuyến cáo
Bệnh HIV có triệu chứng	Điều trị bằng thuốc chống retrovirus được khuyến cáo mạnh bất kể số lượng tế bào CD_4 là bao nhiêu.
Phụ nữ mang thai	
HIV-1 RNA >100.000 bản sao/mm^3	
Giảm nhanh số lượng tế bào CD_4, > 100 tế bào/mm^3 mỗi năm	
Đồng nhiễm viêm gan B cấp	
Đồng nhiễm viêm gan C cấp	
Đang có hoặc có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch	
Bệnh lý thần kinh liên quan với HIV	
Nhiễm HIV tiên phát có triệu chứng	
Nguy cơ cao lây truyền HIV thứ phát (ví dụ: các cặp vợ chồng không tương hợp huyết thanh [serodiscordant couples])	
Không có triệu chứng (bất kể số lượng tế bào CD_4 là bao nhiêu)	Điều trị thuốc chống retrovirus được khuyến cáo.

Từ viết tắt: DHHS (Department of Health and Human Services): Bộ Y tế Hoa Kỳ; IAS-USA (International AIDS Society-USA): Hiệp hội quốc tế về bệnh AIDS Hoa Kỳ.

Phỏng theo: ***Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-infected adults and adolescents. http://aidsinfo.nih.gov/consentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf, 2012.***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG RETROVIRUS

Bảng 5.4. Điều trị thuốc chống retrovirus cho những bệnh nhân chưa từng điều trị theo Hướng dẫn điều trị 2012 của Bộ Y tế Hoa Kỳ (DHHS)

Phác đồ	Phác đồ được ưu tiên lựa chọn	Phác đồ thay thế	Phác đồ có thể được chấp nhận
Dựa trên NNRTI (1 NNRTI +2 NRTIs)	Efavirenz (EFV) + Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC)	Efaviren (EFV) + Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC) Rilpivirine (RPV) ***cộng với*** Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC) ***hoặc*** Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC)	Efavirenz (EFV) + Zidovudine (ZDV) + Lamivudine[b] (3TC) Nevirapine (NVP) + ***cộng với*** Tenofovir (TDF) + Emtricitabine) (FTC) ***hoặc*** Zidovudine (ZDV) + Lamivudine (3TC)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dựa trên PI (1PI +2 NRTIs)	Atazanavir (ATV)/r + Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC) Darunavir (DRV)/r + Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC)	Atazanavir (ATV)/r + Abacavir (ABC) + Lamivudin Darunavir (DRV)/r + Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC) Fosamprenavir (FPV)/r ***cộng với*** Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC) ***hoặc*** Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC) Lopinavir (LPV)/r ***cộng với*** Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC) ***hoặc*** Tenofovir (TFV) + Emtricitabine	Atazanavir (ATV) + [Abacavir (ABC) hoặc Zidovudine (ZDV))] + Lamivudin (3TC) Atazanavir (ATV)/r ***hoặc*** Darunavir (DRV)/r ***hoặc*** Fosamprenavir (FPV)/r ***hoặc*** Lopinavir (LPV)/r ***cộng với*** Zidovudine (ZDV) + Lamivudin (3TC)
Dựa trên INSTI (1 INSTI + 2 NRTIs)	Raltegravir (RAL) + Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC)	Raltegravir (RAL) + Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC) Elvitegravir (EVG) + Combicistat (COBI) + Emtricitabine (FTC) + Tenofovir (TDF)	Raltegravir (RAL) + Zidovudine (ZDV) + Lamivudin (3TC)

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dựa trên thuốc đối kháng thụ thể CCR5 (1 CCR5+ 2NRTIs)	N/A	N/A	Maraviroc (MVC) ***cộng với*** Zidovudine (ZDV) + Lamivudin (3TC) ***hoặc*** Tenofovir (TDF) + Emtricitabine (FTC) ***hoặc*** Abacavir (ABC) + Lamivudin (3TC)

***Từ viết tắt*: NNRTI** (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor): Thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleoside; **NRTI** (nucleoside reverse transcriptase inhibitor): Thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcriptase) loại nucleoside; **PI** (Protease Inhibitors): Thuốc ức chế protease, bao gồm: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir và tipranavir; **INSTI** (integrase strand transfer inhibitor or integrase inhibitor for HIV-1): Thuốc ức chế chuyển đoạn enzym tích hợp integrase, ví dụ: như raltegravir.

Thuốc ức chế hòa màng virus HIV (HIV fusion inhibitor): ví dụ: enfuvirtide (INN) là thuốc ức chế hòa màng virus HIV, một thuốc đầu tiên thuộc nhóm thuốc chống retrovirus mới đượcdùng trong điều trị phối hợp để điều trị nhiễm HIV-1. Thuốc được lưu hành trên thị trường dưới tên thương mại **Fuzeon** (Roche); **Thuốc đối kháng thụ thể CCR5** (CCR5 receptor antagonist): (tên thương mại của thuốc sáng chế là **Selzentry** hoặc **Celsentri**) là một thuốc chống retrovirus thuộc nhóm đối kháng thụ thể CCR5 được sử dụng trong điều trị nhiễm HIV. Thuốc cũng được phân loại như một thuốc ức chế gia nhập của virus vào tế bào (an entry inhibitor). Maraviroc là một thuốc thuộc loại ức chế gia nhập của virus vào (entry inhibitor).

***Phỏng theo*: Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-infected adults and adolescents. http://aidsinfo.nih.gov/consentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf, 2012.**

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2010 Recommendations of the International AIDS Society - USA Panel. JAMA. 304:321–333, 2010 và Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 5th Edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2012.

Phác đồ điều trị đối với phụ nữ có thai: LPV/r (dùng 2 lần/ngày) ZDV/3TC được khuyến cáo sử dụng như các thuốc chống retrovirus cho những phụ nữ bị nhiễm HIV trong khi có thai để duy trì sức khỏe và điều trị cho mẹ nhằm làm giảm lây truyền HIV xảy ra ở giai đoạn chu sinh tại Hoa Kỳ. Tham khảo thêm tại địa chỉ: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines.

a. Không nên dùng Efavirenz trong ba tháng đầu thai kỳ hoặc cho những người phụ nữ đang muốn có con hoặc cho những đối tượng không thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

b. Lamivudin có thể thay cho emtricitabine hoặc ngược lại.

c. Không nên dùng Abacavir cho bệnh nhân có xét nghiệm HLA-B*5701 dương tính và nên dùng một cách thận trọng cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch hoặc cho các đối tượng trước khi điều trị có HIV-RNA > 100.000 bản sao/mL.

d. Không nên dùng Nevirapin cho những bệnh nhân bị suy gan từ vừa đến nặng. Không nên dùng cho những phụ nữ có số lượng tế bào CD_4 > 250 tế bào/mm^3 trước điều trị thuốc chống retrovirus hoặc các nam giới có số lượng tế bào CD_4 > 400 tế bào/mm^3 trước điều trị thuốc chống retrovirus.

e. Không nên dùng Atazanavir/r cho bệnh nhân cần > 20 mg omprazol mỗi ngày.

f. Nói chung Atazanavir/r được ưu tiên dùng hơn atazanavir. Atazanavir không cần thuốc khởi động tác dụng (unboosted atazanavir) có thể được dùng khi không thể gây khởi động tác dụng bằng ritonavir.

g. Không nên dùng Abacavir cho bệnh nhân xét nghiệm HLA-B*5701 dương tính và nên dùng một cách thận trọng cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch hoặc cho các đối tượng trước khi điều trị có HIV-RNA > 100.000 bản sao/mL.

h. Không khuyến cáo dùng Lopinavir/r ngày 1 lần cho bệnh nhân đang mang thai.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.5. Khuyến cáo điều trị ban đầu thuốc chống retrovirus theo Hướng dẫn điều trị của Hiệp hội quốc tế về bệnh AIDS Hoa Kỳ (IAS-USA)

	Phác đồ được khuyến cáo	Phác đồ thay thế	Bình luận
Dựa trên NNRTI	Efavirenz + Tenofovir + Emtricitabine Efavirenz + Abacavir + Lamivudin	Nevirapine +Tenofovir + Emtricitabine Nevirapine + Abacavir + Lamivudin Rilpivirine +Tenofovir + Emtricitabine Rilpivirine + Abacavir + Lamivudin	Chỉ dùng Abacavir cho bệnh nhân có nhóm kháng nguyên HLA-B* 5701 âm tính với HIV-1 RNA < 100.000 bảo sao/ mL. Tình trạng nhiễm độc gan nặng và phát ban do dùng nevirapine thường xảy ra hơn khi bắt đầu điều trị ở các bệnh nhân nữ có số lượng tế bào CD_4 > 250/ µL và ở các bệnh nhân nam có số lượng tế bào CD_4 > 400/µL.

Dựa trên PI	Darunavir/r + Tenofovir + Emtricitabine Atazanavir/r + Tenofovir + Emtricitabine Atazanavir/r + Abacavir +Lamivudin	Darunavir/r + Abacavir + Lamivudin Lopinavir/r + Tenofovir + Emtricitabine Lopinavir/r + Abacavir + Lamivudin	Các PIs thay thế khác bao gồm fosamprenavir/r và saquinavir/r song rất hiếm chỉ định sử dụng các lựa chọn này cho điều trị khởi đầu.
Dựa trên InSTI	Raltegravir + Tenofovir + Emtricitabine	Raltegravir +Abacavir + Lamivudin Elvitegravir + Combicistat + Tenofovir + Emtricitabine	Raltegravir được dùng 2 lần/ngày Kinh nghiệm sử dụng đối với elvitegravir/ combicistat/tenofovir/ emtricitabine bị hạn chế ở các dữ liệu kéo dài trong vòng 48 tuần.

Phỏng theo: **Thompson MA, Aberg JA, Hoy JF, et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2012 recommendations of the International Antiviral Society - USA Panel. JAMA. 308:387–402, 2012 và Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 4th Edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.**

Từ viết tắt: **CCR5**: thụ thể chemokine CC 5 [CC chemokine receptor 5]; **IAS-USA**: Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS -Hoa Kỳ [International AIDS Society-USA]; **INSTI**: thuốc ức chế chuyển đoạn enzyme tích hợp [integrase stand transfer inhibitor]; **NNRTI**: thuốc ức chế enym sao chép ngược không phải nucleoside [non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor]; **NRTI**: thuốc ức chế enzym sao chép ngược loại nucleoside [nucleoside reverse transcriptase inhibitor]; **PI**: thuốc ức chế protease [protease inhibitor]; **/r** = tăng cường ritonavir.

Lựa chọn điều trị thuốc chống retrovirus tối ưu: Lựa chọn phác đồ điều trị kháng retrovirus tối ưu ban đầu cần phải tính đến hiệu lực kháng virus của thuốc, khả năng dung nạp và tính an toàn qua các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế Hoa Kỳ (DHHS) và Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS- Hoa Kỳ (IAS-USA) (***Bảng 5.4 và 5.5***).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

THẤT BẠI ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC CHỐNG RETROVIRUS (BẢNG 5.6)

Thất bại điều trị bằng thuốc chống retrovirus có thể được định nghĩa theo những cách khác nhau như trình bày ở dưới đây. Những nguyên nhân của thất bại điều trị bao gồm tuân thủ không thỏa đáng, có tình trạng kháng thuốc từ trước, phác đồ điều trị phức tạp, tác dụng phụ và dược động học của thuốc chưa đạt tới mức tối ưu. Tất cả những yếu tố này đều có thể dẫn đến sự nhân lên liên tục của virus và tiến triển thành kháng thuốc. Tuân thủ dùng thuốc kém là nguyên nhân thường gặp nhất của thất bại điều trị.

A. Các loại thất bại điều trị

1. **Thất bại virus học:** Được định nghĩa nghiêm ngặt nhất là không có khả năng đạt được hoặc duy trì được sự ức chế virus. Ở những bệnh nhân chưa từng điều trị, nồng độ HIV RNA sẽ là < 400 bản sao/mL sau 24 tuần hoặc < 50 bản sao/mL sau 48 tuần kể từ khi bắt đầu điều trị. Sự tái hồi lại virus (virologic rebound) được gặp khi lại phát hiện được HIV RNA sau khi đã có sự ức chế virus ở cả những bệnh nhân chưa từng được điều trị và đã từng được điều trị.

2. **Thất bại miễn dịch học:** Có thể xảy ra khi có hoặc không có thất bại virus học và được định nghĩa là số lượng tế bào CD_4 không thể tăng được thêm 25-50 tế bào/mm^3 so với giá trị trước điều trị trong năm điều trị đầu tiên hoặc là có giảm số lượng tế bào CD_4 xuống thấp hơn con số trước điều trị trong khi vẫn đang được điều trị.

3. **Thất bại lâm sàng:** Là sự xuất hiện hoặc tái xuất hiện các biến cố liên quan với HIV sau ít nhất 3 tháng điều trị thuốc chống retrovirus mạnh, ngoại trừ các biến cố liên quan đến hội chứng phục hồi miễn dịch.

4. **Trình tự thường gặp của thất bại điều trị:** Thất bại virus học thường xuất hiện trước, sau đó là thất bại miễn dịch học và cuối cùng là tiến triển bệnh về lâm sàng. Những biến cố này có thể cách nhau hàng tháng đến hàng năm và có thể không xuất hiện theo trình tự như vừa được nêu ở tất cả các bệnh nhân.

B. Mục tiêu điều trị cần đạt sau thất bại virus học: Khi bệnh nhân có HIV DNA phát hiện được trong quá trình điều trị, nhà lâm sàng cần cố gắng xác định nguyên nhân không đáp ứng và xác định mục tiêu điều trị cần đạt được là ức chế hoàn toàn về mặt virus học (HIV RNA < 50 bản sao/mL). Bên cạnh việc cải thiện kết cục lâm sàng và miễn dịch học, chiến lược này

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

cũng sẽ ngăn ngừa chọn lọc thêm các đột biến để kháng với thuốc điều trị. Nếu đã giải quyết các vấn đề liên quan với tuân thủ thuốc điều trị và khả năng dung nạp với phác đồ điều trị thì cần thay đổi phác đồ điều trị càng sớm càng tốt. Mặt khác, có thể vẫn không đạt được việc đưa giá trị HIV RNA xuống dưới ngưỡng phát hiện ở những bệnh nhân có tiền sử điều trị đã lâu. Mục tiêu chính ở những bệnh nhân này là ức chế được một phần HIV RNA xuống dưới mức trước điều trị để bảo tồn chức năng miễn dịch và ngăn ngừa tiến triển lâm sàng.

C. **Xét nghiệm đánh giá tình trạng đề kháng của virus với thuốc điều trị và lựa chọn thuốc điều trị kháng retrovirus mới:** Các thử nghiệm xác định kiểu gen tìm đặc điểm trình tự các nucleotide của thành phần enzyme sao chép ngược/protease của virus và phát hiện các đột biến đề kháng liên quan với các thuốc khác nhau. Các thử nghiệm xác định kiểu hình với thử để virus phát triển khi có mặt các thuốc điều trị, nhằm cung cấp một thông số đo lường trực quan hơn về tình trạng đề kháng với thuốc điều trị của virus (tương tự như cách làm đối với vi khuẩn). Khi so sánh với các thử nghiệm kiểu hình, các thử nghiệm kiểu gen cho kết quả nhanh hơn (sau 1-2 tuần đối với thử nghiệm kiểu gen so với 2-4 tuần đối với thử nghiệm kiểu hình), rẻ tiền hơn (400 đô la so với 1000 đô la) và có ít biến thiên giữa các phòng xét nghiệm hơn. Tuy nhiên, các đột biến không phải lúc nào cũng tương quan với tình trạng đề kháng của virus và kết quả thường khó phiên giải.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.6. Xử trí đối với tình trạng thất bại điều trị thuốc chống retrovirus

Loại thất bại	Tiếp cận được khuyến cáo	Bình luận
Thất bại virus học *Mức độ hạn chế hoặc* *trung gian* *trước điều trị*	Đánh giá sự tuân thủ điều trị và khả năng dung nạp với phác đồ điều trị. Làm xét nghiệm kiểu gen để đánh giá tình trạng đề kháng thuốc của virus. Chọn phác đồ mới dựa trên kết quả xét nghiệm đánh giá tình trạng đề kháng của virus và khả năng dung nạp.	Thường kết hợp với tình trạng đề kháng của virus ở mức hạn chế hoặc không phát hiện được. Nếu không thấy có tình trạng đề kháng, xem xét làm lại xét nghiệm đánh giá tình trạng đề kháng của virus sau khi dùng lại thuốc chống retrovirus 2-4 tuần. Ngừng các thuốc nhóm ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI) nếu phát hiện thấy có đề kháng. Nhiều khả năng ức chế được virus nếu bệnh nhân tuân thủ tốt điều trị.

Mức độ nhiều trước *điều trị*	Đánh giá sự tuân thủ điều trị và khả năng dung nạp phác đồ điều trị. Làm xét nghiệm đánh giá tình trạng để kháng thuốc của virus - xem xét đánh giá kiểu hình, "kiểu hình giả lập" hoặc kết hợp kiểu gen-kiểu hình nếu nhiều khả năng bệnh nhân có mức độ để kháng cao. Làm xét nghiệm tính hướng tế bào của virus (viral tropism) để đánh giá khả năng sử dụng thuốc đối kháng thụ thể CCR5. Lựa chọn phác đồ điều trị mới sử dụng ít nhất 2 thuốc mới có hoạt lực chống virus; nếu không có sẵn 2 thuốc mới có tác dụng để dùng cần tiếp tục duy trì phác đồ "ghìm chân" ("holding" regimen).	Ở những bệnh nhân có tình trạng để kháng với các thuốc điều trị retrovirus nhóm ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) loại nucleosid (NRTI). Thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleoside (NNRTI) và thuốc ức chế protease (PI), nói chung sử dụng một phác đồ mới phải bao gồm ít nhất: (1) một thuốc từ một nhóm thuốc mới (thuốc ức chế enzyme tích hợp, thuốc đối kháng thụ thể CCR5 hoặc thuốc ức chế hòa màng); (2) một thuốc ức chế protease tăng cường hoạt lực (boosted PI) có hoạt tính đối với virus để kháng (tipranavir hoặc darunavir); và (3) một hoặc hai thuốc thuộc nhóm ức chế enzym sao chép ngược loại nucleosid (NRTI), mà một trong các thuốc phải là 3TC hoặc FTC. Phác đồ "ghìm chân" luôn cần bao gồm 3TC hoặc FTC cộng với một thuốc ức chế protease (PI) tăng cường hoạt lực; không bao giờ nên dùng thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI).
HIV RNA có nồng độ thấp (50-1000 bản sao)	Đánh giá về tuân thủ điều trị, tương tác thuốc, bệnh lý gian phát, tiêm chủng gần đây. Tiến hành xét nghiệm lại sau 3-4 tuần.	Đối với một nồng độ virus trong máu mức độ thấp và sau đó không phát hiện được HIV RNA ("blip") không cần thiết phải thay đổi điều trị. Nếu liên tục phát hiện được HIV RNA ở mức > 500 bản sao/mL, cho làm xét nghiệm đánh giá tình trạng để kháng như được trình bày ở trên và điều trị tùy theo kết quả. Nếu thường xuyên phát hiện được HIV RNA ở mức 50-500 bản sao/mL, xem xét phác đồ "điều trị tăng cường bằng cách dùng thêm một thuốc nữa".

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thất bại miễn dịch học *HIV RNA ở mức phát hiện được*	Đánh giá tuân thủ điều trị và khả năng dung nạp. Nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị, bắt đầu lại điều trị sau khi đã giải quyết được các rào cản tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị cần cho làm xét nghiệm đánh giá tình trạng để kháng và thay đổi điều trị như đã được trình bày ở trên.	Nếu HIV RNA quay về mức trước điều trị thì giải thích hợp lý nhất là bệnh nhân không tuân thủ điều trị.
Đã ức chế được HIV RNA	Thăm dò để phát hiện được các tình trạng có khả năng thay đổi được có liên quan với suy giảm đáp ứng của CD_4 (nhiễm virus viêm gan C mạn tính, điều trị bằng ZDV, TDF + ddI). Nếu không phát hiện được bất kỳ tình trạng nào có khả năng thay đổi được, cần tiếp tục phác đồ hiện đang dùng cho bệnh nhân.	Tiên lượng đối với các bệnh nhân đã ức chế được HIV RNA song có thất bại miễn dịch học tốt hơn so với những bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4 tương tự và phát hiện được virus huyết.
Thất bại lâm sàng *HIV RNA ở mức phát hiện được*	Điều trị các nhiễm trùng cơ hội bằng thuốc thích hợp. Đánh giá sự tuân thủ của bệnh nhân và khả năng dung nạp với thuốc chống retrovirus. Cho làm xét nghiệm đánh giá tình trạng để kháng và chọn phác đồ mới dựa trên kết quả xét nghiệm và các lựa chọn điều trị khác.	Nhiễm trùng cơ hội trừ hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (thường xảy ra nhất ở những người không duy trì thuốc chống retrovirus do kém tuân thủ điều trị và/hoặc kém dung nạp với phác đồ điều trị).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Đã ức chế được HIV RNA	Tiếp tục dùng thuốc chống retrovirus hiện đang dùng. Điều trị nhiễm trùng cơ hội bằng các thuốc chống nhiễm trùng thích hợp. Nếu triệu chứng vẫn tồn tại và có khả năng bị hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (IRIS), dùng bổ sung corticoid.	Nhiều khả năng là xảy ra hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (IRIS) khi số lượng tế bào CD_4 trước điều trị thấp (< 200/mm³); thường khởi phát sau khi bắt đầu dùng một phác đồ mạnh nhiều tuần đến nhiều tháng. Hội chứng này đã được báo cáo với hầu như tất cả các nhiễm trùng cơ hội. Tiến triển lâm sàng thực sự với HIV RNA đã bị ức chế hiếm gặp không được coi là bị hội chứng viêm do hồi phục miễn dịch là một dấu hiệu của thất bại điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

DỰ PHÒNG CÁC NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV (BẢNG 5.7, 5.8)

Những bệnh nhân bị bệnh HIV có nguy cơ mắc các biến chứng nhiễm trùng vốn không thấy ở bệnh nhân có miễn dịch khỏe mạnh. Những nhiễm trùng cơ hội này xảy ra một cách tương ứng với mức độ nặng của rối loạn chức năng hệ miễn dịch (được phản ánh bằng giảm số lượng tế bào CD_4). Trong khi những nhiễm trùng mắc phải từ cộng đồng (ví dụ: viêm phổi do phế cầu) có thể xuất hiện với bất kỳ số lượng tế bào CD_4 nào, các nhiễm trùng cơ hội liên quan HIV "cổ điển" (viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*, bệnh do Toxoplasma, nhiễm nấm Cryptococcus, nhiễm *M. avium* nội bào lan tỏa, nhiễm cytomegalovirus) chỉ xảy ra khi số lượng tế bào CD_4 giảm đáng kể. Cụ thể là hiếm khi gặp viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* ở bệnh nhân HIV có số lượng tế bào CD_4 > 200/mm³ và nhiễm CMV với nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào lan tỏa xảy ra khi giá trị trung vị của số lượng tế bào CD_4 < 50/mm³.

Bảng 5.7. Tổng quan về điều trị dự phòng (xem chi tiết Bảng 5.8)

Nhiễm trùng	Chỉ định	Can thiệp
Viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*	Số lượng $CD_4 < 200/mm^3$.	TMP–SMX.
Lao (*M. tuberculosis*)	Phản ứng Mantoux > 5 mm (hiện tại hay trước đây) hoặc tiếp xúc với ca bệnh lao tiến triển.	INH.
Nhiễm Toxoplasma	Kháng thể IgG(+) và số lượng $CD_4 < 100/mm^3$.	TMP–SMX.
Nhiễm *Mycobacterium avium* nội bào (MAI)	Số lượng $CD_4 < 50/mm^3$.	Azithromycin hoặc Clarithromycin.
Phế cầu (*S. pneumoniae*)	Số lượng $CD_4 > 200/mm^3$.	Vaccin phế cầu.
Viêm gan B (HBV)	Bệnh nhân có thể cảm nhiễm bệnh.	Vaccin viêm gan B.
Viêm gan A (HAV)	Nam có hoạt động tình dục đồng tính và lữ khách đến vùng bệnh lưu hành có HCV (+) và HA Ab (–); HCV (–) và HA Ab (–), bệnh gan mạn tính.	Vaccin viêm gan A.
Cúm	Tất cả bệnh nhân.	Vaccin cúm hàng năm Vaccin cúm lợn (H_1N_1).
Nhiễm virus thủy đậu (VZV)	Phơi nhiễm với thủy đậu hoặc zona; không có tiền sử trước đó.	Globulin miễn dịch đối với virus thủy đậu.

***Từ viết tắt*: Ab** (antibody): kháng thể; **HAV**(Hepatitis A virus): Virus viêm gan A; **HCV** (Hepatitis C virus): Virus viêm gan C; **VZV** (Varicella- zoster virus): Virus thủy đậu; các chữ viết tắt khác xem (trang 9).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.8. Dự phòng các nhiễm trùng cơ hội ở người nhiễm HIV

Nhiễm trùng	Các chỉ định và điều trị dự phòng	Bình luận
Viêm phổi do *P. (carinii) jiroveci* (PCP)	*Chỉ định:* CD_4 < 200/mm³, tưa miệng, các triệu chứng thể tạng hoặc có tiền sử viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci.* *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* TMP–SMX 1 viên liều kép (DS tablet) (uống) mỗi 24h/lần hoặc 1 viên liều đơn (SS tablet) (uống) mỗi 24h/lần. 1 viên liều kép (DS tablet) (uống) 3 lần x mỗi tuần cũng có hiệu quả, nhưng uống hàng ngày có thể có hiệu quả hơn một chút. *Điều trị dự phòng thay thế:* Dapson 100mg (uống) mỗi 24h/lần (được hầu hết các thầy thuốc ưu tiên lựa chọn như một thuốc điều trị tuyến 2; thuốc có hiệu quả hơn pentamidin khí dung khi số lượng tế bào CD_4 < 100) ***hoặc*** Atovaquon 1500 mg (uống) mỗi 24h/lần (hiệu quả tương tự như dapson và pentamidin khí dung; độc tính trên đường tiêu hóa cao hơn so với dapson nhưng ít gây phát ban hơn) ***hoặc*** Pentamidin khí dung 300mg qua bộ phun mù Respirgard II một lần mỗi tháng (trước đó cần loại trừ lao phổi tiến triển để tránh lây truyền trong bệnh viện).	Nếu không dự phòng 80% bệnh nhân AIDS xuất hiện viêm phổi do *P. (carinii) jiroveci* và 60-70% tái phát trong năm đầu sau đợt bệnh đầu tiên. Dự phòng bằng TMP-SMX cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh do Toxoplasma và các nhiễm khuẩn khác có thể gặp. Trong số bệnh nhân trước đó đã từng có phản ứng phụ song không đe dọa tính mạng khi dùng TMP-SMX, 55% có thể thành công khi thử dùng lại thuốc với viên liều đơn (SS tablet) một lần mỗi ngày và 80% có thể dùng lại với liều leo thanh dần bằng cách sử dụng TMP-SMX dạng bào chế cồn ngọt (8 mg TMP + 40 mg SMX/mL) được cho 1 mL x 3 ngày, sau đó 2 mL x 3 ngày rồi 5 mL x 3 ngày, sau đó 1 viên liều đơn (SS) (uống) mỗi 24h/lần. Các phác đồ dùng macrolid điều trị nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào (MAI) (azihromycin, clarithromycin) làm tăng thêm hiệu quả của điều trị dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci.* Có thể ngừng dự phòng tiên phát và thứ phát nếu số lượng tế bào CD_4 tăng > 200 tế bào/mm³ trong thời gian từ 3 tháng trở lên khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus (tức là có phục hồi miễn dịch). Cần bắt đầu lại điều trị dự phòng nếu số lượng tế bào CD_4 giảm < 200/mm³.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do Toxoplasma	*Chỉ định:* CD_4 < 100/mm³ với huyết thanh học đối với Toxoplasma (IgG) dương tính. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* TMP–SMX 1 viên liều kép (DS tablet) (uống) mỗi 24h/lần. *Điều trị dự phòng thay thế:* Dapson 50 mg (uống) mỗi 24h/lần + pyrimethamin 50mg (uống) hàng tuần + acid folinic 25mg (uống) hàng tuần ***hoặc*** Dapson 100 mg/pyrimethamin 50 mg x 2 lần mỗi tuần (không cần dùng acid folinic) ***hoặc*** Atovaquon 1500mg (uống) mỗi 24h/lần.	Tỷ lệ mắc bệnh do Toxoplasma ở bệnh nhân huyết thanh âm tính là quá thấp để cần phải điều trị dự phòng bằng thuốc. Có thể ngừng dự phòng tiên phát nếu số lượng tế bào CD_4 tăng > 200 tế bào/mm³ trong ít nhất 3 tháng khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus. Có thể ngừng dự phòng thứ phát (điều trị duy trì kéo dài) ở những bệnh nhân đáp ứng với điều trị ban đầu, không còn triệu chứng và số lượng tế bào CD_4 tăng > 200 tế bào/mm³ trong thời gian từ 6 tháng trở lên khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus. Cần bắt đầu lại điều trị dự phòng nếu số lượng tế bào CD_4 giảm < 200/mm³. Một số chuyên gia sẽ cho bệnh nhân chụp MRI não như một phần của quá trình đánh giá trước khi ngừng dự phòng thứ phát.
M. tuberculosis (Lao)	*Chỉ định:* Cục sần của test tuberculin da (PPD) ≥ 5 mm hoặc tiền sử có phản ứng mantoux dương tính mà không điều trị trước đó hoặc tiếp xúc gần với một ca bệnh lao tiến triển. Phải loại trừ bệnh lao tiến triển (bắt buộc phải chụp Xquang phổi). Được chỉ định ở bất kỳ số lượng tế bào CD_4 nào. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần x 9 tháng + pyridoxin 50mg (uống) mỗi 24 giờ x 9 tháng. *Điều trị dự phòng thay thế:* Rifampicin 600 mg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tháng + pyrazinamid 20mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x 2 tháng. Không nên dùng Rifampicin cho bệnh nhân đang uống thuốc điều trị HIV nhóm ức chế protease (PI).	Xem xét dự phòng cho những bệnh nhân có test tuberculin da âm tính khi xác suất phơi nhiễm lao trước đó > 10% (ví dụ: những bệnh nhân đến từ các nước đang phát triển, người lạm dụng thuốc tiêm chích tĩnh mạch ở một số thành phố của Hoa Kỳ, tù nhân). Tuy nhiên, một thử nghiệm khảo sát chiến lược này ở Hoa Kỳ đã không thấy có lợi ích đối với việc điều trị dự phòng theo kinh nghiệm. Điều trị dự phòng bằng INH làm chậm tiến triển đến AIDS và kéo dài cuộc sống ở quần thể đối tượng người Haiti có test tuberculin da dương tính được điều trị x 6 tháng. Rifampicin cộng với pyrazinamid x 2 tháng có hiệu quả trong một thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia (nhưng kết hợp này có thể làm tăng độc tính đối với gan). Rifabutin có thể dùng thay cho rifampicin trong những phác đồ có rifampicin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm khuẩn *Mycobacterium avium* nội bào (MAI)	*Chỉ định:* CD_4 < 50/mm³. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Azithromycin 1200 mg (uống) 1 lần mỗi tuần (số lượng viên ít nhất, ít tương tác thuốc nhất, có thể tăng hiệu quả cho điều trị dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* ***hoặc*** Clarithromycin 500mg (uống) mỗi 12h/lần (hiệu quả hơn so với rifabutin; kết hợp với các ưu điểm về tỉ lệ sống sót; tình trạng đề kháng được phát hiện ở một số trường hợp bệnh bùng phát) *Điều trị dự phòng thay thế:* Rifabutin (ít hiệu quả hơn). Xem lao (trang 326) để biết liều dùng.	Ưu tiên dùng macrolid (azithromycin, clarithromycin) hơn so với rifabutin. Ưu tiên lựa chọn azithromycin cho các bệnh nhân đang được điều trị thuốc ức chế protease (ít tương tác thuốc hơn). Có thể ngừng điều trị dự phòng tiên phát nếu số lượng tế bào CD_4 tăng > 100 tế bào/mm³ và ức chế được HIV RNA trong ít nhất 3-6 tháng hoặc lâu hơn khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus. Có thể ngừng điều trị dự phòng thứ phát đối với các trường hợp số lượng tế bào CD_4 tăng > 100 tế bào/mm³ x 6 tháng hoặc lâu hơn khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus nếu bệnh nhân đã hoàn thành 12 tháng điều trị nhiễm khuẩn Mycobacterium avium nội bào và không còn bằng chứng bệnh. Bắt đầu điều trị dự phòng nhiễm khuẩn Mycobacterium avium nội bào (MAI) trở lại trong trường hợp CD_4 < 100/mm³.
Phế cầu (*S. pneumoniae*)	*Chỉ định:* CD_4 > 200/mm³. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin polysaccharid phế cầu đa giá (23 valent)*. Tiêm nhắc lại vaccin x 1 sau 5 năm.	Tỷ lệ mắc bệnh phế cầu xâm lấn cao hơn > 100 lần ở bệnh nhân HIV. Hiệu quả của tiêm phòng vaccin thay đổi qua các nghiên cứu lâm sàng.
Cúm (cúm mùa ở người)	*Chỉ định:* Nói chung được khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin cúm (vaccin được bào chế từ toàn bộ và một phần virus bất hoạt).*	Tiêm hàng năm (tốt nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 1). Một số chuyên gia không cho tiêm vaccin nếu số lượng tế bào CD_4 < 100/mm³ (đáp ứng kháng thể kém). Vaccin mới được bào chế từ virus sống dùng trong mũi bị chống chỉ định ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan B (HBV)	*Chỉ định:* Tất cả bệnh nhân có thể nhiễm virus (kháng thể kháng HBc và kháng nguyên kháng HBs âm tính). *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin viêm gan B ADN tái tổ hợp*.	Tỷ lệ đáp ứng thấp hơn so với nhóm chứng HIV âm tính. Tiêm lại cả loạt nếu không đáp ứng, nhất là khi CD_4 thấp trong loạt tiêm khởi đầu và hiện tại số lượng CD_4 tăng lên.
Viêm gan A (HAV)	*Chỉ định:* Tất cả bệnh nhân có thể nhiễm virus đồng thời cũng là đối tượng có thể nhiễm virus viêm gan C; nam có hoạt động tình dục đồng tính huyết thanh âm tính dễ nhiễm virus viêm gan A hoặc các khách du lịch đến vùng có bệnh lưu hành; bệnh gan mạn tính; người dùng ma túy bất hợp pháp. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin viêm gan A.*	Tỷ lệ đáp ứng thấp hơn so với nhóm chứng HIV âm tính.
Sởi, Quai bị, Rubella	*Chỉ định:* Những bệnh nhân sinh sau năm 1957 và chưa bao giờ tiêm vaccin; những bệnh nhân tiêm vaccin trong những năm 1963-1967. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)*.	Một trường hợp duy nhất bị viêm phổi do chủng sởi trong vaccin ở người lớn bị suy giảm miễn dịch nặng sau khi tiêm vaccin phòng Sởi-Quai bị-Rubella. Vì vậy vaccin bị chống chỉ định ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng (CD_4 < 200).
H. influenzae	*Chỉ định:* Nói chung không khuyến cáo cho người lớn. *Điều trị dự phòng được ưu tiên lựa chọn:* Vaccin polysaccharid H. influenzae typ B*.	Tỷ lệ mắc bệnh *H. influenzae* tăng ở bệnh nhân HIV nhưng 65% được gây ra do các chủng virus cúm không phải typ B. Chưa rõ là vaccin có tác dụng bảo vệ hay không.
Vaccin cho người đi du lịch*	*Chỉ định:* Đi du lịch tới vùng có bệnh lưu hành.	Tất cả được coi là an toàn ngoại trừ các vaccin virus sống như bại liệt uống, sốt vàng và thương hàn uống bào chế bằng vi khuẩn sống.

** Cùng liều như khi dùng cho người bình thường (xem trang 606-609). Nếu có thể, tiêm vaccin sớm ở giai đoạn đầu nhiễm HIV khi hệ miễn dịch có thể vẫn còn có đáp ứng. Nếu không tiêm được sớm vaccin, để tăng cơ may có được đáp ứng ở bệnh nhân bị bệnh HIV tiến triển, có thể dùng vaccin sau 6-12 tháng điều trị thuốc chống retrovirus hiệu quả. Nên cho vaccin khi bệnh nhân ổn định về lâm sàng, không có bệnh cấp tính (ví dụ: cho dùng trong lần khám thường quy hơn là trong thời gian nằm viện do nhiễm trùng cơ hội). Các vaccin sống (ví dụ: bại liệt uống, thương hàn uống, sốt vàng) nói chung bị chống chỉ định nhưng vaccin sởi được dung nạp tốt ở trẻ em và vaccin dự phòng Sởi-Quai bị-Rubella (MMR) được khuyến cáo cho người lớn như đã trình bày ở trên.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ CÁC NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV

Các phác đồ điều trị thuốc chống retrovirus (ART) và điều trị dự phòng kháng sinh đặc hiệu đã giúp làm giảm đáng kể các nhiễm trùng cơ hội liên quan với HIV. Ngày nay, các nhiễm trùng cơ hội xuất hiện chủ yếu ở những bệnh nhân chưa được điều trị thuốc chống retrovirus (do nhiễm HIV chưa được chẩn đoán hoặc bệnh nhân không chấp nhận điều trị) hoặc trong giai đoạn sau khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus (do thiếu sự phục hồi miễn dịch hoặc từ đáp ứng viêm của một vật chủ vốn trước đó chưa có). Mặc dù có tỷ lệ thất bại cao về virus học trong thực hành lâm sàng, tỷ lệ nhiễm trùng cơ hội ở bệnh nhân tuân thủ điều trị thuốc chống retrovirus vẫn còn thấp, điều này có thể được giải thích là do bệnh nhân vẫn tiếp tục có đáp ứng miễn dịch cho dù bị thất bại về virus học, một hiện tượng có thể được kết nối với tình trạng suy giảm "sức khỏe" ("độc lực") của các chủng HIV để kháng thuốc. Đối với những bệnh nhân đang hoặc dùng không liên tục điều trị thuốc chống retrovirus, số lượng tuyệt đối tế bào CD_4 cung cấp một chỉ dấu tốt nhất cho nguy cơ nhiễm trùng cơ hội.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI ĐƯỜNG HÔ HẤP

Bệnh do nấm Aspergillus xâm lấn phổi

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Aspergillus fumigatus (hiếm khi do các loài nấm khác)	Voriconazol 400mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần × 2 ngày, sau đó 200mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần cho đến khi chữa khỏi (điển hình 6–18 tháng).	Amphotericin B 1 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần cho đến khi dùng đến tổng liều 2–3 g (thời gian điều trị tối ưu còn chưa được xác định rõ). ***hoặc*** Amphotericin dạng bào chế kết hợp với lipid (Abelcet hoặc Ambisome) 5 mg/kg/ngày (TM) cho đến khi chữa khỏi bệnh.

Biểu hiện lâm sàng: Đau ngực kiểu màng phổi, ho máu, ho ở bệnh nhân có bệnh HIV tiến triển. Các yếu tố nguy cơ bổ sung bao gồm giảm bạch cầu trung tính và sử dụng corticoid.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng soi phế quản có sinh thiết/nuôi cấy. Đôi khi cần sinh thiết phổi mở (thường là phẫu thuật nội soi lồng ngực có video trợ giúp). Hình ảnh điện quang bao gồm hình hang, nốt, đôi khi đông đặc thành ổ. Lan rộng tới hệ thần kinh trung ương có thể xảy ra và được biểu hiện bằng các thiếu sót thần kinh khu trú.

Lưu ý: Cấy đờm dương tính với Aspergillus trong bệnh HIV tiến triển cần được nâng mức cảnh giác về khả năng có nhiễm trùng.

Xem xét điều trị: Nếu có thể, cần giảm/ngừng corticosteroid. Nếu có tình trạng giảm bạch cầu trung tính, cần điều trị bằng yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt (granulocyte-colony stimulating factor [G-CSF]) để đạt được số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính > 1000/mm^3. Không có đủ dữ liệu để khuyến cáo điều trị ức chế hoặc duy trì lâu dài.

Tiên lượng: Tồi trừ khi có thể điều chỉnh được tình trạng khiếm khuyết miễn dịch.

Viêm phổi do vi khuẩn

Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Bình luận
Phế cầu (*Streptococcus pneumoniae*) (thường gặp nhất) *Haemophilus influenzae* *Pseudomonas aeruginosa*	**Đơn trị liệu với** Levofloxacin 750mg (uống/TM) mỗi 24 giờ hoặc Moxifloxacin 400mg (uống/TM) mỗi 24h/lần × 7–14 ngày, tùy thuộc vào mức độ nặng **hoặc điều trị kết hợp với** Ceftriaxon 1–2 g (TM) mỗi 24h/lần (hoặc Cefotaxim 1g [TM] mỗi 8h/lần) cộng với Azithromycin 500g mỗi 24h/lần ×7–14 ngày.	Đối với tình trạng suy giảm miễn dịch nặng (CD_4 < 100/mm^3), giảm bạch cầu trung tính hoặc tiền sử nhiễm pseudomonas trước đó, mở rộng mức bao phủ đến P. aeruginosa và các trực khuẩn Gram âm khác *bằng cách phối hợp thêm* Ceftazidim 1 g (TM) mỗi 8h/lần hoặc Cefepime 1 g (TM) mỗi 12h/lần hoặc Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc 400mg (TM) mỗi 8h/lần.

Biểu hiện lâm sàng: Những bệnh nhân nhiễm HIV bị viêm phổi vi khuẩn được biểu hiện tương tự như những bệnh nhân không bị HIV, với tình trạng bệnh tương đối cấp tính (qua nhiều ngày) và tình trạng này thường kết hợp với rét run, đau ngực kiểu màng phổi và đờm mủ. Những bệnh nhân có tình trạng bệnh qua trong nhiều tuần cho đến nhiều tháng sẽ nhiều khả năng bị viêm phổi do Pneumocystis (carinii) jiroveci, lao hoặc nhiễm nấm. Do viêm phổi vi khuẩn có thể xảy ra ở bất kỳ số lượng tế bào CD_4 nào, nhiễm trùng này

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

thường là triệu chứng biểu hiện của bệnh HIV, thúc đẩy việc xét nghiệm và chẩn đoán HIV.

Xem xét chẩn đoán: Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là *Streptococcus pneumoniae*, sau đó là *Haemophilus influenzae*. Hiếm gặp các tác nhân gây bệnh viêm phổi không điển hình (*Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae và Chlamydia pneumoniae*), kể cả khi mở rộng các xét nghiệm thăm dò thêm. Thâm nhiễm thùy trên phim Xquang phổi là một yếu tố dự đoán thêm cho viêm phổi vi khuẩn. Cần tiến hành cấy máu do bệnh nhân HIV có sự gia tăng tỷ lệ bị nhiễm khuẩn huyết khi so sánh với những bệnh nhân không bị nhiễm HIV.

Lưu ý: Nhuộm Gram và cấy đờm nói chung chỉ hữu ích nếu bệnh phẩm được làm trước khi bắt đầu dùng kháng sinh và chỉ khi có một tác nhân gây bệnh duy nhất chiếm ưu thế. Những bệnh nhân HIV bị viêm phổi vi khuẩn có thể hiếm khi có thêm một nhiễm trùng cơ hội bán cấp xảy ra đồng thời ví dụ: như viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* hoặc lao.

Xem xét điều trị: Ngay khi có cải thiện, chuyển sang điều trị đường uống nói chung là an toàn. Những bệnh nhân có bệnh HIV tiến triển là các đối tượng có nguy cơ cao hơn bị viêm phổi nhiễm khuẩn huyết (bacteremic pneumonia) do trực khuẩn Gram âm và nên điều trị bao vây theo kinh nghiệm đối với tình trạng này.

Tiên lượng: Đáp ứng với điều trị nói chung xuất hiện nhanh và tiên lượng chung tương đối tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi *Pneumocystis (carinii) jiroveci*
(viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*)

Phân loại bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nặng (pO_2 < 70 mmHg, gradient oxy động mạch-phế nang [A-a gradient] > 35)	TMP–SMX (5mg/kg TMP) (TM) mỗi 6h/lần × 21 ngày ***cộng với*** Prednison 40mg (uống) mỗi 12h/lần vào ngày 1–5, sau đó 40 mg (uống) mỗi 24h/lần vào ngày 6–10, sau đó 20mg (uống) mỗi 24h/lần vào ngày 11–21. Có thể thay methylprednisolon (TM) với liều bằng 75% liều prednison.	Pentamidin 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần (truyền trong ≥ 60 phút) × 21 ngày *cộng với* prednison × 21 ngày. (Giảm liều pentamidin xuống 3mg/kg [TM] mỗi 24h/lần có thể làm giảm độc tính) ***hoặc*** Primaquin 30mg (uống) mỗi 24h/lần × 21 ngày *cộng với* clindamycin 600mg (uống) mỗi 8h/lần × 21 ngày.
Bệnh nhẹ hoặc trung bình (pO_2 > 70 mmHg, gradient oxy động mạch-phế nang [A-a gradient] < 35)	TMP–SMX 2 viên hàm lượng kép (DS tablets) (uống) mỗi 6h/lần × 21 ngày.	Dapson 100 mg (uống) mỗi 24h/lần × 21 ngày *cộng với* TMP 5 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần× 21 ngày ***hoặc*** Primaquin 30mg (uống) mỗi 24h/lần × 21 ngày cộng với clindamycin 600mg (uống) mỗi 8h/lần × 21 ngày ***hoặc*** Atovaquone 750mg (uống) 12h/lần (với thức ăn) × 21 ngày.

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, ho, khó thở, bệnh thường biểu hiện âm thầm. Khám thực thể thường bình thường. Xquang phổi thay đổi, nhưng thường thấy có hình ảnh tổn thương kẽ lan tỏa. Tăng nồng độ LDH/tăng β-glucan và giảm độ bão hòa oxy khi vận động thể lực gợi ý nhiều đến viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm miễn dịch huỳnh quang mẫu đờm kích thích hoặc bệnh phẩm soi phế quản. Kiểm tra khí máu nếu độ bão hòa oxy bất thường hoặc có tăng tần số thở.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Thường thấy các triệu chứng tiến triển tối đi nhẹ sau khi bắt đầu điều trị, nhất là nếu không điều trị corticossteroid. Không được bỏ sót viêm phổi do vi khuẩn chồng thêm vào hoặc các nhiễm trùng thứ phát khác, nhất là trong khi đang dùng pentamidin. Những bệnh nhân điều trị dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* bằng các thuốc được chọn hạng hai, nhất là pentamidin khí dung, có thể có các biểu hiện Xquang phổi không điển hình bao gồm: thâm nhiễm vùng đỉnh; có nhiều nang thành mỏng; tràn dịch màng phổi; tràn khí màng phổi hoặc có một/nhiều nốt ở phổi.

Xem xét điều trị: Có thể điều trị ngoại trú khi bệnh nhẹ nhưng chỉ khi đảm bảo bệnh nhân được theo dõi sát. Các phản ứng bất lợi đối với TMP-SMX (phát ban, sốt, triệu chứng tiêu hóa, viêm gan, tăng kali máu, giảm bạch cầu, thiếu máu huyết tán) xảy ra ở 25-50% các bệnh nhân, nhiều bệnh nhân trong số này sẽ phải dùng phác đồ với các thuốc được chọn hàng thứ hai để điều trị cho đủ liệu trình (Vd: trimethoprim-dapson hoặc atovaquone). Trừ khi có các phản ứng bất lợi đặc biệt nặng với TMP–SMX (ví dụ: hội chứng Stevens-Johnson hoặc vấn đề đe dọa tính mạng khác), có thể xem xét dùng TMP–SMX để điều trị dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci*, do dự phòng cần liều thấp hơn nhiều (chỉ bằng 10–15% liều điều trị). Những bệnh nhân đang được điều trị viêm phổi nặng do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* bằng TMP-SMX song không thấy cải thiện sau 1 tuần có thể chuyển sang dùng pentamidin, mặc dù không có dữ liệu tiến cứu khẳng định cách tiếp cận này. Nói chung, những bệnh nhân đang điều trị thuốc chống retrovirus khi viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* xuất hiện nên tiếp tục điều trị họ đang sử dụng do điều trị thuốc chống retrovirus không liên tục có thể dẫn đến để kháng thuốc. Đối với những bệnh nhân HIV mới được chẩn đoán hoặc chưa từng dùng thuốc chống retrovirus, có thể hoàn tất điều trị viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci* trước khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus. Nên giảm dần liều steroid chứ không ngừng đột ngột. Dùng bổ sung steroid sẽ làm tăng nguy cơ bị tưa miệng/nhiễm trùng Herpes simplex nhưng có lẽ không làm tăng nguy cơ bị nhiễm cytomegalovirus, lao hoặc nhiễm nấm lan tỏa.

Tiên lượng: Thường đáp ứng với điều trị. Các yếu tố tiên lượng bất lợi bao gồm tăng gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang, giảm nồng độ oxy máu, tăng LDH.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lao phổi (đối với những chủng trực khuẩn lao phân lập được nhạy với INH và rifampin)

Tác nhân gây bệnh	Bệnh nhân KHÔNG dùng thuốc ức chế protease (PI) hoặc thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI)	Bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế protease (PI) hoặc thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI)
Mycobacterium tuberculosis (Lao)	Giai đoạn khởi đầu (8 tuần) INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Rifampin† 600mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Pyrazinamid (PZA) 25 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Ethambutol (EMB)15–20 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần. Giai đoạn kéo dài (18 tuần) INH 300 mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Rifampin† 600mg (uống) mỗi 24h/lần.	Giai đoạn khởi đầu (8 tuần) INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Rifabutin* ***cộng với*** PZA 25 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** EMB 15mg/kg (uống) mỗi 24h/lần × 8 tuần. Giai đoạn kéo dài (18 tuần) INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Rifabutin*.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Liều Rifabutin: Nếu thuốc ức chế protease (PI) là nelfinavir, indinavir, amprenavir hoặc fosamprenavir, liều rifabutin sẽ là 150mg (uống) mỗi 24h/lần. Nếu thuốc ức chế protease (PI) là ritonavir, lopinavir/ritonavir hoặc atazanavir, liều rifabutin sẽ là 150mg (uống) 2–3 lần mỗi tuần. Nếu thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI) là efavirenz liều rifabutin sẽ là 450mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc 600mg (uống) 2–3 lần mỗi tuần. Nếu thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleosid (NNRTI) là nevirapin liều rifabutin sẽ là 300 mg (uống) mỗi 24h/lần. Rifabutin* ***bị chống chỉ định*** *ở bệnh nhân đang dùng delavirdin, rilpivirine, etravirine + thuốc ức chế protease (PI) được tăng cường hiệu lực bằng ritonavir hoặc saquinavir dạng viên gel cứng. Những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế protease (PI) và thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) không phải nucleoside (NNRTI): như trên, ngoại trừ cần điều chỉnh liều rifabutin lên 300mg (uống) mỗi 24h/lần.*

† Đối với những bệnh nhân đang dùng phác đồ ba thuốc của nhóm thuốc ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcritase) loại nucleosid (NRTI), thay rifampicin bằng rifabutin 30 mg (uống) mỗi 24h/lần.

Biểu hiện lâm sàng: Có thể biểu hiện không điển hình. Những bệnh nhân HIV có số lượng tế bào CD_4 cao (> 500/mm^3) có nhiều khả năng sẽ có biểu hiện phổi điển hình, song những bệnh nhân có bệnh HIV tiến triển có thể có hình ảnh tổn thương kẽ lan tỏa, hạch rốn phổi to hoặc Xquang phổi bình thường. Test tuberculin da (phản ứng Mantoux) hữu ích nếu dương tính nhưng không đáng tin cậy nếu âm tính do tình trạng mất đáp ứng miễn dịch.

Xem xét chẩn đoán: Ở nhiều vùng đô thị, lao là một trong các bệnh lý hô hấp liên quan HIV thường gặp nhất. Ở những vùng khác, lao liên quan HIV không thường xuyên xảy ra ngoại trừ ở những người nhập cư hoặc những bệnh nhân đến từ những vùng có bệnh lao lưu hành cao. Luôn duy trì thái độ nghi vấn cao độ về khả năng bị lao ở bệnh nhân HIV có tình trạng sốt/thâm nhiễm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Lưu ý: Lao ngoài phổi và lao phổi thường cùng tồn tại, nhất là trong bệnh HIV tiến triển.

Xem xét điều trị: Điều trị bằng phác đồ được giám sát trực tiếp (DOT) được khuyến cáo mạnh cho tất cả các bệnh nhân HIV. Nếu bệnh nhân có bệnh tạo hang hoặc cấy đờm dương tính hoặc không có đáp ứng lâm sàng sau 2 tháng điều trị, tổng thời gian điều trị cần phải tăng lên thành 9 tháng. Nếu transaminase gan tăng cao (AST > 3 lần bình thường) trước khi bắt đầu điều trị, các lựa chọn điều trị bao gồm: (1) điều trị chuẩn và theo dõi thường xuyên; (2) rifamycin (rifampin hoặc rifabutin) + Ethambutol (EMB) + Pyrazinamid (PZA) trong 6 tháng; hoặc (3) INH + rifamycin + EMB trong 2 tháng, sau đó INH + rifamycin trong 7 tháng. Không khuyến cáo áp dụng phác đồ rifapentine dùng một lần mỗi tuần cho bệnh nhân HIV. Hội chứng viêm sau phục hồi miễn dịch (IRIS) không quá nặng nề có thể được điều trị bằng các thuốc chống viêm không steroid; những trường hợp nặng cần điều trị bằng corticosteroid. Trong tất cả các trường hợp có biểu hiện hội chứng viêm sau phục hồi miễn dịch (IRIS), cần tiếp tục điều trị thuốc chống retrovirus nếu có thể được. Theo dõi cẩn thận các dấu hiệu ngộ độc rifabutin (đau khớp, viêm màng mạch nho, giảm bạch cầu).

Tiên lượng: Thường đáp ứng với điều trị. Tỷ lệ tái phát liên quan đến mức độ ức chế miễn dịch và nguy cơ phơi nhiễm với trực khuẩn lao tại địa phương của bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI Ở HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Viêm võng mạc do cytomegalovirus

Điều trị được ưu tiên chọn, Thời gian điều trị, Điều trị duy trì dài ngày	Điều trị thay thế	Các lựa chọn/vấn đề khác
Điều trị được ưu tiên lựa chọn đối với viêm võng mạc do cytomegalovirus Đối với những tổn thương đe dọa thị lực ngay lập tức Ganciclovir mảnh cấy nội nhãn + valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần trong 14–21 ngày, sau đó mỗi 24h/lần hàng ngày) Có thể dùng một liều ganciclovir trong dịch kính ngay sau khi chẩn đoán cho đến khi có thể đặt được mảnh cấy ganciclovir. Đối với những tổn thương nhỏ ngoại vi Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần × 14–21 ngày, sau đó 900mg (uống) mỗi 24h/lần.	*Điều trị thay thế đối với viêm võng mạc do cytomegalovirus* Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12 giờ × 14–21 ngày, sau đó 5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần. **hoặc** Ganciclovir 5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 14–21 ngày, sau đó valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần. **hoặc** Foscarnet 60mg/kg (TM) mỗi 8h/lần hoặc 90 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần × 14–21 ngày, sau đó 90–120 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần. **hoặc** Cidofovir 5mg/kg (TM) mỗi tuần× 2 tuần, sau đó 5mg/kg (TM) cách tuần + bổi phụ nước bằng dung dịch muối trước và sau điều trị cộng với probenecid 2g (uống) 3 giờ trước liều, sau đó 1g (uống) 2 giờ sau liều và 1g (uống) 8 giờ sau liều (tổng 4 g). Ghi chú: Nên tránh phác đồ này ở những bệnh nhân dị ứng với sulfamid do quá mẫn chéo với probenecid.	Lựa chọn điều trị ban đầu đối với viêm võng mạc do cytomegalo-virus cần điều chỉnh tùy từng cá nhân, dựa trên vị trí và mức độ nặng của tổn thương, mức độ suy giảm miễn dịch và các yếu tố khác như các thuốc dùng đồng thời và khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Điều trị khởi đầu ở các bệnh nhân bị viêm võng mạc, viêm thực quản, viêm đại tràng và viêm phổi do cytomegalovirus cần bao gồm cả việc bắt đầu và tối ưu hóa điều trị thuốc chống retrovirus. Ở những bệnh nhân bị bệnh thần kinh do cytomegalovirus, tình trạng bệnh khu trú có thể xảy ra do hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (IRIS), có thể cần thận trì hoãn tạm thời việc bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus cho đến khi có cải thiện lâm sàng. Có thể ngừng điều trị duy trì viêm võng mạc do cytomegalovirus một cách an toàn ở những bệnh nhân có bệnh không trong giai đoạn hoạt động và số lượng CD_4+ liên tục ổn định (>100 tế bào/mm^3 trong ≥ 3–6 tháng); nên hội chẩn với thầy thuốc chuyên khoa mắt. Những bệnh nhân bị viêm võng mạc do cytomegalovirus đã ngừng điều trị duy trì nên được khám mắt thường xuyên, tốt nhất là 3 tháng một lần để phát hiện sớm tình trạng tái phát hoặc viêm màng mạch nho sau phục hồi miễn dịch (immune recovery uveiitis [IRU]). Viêm màng mạch nho sau hồi phục miễn dịch (IRU) có thể xuất hiện trong bối cảnh bệnh nhân phục hồi miễn dịch. *Điều trị đối với viêm màng mạch nho sau hồi phục miễn dịch:* tiêm corticosteroid quanh nhãn cầu hoặc liệu trình steroid toàn thân ngắn ngày.
Điều trị duy trì kéo dài (dự phòng thứ phát) được ưu tiên lựa chọn đối với viêm võng mạc do cytomegalovirus Valganciclovir 900mg (uống) hàng ngày **hoặc** Ganciclovir cấy (có thể được thay sau 6–8 tháng nếu số lượng tế bào CD_4+ vẫn <100tế bào/µL) + valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24 giờ cho đến khi phục hồi miễn dịch.	*Điều trị duy trì kéo dài (dự phòng thứ phát) thay thế đối với viêm võng mạc do cytomegalovirus* Ganciclovir 5mg/kg TM 5–7 lần mỗi tuần **hoặc** Foscarnet 90–120mg/kg (TM) mỗi 24h/lần **hoặc** Cidofovir 5mg/kg (TM) cách tuần + bổi phụ nước bằng dung dịch nước muối và probenecid (như trên).	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não do cytomegalovirus

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Cytomegalovirus (CMV)	*Điều trị cấp tính* Ganciclovir (GCV) 5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần cho đến khi cải thiện triệu chứng (thường > 3 tuần). ***Đối với những trường hợp nặng***, xem xét điều trị cấp tính bằng Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần cộng với Foscarnet 90mg/kg (TM) mỗi 24h/lần cho đến khi có cải thiện. *Tiếp theo bằng điều trị ức chế virus suốt đời* Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần.	*Điều trị cấp tính* Foscarnet 60mg/kg (TM) mỗi 8h/lần hoặc 90mg/kg (TM) mỗi 12h/lần ×3 tuần. *Tiếp theo bằng điều trị ức chế suốt đời* Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần.

Viêm võng mạc CMV

Biểu hiện lâm sàng: Nhìn mờ, ám điểm, thường gặp thị trường bị cắt hẹp lại. Thường hai bên, ngay cả khi triệu chứng ban đầu ở một bên.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng tình trạng viêm võng mạc xuất huyết đặc trưng (súp cà chua và sữa) khi soi đáy mắt. Hội chẩn chuyên khoa mắt đối với những trường hợp nghi ngờ.

Lưu ý: Có thể xuất hiện viêm dịch kính khi phục hồi miễn dịch sau khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus.

Xem xét điều trị: Valganciclovir dùng đường uống là lựa chọn ưu tiên cho điều trị ban đầu và điều trị duy trì. Cần điều trị duy trì suốt đời đối với viêm võng mạc do cytomegalovirus khi số lượng tế bào CD_4 <100/mm^3 nhưng có thể ngừng nếu số lượng tế bào CD_4 tăng lên > 100-150/mm^3 trong ít nhất 6 tháng khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus (cần hội chẩn với thầy thuốc chuyên khoa mắt). Các bệnh nhân bị viêm võng mạc do cytomegalovirus ngừng điều trị cần được khám mắt thường xuyên để theo dõi tái phát. Tấm ganciclovir cấy nội nhãn có thể cần phải thay sau 6-8 tháng cho những bệnh nhân vẫn bị suy giảm miễn dịch với số lượng tế bào CD_4 < 100-150/mm^3. Viêm màng mạch nho khi phục hồi miễn dịch (IRU) có thể xuất hiện trong bệnh cảnh phục hồi miễn dịch nhờ điều trị bằng thuốc chống retrovirus và do bác sĩ chuyên khoa mắt điều trị bằng tiêm corticosteroid quanh nhãn cầu, đôi khi cần phải dùng corticosteroid toàn thân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tiên lượng: Đáp ứng ban đầu tốt với điều trị. Tỷ lệ tái phát cao trừ khi điều trị thuốc chống retrovirus cải thiện được số lượng tế bào CD_4.

Viêm não do cytomegalovirus

Biểu hiện lâm sàng: Viêm não được biểu hiện bằng sốt, thay đổi tình trạng tinh thần và đau đầu tiến triển trong 1-2 tuần. Hiếm khi có dấu hiệu kích thích màng não. Viêm não do cytomegalovirus xảy ra trong bệnh HIV tiến triển (số lượng tế bào $CD_4 < 50/mm^3$), thường ở những bệnh nhân trước đó đã bị viêm võng mạc do cytomegalovirus. Viêm đa rễ thần kinh được biểu hiện bằng yếu cơ/rối loạn cảm giác tiến triển nhanh ở chi dưới, thường đi kèm với mất kiểm soát cơ tròn bàng quang/ruột. Mất cảm giác "phân bố kiểu yên ngựa" và có thể giảm trương lực cơ thất.

Xem xét chẩn đoán: Dịch não tủy có thể cho thấy có tăng tế bào bạch cầu lympho hoặc bạch cầu trung tính, nồng độ glucose thường giảm. Đối với viêm não do cytomegalovirus, những biểu hiện đặc trưng trên hình ảnh chụp MRI não bao gồm những bất thường quanh não thất hội tụ lại với mức độ tăng tín hiệu có thể thay đổi. Chẩn đoán được khẳng định bằng xét nghiệm theo kỹ thuật PCR tìm CMV trong dịch não tủy (xét nghiệm được ưu tiên chỉ định), nuôi cấy tìm CMV hoặc sinh thiết não.

Lưu ý: Đối với viêm não do cytomegalovirus, có thể gặp một phổ rộng các dấu hiệu về điện quang, kể cả tổn thương khối choán chỗ (hiếm gặp). Tiến hành đánh giá về nhãn khoa để loại trừ viêm võng mạc tiến triển. Đối với viêm đa rễ thần kinh, tiến hành chụp cộng hưởng từ tủy sống theo trục đứng dọc để loại trừ tổn thương khối choán chỗ và làm tế bào học dịch não tủy để loại trừ tình trạng xâm lấn trong u lympho (có thể gây các triệu chứng tương tự).

Xem xét điều trị: Đối với bất kỳ bệnh do cytomegalovirus nào đã xác định, tối ưu hóa điều trị thuốc chống retrovirus là quan trọng cùng với việc bắt đầu điều trị thuốc kháng cytomegalovirus. Ganciclovir cộng với foscarnet có thể là điều trị ban đầu có hiệu quả đối với những trường hợp nặng. Xem xét ngừng điều trị duy trì bằng valganciclovir nếu số lượng tế bào CD_4 tăng > 100–150/mm^3 × từ 6 tháng trở lên khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.

Tiên lượng: Trừ khi số lượng tế bào CD_4 tăng lên khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus, đáp ứng với điều trị kháng cytomegalovirus thường thoáng qua, được tiếp sau bằng tình trạng tiến triển triệu chứng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não Cryptococcus

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Cryptococcus neoformans	*Nhiễm nấm cấp tính (điều trị tấn công)* Amphotericin B 0,7mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ± flucytosin (5-FC) 25 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Dạng bào chế của Amphotericin kết hợp với lipid 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ± flucytosin (5-FC) 25mg/kg (uống) mỗi 6h/lần × 2 tuần. *Điều trị củng cố* Fluconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần × 8 tuần ***hoặc*** cho đến khi cấy dịch não tủy âm tính. *Điều trị duy trì kéo dài (dự phòng thứ phát)* Fluconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần.	*Nhiễm nấm cấp tính (điều trị tấn công)* Amphotericin B 0,7mg/kg/ngày (TM) × 2 tuần ***hoặc*** Fluconazol 400–800mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần × 6 tuần (đối với các tình trạng bệnh ít nặng) ***hoặc*** Fluconazol 400–800mg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần cộng với flucytosin (5-FC) 25 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần × 4–6 tuần. *Điều trị củng cố* Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 8 tuần hoặc cho đến khi cấy dịch não tủy âm tính. *Điều trị duy trì kéo dài* Itraconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần nếu không dung nạp được với fluconazol hoặc điều trị fluconazol thất bại.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Thường khởi phát âm thầm với sốt, đau đầu, thiếu sót nhận thức kín đáo. Đôi khi có dấu hiệu màng não và dấu hiệu thần kinh khu trú, mặc dù biểu hiện không đặc hiệu rất thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán thường bằng kháng nguyên Cryptococcus, xét nghiệm nhuộm mực tàu dịch não tủy kém nhạy. Chẩn đoán gần như được loại trừ chắc chắn nếu xét nghiệm tìm kháng nguyên Cryptococcus huyết thanh âm tính (độ nhạy của xét nghiệm này ở bệnh nhân bị AIDS lên tới gần 100%). Nếu kháng nguyên Cryptococcus huyết thanh dương tính, tìm kháng nguyên trong dịch não tủy có thể âm tính khi bệnh lan tỏa song không lan tràn đến hệ thần kinh trung ương/màng não. Hình ảnh học não thường là bình thường nhưng kết quả phân tích dịch não tủy thường có bất thường với tăng áp lực rõ.

Lưu ý: Cần đảm bảo có được áp lực dịch não tủy mở do việc làm giảm tình trạng tăng áp lực nội sọ rất quan trọng để điều trị thành công. Lấy bỏ đủ dịch não tủy trong lần chọc dịch não tủy đầu tiên để làm giảm áp lực đóng xuống < 200 mm H_2O hoặc 50% áp lực mở. Tăng áp lực nội sọ đòi hỏi phải chọc lại dịch não tủy hàng ngày cho đến khi áp lực dịch não tủy ổn định; áp lực nội sọ tăng cao bền bỉ đòi hỏi phải đặt ngay shunt dẫn lưu ống sống hoặc shunt não thất-ổ bụng. Không khuyến cáo điều trị bổ sung corticosteroid.

Xem xét điều trị: Tổng liều/tổng thời gian điều trị tối ưu bằng amphotericin B trước khi chuyển sang dùng fluconazol còn chưa rõ (2-3 tuần là hợp lý nếu bệnh nhân tiến triển tốt). Điều trị bằng 5-FC là một lựa chọn khác; tuy nhiên, do 5-FC được kết hợp với tình trạng sạch vi sinh vật trong dịch não tủy nhanh hơn, vì vậy một điều hợp lý là bắt đầu điều trị bằng 5-FC và rồi ngừng thuốc nếu xuất hiện độc tính của thuốc (giảm bạch cầu trung tính, buồn nôn). Fluconazol được ưu tiên chọn dùng hơn itraconazol để điều trị duy trì suốt đời bệnh nhân. Xem xét ngừng điều trị duy trì kéo dài ở bệnh nhân vẫn không có triệu chứng với số lượng tế bào CD_4 > 100-200/mm^3 trong > 6 tháng do điều trị bằng thuốc chống retrovirus.

Tiên lượng: Thay đổi. Tỷ lệ tử vong lên đến 40%. Các yếu tố tiên lượng bất lợi khác bao gồm tăng áp lực nội sọ, có tình trạng tinh thần bất thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh não đa ổ tiến triển (Progressive Multifocal Encephalopathy [PML])

Tác nhân gây bệnh	Điều trị
Tái hoạt papovavirus tiềm tàng (chủng JC hay gặp nhất).	Điều trị thuốc kháng retrovirrus hiệu quả làm phục hồi miễn dịch.

Biểu hiện lâm sàng: Yếu nửa người, thất điều, thất ngôn, các khuyết tổn thần kinh khu trú khác và các biểu hiện nói trên có thể tiến triển qua nhiều tuần đến nhiều tháng. Bệnh nhân thường vẫn còn tỉnh táo không có đau đầu hoặc co giật khi đến khám.

Xem xét chẩn đoán: Bệnh mất myelin (demyelinating disease) do tái hoạt động của virus papovavirus tiềm tàng (chủng JC thường gặp nhất). Chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng và kết quả chụp cộng hưởng từ não cho thấy có mất myelin từng mảng ở chất trắng ± tiểu não/thân não. Chỉ định làm PCR tìm virus JC trong dịch não tủy hữu ích như một biện pháp chẩn đoán không xâm nhập. Trong trường hợp biểu hiện lâm sàng không điển hình hoặc lẫn lộn với các bệnh lý khác, có thể cần tiến hành sinh thiết để phân biệt giữa bệnh não đa ổ

tiến triển (PML) với các nhiễm trùng cơ hội khác, u lympho hệ thần kinh trung ương hoặc viêm não/bệnh não do HIV.

Lưu ý: Bệnh não tiên phát liên quan với HIV có hình ảnh biểu hiện tương tự trên chụp cộng hưởng từ não.

Xem xét điều trị: Điều trị hiệu quả nhất là điều trị thuốc chống retrovirus với sự phục hồi miễn dịch. Một số bệnh nhân có các triệu chứng thần kinh xấu đi ngay khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus do tình trạng viêm gây ra bởi sự phục hồi miễn dịch. Nên tiếp tục điều trị thuốc chống retrovirus và xem xét bổ sung thêm steroid. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã tiến hành đánh giá cidofovir và vidarabine cho thấy cả hai thuốc này không có hiệu quả cũng như không được khuyến cáo áp dụng cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Các thiếu sót thần kinh tiến triển nhanh qua nhiều tuần đến nhiều tháng thường gặp. Cơ hội sống sót tốt nhất là sự phục hồi miễn dịch đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus mặc dù một số bệnh nhân sẽ có bệnh tiến triển ngay cả khi có phục hồi miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não Toxoplasma

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Toxoplasma gondii	*Điều trị cấp tính (x 6-8 tuần cho đến khi có đáp ứng tốt trên lâm sàng)* Pyrimethamin 200mg (uống) × 1 liều, sau đó 50mg (<60kg thể trọng) hoặc 75 mg (> 60 kg) (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Sulfadiazin 1000mg (< 60 kg) hoặc 1500mg (> 60 kg) (uống) mỗi 6h/lần ***cộng với*** Leucovorin 10–25mg (uống) mỗi 24h/lần. *Đối với bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng không thể uống thuốc được*, điều trị bằng TMP–SMX (5 mg/kg TMP và 25 mg/kg SMX) (TM) mỗi 12h/lần.	*Điều trị cấp tính (x 6-8 tuần cho đến khi có đáp ứng tốt trên lâm sàng)* Pyrimethamin 200mg (uống) × 1 liều, sau đó 50 mg (< 60 kg thể trạng) hoặc 75 mg (> 60 kg) (uống) mỗi 24h/lần cộng với clindamycin 600mg (TM hoặc uống) mỗi 6 giờ cộng với leucovorin 10mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** TMP–SMX (5 mg/kg TMP (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần. ***hoặc*** Atovaquone 1500mg (uống) mỗi 12h/lần (cùng với bữa ăn hoặc bổ sung chất dinh dưỡng) cộng với pyrimethamin (như trên) ***hoặc*** Atovaquone 1500 mg (uống) mỗi 12h/lần (cùng bữa ăn hoặc bổ sung chất dinh dưỡng) cộng với sulfadiazin 1000-1500mg (uống) mỗi 6h/lần. ***hoặc*** Atovaquone 1500 mg (uống) mỗi 12h/lần (cùng bữa ăn) **hoặc** Pyrimethamin (xem ở trên) cộng với leucovorin 10mg (uống) mỗi 24h/lần cộng với azithromycin 900–1200mg (uống) mỗi 24h/lần.
	Tiếp theo điều trị ức chế kéo dài suốt đời Sulfadiazin 500–1000mg (uống) mỗi 6h/lần ***cộng với*** Pyrimethamin 50mg (uống) mỗi 24h/lần ***cộng với*** Leucovorin 10–25mg (uống) mỗi 24h/lần.	*Điều trị ức chế kéo dài suốt đời* Clindamycin 600mg (uống) mỗi 8h/lần cộng với pyrimethamin 50mg (uống) mỗi 24h/lần cộng với leucovorin 10–25mg (uống) mỗi 24h/lần (phác đồ lựa chọn hàng thứ 2) ***hoặc*** Atovaquone 750mg (uống) mỗi 12h/lần ± pyrimethamin 25mg (uống) mỗi 24h/lần và leucovorin 10mg (uống) mỗi 24h/lần (phác đồ lựa chọn hàng thứ 3).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Phổ rộng các triệu chứng thần kinh, bao gồm các thiếu sót vận động-cảm giác, co giật, lú lẫn, thất điều, sốt/đau đầu thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng hình ảnh điện quang đặc trưng và đáp ứng với điều trị theo kinh nghiệm ở một bệnh nhân có huyết thanh chẩn đoán *T. gondii* dương tính.

Lưu ý: Dùng leucovorin (folinic acid) 10mg (uống) hàng ngày với các phác đồ có sử dụng pyrimethamin, không dùng folat/acid folic. Cải thiện hình ảnh Xquang có thể xuất hiện chậm hơn sau khi có đáp ứng lâm sàng.

Xem xét điều trị: Các thuốc thay thế bao gồm atovaquone, azithromycin, clarithromycin, minocyclin (đều dùng cùng với pyrimethamin nếu có thể được). Decadron 4mg (uống hoặc TM) mỗi 6h/lần hữu ích để điều trị đối với tình trạng phù não/hiệu ứng khối choán chỗ. Có thể ngừng điều trị ức chế kéo dài nếu bệnh nhân không còn các dấu hiệu và triệu chứng bệnh và có số lượng tế bào CD_4 > 200/mm^3 trong > 6 tháng nhờ điều trị bằng thuốc chống retrovirus.

Tiên lượng: Thường đáp ứng với điều trị nếu bệnh nhân có thể dung nạp được với thuốc. Đáp ứng lâm sàng được thấy rõ sau 1 tuần ở 70%, sau 2 tuần ở 90% các bệnh nhân. Cải thiện hình ảnh điện quang thường được thấy rõ sau 2 tuần. Hồi phục thần kinh không có thể thay đổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Viêm ruột do Campylobacter (*C. jejuni*)

Phân loại	Điều trị được ưu tiên lựa chọn
Bệnh nhẹ	Có thể chưa cần phải điều trị trừ khi triệu chứng kéo dài trong vài ngày.
Bệnh trung bình	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 1 tuần ***hoặc*** Azithromycin 500 mg (uống) mỗi 24h/lần × 1 tuần.
Có vi khuẩn trong máu	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần*. ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) mỗi 24h/lần × 2 tuần*.

** Cân nhắc phối hợp thêm aminoglycosid cho các bệnh nhân có vi khuẩn trong máu.*

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy khởi phát cấp tính, đôi khi có máu, các triệu chứng thể tạng có thể nổi trội.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy phân; tình trạng có vi khuẩn trong máu (bacteremia) có thể hiếm khi xảy ra, song vẫn nên chỉ định cấy máu. Nghi ngờ nhiễm khuẩn do campylobacter ở bệnh nhân AIDS có ỉa chảy và cấy máu thấy có trực khuẩn gram Âm cong. Những chủng không phải Jejuni có thể liên quan nhiều hơn với tình trạng nhiễm khuẩn huyết.

Xem xét điều trị: Điều trị tối ưu vẫn còn chưa được xác định rõ. Điều trị bằng quinolon hoặc azithromycin, thay đổi điều trị được dựa trên xét nghiệm đánh giá mức độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh. Tình trạng kháng với quinolon có thể xảy ra và tương quan với thất bại điều trị. Vai trò của aminoglycosid còn chưa rõ.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào tình trạng miễn dịch nền, tiên lượng nhìn chung là tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ỉa chảy/viêm đại tràng do *Clostridium difficile*

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
C. difficile	Metronidazol 500mg (uống) mỗi 8h/lần × 10–14 ngày. Tránh dùng các kháng sinh khác liên quan đến C. difficle nếu có thể được.	Vancomycin 125mg (uống) mỗi 6h/lần ×10–14 ngày. Tránh dùng các kháng sinh khác liên quan đến *C.difficle* nếu có thể được.

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy và đau bụng xảy ra sau điều trị kháng sinh. Ỉa chảy có thể dưới dạng phân nước hoặc phân máu. Thuốc ức chế bơm proton làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong số các kháng sinh, clindamycin và các beta-lactam là nguyên nhân chịu trách nhiệm thường gặp nhất. Hiếm khi gặp do dùng aminoglycosid, linezolid, doxycyclin, TMP–SMX, các carbapenem, daptomycin, vancomycin.

Xem xét chẩn đoán: Nguyên nhân thường gặp nhất gây ỉa chảy nhiễm khuẩn trên bệnh nhân nhiễm HIV ở Hoa Kỳ. Ỉa chảy phân nước với độc tố *C. difficile* dương tính trong mẫu bệnh phẩm phân. Xét nghiệm độc tố *C. difficile* trong phân có đủ độ nhạy/độ đặc hiệu. Nếu dương tính, không cần xét nghiệm lại cho đến khi âm tính (tiêu chí là hết tình trạng tiêu chảy). Nếu âm tính, không cần xét nghiệm lại (làm lại xét nghiệm sẽ âm tính). Viêm đại tràng do *C. difficile* có thể khác biệt về mặt lâm sàng với ỉa chảy do *C. difficile* ở chỗ nhiệt độ > 49°C, tăng

số lượng bạch cầu, tăng tốc độ máu lắng và/hoặc đau bụng. Chủng *C. difficile* có độc tính mạnh gây dịch tại chỗ thuộc typ B1 (typ độc tố III) sinh ra một lượng độc tố A/B cao gấp 20 lần so với các chủng ít độc lực hơn.

Lưu ý: Ở bệnh nhân bị ỉa chảy do *C. difficile*, viêm đại tràng *C. difficile* được gợi ý khi bệnh nhân có tăng số lượng bạch cầu, tăng tốc độ máu lắng, đau bụng và nhiệt độ > 49°C. Khẳng định chẩn đoán bằng chụp CT bụng cho thấy có dầy thành đại tràng. Các chủng *C. difficile* có độc lực mới có thể được biểu hiện bằng viêm đại tràng với nhiệt độ ≤ 49°C, ít/không có tăng số lượng bạch cầu và ít/không đau bụng. Khẳng định chẩn đoán bằng chụp CT/MRI bụng. Độc tố *C. difficile* có thể vẫn dương tính trong phân sau nhiều tuần điều trị. Không điều trị những trường hợp có độc tố dương tính trong phân trừ khi bệnh nhân có triệu chứng.

Xem xét điều trị: Khởi đầu điều trị đối với tình trạng bệnh nhẹ bằng metronidazol, các triệu chứng thường cải thiện trong vòng 2-3 ngày. Đối với các thể bệnh trung bình hoặc nặng hoặc có bằng chứng viêm đại tràng trên lâm sàng (tăng bạch cầu trung tính, sốt, dày đại tràng trên chụp cắt lớp vi tính), vancomycin trở thành một thuốc được ưu tiên lựa chọn cho bệnh nhân ở nhiều trung tâm do quan ngại về khả năng bị nhiễm các chủng có độc lực cao hơn và dựa trên kết quả của những nghiên cứu quan sát gợi ý vancomycin có hiệu quả hơn. Thời gian điều trị cần kéo dài trên 14 ngày nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục phải dùng các kháng sinh toàn thân khác. Tái phát xảy ra ở 10-25% bệnh nhân và tỷ lệ này có thể cao hơn ở bệnh nhân nhiễm HIV do nhu cầu thường xuyên phải điều trị bằng các kháng sinh khác. Có thể điều trị những lần tái phát đầu tiên bằng cách dùng nhắc lại phác đồ metronidazol hoặc vancomycin ban đầu. Đối với các bệnh nhân bị tái phát nhiều lần, giảm dần liều trong thời gian dài là phù hợp: tuần 1–125mg 4x/ngày; tuần 2–125mg 2x/ngày; tuần 3–125mg một lần mỗi ngày; tuần 4–125 mg cách ngày; tuần 5 và 6–125mg 3 ngày một lần. Cần cố gắng quay lại chế độ ăn bình thường và tránh các điều trị bằng các kháng sinh khác. Điều trị lợi khuẩn (chẳng hạn như lactobacillus hoặc Saccharomyces boulardii) chưa được chứng minh là sẽ làm giảm nguy cơ tái phát trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng.

Tiên lượng: Tiên lượng đối với viêm đại tràng do *C. difficile* liên quan đến mức độ nặng của viêm đại tràng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm thực quản/viêm đại tràng do Cytomegalovirus

Nhiễm trùng	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Nhiễm trùng khởi đầu	Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 3–4 tuần hoặc cho đến khi hết các dấu hiệu và triệu chứng. ***hoặc*** Có thể dùng Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 12h/lần nếu bệnh nhân dung nạp được đường uống. Nói chung không cần thiết phải điều trị duy trì nhưng nên xem xét sau khi bị tái phát.	Foscarnet 90mg/kg (TM) mỗi 12h/lần x 3–4 tuần hoặc cho đến khi giải quyết hết các dấu hiệu và triệu chứng ***hoặc*** Cidofovir 5mg/kg (TM) cách tuần với bổi phụ nước bằng dung dịch muối và probenecid (***xem viêm võng mạc do cytomegalovirus***).
Tái phát	Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần dùng không có hạn định thời gian; xem xét ngừng nếu số lượng tế bào CD_4 > 200/mm³ trong ≥ 6 tháng điều trị thuốc chống retrovirus.	

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng khu trú bao gồm nuốt đau, đau bụng, ỉa chảy, đôi khi phân có máu.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách phát hiện thể vùi của CMV trên bệnh phẩm sinh thiết. Cytomegalovirus có thể tác động tới toàn bộ đường tiêu hóa, gây nên loét miệng/thực quản, viêm dạ dày và viêm đại tràng (thường gặp nhất). Viêm đại tràng do Cytomegalovirus rất thay đổi về mức độ nặng nhưng điển hình sẽ có biểu hiện sốt, đau quặn bụng và đôi khi phân có máu.

Lưu ý: Viêm đại tràng do Cytomegalovirus có thể gây thủng đại tràng và nên nghĩ tới chẩn đoán này khi bệnh nhân AIDS đến khám vì tình trạng bụng cấp tính, nhất là khi kết quả Xquang bụng cho thấy có khí tự do trong khoang phúc mạc.

Xem xét điều trị: Thời gian điều trị tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng, thường là 3-4 tuần. Cân nhắc điều trị ức chế kéo dài đối với bệnh tái phát. Cần sàng lọc viêm võng mạc do cytomegalovirus.

Tiên lượng: Tỷ lệ tái phát giảm nhiều khi có phục hồi miễn dịch do điều trị thuốc chống retrovirus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm ruột do Cryptosporidium

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Cryptosporidium sp.	Điều trị thuốc chống retrovirus hữu hiệu với phục hồi miễn dịch đến mức số lượng tế bào CD_4 > 100/mm³ có thể dẫn đến hết hoàn toàn triệu chứng và sạch nhiễm trùng.	Nitazoxanid 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 4–6 tuần ***hoặc*** Paromomycin 1g (uống) mỗi 12h/lần × 2-4 tuần.

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy phân nước số lượng nhiều gây sút cân và rối loạn điện giải, nhất là với bệnh HIV giai đoạn tiến triển.

Xem xét chẩn đoán: Sinh vật đơn bào sinh bào tử. Chẩn đoán bằng làm phiến đồ phân nhuộm tìm trực khuẩn kháng acid (AFB) cho thấy có noãn nang đặc trưng. Tình trạng kém hấp thu có thể xảy ra.

Lưu ý: Không có bạch cầu trong phân; không nhìn thấy vi sinh vật khi xét nghiệm soi tìm trứng và kí sinh trùng thông thường (cần yêu cầu nhuộm đặc biệt).

Xem xét điều trị: Các báo cáo không chính thống cho thấy điều trị kháng sinh mang lại thành công điều trị. Thuốc mới nhất là nitazoxanid có thể có hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn của nitazoxanid không tăng nếu số lượng tế bào CD_4 < 50/mm³. Phục hồi tình trạng miễn dịch khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus là điều trị hiệu quả nhất và có thể gây ra được một đợt lui bệnh kéo dài và chữa khỏi. Các thuốc chống tiêu chảy (Lomotil, Pepto-Bismol) hữu ích để kiểm soát triệu chứng. Có thể cần phải tăng cường nuôi dưỡng cho những trường hợp nặng.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ ức chế miễn dịch/đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm ruột do Isospora (*Isospora belli*)

Phân loại	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Nhiễm trùng cấp tính	TMP 160mg và SMX 800mg (TM hoặc uống) mỗi 6h/lần × 10 ngày. ***hoặc*** TMP 320mg và SMX 1600mg (TM hoặc uống) mỗi 12h/lần × 10-14 ngày.	Pyrimethamin 50-75mg (uống) mỗi 24 giờ cộng với leucovorin 5-10mg (uống) mỗi 24h/lần. ***hoặc*** Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần hoặc các fluoroquinolon khác.
Điều trị duy trì mạn tính đối với số lượng tế bào CD_4 < 200 (dự phòng thứ phát)	TMP 320 mg cộng với SMX 1600mg (uống) mỗi 24h/lần *.	Pyrimethamin 25mg (uống) mỗi 2412h/lần cộng với leucovorin 5–10mg (uống) mỗi 24h/lần *.

** Có thể cân nhắc ngừng điều trị dự phòng thứ phát nếu số lượng tế bào CD_4 > 200/mm³ trong > 3 tháng.*

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy mạn tính không có sốt/xuất hiện bạch cầu trong phân.

Xem xét chẩn đoán: Sinh vật đơn bào sinh bào tử (Isosopra belli). Noãn nang trên phiến đồ phân nhuộm tìm trực khuẩn ưa acid lớn hơn so với cryptosporidium (20–30 microns so với 4–6 microns). Thường gặp hơn ở bệnh nhân nhiễm HIV từ vùng nhiệt đới (ví dụ: Haiti). Ít gặp hơn cryptosporidium hoặc microsporidia. Tình trạng kém hấp thu có thể xảy ra.

Lưu ý: Có thể bị tái phát nhiều lần.

Xem xét điều trị: Có thể cần phải điều trị ức chế kéo dài nếu số lượng tế bào CD_4 không tăng.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ ức chế miễn dịch/đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.

Bình luận: Phục hồi miễn dịch với điều trị thuốc chống retrovirus dẫn đến ít bị các đợt tái phát hơn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm ruột do Microsporidia

Tác nhân gây bệnh	Điều trị*
Microsporidia ngoài *Enterocytozoon bienuesi*	Albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần (tiếp tục cho đến khi số lượng tế bào CD_4 > 200/mm³).
Enterocytozoon bienuesi	Fumagillin 60mg (uống) mỗi 24h/lần (không có trên thị trường Hoa Kỳ).
Trachipleistophora hoặc Brachiola	Itraconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần cộng với albendazol 400mg (uống) mỗi 12h/lần .

** Bất kể do loài nào gây bệnh, điều trị thuốc chống retrovirus giúp phục hồi miễn dịch là một cấu thành điều trị quan trọng.*

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy mạn tính từng đợt không có sốt/bạch cầu trong phân.

Xem xét chẩn đoán: Sinh vật đơn bào sinh bào tử (*S. intestinalis, E. bieneusi*). Chẩn đoán bằng kỹ thuật nhuộm phân trichrome cải tiến hoặc nhuộm kháng thể huỳnh quang trong phân. Hiếm khi microsporidia có thể lan tràn đến các xoang/giác mạc. Tình trạng giảm hấp thu nặng có thể xảy ra.

Lưu ý: Microsporidia quá nhỏ để có thể phát hiện được qua soi phân thường quy.

Xem xét điều trị: Albendazol ít hiệu quả đối với *E. bieneusi* so với *S. intestinalis*, nhưng thường không thể phân định được loài kí sinh vật. Có thể xem xét ngừng điều trị đối với số lượng tế bào CD_4 < 200/mm³ nếu bệnh nhân vẫn không có triệu chứng (không có các dấu hiệu hoặc triệu chứng bệnh của microsporidia). Nếu có biểu hiện nhiễm trùng mắt, cần tiếp tục điều trị vô thời hạn cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ ức chế miễn dịch/đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do nhiễm Candida họng miệng/thực quản

Nhiễm trùng	Điều trị	Đề kháng với Fluconazol
Nhiễm Candida họng miệng (tưa miệng)	***Điều trị được ưu tiên lựa chon*** Fluconazol 100mg (uống) mỗi 24h/lần × 1-2 tuần. ***Điều trị thay thế*** Itraconazol dung dịch uống 200mg (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần hoặc Clotrimazol viên ngậm 10mg (uống) 5 lần/ngày x 1-2 tuần hoặc huyền dịch nystatin 4-6mL mỗi 6h/lần hoặc 1-2 viên ngậm 4-5 lần/ngày x 1-2 tuần.	Fluconazol ở mức liều lên đến 800mg (uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần ***hoặc*** Caspofungin 70mg (TM) vào ngày 1, sau đó 50mg (TM) mỗi 24h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** Micafungin 150mg (TM) mỗi 24h/lần × 1-2 tuần.
Nhiễm Candida thực quản	***Điều trị được ưu tiên lựa chọn*** Fluconazol 100mg (lên đến 400mg) (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần. ***Điều trị thay thế*** Itraconazol dung dịch uống 200mg (uống) mỗi 24h/lần × 2–3 tuần hoặc Voriconazol 200mg (uống) mỗi 24h/lần × 2–3 tuần hoặc Caspofungin 50mg (TM) mỗi 24h/lần × 2–3 tuần.	Amphotericin B 0,3mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 1-2 tuần ***hoặc*** Amphotericin dạng bào chế trong lipid 3–5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 1-2 tuần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tưa miệng (Candida)

Biểu hiện lâm sàng: Khó nuốt/nuốt đau. Thường gặp hơn/nặng hơn trong bệnh HIV tiến triển.

Xem xét chẩn đoán: Các thể giả (thường gặp nhất), hồng ban (erythematous form) và tăng sản (hyperplastic form) (bạch sản [leukoplakia]). Các giả mạc (mảng trắng trên nền viêm) ở niêm mạc má/lưỡi/lợi/màng khẩu cái cạo được dễ dàng còn tổn thương tăng sản thì không cạo hết được. Chẩn đoán bằng biểu hiện lâm sàng ± nhuộm KOH/Gram mẫu bệnh phẩm cạo từ tổn thương

thấy có nấm men/giả sợi nấm. Các tổn thương ở miệng khác trên bệnh nhân bị AIDS bao gồm Herpes simplex, loét miệng Áptơ, Sarcoma Kaposi, bạch sản lông ở miệng.

Lưu ý: Bệnh nhân có thể không có triệu chứng.

Xem xét điều trị: Fluconazol là thuốc tốt để điều trị tại chỗ trong ngăn ngừa tái phát tưa và điều trị viêm thực quản do Candida. Điều trị liên tục bằng fluconazol có thể dẫn đến tình trạng kháng fluconazol và khi xảy ra tình trạng này tốt nhất là điều trị ban đầu bằng huyền dịch itraconazol, nếu không có đáp ứng cần dùng caspofungin hoặc amphotericin đường tĩnh mạch. Thường chỉ xem xét điều trị duy trì kéo dài cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nặng.

Tiên lượng: Thường thấy có triệu chứng cải thiện trong vòng 24-48 giờ.

Viêm thực quản do Candida

Biểu hiện lâm sàng: Nuốt khó/nuốt đau, gần như luôn có trong bệnh cảnh tưa họng-miệng. Sốt không thường gặp.

Xem xét chẩn đoán: Là nguyên nhân phổ biến nhất của viêm thực quản trong bệnh HIV. Đối với các triệu chứng tiếp diễn dai dẳng mặc dù đã điều trị, khuyến cáo nội soi kèm theo sinh thiết/cấy để khẳng định chẩn đoán và đánh giá tình trạng kháng với azole của Candida.

Lưu ý: Tổn thương có thể lan xuống dạ dày. Các nguyên nhân thường gặp khác của viêm thực quản bao gồm cytomegalovirus, Herpes simplex và loét miệng Áp-tơ. Hiếm gặp là ung thư Kaposi, u lympho không Hodgkin, do dùng zidovudin, dideoxycytidin và các nhiễm trùng khác có thể gây các triệu chứng thực quản.

Xem xét điều trị: Điều trị toàn thân được ưu tiên lựa chọn hơn là điều trị tại chỗ. Không thấy có cải thiện khi điều trị theo kinh nghiệm đòi hỏi phải nội soi để tìm kiếm các nguyên nhân khác, nhất là do virus Herpes/loét miệng Áptơ. Xem xét điều trị duy trì bằng fluconazol cho những trường hợp tái phát thường xuyên mặc dù điều trị này làm tăng nguy cơ kháng với fluconazol. Điều trị ban đầu tình trạng kháng fluconazol tốt nhất bằng huyền dịch itraconazol và nếu không đáp ứng cần dùng caspofungin, micafungin hoặc amphotericin đường tĩnh mạch.

Tiên lượng: Tỉ lệ tái phát liên quan với mức độ suy giảm miễn dịch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm dạ dày ruột Salmonella (không typhi)

Phân loại	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Bệnh nhẹ	Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần × 1-2 tuần.	TMP–SMX 1 viên hàm lượng kép (DS tablet) (uống) mỗi 12h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Ceftriaxon 2g (TM) mỗi 24h/lần × 2 tuần ***hoặc*** Cefotaxim 1g (TM) mỗi 8h/lần × 2 tuần.
$CD_4 < 200$	Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần × 4-6 tuần.	
Có vi khuẩn trong máu	Ciprofloxacin 750mg (uống) mỗi 12h/lần × 4-6 tuần, sau đó 500mg (uống) mỗi 12h/lần không giới hạn thời gian.	

Biểu hiện lâm sàng: Các bệnh nhân nhiễm HIV có tăng rõ rệt nguy cơ bị nhiễm khuẩn do Salmonella. Có thể thấy ba biểu hiện: (1) Viêm dạ dày ruột tự khỏi, như được thấy điển hình ở các đối tượng có hệ miễn dịch lành mạnh; (2) Bệnh la chảy nặng hơn và kéo dài hơn, kèm theo sốt, la chảy phân máu và sút cân hoặc (3) Nhiễm khuẩn huyết do Salmonella có thể có hoặc không có biểu hiện triệu chứng dạ dày-ruột.

Xem xét chẩn đoán: Xác định được chẩn đoán qua cấy phân và cấy máu. Do có tỷ lệ cao xuất hiện tình trạng có vi khuẩn trong máu kết hợp với viêm dạ dày ruột do Salmonella, nhất là trong bệnh HIV giai đoạn tiến triển, cần cấy máu cho tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV có biểu hiện la chảy và sốt.

Lưu ý: Đặc điểm đặc trưng của tình trạng nhiễm khuẩn huyết do salmonella ở bệnh nhân AIDS là xu hướng rất dễ tái phát (tỷ lệ > 20%).

Xem xét điều trị: Điều trị chủ yếu là fluoroquinolon. Kinh nghiệm nhiều nhất là điều trị bằng ciprofloxacin nhưng những quinolon mới hơn (Vd: moxifloxacin, levofloxacin) cũng có thể có hiệu quả. Đối với bệnh do nhiễm salmonella không biến chứng ở bệnh nhân HIV có số lượng tế bào $CD_4 > 200/mm^3$, điều trị 1-2 tuần là hợp lý để làm giảm nguy cơ bệnh lan rộng ra ngoài ruột. Đối với các bệnh nhân bị bệnh HIV giai đoạn tiến triển (số lượng tế bào $CD_4 < 200/mm^3$) hoặc có vi khuẩn Salmonella trong máu, cần điều trị ít nhất 4-6 tuần. Điều trị duy trì kéo dài, cho thuốc trong vài tháng hoặc đến khi đảm bảo có phục hồi miễn dịch nhờ điều trị thuốc chống retrovirus được chỉ định cho các bệnh nhân bị tái phát sau khi ngừng điều trị. Xem xét sử dụng ZDV như một thành phần của phác đồ điều trị kháng retrovirus (ZDV có hoạt tính đối với Salmonella).

Tiên lượng: Thường đáp ứng tốt với điều trị. Tỷ lệ tái phát ở bệnh nhân AIDS có vi khuẩn trong máu là > 20%.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm ruột do Shigella (Shigella sp.)

Phân loại	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Không có vi khuẩn trong máu	Fluoroquinolon (TM hoặc uống) × 3–7 ngày.	TMP–SMX 1 viên hàm lượng kép (DS tablet) (uống) mỗi 12h/lần × 3-7 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) vào ngày 1, sau đó 250mg (uống) mỗi 24h/lần × 4 ngày.
Có vi khuẩn trong máu	Kéo dài thời gian điều trị đến 14 ngày.	Kéo dài thời gian điều trị đến 14 ngày.

Biểu hiện lâm sàng: Ỉa chảy phân máu/nhầy khởi phát cấp tính.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cách chứng minh có vi sinh vật trong mẫu bệnh phẩm phân. Ổ loét do shigella ở đại tràng có dạng vạch, ngoằn ngoèo, hiếm khi dẫn đến thủng đại tràng. Thường gặp hơn ở các nam hoạt động tình dục đồng tính.

Xem xét điều trị: Bệnh lỵ do shigella có tình trạng cấp tính/bùng phát hơn so với bệnh lỵ amip. Không có tình trạng người mang shigella như gặp trong nhiễm Entamoeba. Nhiễm khuẩn shigella mắc phải bên ngoài Mỹ có tỷ lệ kháng TMP-SMX cao. Chỉ định điều trị để rút ngắn thời gian bị bệnh và ngăn ngừa nhiễm khuẩn lan rộng.

Tiên lượng: Tốt nếu được điều trị sớm. Mức độ nặng của bệnh liên quan đến các chủng Shigella: *S. dysenteriae* (nặng nhất) > *S. flexneri* > *S. boydii/S. sonnei* (nhẹ nhất).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ CÁC NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI KHÁC TRONG HIV

Viêm âm đạo do Candida

Tác nhân gây bệnh	Điều trị
Candida albicans	Miconazol đặt âm đạo 200mg mỗi 24h/lần x 3 ngày ***hoặc*** miconazol 3% x 7 ngày ***hoặc*** Nystatin viên âm đạo 100.000U mỗi 24h/lần x14 ngày ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần x 1 ngày (hoặc 200mg mỗi 24h/lần x 3 ngày) ***hoặc*** Fluconazol 150mg (uống) x 1 liều.

Biểu hiện lâm sàng: Xuất tiết âm đạo màu trắng, mủn hoặc phát ban ± ngứa/đau vùng âm hộ. Nhiễm trùng tại chỗ không phải là một dấu hiệu của bệnh lan tỏa.

Xem xét chẩn đoán: Nhiễm trùng khu trú. Không phải là một biểu hiện của bệnh lan tỏa.

Lưu ý: Bệnh nhân nữ bị AIDS giai đoạn tiến triển đang dùng fluconazol có thể xuất hiện tình trạng Candida kháng fluconazol.

Xem xét điều trị: Đối với trường hợp tái phát, xem xét điều trị duy trì bằng fluconazol 100-200mg (uống) hàng tuần.

Tiên lượng: Đáp ứng tốt với điều trị. Tình trạng tái phát phổ biến.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm nấm Coccidioides (*C. immitis*)

Nhiễm trùng	Điều trị*
Không nhiễm trùng màng não	*Điều trị cấp tính (bệnh phổi lan tỏa hoặc bệnh lan tỏa)* Amphotericin B 0,5–1,0mg/kg (TM) mỗi 24h/lần cho đến khi cải thiện lâm sàng (thường tổng liều 500–1000mg). Một số chuyên gia phối hợp thêm một thuốc kháng nấm nhóm azole với điều trị amphotericin B. *Điều trị cấp tính (bệnh nhẹ hơn)* Fluconazol 400–800mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần . *Điều trị duy trì kéo dài (dự phòng thứ phát)* *Ưu tiên lựa chọn*: Fluconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần không giới hạn thời gian; *Điều trị thay thế*: Itraconazol 200mg viên nang (uống) mỗi 12h/lần không giới hạn thời gian.
Nhiễm trùng màng não*	*Điều trị cấp tính* Fluconazol 400–800mg (TM) hoặc (uống) mỗi 24h/lần. Amphotericin B tiêm trong ống sống nếu không có đáp ứng với điều trị bằng azole. *Điều trị duy trì kéo dài (dự phòng thứ phát)* Fluconazol 400mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc Itraconazol 200mg viên nang (uống) mỗi 12h/lần không giới hạn thời gian.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Nhiễm trùng màng não cần điều trị kéo dài suốt cuộc đời bệnh nhân bằng fluconazol 400-800mg mỗi 24h/lần. Chưa có đủ dữ liệu để khuyến cáo ngừng điều trị duy trì kéo dài trong những tình huống khác.*

Biểu hiện lâm sàng: Thường là một biến chứng của nhiễm HIV tiến triển (số lượng tế bào $CD_4 < 200/mm^3$). Phần lớn bệnh nhân có tình trạng bệnh lan tỏa, có thể biểu hiện bằng sốt, thâm nhiễm phổi lan tỏa, hạch to, tổn thương da (đa dạng – hột cơm, áp xe lạnh, loét, nốt) và/hoặc tổn thương xương. Khoảng 10% có biểu hiện lan rộng tới hệ thần kinh trung ương dưới dạng viêm màng não (sốt, đau đầu, thay đổi trạng thái tinh thần).

Xem xét chẩn đoán: Xem xét chẩn đoán này ở tất cả các bệnh nhân có tình trạng ức chế miễn dịch liên quan với nhiễm HIV giai đoạn tiến triển đã từng ở vùng có *C. immitis* lưu hành thành dịch địa phương (Tây Nam Hoa Kỳ, Bắc Mexico) và có biểu hiện hội chứng sốt toàn thể. Có thể chẩn đoán dựa trên cấy tìm vi sinh vật gây bệnh, quan sát thấy các tiểu cầu đặc trưng trên mô bệnh học

hoặc kháng thể cố định bổ thể dương tính (≥ 1:16). Trong những trường hợp có viêm màng não, các thông tin về phân tích dịch não tủy cho thấy nồng độ glucose thấp, protein cao và tăng tế bào bạch cầu lympho.

Lưu ý: Hiệu giá kháng thể thường âm tính khi khởi bệnh. Các thông tin về phân tích dịch não tủy của viêm màng não có thể tương tự như viêm màng não do lao.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của nhiễm trùng và mức độ ức chế miễn dịch. Đáp ứng lâm sàng có xu hướng xảy ra chậm, nhất là khi gánh nặng bệnh tật cao và bệnh HIV ở giai đoạn tiến triển nặng. Bệnh lý màng não cần được điều trị kéo dài suốt đời trừ khi có sự hồi phục số lượng tế bào CD_4.

Lao ngoài phổi

Tác nhân gây bệnh	Điều trị
Mycobacterium tuberculosis	**Điều trị như lao phổi *(xem trang 536)*. Có thể cần thời gian điều trị dài hơn dựa trên đáp ứng lâm sàng.**

Biểu hiện lâm sàng: Có thể có biểu hiện đa dạng (ví dụ: viêm hạch, viêm xương-tủy xương, viêm màng não, viêm gan). Tình trạng bệnh lan tỏa thường gặp hơn ở các bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4 thấp (< 100/mm^3).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng cấy máu ly giải-ly tâm (isolator blood cultures) hoặc sinh thiết mô.

Lưu ý: Những bệnh nhân có bệnh lan tỏa thường có bệnh phổi, điều này có ý nghĩa đối với kiểm soát nhiễm khuẩn.

Xem xét điều trị: Đáp ứng với điều trị có thể chậm hơn so với người có chức năng miễn dịch bình thường.

Tiên lượng: Thường đáp ứng với điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh do virus Herpes simplex (HSV)

Nhiễm trùng	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Tổn thương môi miệng hoặc nhiễm HSV sinh dục ban đầu/tái phát	Famciclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** valacyclovir 1 g (uống) mỗi 12h/lần × 1–2 tuần ***hoặc*** acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần × 1-2 tuần.	***HSV kháng với acyclovir*** Foscarnet 60-100mg/kg (TM) mỗi 12h/lần đến khi có đáp ứng lâm sàng ***hoặc*** Cidofovir 5 mg/kg (TM) hàng tuần đến khi có đáp ứng lâm sàng.
Nhiễm HSV da –niêm mạc từ vừa đến nặng	Điều trị khởi đầu: Acyclovir 5mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2–7 ngày. Nếu có cải thiện chuyển sang famciclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** valacyclovir 1g (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần đến khi hoàn tất liệu trình kéo dài 7–10 ngày.	***HSV kháng với acyclovir*** Foscarnet 60–100mg/kg (TM) mỗi 12h/lần đến khi có đáp ứng lâm sàng ***hoặc*** Cidofovir 5mg/kg (TM) hàng tuần đến khi có đáp ứng lâm sàng.
Viêm giác mạc do HSV	Trifluridin 1% dung dịch tra mắt, nhỏ một giọt vào giác mạc mỗi 2h/lần , không quá 9 giọt mỗi ngày và không kéo dài quá 21 ngày. Điều trị kết hợp với hội chẩn chuyên khoa mắt.	***HSV kháng với acyclovir*** Foscarnet 60–100mg/kg (TM) mỗi 12h/lần đến khi có đáp ứng lâm sàng ***hoặc*** Cidofovir 5 mg/kg (TM) hàng tuần đến khi có đáp ứng lâm sàng.
Viêm não do HSV	Acyclovir 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 2-3 tuần ***hoặc*** Valacyclovir 1 g (uống) mỗi 6h/lần × 2-3 tuần.	***HSV kháng với acyclovir*** Foscarnet 60–100 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần đến khi có đáp ứng lâm sàng hoặc Cidofovir 5 mg/kg (TM) hàng tuần đến khi có đáp ứng lâm sàng.
Tổn thương da niêm mạc nhiều lần tái phát (miệng hoặc hậu môn sinh dục) (điều trị duy trì kéo dài)	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Famciclovir 250 mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Valacyclovir 500 mg (uống) mỗi 12h/lần .	Bệnh nhân có thể điều chỉnh giảm liều để duy trì đáp ứng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Herpes simplex (sinh dục/miệng)

Biểu hiện lâm sàng: Mụn nước từng đám và đau trên nền ban đỏ sau đó vỡ ra, đóng vẩy và lành trong vòng 2 tuần. Tổn thương có thể loét, nặng, mạn tính khi tình trạng ức chế miễn dịch tiến triển.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nuôi cấy virus từ mẫu bệnh phẩm quệt ở đáy tổn thương/vỏ mụn phỏng nước; các kỹ thuật chẩn đoán thay thế bao gồm phiến đồ Tzanck hoặc nhuộm huỳnh quang miễn dịch.

Lưu ý: Không cần dự phòng bằng acyclovir ở bệnh nhân đang dùng ganciclovir hoặc foscarnet.

Xem xét điều trị: Trong những trường hợp dai dẳng khó điều trị, xem xét có tình trạng kháng với acyclovir và cần điều trị bằng foscarnet. Có thể cân nhắc dùng tại chỗ dung dịch tra mắt trifluridin (Viroptic 1%) nhỏ trực tiếp vào những vùng bị tổn thương dai dẳng có diện tích nhỏ, khu trú, làm sạch bằng nước oxy già, sau đó dùng gạc nhẹ nhàng lấy hết tổ chức tổn thương, tra trifluridin và bôi phủ mỡ bacitracin/polymyxin và gạc không hấp thu, cũng có thể thử dùng cidofovir tại chỗ. Điều trị duy trì kéo dài bằng acyclovir, famciclovir hoặc valacyclovir đường uống có thể được chỉ định cho những bệnh nhân bị tái phát thường xuyên, với liều tương tự như đối với bệnh nhân HIV âm tính.

Tiên lượng: Đáp ứng tốt với điều trị ngoại trừ bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng, ở những đối tượng này có thể xuất hiện tình trạng kháng với acyclovir. Tiên lượng đối với viêm màng não do HSV rất tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não do Herpes (HSV-1)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và thay đổi trạng thái tinh thần.

Xem xét chẩn đoán: Bất thường điện não đồ xảy ra sớm (< 72 giờ), cho thấy những bất thường điện não ở một bên thùy thái dương. Chụp MRI não cho kết quả bất thường xảy ra sớm hơn so với kết quả chụp CT (có thể phải sau vài ngày mới thấy được hình ảnh bất thường khu trú ở thùy thái dương). Chẩn đoán xác định bằng cách làm PCR dịch não tủy tìm HSV-1 DNA. Giảm nặng chức năng vỏ não là đặc điểm của viêm não-màng não do virus herpes-simplex. Dịch não tủy có thể có tình trạng tăng ưu thế bạch cầu đa nhân trung tính và giảm nồng độ glucose, khác với các căn nguyên viêm màng não do virus khác. Một thể lâm sàng khác là viêm màng não do HSV, thường kết hợp với HSV-2 và có thể tái xuất hiện với viêm màng não tăng tế bào lympho.

Các Lưu ý: Cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh não không do nhiễm trùng. Điều đáng ngạc nhiên là viêm não do HIV là một nguyên nhân gây viêm não khá hiếm gặp ở bệnh nhân HIV.

Xem xét điều trị: Điều trị càng sớm càng tốt do các thiếu sót thần kinh có thể nhẹ và hồi phục khi được điều trị sớm nhưng sẽ nặng và không hồi phục nếu điều trị muộn.

Tiên lượng: Liên quan đến mức độ lan rộng của tổn thương não và điều trị thuốc chống retrovirus sớm. Tiên lượng đối với viêm màng não do HSV rất tốt.

Bệnh do Histoplasma (*H. capsulatum*) lan tỏa

Phân loại	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Giai đoạn cấp tính (3-10 ngày hoặc đến khi cải thiện về lâm sàng)	Amphotericin B liposom 3mg/kg × 1–2 tuần hoặc các dạng bào chế kết hợp với lipid khác với liều 5mg/kg.	Amphotericin B doxycholat 0,7–1mg/kg ***hoặc*** Itraconazol tĩnh mạch (200mg mỗi 12h/lần × 4 liều sau đó 200mg mỗi 24h/lần).
Giai đoạn duy trì	Itraconazol 200mg (uống) 3 lần/ngày × 3 ngày, sau đó một lần mỗi ngày hoặc hai lần mỗi ngày trong ít nhất 12 tháng (cần khẳng định nồng độ thuốc trong huyết thanh thỏa đáng). Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể cần phải điều trị duy trì suốt đời	Itraconazol dung dịch uống 200mg (uống) mỗi 12h/lần × 12 tuần ***hoặc*** Fluconazol 800mg (uống) mỗi 24h/lần × 12 tuần.
Viêm màng não	Amphotericin B deoxycholat 0,7mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 12-16 tuần ***hoặc*** Amphotericin B liposom 4mg/kg (TM) mỗi 24h/lần × 12-16 tuần.	Fluconazol 800mg (uống) mỗi 24h/lần × 12 tuần.

** Thời gian điều trị tùy thuộc vào đáp ứng điều trị.*

Biểu hiện lâm sàng: Hai thể chính: Bệnh nhẹ với sốt/hạch to (Vd: viêm hạch cổ) hoặc bệnh nặng với sốt, suy mòn ± ỉa chảy/viêm màng não/loét đường tiêu hóa.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng tìm kháng nguyên histoplasma trong nước tiểu/huyết thanh, đôi khi bằng nuôi cấy tủy xương/gan hoặc cấy máu có

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ly giải-ly tâm (isolator blood cultures). Có thể xảy ra ở bệnh nhân nhiều tháng cho đến nhiều năm sau khi sống/chuyển khỏi vùng có bệnh lưu hành thành dịch địa phương.

Lưu ý: Tái phát thường gặp sau khi ngừng điều trị. Nuôi cấy có thể mất từ 7-21 để chuyển dương tính.

Xem xét điều trị: Điều trị ban đầu phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh khi bệnh nhân đến khám. Những bệnh nhân có bệnh cực nặng cần được bắt đầu dùng amphotericin B deoxycholat, với thời gian điều trị theo đường TM phụ thuộc vào đáp ứng điều trị. Những bệnh nhân bị bệnh nhẹ có thể được khởi đầu điều trị bằng itraconazol. Tất cả các bệnh nhân đều cần điều trị duy trì kéo dài và có thể ngừng khi phục hồi miễn dịch với số lượng tế bào CD_4 > 100/mm^3 trong ít nhất 6 tháng. Bệnh nhân HIV có số lượng tế bào CD_4 > 500/mm^3 và bệnh nhiễm Histoplsma cấp tính ở phổi có lẽ không cần điều trị nhưng một liệu trình itraconazol ngắn (4-8 tuần) là hợp lý để ngăn ngừa bệnh lan toàn thân.

Tiên lượng: Thường đáp ứng với điều trị, trừ những trường hợp tối cấp.

Nhiễm mycobacterium avium-nội tế bào (MAI)

Tác nhân gây bệnh	Điều trị được ưu tiên lựa chọn	Điều trị thay thế
Mycobacterium avium nội bào (MAI)	***Ít nhất 2 thuốc như điều trị khởi đầu*** Clarithromycin 500mg (uống) mỗi 12h/lần cộng với ethambutol 15 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần (thường 800mg hoặc 1200mg mỗi ngày). Cân nhắc thêm thuốc thứ 3, rifabutin 300mg (uống) mỗi 24h/lần cho bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4 < 50/mm^3, tải lượng mycobateria cao và bệnh có triệu chứng nặng. Thời gian điều trị ***kéo dài suốt đời bệnh nhân***, mặc dù có thể xem xét ngừng điều trị ở những bệnh nhân không có triệu chứng sau điều trị > 12 tháng và số lượng tế bào CD_4 > 100/mm^3 trong > 6 tháng khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus.	***Thay thế cho clarithromycin*** Azithromycin 500-600mg (uống) mỗi 24h/lần. ***Thay thế thuốc thứ 3 hoặc thứ 4 đối với triệu chứng nặng hoặc bệnh lan tỏa*** Ciprofloxacin 500-750mg (uống) mỗi 12h/lần. ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần. ***hoặc*** Amikacin 10-15mg/kg (TM) mỗi 24h/lần .

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Thường biểu hiện như một tình trạng bệnh lý gây suy mòn có sốt trong bệnh HIV giai đoạn tiến triển (số lượng tế bào CD_4 < 50/mm³). Có thể gặp bệnh xâm lấn khu trú, nhất là ở những bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch tiến triển sau khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus. Bệnh khu trú nhiều khả năng phản ánh tình trạng hồi phục đáp ứng miễn dịch đặc hiệu với tác nhân gây bệnh đối với nhiễm trùng dưới lâm sàng ("hội chứng viêm sau phục hồi miễn dịch" [IRIS]) và thường được biểu hiện bằng viêm hạch (mạc treo, cổ, ngực) hoặc hãn hữu là bệnh của cột sống giống như bệnh lao cột sống. Hội chứng phục hồi miễn dịch thường xảy ra trong vòng nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi bắt đầu điều trị thuốc chống retrovirus lần đầu tiên nhưng có thể xuất hiện từ sau một năm trở lên.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng phân lập được vi sinh vật từ một vị trí vốn vô khuẩn trong cơ thể trong điều kiện bình thường (Vd: máu, hạch, tủy xương, sinh thiết gan). Ly giải-ly tâm (Lysis-centrifugation) bằng bộ phân lập DuPont là phương pháp nuôi cấy máu được ưu tiên áp dụng. Thiếu máu/tăng phosphatase kiềm đôi khi được gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các Lưu ý: Cấy máu có ly giải-ly tâm có thể âm tính, nhất là trong hội chứng viêm sau phục hồi miễn dịch lúc đầu.

Xem xét điều trị: Một số nghiên cứu gợi ý lợi ích của việc bổ sung rifabutin 300mg (uống) mỗi 24h/lần, một số nghiên cứu khác không thấy được lợi ích này. Có thể cần phải điều chỉnh liều rifabutin khi dùng với thuốc ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleosid (NNRTI) và thuốc ức chế protease (PI). Khi dùng đồng thời nelfinavir, indinavir hoặc amprenavir, giảm liều rifabutin xuống 150mg (uống) mỗi 24h/lần. Khi dùng đồng thời với ritonavir, giảm liều rifabutin xuống 150mg (uống) 2-3 lần/tuần. Khi dùng đồng thời với efavirenz, tăng liều rifabutin lên 450-600mg (uống) mỗi 24h/lần. Có thể cần phải tăng liều thuốc ức chế protease (PI) hoặc thuốc ức chế enzym sao chép ngược không phải nucleosid (NNRTI) lên 20-25%. Theo dõi cẩn thận độc tính thuốc rifabutin (đau khớp, viêm mống mắt, giảm bạch cầu). Điều trị hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (IRIS) khởi đầu bằng dùng các thuốc chống viêm không steroid; nếu vẫn còn triệu chứng có thể dùng corticoid đường toàn thân (prednison 20-40 mg hàng ngày) trong 4-8 tuần. Một số bệnh nhân sẽ cần liệu trình corticoid kéo dài hơn với thời gian giảm dần liều chậm trong nhiều tháng. Azithromycin thường được bệnh nhân dung nạp tốt hơn clarithromycin và có ít tương tác thuốc hơn. Còn chưa rõ về xử trí lâu dài tối ưu, mặc dù phần lớn nghiên cứu gợi ý có thể ngừng điều trị ở những bệnh nhân không có triệu chứng sau > 12 tháng điều trị và số lượng tế bào CD_4 > 100/mm³ trong > 6 tháng.

Tiên lượng: Phụ thuộc vào sự phục hồi miễn dịch khi đáp ứng với điều trị thuốc chống retrovirus. Các yếu tố tiên lượng bất lợi bao gồm xuất hiện vi khuẩn trong máu trên nhiều mẫu cấy máu hoặc có tình trạng suy mòn nặng.

Virus thủy đậu (Varicella Zoster virus [VZV])

Nhiễm trùng	Điều trị được ưu tiên clựa chọn
Nhiễm virus thủy đậu (VZV) tiên phát (bệnh thủy đậu)	Acyclovir 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần × 7-10 ngày. Có thể bắt đầu bằng hoặc chuyển sang điều trị theo đường uống với Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8 giờ hoặc Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần sau khi bệnh đỡ nếu không có bằng chứng tổn thương nội tạng.
Nhiễm *Herpes zoster* (bệnh zona) vùng da thần kinh khu trú	Famciclovir 500mg (uống) mỗi 8h/lần × 7–10 ngày hoặc Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần × 7–10 ngày.
Tổn thương da lan rộng hoặc tổn thương nội tạng	Acyclovir 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần cho đến khi hết hẳn bệnh ở da và nội tạng và bệnh nhân cải thiện trên lâm sàng.
Hoại tử võng mạc cấp tính	Acyclovir 10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần cho đến khi ngừng tiến triển, sau đó Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần × 6 tuần. Điều trị kết hợp với khám cẩn thận chuyên khoa mắt.

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh nhiễm virus thủy đậu tiên phát (bệnh thủy đậu) được biểu hiện với các mụn nước trong trên nền ban đỏ, khi lành đóng vẩy và đôi khi tạo sẹo. Bệnh zona thường được biểu hiện bằng các mụn nước căng đau trên nền ban đỏ ở vùng phân bố thần kinh da (dermatoma distribution). Ở bệnh nhân nhiễm HIV, bệnh thủy đậu tiên phát thường nặng hơn /kéo dài hơn còn bệnh zona thì có nhiều khả năng bị tổn thương nhiều vùng thần kinh da/lan tỏa hơn. Virus thủy đậu có thể gây hoại tử võng mạc cấp nhưng hiếm và tình trạng này đòi hỏi khám cẩn thận chuyên khoa mắt.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán thường dựa vào lâm sàng. Trong những trường hợp không điển hình, có thể sử dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang để phân biệt *Herpes zoster* với *Herpes simplex*.

Lưu ý: Điều trị kéo dài thêm hơn 7-10 ngày nếu các mụn nước mới vẫn hình thành sau giai đoạn điều trị ban đầu. Không khuyến cáo dùng corticoid đối với zona thần kinh da ở bệnh nhân HIV dương tính.

Xem xét điều trị: Nói chung điều trị theo đường tĩnh mạch được chỉ định cho các tình trạng bệnh nặng/zona thần kinh sọ.

Tiên lượng: Thường đáp ứng chậm với điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC BỆNH ĐỒNG NHIỄM VỚI HIV (VIRUS VIÊM GAN B [HBV]/ VIRUS VIÊM GAN C [HCV])

Virus viêm gan B (HBV)

Điều trị được ưu tiên lựa chọn Thời gian điều trị, Duy trì kéo dài	Điều trị thay thế	Các lựa chọn/vấn đề khác
Điều trị cho bệnh nhân cần được điều trị thuốc chống retrovirus Nên điều trị cho bệnh nhân bằng các thuốc có tác dụng với cả HIV và virus viêm gan B hoặc bằng các thuốc có hoạt tính độc lập với từng loại virus nói trên. Xem xét dùng tenofovir + emtricitabine trong phác đồ điều trị HIV và virus viêm gan B. *Những bệnh nhân chưa từng điều trị lamivudin hoặc emtricitabine* [Lamivudin 150mg (uống) x 2 lần mỗi ngày (hoặc 300mg uống hàng ngày) hoặc emtricitabine 200mg uống hàng ngày] + tenofovir (TDF) 300mg uống hàng ngày (+ thuốc bổ sung có hoạt tính đối với HIV) *Những bệnh nhân đã từng dùng lamivudin hoặc emtricitabine có HBV DNA trên ngưỡng có thể phát hiện được (được giả định là có tình trạng kháng với lamivudin).* *Nếu hiện không dùng TDF*: Phối hợp thêm TDF 300mg đường uống hàng ngày trong phác đồ điều trị thuốc chống retrovirus + lamivudin hoặc emtricitabine ***hoặc*** Adefovir 10mg đường uống hàng ngày + lamivudin hoặc emtricitabine + điều trị thuốc chống retrovirus kết hợp khác ***hoặc*** Có thể xem xét dùng entecavir 1 mg đường uống hàng ngày ở những bệnh nhân ức chế được hoàn toàn HIV (trong khi đang điều trị thuốc chống retrovirus) và các đối tượng này không thấy bị đột biến dạng YMDD (M204V/I) trên DNA của virus viêm gan B. Thời gian điều trị: Do tỷ lệ tái phát cao, một số chuyên gia khuyến cáo tiếp tục điều trị không giới hạn thời gian.	*Điều trị cho bệnh nhân không cần điều trị thuốc chống retrovirus* Dùng các thuốc chỉ có hoạt tính riêng đối với virus viêm gan B và có ít nguy cơ chọn lọc các đột biến kháng thuốc với HIV nhất. Xem xét bắt đầu sớm điều trị thuốc chống retrovirus, nhất là đối với các bệnh nhân có HBV DNA cao. *Đối với những bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4+ > 350 tế bào/μL, HBeAg (-) HBV DNA > 2.000 IU/mL (> 20.000 bản sao/mL).* Dùng Adefovir 10mg (uống) hàng ngày. *Đối với những bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4+>350 tế bào/μL, HBeAg (+), HBV DNA > 20.000 IU/mL (> 200.000 bản sao/mL) và tăng ALT.* Peginterferon alfa-2a 180μg tiêm dưới da hàng tuần x 48 tuần- theo dõi cẩn thận tình trạng chuyển đảo HBeAg.	Không nên dùng emtricitabine, entecavir, lamivudin hoặc tenofovir để điều trị nhiễm virus viêm gan B cho những bệnh nhân hiện không điều trị thuốc chống retrovirus kết hợp. Trong số những bệnh nhân đồng nhiễm HIV, HBV và HCV, nên ưu tiên xem xét cho điều trị thuốc chống retrovirus. Nếu không cần điều trị thuốc chống retrovirus, nên cân nhắc sử dụng phác đồ điều trị dựa trên interferon ức chế cả virus viêm gan C (HCV) và virus viêm gan B (HBV). Nếu phác đồ điều trị virus viêm gan C dựa trên IFN bị thất bại có khuyến cáo điều trị viêm gan B mạn tính mạn bằng các thuốc tương tự nucleosid hoặc nucleotid. Nên giả định là có tình trạng đề kháng chéo với emtricitabine hoặc telbivudin ở bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã được chứng có đề kháng với 3TC. Khi thay đổi phác đồ điều trị thuốc chống retrovirus, cần tiếp tục dùng các thuốc có hoạt tính chống virus viêm gan B do có nguy cơ bị hội chứng viêm sau hồi phục miễn dịch (IRIS). Nếu ngừng điều trị thuốc kháng virus viêm gan B và xảy ra một đợt bùng bệnh phát, nên tiến hành điều trị lại khi điều trị này có thể tiềm ẩn khả năng cứu sống người bệnh.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phỏng theo: **Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 4th edition. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.**

Dịch tễ học: Nhiễm virus viêm gan B (HBV) tương đối thường gặp ở bệnh nhân HIV, với khoảng 60% cho thấy có bằng chứng phơi nhiễm trước đó. Nhiễm viêm gan B mạn tính tương tác với nhiễm HIV theo một số cách quan trọng:

- Virus viêm gan B (HBV) làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến gan và ngộ độc gan do điều trị thuốc chống retrovirus.
- Cả ba loại thuốc 3TC, FTC và tenofovir đều có tác dụng kháng virus viêm gan B. Do vậy việc lựa chọn điều trị thuốc chống retrovirus cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B có thể có những ý nghĩa lâm sàng và đề kháng đối với HBV cũng như HIV. Điều đáng lưu ý nhất với 3TC và FTC là có một tỷ lệ cao bệnh nhân đồng nhiễm sẽ phát sinh tình trạng đề kháng liên quan với HBV đối với những thuốc này sau nhiều năm điều trị. Tình trạng đề kháng này làm giảm đáp ứng với các phác đồ điều trị kháng virus viêm gan B không có 3TC hoặc FTC sau này.
- Ngừng điều trị thuốc kháng virus viêm gan B có thể dẫn đến đợt tiến triển cấp tính nặng của bệnh gan tiềm tàng; trong một số trường hợp, những đợt bùng phát đã gây tử vong cho bệnh nhân.
- Tình trạng phục hồi miễn dịch có thể dẫn đến tiến triển xấu đi của bệnh gan, diễn biến này được cho là có liên quan bệnh nhiễm virus viêm gan B qua trung gian miễn dịch. Đôi khi tình trạng này liên quan đến sự mất HBeAg.
- Entecavir có thể không còn được khuyến cáo cho những bệnh nhân đồng nhiễm HIV/HBV, do thuốc này có tác dụng kháng HIV và có thể chọn lọc đột biến M184V đề kháng với HIV. Nếu cần chỉ nên dùng thuốc cùng với phác đồ ức chế được hoàn toàn HIV.

Xem xét chẩn đoán: Tiến hành làm xét nghiệm HBsAb, HBsAg và HBcAb tại thời điểm nền trước điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Nếu các xét nghiệm nói trên âm tính, chỉ định tiêm vaccin viêm gan B. Nếu xác định nhiễm HBV mạn tính (HBsAg dương tính), làm HBeAg, HBeAb và định lượng nồng độ HBV DNA. Như với nhiễm HCV, tiêm vaccin viêm gan A và tư vấn bệnh nhân tránh uống rượu là những thành tố quan trọng trong chăm sóc dự phòng.

Chỉ đơn độc có kháng thể lõi viêm gan B (Isolated Hepatitis B Core Antibody)- Một tình trạng được định nghĩa là khi bệnh nhân có anti-HBc song lại không phát hiện được HBsAg và anti-HBs. Nhiều bệnh nhân HIV có kháng thể đối với kháng nguyên lõi viêm gan B (anti-HBc) nhưng âm tính đối với cả HBsAg và HBsAb. Hiện tượng này dường như thường được gặp hơn ở những người đồng nhiễm virus viêm gan C (*Clin Infec Dis 2003 36:1602–6*). Trong tình huống này,

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

những lưu ý về chẩn đoán bao gồm: (1) Nhiễm HBV phải xảy ra gần đây, trước khi xuất hiện HBsAb; (2) Nhiễm HBV mạn tính, với HBsAg ở dưới mức phát hiện được; (3) Miễn dịch với HBV, với HBsAb ở dưới mức phát hiện được; (4) Kháng thể lõi HBV dương tính giả. Do tỷ lệ mắc mới HBV tương đối thấp trong phần lớn các quần thể và anti-HBc đơn độc thường là một hiện tượng ổn định trong nhiều năm, nguyên nhân hiếm khi là do bệnh nhân mắc HBV gần đây. Trong tình huống này, chúng tôi khuyến cáo kiểm tra HBV DNA: Nếu dương tính, điều này chỉ điểm nhiễm HBV mạn tính, nếu âm tính thì nguyên nhân vẫn có thể là do miễn dịch mức độ thấp hoặc kháng thể lõi HBV dương tính giả. Do không thể phân định được giữa các khả năng này, chúng tôi khuyến cáo tiêm cả loạt vaccin viêm gan B. Việc định kỳ đo lường các dấu ấn huyết thanh HBV trong quần thể này là có ích vì cải thiện tình trạng miễn dịch do điều trị bằng thuốc chống retrovirus có thể dẫn đến tăng hiệu giá HBsAb và kết quả là khẳng định khả năng miễn dịch của bệnh nhân.

Xem xét điều trị: Điều trị tối ưu đối với bệnh nhân nhiễm HBV vẫn còn đang tiếp tục phát triển. Các hướng dẫn hiện nay gợi ý cần điều trị virus viêm gan B cho tất cả các bệnh nhân đang có sự nhân lên của HBV, được xác định bằng xét nghiệm HBeAg hoặc HBV DNA trên ngưỡng phát hiện được. Trong khi chờ đợi những nghiên cứu lâu dài xác định cách xử trí tối ưu, những khuyến cáo trình bày như ở trên là hợp lý. Những bệnh nhân đang được điều trị bằng các phác đồ điều trị đối với HBV cần được theo dõi ALT mỗi 3-4 tháng. Nồng độ HBV DNA là chỉ điểm tốt về hiệu quả điều trị và cần đưa vào quy trình theo dõi thường xuyên về xét nghiệm. Mục đích điều trị là làm giảm nồng độ HBV DNA xuống mức thấp nhất có thể, tốt nhất là dưới ngưỡng phát hiện. Thời gian điều trị HBV còn chưa được xác định rõ; với sự xuất hiện HBeAb, trong khi một số người không HIV có thể ngừng điều trị sau khi có sự chuyển đảo HBEAg về âm tính, lại không có chỉ định ngừng rõ ràng cho những bệnh nhân đồng nhiễm HIV.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Virus viêm gan C (HCV)

Điều trị được ưu tiên lựa chọn, Thời gian điều trị, Duy trì kéo dài	Điều trị thay thế	Các lựa chọn/vấn đề khác
Kiểu gen 1, 4, 5 hoặc 6 Peginterferon alfa-2a 180µg tiêm dưới da hàng tuần, ***hoặc*** Peginterferon alfa-2b 1,5mg/kg tiêm dưới da hàng tuần ***cộng với*** Ribavirin dùng đường uống (liều theo cân nặng) <75 kg: 600mg mỗi buổi sáng và 400 mg mỗi buổi tối; ≥75 kg: 600mg mỗi buổi sáng và 600mg mỗi buổi tối.	*Ở bệnh nhân có chống chỉ định với ribavirin (Vd: bệnh tim phổi không ổn định, thiếu máu có từ trước không đáp ứng với erythropoietin, suy thận hoặc bệnh hemoglobin)* Peginterferon alfa-2a 180µg tiêm dưới da hàng tuần ***hoặc*** Peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg tiêm dưới da hàng tuần.	Đối với những bệnh nhân có số lượng tế bào CD_4+ <200 tế bào/µL, có thể cân nhắc điều trị thuốc chống retrovirus trước khi điều trị virus viêm gan C. Didanosin + Ribavirin có thể dẫn đến tăng độc tính ty thể; chống chỉ định dùng đồng thời.
Kiểu gen 2 hoặc 3 Peginterferon alfa-2a 180 µg tiêm dưới da hàng tuần, ***hoặc*** Peginterferon alfa-2b 1,5 mg/kg tiêm dưới da hàng tuần ***cộng với*** Ribavirin (liều cố định) dùng đường uống 400mg mỗi buổi sáng và 400mg mỗi buổi tối. Thời gian điều trị: 48 tuần đối với kiểu gen 1 hoặc 4, 5 hoặc 6 và kiểu gen 2 và 3. Ít nhất 24 tuần-điều trị nhiễm HCV cấp tính (<6 tháng kể từ phơi nhiễm HCV).	*Ở những bệnh nhân có bệnh gan mất bù* Ghép gan nếu khả thi.	Không khuyến cáo điều trị virus viêm gan C cho những bệnh nhân có bệnh gan mất bù. Nếu khả thi thì ghép gan sẽ là lựa chọn điều trị chủ yếu. Interferon gây sảy thai ở liều cao và ribavirin gây quái thai. Không khuyến cáo điều trị virus viêm gan C cho phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ không muốn áp dụng các biện pháp ngừa thai.

Phỏng theo: **Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 5th edition. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2012** (*cũng xem trang 174-177*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dịch tễ học: Nhiễm virus viêm gan C (HCV) lây truyền chủ yếu qua phơi nhiễm máu; lây truyền qua tình dục và chu sinh cũng có thể có nhưng ít hiệu quả. Một ngoại lệ đáng lưu ý là HCV lây truyền qua đường tình dục ở những người đồng tính nam. Do phương thức lây truyền HIV và HCV là tương tự nhau, có tỷ lệ cao đồng nhiễm HCV ở bệnh nhân HIV - ước tính 16% tổng số bệnh nhân HIV, bao gồm từ 80% trở lên ở người tiêm chích ma túy và 5-10% những người đồng tính nam. Kiểu gen 1 của virus viêm gan C chiếm 75% HCV ở Hoa Kỳ. HIV làm tăng tốc độ tiến triển nhiễm HCV mạn tính thành xơ gan, suy gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Dữ liệu mâu thuẫn về ảnh hưởng độc lập của HCV trên tiến triển bệnh HIV nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ cao rõ rệt ngộ độc gan do điều trị thuốc chống retrovirus gây nên ở những người nhiễm HCV mạn tính. Trong một số loạt ca bệnh, suy gan do HCV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người đồng nhiễm HIV/HCV.

Biểu hiện lâm sàng: Tăng transaminases gan kéo dài, thường không có triệu chứng.

Xem xét chẩn đoán: Tất cả bệnh nhân HIV dương tính đều cần xét nghiệm kháng thể HCV. Nếu xét nghiệm kháng thể âm tính nhưng khả năng bị nhiễm HCV cao (người tiêm chích ma túy, tăng men gan không giải thích được), làm HCV RNA do xét nghiệm kháng thể có thể âm tính giả, nhất là trong bệnh HIV giai đoạn tiến triển. Do men gan tăng không tương quan nhiều với mức độ hoạt động tiềm tàng của HCV, sinh thiết gan là cách tốt nhất để đánh giá mức độ xơ hóa và viêm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị:

Ngay khi xác định chẩn đoán: Khuyên bệnh nhân kiêng rượu và tiêm vaccin viêm gan A và B (nếu chưa có miễn dịch). Đồng thời làm xét nghiệm nồng độ HCV RNA với đánh giá kiểu gen. Nồng độ HCV RNA không có ý nghĩa tiên lượng về mức độ bệnh gan tiềm tàng, nhưng nồng độ cao hơn thì ít có khả năng sẽ điều trị khỏi hơn. Kết quả về kiểu gen cũng tương quan với tỷ lệ khỏi (tỷ lệ khỏi được báo cáo: 60–75% đối với kiểu gen 2 và 3; 15–25% đối với kiểu gen 1). Một số nhà lâm sàng lựa chọn điều trị HCV mà không sinh thiết gan do: nguy cơ, tốn kém và sự bất tiện của xét nghiệm; nguy cơ ước tính không đủ mức độ hoạt động của virus HCV do lỗi chọn mẫu và tỷ lệ cao điều trị thành công đối với kiểu gen 2 và 3.

Các đặc điểm bệnh nhân HIV tối ưu để điều trị HCV bao gồm không có bệnh tâm thần tiến triển hoặc đang lạm dụng nghiện chất; bệnh HIV ổn định có HIV RNA dưới ngưỡng phát hiện được và số lượng tế bào CD_4 cao hơn; điều trị phác đồ thuốc chống retrovirus không có ddI, d4T hoặc ZDV; và tuân thủ dùng thuốc,

các lần khám theo dõi và theo dõi xét nghiệm máu. Chỉ một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn này; do đó để tăng hiệu quả điều trị tối đa, điều quan trọng là tối ưu hóa tình trạng lâm sàng trước khi bắt đầu điều trị HCV. Bệnh nhân cần được thông tin đầy đủ về mục đích và nguy cơ của điều trị, có đưa ra thông tin dạng văn bản về các tác dụng phụ, nhóm hỗ trợ tại chỗ và những người liên hệ khi cần. Việc cho dùng liều điều trị đầu tiên tại bệnh viện rất hữu ích để đưa ra các chỉ dẫn về kỹ thuật tiêm cho bệnh nhân.

Chọn điều trị dùng thuốc: Điều trị được chọn đối với nhiễm virus viêm gan C là interferon pegyl hóa (pegylated interferon) cộng với ribavirin. Tất cả các bệnh nhân cũng cần được tiêm vaccin viêm gan A và tư vấn tránh sử dụng rượu.

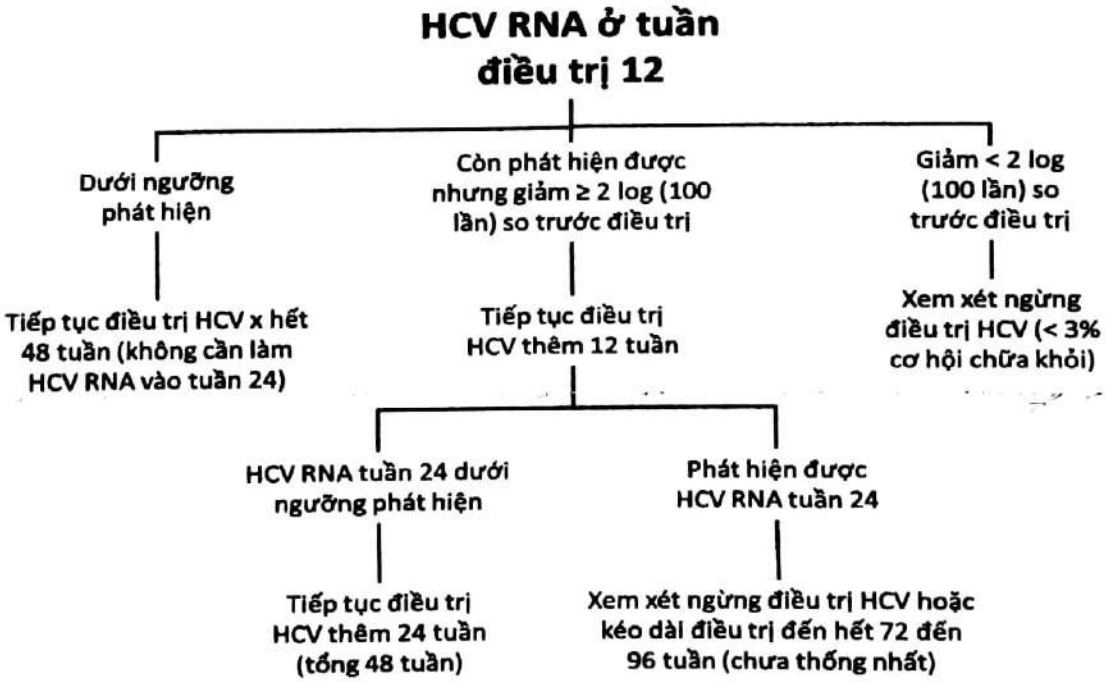
- **Interferon pegyl hóa**: Hai dạng chế phẩm interferon pegyl hóa khác nhau hiện có để điều trị nhiễm HCV: (1) peginterferon alfa-2a (Pegasys), cung ứng dưới dạng dung dịch trộn sẵn, dùng đường tiêm dưới da theo liều cố định 180µg một lần mỗi tuần; và (2) peginterferon alfa-2b (Peg-Intron), cung ứng dưới dạng bột pha nước muối và dùng đường tiêm dưới da theo liều dựa trên cân nặng một lần mỗi tuần. Hiệu quả và độc tính của hai dạng chế phẩm peginterferon này có vẻ giống nhau. Ba thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy interferon pegyl hóa cộng với ribavirin có hiệu quả hơn interferon chuẩn cộng với ribavirin (*N Engl J Med 2004;351:451–9; N Engl J Med 2004;351:438–50; JAMA 2004;292:2839–48*). Interferon có nhiều tác dụng phụ, các tác dụng phụ quan trọng nhất được trình bày trong ***Bảng 5.9***.

- **Ribavirin:** Ribavirin sẵn có dưới dạng viên nang 200mg. Mặc dù liều dùng trong các thử nghiệm lâm sàng là 800 mg hàng ngày (400 mg dùng hai lần mỗi ngày), có vẻ như liều ban đầu cao hơn kết hợp với hiệu quả tốt hơn. Liều chuẩn hiện nay là 400 mg mỗi buổi sáng và 600 mg mỗi buổi tối cho bệnh nhân nặng < 75 kg và 600 mg mỗi buổi sáng và 600 mg mỗi buổi tối cho bệnh nhân nặng > 75 kg. Ribavirin gây thiếu máu huyết tán, do đó dẫn đến giảm hemoglobin khi xét nghiệm công thức máu, tình trạng này ổn định vào tuần điều trị thứ 4-8. Thiếu máu huyết tán có thể bùng phát ở những bệnh nhân đang dùng ZDV; nếu có thể thì nên chọn thay thế bằng một thuốc thuộc nhóm ức chế enzym sao chép ngược (reverse transcriptase) không phải nucleosid (NRTI), ưu tiên dùng tenofovir hoặc abacavir. Đối với thiếu máu có triệu chứng hoặc ở các bệnh nhân có tình trạng bệnh đi kèm nặng lên do thiếu máu, dùng erythropoietin để duy trì nồng độ hemoglobin > 10 g/dL hoặc cao hơn nếu cần. Liều khởi đầu thông thường của erythropoietin là 40.000 đơn vị tiêm dưới da một lần mỗi tuần. Didanosin bị chống chỉ định khi dùng ribavirin do tăng nguy cơ gây độc cho ty thể và mất bù

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

gan (*Clin Infect Dis 2004;38:e79–e80*). Cũng nên tránh d4T do nguy cơ gây độc ty thể của thuốc này. Cuối cùng là một số dữ liệu gợi ý rằng ABC có thể tương tác với ribavirin, làm giảm hiệu quả điều trị vius viêm gan C. Một tác dụng phụ thường gặp khác của ribavirin là rối loạn tiêu hóa, tác dụng phụ này có thể lẫn với tác dụng tương tự của interferon. Ribavirin được xếp loại × trong thai kỳ (sinh quái thai mạnh) và chỉ có thể dùng cho phụ nữ còn trong thời kỳ hoạt động tình dục có khả năng sinh con nếu họ đang dùng 2 biện pháp kiểm soát sinh đẻ. Cần tránh mang thai cho đến ít nhất 6 tháng sau ngừng ribavirin.

Theo dõi: Kế hoạch theo dõi những bệnh nhân đồng nhiễm HIV/HCV bao gồm những đánh giá về cả tính an toàn và hiệu quả (Bảng 5.10). Sử dụng các kết quả xét nghiệm HCV RNA để quyết định giữa việc hoàn thành 48 tuần điều trị HCV hay ngừng điều trị ở tuần 12 hoặc 24 do xác suất chữa khỏi thấp (Hình 5.4).



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Hình 5.4. Xử trí nhiễm HCV dựa trên xét nghiệm HCV RNA

Cần đánh giá HCV RNA vào tuần 12. Nếu tải lượng virus HCV không giảm xuống trên 2 log (100 lần) thì khả năng chữa khỏi được là cực thấp. Nhiều bệnh nhân và thầy thuốc sẽ lựa chọn ngừng điều trị ở thời điểm này, cho dù về mặt lý thuyết peg-interferon liều thấp có thể giúp cải thiện xơ hóa gan độc lập với tác dụng kháng virus. (Chiến lược này đang được kiểm định trong các thử nghiệm lâm sàng). Cần đánh giá HCV RNA vào tuần 24 và 48. Nếu không phát hiện được HCV RNA vào tuần 48, cần làm thêm các thông số đo lường vào tuần 4, 12 và 24 sau ngừng điều trị. Không phát hiện được HCV RNA vào tuần 24 sau điều

trị là tiêu chuẩn hiện tại để đánh giá "đáp ứng virus học bền vững" ("Sustained virologic response" [SVR]) có thể được coi tương đương với chữa khỏi bệnh. Điều quan trọng là những bệnh nhân đã khỏi HCV vẫn có khả năng mắc lại và cần thận trọng tránh bắt đầu lại các hành vi nguy cơ cao.

Bảng 5.9. Các tác dụng bất lợi liên quan đến Interferon

Tác dụng phụ	Ghi chú
Mệt mỏi và các triệu chứng giống cúm (sốt, rét run, đau cơ, đau đầu)	Dùng thuốc vào buổi tối để một số triệu chứng khởi đầu có thể hết khi ngủ. Triệu chứng có thể không đạt đến mức đỉnh cho đến 48-72 giờ sau liều dùng hàng tuần và có thể được xử trí bằng paracetamol (tối đa 1300 mg/ngày) hoặc ibuprofen cộng với bổi phụ dịch tốt. Đôi khi mệt mỏi là một biểu hiện rối loạn điều hòa chức năng tuyến giáp hoặc thiếu máu; theo dõi xét nghiệm chức năng tuyến giáp và công thức máu.
Trầm cảm	Interferon có thể làm nặng thêm các rối loạn tâm thần đe dọa tính mạng bệnh nhân. Khởi đầu điều trị chống trầm cảm ở ngưỡng thấp. Những bệnh nhân có tiền sử trầm cảm hoặc bị bệnh tâm thần khác từ trước cần được chuyên gia sức khỏe tâm thần theo dõi sát trong thời gian điều trị virus viêm gan C.
Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu	Giảm các dòng tế bào thường gặp hơn trong đồng nhiễm HIV/HCV. Có thể điều trị bằng G-CSF 300 µg x 3 lần/tuần nếu số lượng tuyệt đối bạch cầu trung tính < 500/mm^3. Nếu giảm bạch cầu trung tính kéo dài, cần giảm liều interferon. Nếu số lượng tiểu cầu giảm xuống < 80.000/mm^3, cũng cần xem xét giảm liều interferon (một số nhà lâm sàng chấp nhận mức giảm xuống tới 50.000/mm^3). Ngưỡng thấp để dùng erythropoietin (EPO) 40.000 U/tuần đối với thiếu máu (xem phần về ribavirin).
Loét miệng	Lidocain hoặc sucralfat dạng keo nhớt dùng tại chỗ có ích trong một số trường hợp.
Các triệu chứng tiêu hóa	Buồn nôn và chán ăn thường gặp nhất, thường dẫn đến sụt cân. Khuyên bệnh nhân ăn thành các bữa nhỏ hàng ngày hơn là ăn ít bữa lớn.
Rụng tóc	Có thể phục hồi sau khi hoàn tất liệu trình điều trị.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 5.10. Kế hoạch theo dõi trong quá trình điều trị nhiễm virus viêm gan C

	Tuần điều trị								
	Trước điều trị	**2**	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	**24**	**24-28**
Công thức máu	X	X	X	X	X	X	X	X	mỗi 4 tuần
Bộ xét nghiệm chức năng gan + chuyển hóa	X		X	X	X	X	X	X	mỗi 4 tuần
HCV RNA	X		X¶		X*			X**	mỗi 12 tuần
HIV RNA + CD_4	X				X†			X	mỗi 12 tuần
TSH	X				X			X	mỗi 12 tuần
Trầm cảm	X	X	X	X	X	X	X	X	Liên tục
Khám mắt	X‡				X			X**	mỗi 12 tuần
Xét nghiệm PT	X					X			mỗi 12 tuần
Thử thai	Tiến hành xét nghiệm định kỳ nếu thấy phù hợp.								

* *Những bệnh nhân không giảm HCV RNA ≥ 2 log vào tuần thứ 12 so với thời điểm ban đầu (đáp ứng sớm về virus học) chỉ có < 3% cơ hội đạt được đáp ứng virus bền vững (HCV RNA dưới ngưỡng phát hiện sau điều trị 6 tháng). Tối ưu ra, HCV RNA phải dưới ngưỡng phát hiện lúc 12 tuần (đáp ứng sớm "hoàn toàn" về virus học). Một chiến lược được đề xuất cho những bệnh nhân có HCV RNA còn phát hiện được ở mức thấp vào tuần 12 (đáp ứng sớm "một phần" về virus học) là kéo dài liệu trình điều trị đến 72 tuần hoặc lâu hơn để làm giảm nguy cơ tái phát; chiến lược này hiện đang được nghiên cứu.*

** *Nếu HCV RNA giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện vào tuần 24, cần tiếp tục điều trị thêm 24 tuần nữa (nếu đã biết kiểu gen 2 hoặc 3 thì thảo luận về khả năng ngừng điều trị, nhưng một số chuyên gia nhất trí rằng nên tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân đồng nhiễm trong 48 tuần để giảm nguy cơ tái phát). Nếu HCV RNA dương tính vào tuần thứ 24, cần xem xét ngừng điều trị HCV. Ngay cả ở các bệnh nhân không có đáp ứng virus điều trị vẫn có thể cải thiện được tình trạng mô học gan.* ***Xem hình 5.1.***

† *Dự kiến trước có giảm số lượng tế bào tuyệt đối nhưng ổn định về % số lượng tế bào* CD_4

¶ *Kiểm tra HCV RNA vào tuần 4; nếu không thấy giảm HCV RNA thì cực kỳ khó có khả năng đáp ứng. Trái lại, giảm ≥ 1 log là kết quả rất đáng khích lệ và nên tiếp tục điều trị. Cơ hội chữa khỏi tốt nhất là HCV RNA xuống dưới ngưỡng phát hiện ở tuần 4, đôi khi còn gọi là đáp ứng "sớm" về virus học.*

‡ *Cần cho những bệnh nhân có tiền sử bệnh võng mạc; tờ hướng dẫn sử dụng IFN khuyến cáo sàng lọc cho tất cả bệnh nhân trước khi điều trị. Nhiều nhà lâm sàng lựa chọn trì hoãn khám ban đầu mà chỉ cần theo dõi các rối loạn về thị lực và mất cảm nhận màu sắc.*

Phỏng theo: **Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 4th Edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.**

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GỢI Ý ĐỌC THÊM

GUIDELINES

Aberg JA, Kaplan JE, Libman H, et al. Primary care guidelines for the management of persons infected with human immunodeficiency virus: 2009 update by the HIV medicine Association of the Infectious Society of America. Clin Infect Dis 49:651–681, 2009.

Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection-Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV in the United States. MMWR 54(RR02): 1–20, 2005.

Guidelines for Treating Opportunistic Infections Among HIV-Infected Adults and Adolescents. www.hivatis .org. January 29, 2008.

Management of Possible Sexual, Infection-Drug-Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV, Including Considerations Related to Antiretroviral Therapy - 2005. www.hivatis.org.

Public Health Service Task Force Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1–Infected Women for Maternal Health and Interventions to Reduce Perinatal HIV-1 Transmission in the United States www.hivatis.org. November 2, 2007.

Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2010 Recommendations of the International AIDS Society - USA Panel. JAMA. 304:321–333, 2010.

Updated Public Health Service Guidelines for the management of occupational exposures to HIV and recommendations for post-exposure prophylaxis. MMWR 54(RR-9): 1–17, Sept. 30, 2005.

Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR 50(RR-11); 1–42, June 29, 2001.

TEXTBOOKS

Dolin R, Masur H, Saag MS (eds). AIDS Therapy, 2nd Edition, Churchill Livingstone, New York, 2003.

Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds). Infectious Diseases, 3rd Edition, Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th Edition, Philadelphia, Elsevier, 2010

Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR (eds). HIV Essentials. 5th Edition, Jones & Bartlett, Sudbury, MA , 2012.

Wormser GP (ed). AIDS, 4th Edition, Elsevier, Philadelphia, 2004.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TỦ SÁCH A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ISBN: 978 604 66 1886 7

BURKE A. CUNHA, MD, MACP

ANTIBIOTIC ESSENTIALS

JAYPEE

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

TẬP 2

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

BIÊN DỊCH:

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
Trưởng Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

HÀ NỘI - 2016

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

BURKE A. CUNHA, MD, MACP

ANTIBIOTIC ESSENTIALS

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Fourteenth Edition

BIÊN DỊCH:

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
Trưởng Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

BS.CKII. Nguyễn Hồng Hà
Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung
Trưởng Bộ môn Vi sinh trường Đại học Y Hà Nội
Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Nhà xuất bản Y học - 2016

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các tác giả, ban biên tập và nhà xuất bản đã nỗ lực hết sức mình để cung cấp cho độc giả các thông tin chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sai sót, lỗi sót hoặc bất kỳ hậu quả nào liên quan với sử dụng nội dung của cuốn sách này, cũng như không nhận trách nhiệm liên quan đối với các thuốc và các thủ thuật được mô tả trong sách. Các điều trị và tác dụng không mong muốn được mô tả trong cuốn sách này có thể không phải luôn áp dụng được cho tất cả mọi đối tượng; tương tự như vậy, một số đối tượng có thể cần tới liều dùng hoặc bị các tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc song không được mô tả trong sách. Thuốc và các thiết bị y tế được thảo luận trong sách có thể không có sẵn để sử dụng do được đặt dưới sự kiểm soát của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chỉ cấp phép sử dụng trong nghiên cứu hoặc các thử nghiệm lâm sàng. Nghiên cứu, thực hành lâm sàng và các quy định của nhà nước Hoa Kỳ thường xuyên thay đổi trong các tiêu chuẩn được chấp thuận trong lĩnh vực này. Khi có các cân nhắc trong sử dụng bất kỳ một thuốc nào trên lâm sàng, nhân viên y tế hoặc độc giả có trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng thuốc trên cơ sở cấp phép của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng kẹp trong hộp thuốc và xem lại các thông tin kê đơn để biết rõ các khuyến cáo cập nhật nhất về liều dùng, các thận trọng và các chống chỉ định và quyết định về việc sử dụng hợp lý đối với sản phẩm. Điều này cực kỳ quan trọng trong trường hợp dùng các thuốc là thuốc mới hoặc ít được kê dùng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cuốn **Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm** được dịch nguyên bản từ **"Antibiotic Essentials"** ISBN: 99789351523468 của Nhà xuất bản Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. tác giả Burke A. Cunha theo hợp đồng đã ký giữa Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam - XUNHASABA và Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

Bất kỳ sự sao chép, trích dẫn nào không được sự đồng ý của Công ty XUNHASABA đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ Berne.

Sách đã có bản quyền. Mọi hình thức sao chép, cắt xén, dịch thuật cả cuốn sách hay một phần đều bị nghiêm cấm. Nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Một thành viên
Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam - XUNHASABA
Địa chỉ: 32 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 84-4 39343172 | Fax: 84-4 38252860
E-mail: xunhasaba@hn.vnn.vn
Website: www.xunhasaba.com.vn

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Burke A. Cunha, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ hàng đầu của Trường môn các thầy thuốc Hoa Kỳ (MACP) là Trưởng khoa- Khoa bệnh nhiễm khuẩn tại Bệnh viện- Đại học Tổng hợp Winthrop, Mineola, New York; Giáo sư Y khoa, Đại học tổng hợp Quốc gia của trường Y New York, Stony Brook, New York và là một trong số các tác giả hàng đầu thế giới về bệnh nhiễm khuẩn. Trong sự nghiệp khoa học của mình, tác giả đã viết và chủ biên 1225 bài báo khoa học, 193 chương sách và 30 cuốn sách về bệnh nhiễm khuẩn. Tác giả cũng đã nhận nhiều giải thưởng về giảng dậy, như Giải thưởng Aesculapius cho Sự nghiệp giảng dậy nổi bật và Giải thưởng Spatz cho thành tích xuất sắc về lâm sàng và thành tích giảng dậy xuất sắc. Giáo sư là thành viên trong ban biên tập của một số tạp chí bệnh nhiễm khuẩn và là Trưởng ban biên tập của tạp chí Bệnh nhiễm khuẩn về các kiến thức Y khoa trực tuyến. Giáo sư Cunha là một Hội viên của Hiệp hội Bệnh Nhiễm khuẩn Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm Vi sinh học Hoa Kỳ, Trường môn Dược lý Lâm sàng Hoa Kỳ, Hội nhiễm khuẩn Ngoại khoa và Trường môn các Thầy thuốc Lồng ngực Hoa Kỳ. Tác giả đã quan tâm trong một thời gian dài tới chẩn đoán các hội chứng lâm sàng, lập luận chẩn đoán, điều trị kháng sinh và tình trạng để kháng lại kháng sinh của vi khuẩn, các viêm phổi không điển hình, nhiễm khuẩn ngoại khoa, các nhiễm khuẩn ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch, bệnh lây từ động vật sang người, sốt không rõ căn nguyên, viêm màng não và viêm não, viêm nội tâm mạc và nhiễm khuẩn bệnh viện. Bác sĩ Cunha là một thầy thuốc hàng đầu của Trường môn các Thầy thuốc Hoa Kỳ và là người đã được bầu chọn danh hiệu "Thành tựu suốt đời" như một Thầy thuốc Bậc thầy và Thầy giáo Bậc thầy.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỂM LƯU Ý

Các khuyến cáo điều trị trong cuốn sách này dựa trên kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng của các tác giả tham gia viết sách cũng như các hướng dẫn điều trị lâm sàng và thông tin thu thập từ y văn.

MỤC LỤC

Chương I - Tổng quan về điều trị kháng sinh	3
Chương II - Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng	29
Chương III - Đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn và điều trị kháng sinh ban đầu trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn được phân lập	321
Chương IV - Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp	407
Chương V - Nhiễm HIV	499
Chương VI - Dự phòng và tiêm chủng	575
Chương VII - Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em và các tóm tắt về thuốc dùng trong nhi khoa	625
Chương VIII - Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn dựa trên hình ảnh phim Xquang phổi	687
Chương IX - Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn	739
Chương X - Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp khi sử dụng kháng sinh	789
Chương XI- Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh	813
Phụ lục	1087
Atlas màu - (Hình ảnh nhuộm Gram bệnh phẩm dịch não-tủy, đờm và nước tiểu)	1101
Atlas màu - (Nhuộm tìm nấm)	1105
Index	1109

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương VI

DỰ PHÒNG VÀ TIÊM CHỦNG

Pierce Gardner, MD
John L. Brusch, MD
Jean E. Hage, MD
Ronald L. Nichols, MD
Staci A. Fischer, MD
Burke A. Cunha, MD

NGƯỜI DỊCH:

ThS. Nguyễn Đàm Chính
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Hồi sức-Cấp cứu, trường Đại học Y Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Chi
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dự phòng trong phẫu thuật	577
Dự phòng sau phơi nhiễm	584
Dự phòng trong các bệnh lý mạn tính	593
Dự phòng viêm nội tâm mạc	601
Dự phòng khi đi du lịch	605
Dự phòng uốn ván	612
Tiêm chủng	613
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	619

* ***Để biết thêm thông tin về dự phòng các nhiễm khuẩn cơ hội ở bệnh nhân nhiễm HIV, xem Chương V trang 499***

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT

Kháng sinh dự phòng được sử dụng nhằm mục đích dự phòng nhiễm khuẩn trong một thời gian xác định. **Dự phòng (phophylaxis) nhiều khả năng sẽ có thể đạt hiệu quả khi được cho trong một thời ngắn để chống lại một tác nhân gây bệnh duy nhất được biết rõ là còn nhạy cảm với thuốc được sử dụng** nhưng hầu như sẽ không có tác dụng dự phòng nhiễm khuẩn khi được cho trong một khoảng thời gian dài để chống lại nhiều tác nhân gây bệnh với độ nhạy cảm với kháng sinh thay đổi/hoặc không dự đoán trước được (Bảng 6.1). Một quan niệm sai lầm thường gặp là sẽ không được dùng các kháng sinh dự phòng để điều trị và ngược lại. **Thực tế là chỉ có một khác biệt giữa dự phòng và điều trị là tải lượng vi khuẩn (inoculum size) và khoảng thời gian dùng kháng sinh**: Trong dự phòng, do chưa có nhiễm khuẩn, vì vậy tải lượng vi khuẩn hầu như không có /hoặc bằng zero và chỉ dùng kháng sinh trong khoảng thời gian phơi nhiễm/hoặc trong khi làm thủ thuật ngoại khoa. Với điều trị, tải lượng vi khuẩn lớn do tình trạng nhiễm khuẩn đã hiện hữu và kháng sinh phải được dùng liên tục tới khi diệt sạch nhiễm khuẩn mới thôi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của dự phòng kháng sinh trong phẫu thuật

Số vi khuẩn gây bệnh	Dạng nhạy cảm với kháng sinh	Khoảng thời gian bảo vệ	Hiệu quả dự phòng
Một vi khuẩn gây bệnh duy nhất	Có thể dự kiến được	Ngắn	Cực kỳ tốt
Nhiều vi khuẩn gây bệnh	Có thể dự kiến được	Ngắn	Cực kỳ tốt
Một vi khuẩn gây bệnh duy nhất	Không dự kiến được	Ngắn	Tốt
Một vi khuẩn gây bệnh duy nhất	Có thể dự kiến được	Dài	Tốt
Nhiều vi khuẩn gây bệnh	Không dự kiến được	Dài	Tồi/ không có

Kháng sinh dự phòng (antibiotic prophylaxis) nhằm mục tiêu đạt được nồng độ kháng sinh trong huyết thanh/mô hữu hiệu vào thời điểm bắt đầu rạch da phẫu thuật và được duy trì trong suốt "giai đoạn có thể bị tấn công" ("vulnerable period") của thủ thuật (*giai đoạn này được xác định là khoảng thời gian từ lúc rạch da tới khi đóng da kết thúc cuộc mổ*) (Bảng 6.2). Nếu dùng kháng sinh dự phòng quá sớm, nồng độ thuốc sẽ ở dưới mức tối ưu hoặc thậm chí không còn thuốc ở thời điểm cần tới sự bảo vệ của thuốc. Một điều được mong đợi là cho dự phòng kháng sinh trước mổ đúng thời điểm để có được hiệu quả tối đa do ***kháng sinh được cho vào cơ thể sau khi đã đóng kín da sẽ không còn cơ may mang lại hiệu quả bảo vệ***. Khi có tình trạng nhiễm khuẩn trước khi phẫu thuật (Vd: phẫu thuật sạch/ phẫu thuật sạch bị nhiễm bẩn (clean contaminated surgery), ưu tiên sử dụng kháng sinh dự phòng dùng một liều duy nhất. Khi đã bị nhiễm khuẩn hoặc nhiều khả năng đã bị nhiễm khuẩn trước khi phẫu thuật (ví dụ: trường hợp phẫu thuật "bẩn" như mổ thủng đại tràng, mổ cắt u tuyến tiền liệt qua niệu đạo [TURP] ở bệnh nhân có kết quả cấy nước tiểu dương tính, phẫu thuật sửa chữa gãy xương hở), cần cho kháng sinh kéo dài hơn 1 ngày và liệu pháp kháng sinh lúc này được coi là điều trị kháng sinh sớm đối với nhiễm khuẩn chứ không phải là kháng sinh dự phòng theo đúng nghĩa. Các cephalosphorin đường tiêm thường được sử dụng để dự phòng trong phẫu thuật và thông thường được cho dưới dạng tiêm liều nạp/ truyền tĩnh mạch nhanh trong vòng 15–60 phút trước khi tiến hành thủ thuật. Dự phòng bằng vancomycin hoặc gentamicin được cho theo cách truyền tĩnh mạch chậm trong vòng 1–2 giờ, bắt đầu truyền khoảng 1–2 giờ trước khi tiến hành thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.2. Dự phòng trong ngoại khoa

Thủ thuật	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Dự phòng được ưu tiên chọn dùng	Dự phòng thay thế	Bình luận
Đặt shunt hệ thần kinh trung ương (não thất- nhĩ thất [VA]/ não thất- phúc mạc [VP]), mở hộp sọ, chấn thương sọ não hở	*S. epidermidis* (CoNS) Tụ cầu vàng (*S. aureus*) (tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin [MSSA])	*Ít khả năng do MRSA/ MRSE* Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều. *Nhiều khả năng do MRSA/MRSE* Linezolid 600mg (TM) ×1 liều.	*Ít khả năng là MRSA/MRSE:* Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều **hoặc** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều. *Nhiều khả năng là MRSA/MRSE* Linezolid 600mg (uống) ×1 liều **hoặc** Vancomycin 1 g (TM) ×1 liều **hoặc** Minocyclin 200mg (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật. Vancomycin giúp bảo vệ đối với các nhiễm khuẩn vết thương, song có thể không dự phòng được các nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương. Cho vancomycin tĩnh mạch chậm trong vòng 1 giờ trước khi tiến hành thủ thuật.
Phẫu thuật lồng ngực (không phải là phẫu thuật tim)	Tụ cầu vàng (*S.aureus*) (Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicilin [MSSA])	Cefazolin 1g (TM) ×1 liều **hoặc** Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều.	Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều **hoặc** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật.
Phẫu thuật thay van tim	*S. epidermidis* (MSSE/MRSE) Tụ cầu vàng (*S. aureus*) (MSSA/ MRSA) Enterobacter	Vancomycin 1g (TM) ×1 liều ***cộng với*** Gentamicin 120mg (TM) ×1 liều	Linezolid 600mg (TM) ×1 liều ***cộng với*** Gentamicin 120mg (TM) ×1 liều	Dùng vancomycin và gentamicin tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 1 giờ trước khi tiến hành thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phẫu thuật làm cầu nối động mạch vành (CABG)	Tụ cầu vàng (Tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin [MSSA])	Cefazolin 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều.	Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước thủ thuật. Ngoại trừ đối với ceftriaxon, dùng liều nhắc lại trong quá trình phẫu thuật đối với các thủ thuật kéo dài >3 giờ.
Phẫu thuật đường mật	*E. coli* Klebsiella *E. faecalis* (VSE)	Meropenem 1g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Piperacillin 4 g (TM) ×1 liều.	Ampicillin/ sulbactam 3g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật (không cần phải điều trị bao phủ đối với vi khuẩn kỵ khí).
Phẫu thuật gan	*E. coli* Klebsiella *E. faecalis* (VSE) *B. fragilis*	Ampicillin/ sulbactam 3 g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Piperacillin 4 g (TM) ×1 liều.	Meropenem 1 g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Moxifloxacin 400 mg (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật.
Phẫu thuật dạ dày, đoạn trên của ruột non	*S. aureus* (MSSA) Liên cầu nhóm A	Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Cefazolin 1g (TM) ×1 liều.	Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật (không cần phải điều trị bao phủ đối với vi khuẩn kỵ khí).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phẫu thuật đại tràng, đoạn xa của ruột non	*E. coli* Klebsiella *B. fragilis*	<u>Đường uống</u> Neomycin* ***cộng với hoặc*** Erythromycin base* ***hoặc*** Metronidazol* . <u>Đường tiêm</u> Ertapenem 1g (TM) ×1 liều.	Piperacillin 3g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Cefoxitin 2 g (TM) ×1 liều ***hoặc điều trị kết hợp với*** Metronidazol 1g (TM) ×1 liều ***cộng với hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (TM) ×1 liều ***hoặc*** Gentamicin 240mg (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật. Cho gentamicin tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 1 giờ.
Phẫu thuật vùng tiểu khung (phẫu thuật sản/ phụ khoa)	Trực khuẩn gram âm hiếu khí Liên cầu khuẩn kị khí *B. fragilis*	Ceftriaxon 1g(TM) ×1 liều ***cộng với*** Metronidazol 1 g (TM) ×1 liều.	Cefotetan 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Cefoxitin 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả trong chấn thương chỉnh hình (thay toàn bộ khớp háng hoặc khớp gối)	*S. epidermidis* (CoNS) *S. aureus* (MSSA)	Ít khả năng do MRSA/MRSE Cefazolin 2 g (TM) ×1 liều. Nhiều khả năng do MRSA/MRSE Vancomycin 1g (TM) ×1 liều.	Ít khả năng do MRSA/MRSE Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều. Nhiều khả năng do MRSA/MRSE Linezolid 600mg (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật. Các liều dùng sau mổ không có hiệu quả và không cần thiết.
Nội soi khớp	*S. aureus* (MSSA)	Cefazolin 1 g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều.	Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Thường không cần dùng kháng sinh dự phòng trước thủ thuật đối với các thủ thuật ngoại khoa sạch.
Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (gẫy xương hở)	*S. aureus* (MSSA) Trực khuẩn gram âm hiếu khí	Ceftriaxon 1g (TM) ×1 tuần.	Clindamycin 600mg (TM) mỗi 8h/lần ×1 tuần ***cộng với*** Gentamicin 240mg (TM) mỗi 24h/lần ×1 tuần.	Phản ánh điều trị sớm mà không phải là điều trị dự phòng "đích thực". Khoảng thời gian điều trị kháng sinh sau mổ tùy thuộc vào mức độ nặng của nhiễm khuẩn.
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả vào đường tiết niệu (urological implant surgery)	*S. aureus* (MSSA) Trực khuẩn Gram âm hiếu khí	Ceftriaxon 1g (TM) ×1 liều.	Cefotaxim 2g (TM) ×1 liều ***hoặc*** Ceftizoxim 2g (TM) ×1 liều.	Dùng thuốc ngay trước khi tiến hành thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mổ cắt u tuyến tiền liệt qua niệu đạo (TURP), soi bàng quang	*P. aeruginosa* *P. cepacia* *P. maltophilia* *E. faecalis* (VRE) Trực khuẩn Gram âm hiếu khí	Ciprofloxacin 400mg (TM) ×1 liều **hoặc** Piperacillin 4 g (TM) ×1 liều.	Levofloxacin 500mg (TM) ×1 liều **hoặc** Gatifloxacin 400mg (TM) ×1 liều.	Dự phòng được áp dụng cho các bệnh nhân mổ cắt u tuyến tiền liệt qua niệu đạo có kết quả cấy nước tiểu trước mổ dương tính. Điều trị dự phòng này phản ánh điều trị sớm chứ không phải là điều trị dự phòng đích thực. Không cần dùng kháng sinh dự phòng đối với bệnh nhân được mổ cắt u tuyến tiền liệt qua niệu đạo nếu kết quả cấy nước tiểu trước mổ âm tính.
	E. faecium (VRE)	Linezolid 600mg (TM) ×1 liều.	Quinupristin/ dalfopristin 7,5 mg/kg (TM) ×1 liều.	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Phẫu thuật tiêu hóa: Sau khi đảm bảo chế độ ăn và dùng thuốc tẩy thích hợp hoặc cho dùng 1g neomycin (đường uống) cộng với 1g erythromycin dạng base (đường uống) vào các thời điểm 13 giờ, 14 giờ và 21 giờ hoặc cho 2 g neomycin (đường uống) cộng với 2 g metronidazol (đường uống) vào các thời điểm 19 giờ, 23 giờ vào ngày trước phẫu thuật nếu dự kiến cuộc mổ vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau.*

***Các từ viết tắt*: CoNS** (coagulase-negative staphylococci): Tụ cầu với coagulase âm tính; **MSSA/ MRSA** (Methicillin-sensitive *S.aureus*/Methicillin-resistant *S.aureus*): Tụ cầu nhạy cảm/kháng với methicillin; **MSSE/MRSE** (methicillin-sensitive *S.epidermidis*/Methicillin-resistant *S.epidermidis*): *S. epidermidis* nhạy cảm /kháng với methicillin; **VRE** (vancomycin-resistant enterococci): Cầu khuẩn ruột kháng với vancomycin; **VSE** (vancomycin-sensitive entorococci): Cầu khuẩn ruột nhạy cảm với vancomycin.

DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM (BẢNG 6.3)

Một số bệnh nhiễm khuẩn có thể được dự phòng bằng kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm (post-exposure prophylaxis). Để đạt được hiệu quả tối đa, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm nên tiến hành trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp xúc do hiệu quả của dự phòng sau quá 24 giờ tiếp xúc sẽ giảm đi. Dự phòng sau phơi nhiễm thường được dành cho các đối tượng có tiếp xúc gần/hoặc mật thiết với cá nhân bị nhiễm khuẩn. Tiếp xúc ngẫu nhiên (hay không chủ định) sẽ không cần điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Bảng 6.3. Dự phòng sau phơi nhiễm

Tiếp xúc với	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Dự phòng được ưu tiên chọn dùng	Dự phòng thay thế	Bình luận
Viêm màng não	*N. meningitidis*	Bất kỳ quinolon nào (uống) ×1 liều	Minocyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 ngày ***hoặc*** Rifampin 600mg (uống) mỗi 12h/lần ×2 ngày	Phải được dùng trong vòng 24 giờ sau khi tiếp xúc gần, mặt đối mặt với người nhiễm bệnh để có hiệu quả. Các trường hợp khác, theo dõi và điều trị nếu xảy ra nhiễm khuẩn. Không dùng tetracyclin cho trẻ ≤ 8 tuổi.
	H. influenzae	Rifampin 600 mg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày	Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào ×3 ngày	Phải được dùng trong vòng 24 giờ sau khi tiếp xúc gần mặt đối mặt với người nhiễm bệnh. H. influenzae cần được điều trị dự phòng 3 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Virus cúm (cúm mùa ở người)	Virus cúm typ A hoặc B	Oseltamivir (Tamiflu) 75mg (uống) mỗi 24h/lần trong khoảng thời gian bùng phát dịch (hoặc ít nhất 7 ngày sau khi tiếp xúc gần với đối tượng bị nhiễm virus cúm). Nếu CrCl 10–30 mL/phút, cho 75mg (uống) mỗi 48h/lần‡	Rimantadin 100mg (uống) mỗi 12h/lần* trong khoảng thời gian bùng phát dịch (hoặc ít nhất 7–10 ngày sau khi tiếp xúc gần với đối tượng bị nhiễm virus cúm) ***hoặc*** Amantidin 200mg (uống) mỗi 24h/lần† trong khoảng thời gian bùng phát dịch (hoặc ít nhất 7–10 ngày sau khi tiếp xúc gần với đối tượng bị nhiễm virus cúm).	Thuốc được dùng cho các đối tượng phơi nhiễm không được tiêm phòng và các đối tượng phơi nhiễm có nguy cơ cao ngay cả khi họ đã được tiêm phòng. Bắt đầu vào lúc khởi phát vụ dịch hoặc trong vòng 3 ngày sau khi tiếp xúc gần với đối tượng bị nhiễm virus cúm. Oseltamivir có hoạt tính đối với cả virus cúm A và B; rimantadin và amantadin chỉ có hoạt tính đối với virus cúm A. Oseltamivir có thể không có hiệu quả do có tình trạng virus kháng thuốc.
Cúm gia cầm (Avian influenza)	Cúm A (H_5N_1)	Oseltamivir (như đối với virus cúm nêu ở trên).	Rimantadin ***hoặc*** Amantadin† (như đối với virus cúm nêu ở trên).	Oseltamivir có thể không có hiệu quả do có tình trạng virus kháng thuốc.
Cúm lợn (Swine influenza)	Cúm A (H_1N_1)	Oseltamavir như nêu trên.	Không có.	Amantadin/ rimantadin không có hiệu quả. Tiếp tục điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đối với virus cúm lợn (H_1N_1) x 10 ngày sau tiếp xúc gần ‡.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ho gà (Pertussis)	*B. pertussis*	Erythromycin 500 mg (uống) x mỗi 6h/lần trong 2 tuần.	TMP–SMX dạng viên nén tiêu chuẩn (TMP-SMXSS tablet) x 1 viên uống) mỗi 12h/lần x 2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24 giờ/lần x 2 tuần.	Dùng càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc. Hiệu quả bị giảm đi nhiều nếu dự phòng sau 24 giờ.
Bạch hầu (Diphtheria)	*C. diphtheriae*	Erythromycin 500mg (uống) mỗi 6 h/lần ×1 tuần ***hoặc*** Benzathin penicillin 1,2 triệu đơn vị (Tiêm bắp) ×1 liều.	Azithromycin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày.	Điều trị dự phòng càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc. Hiệu quả bị giảm đi nhiều nếu dự phòng sau 24 giờ.
Lao	*M.tuberculosis*	Rifampin 600mg (uống) mỗi 24h/lần × 4 tháng[5].	INH 300mg (uống) mỗi 24h/lần × 9 tháng.	Đối với điều trị bằng INH, theo dõi SGOT/ SGPT hàng tuần trong 4 tuần, sau đó theo dõi hàng tháng. Tăng nhẹ men gan thường gặp và tình trạng tăng này thuyên giảm một cách tự nhiên. Ngừng dùng INH nếu hoạt độ SGOT/ SGPT tăng ≥ 5 lần so với giá trị bình thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lậu cầu	*N. gonorrhoeae*	Ceftriaxon 125mg (Tiêm bắp) ×1 liều.	Spectinomycin 2g (Tiêm bắp) ×1 liều ***hoặc*** Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào × 1 liều.	Dùng càng sớm càng tốt sau khi có phơi nhiễm qua đường tình dục (≤ 72 giờ). Ceftriaxon cũng được dùng để điều trị giang mai giai đoạn ủ bệnh.
Giang mai	*T. pallidum*	Benzathin penicillin 2,4 triệu đơn vị (Tiêm bắp) ×1 liều.	Doxycyclin 100mg (uống) 12h/lần × 1 tuần.	Dùng càng sớm càng tốt sau khi có phơi nhiễm qua đường tình dục. Cần làm thêm xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán HIV.
Bệnh hạ cam (Chancroid)	*H. ducreyi*	Ceftriaxon 250mg (Tiêm bắp) ×1 liều.	Azithromycin 1g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào × 3 ngày.	Dùng càng sớm càng tốt sau khi có phơi nhiễm qua đường tình dục. Cần làm thêm xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán HIV và giang mai.
Viêm niệu đạo không do lậu cầu (non-gonococcal urethritis [NGU])	*C. trachomatis* *U. urealyticum* *M. genitalium*	Azithromycin 1g (uống) ×1 liều ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×1 tuần.	Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào ×1 tuần	Dùng càng sớm càng tốt sau khi có phơi nhiễm qua đường tình dục. Cũng cần xét nghiệm tìm lậu cầu và ureaplasma.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Varicella (thủy đậu)	VZV	*Dự phòng được ưu tiên chọn dùng*: Đối với các trường hợp phơi nhiễm dưới 72 giờ: cho dùng globulin miễn dịch kháng varicella-zoster (VZIG) liều 625 µg (Tiêm bắp) ×1 liều ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ có thai (đặc biệt là khi có tình trạng hô hấp). Đối với các trường hợp khác hoặc phơi nhiễm trên 72 giờ, xem xét dùng acyclovir 800mg (uống) 5 lần/ ngày × 5–10 ngày. *Điều trị thay thế*: Vaccin thủy đậu 0,5 mL (Tiêm dưới da) ×1 liều. Nhắc lại trong vòng 4 tuần.		Dùng càng sớm càng tốt sau phơi nhiễm (≤ 72 giờ). Vaccin thủy đậu là loại vaccin sống giảm độc lực, do vậy không được sử dụng cho người bị suy giảm miễn dịch hoặc phụ nữ có thai. Nếu xuất hiện triệu chứng của thủy đậu, dùng acyclovir theo phác đồ điều trị ngay lập tức.
Viêm gan A do virus	Virus viêm gan A (HAV)	Vaccin phòng virus viêm gan A 1 mL (Tiêm bắp) x một liều duy nhất.	Huyết thanh chứa globulin miễn dịch 0,02 mL/kg (Tiêm bắp) ×1 liều.	Chỉ tiến hành tiêm vaccin phòng virus viêm gan A đơn độc sau phơi nhiễm trong thời gian 14 ngày.
Viêm gan B do virus	Virus viêm gan B (HBV)	*Chưa được tiêm phòng vaccin viên gan B trước đó*: Globulin miễn dịch chống viêm gan B (HBIG) 0,06 mL/ kg (Tiêm bắp) ×1 liều ***cộng với*** vaccin phòng virus viêm gan B (40 µg kháng nguyên HBs/ mL) tiêm bắp sâu cơ delta vào các tháng 0, 1, 6 (Có thể dùng liều 10µg ở người khỏe mạnh dưới 40 tuổi.	*Đã được tiêm vaccin phòng viêm gan trước đó*: Đối tượng được biết chắc chắn có đáp ứng miễn dịch (nồng độ kháng thể kháng HBsAg ≥ 10 IU/mL): không cần điều trị. Đối tượng được biết chắc chắn không có đáp ứng miễn dịch: (nồng độ kháng thể kháng HBsAg < 10 IU/mL): Xử trí như đối với trường hợp chưa được tiêm phòng vaccin. Tình trạng đáp ứng kháng thể không được biết: Tiến hành xét nghiệm nồng độ kháng thể kháng HBsAg để xác định tình trạng miễn dịch của đối tượng. Nếu không thể tiến hành xét nghiệm hoặc không có được kết quả xét nghiệm trong 24 giờ sau phơi nhiễm, cho bệnh nhân dùng globulin miễn dịch chống viêm gan B (HBIG) cộng với một liều vaccin phòng viêm gan B (tiêm phòng nhắc lại).	

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan C do virus	Virus viêm gan C (HCV)	Không có.		
Sốt đốm Rocky Mountain	*R. rickettsia*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần ×1 tuần.	Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào ×1 tuần.	Dùng kháng sinh dự phòng sau khi lấy bỏ ve gây bệnh khỏi bệnh nhân.
Bệnh Lyme	*B. burgdorferi*	Doxycyclin 200mg (uống) ×1 liều.	Amoxicillin* 1 g (uống) mỗi 8h/lần ×3 ngày ***hoặc*** Bất kỳ một cephalosporin* thế hệ 1 nào dùng đường uống × 3 ngày ***hoặc*** Azithromycin* 500 mg (uống) mỗi 24h/lần ×3 ngày.	Nếu ve vẫn còn bám tại chỗ trên da bệnh nhân quá 72 giờ hoặc nhìn con ve đã hút căng máu, sau khi lấy bỏ ve khỏi cơ thể bệnh nhân có thể cho kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng thường không được khuyến cáo trong các trường hợp khác.
		* *Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên dự phòng kháng sinh với liều đơn (single-dose prophylaxis) bằng cách thuốc nói trên có thể vẫn có hiệu quả.*		

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

** Đối với người có tuổi, bị rối loạn chức năng gan nặng hoặc CrCl <10 mL/phút: 100 mg (uống) mỗi 24h/lần.*

† Đối với tuổi ≥ 65: cho dùng 100 mg (uống) mỗi 24h/lần. Đối với người bị suy giảm chức năng thận: cho dùng liều nạp 200 mg (Uống) sau đó dùng liều 100 mg mỗi 24h/lần (nếu CrCl 30 – 50 mL/phút) hoặc 100 mg mỗi 48h/lần (nếu CrCl 15 – 29 mL/phút) hoặc 200 mg mỗi tuần (nếu CrCl <15 mL/phút).

‡ Dự phòng đối với trẻ em: < 15 kg: 30 mg (Uống) x 1 lần/ngày trong 10 ngày; >15 - 24 kg: 45 mg (uống) x 1 lần/ngày trong 10 ngày; 24 - 40 kg: 60 mg (Uống) x 1 lần/ngày trong 10 ngày; > 40 kg: liều giống như người lớn.

§ INH được ưu tiên chọn dùng nếu bệnh nhân sử dụng kính áp tròng, nhiễm HIV hoặc đang dùng các thuốc có tương tác với rifampin.

Từ viết tắt: **TMP/SMX** Tablets Single strength (SS: 80/mg/400mg): **TMP/SMX** dạng viên nén

liều đơn; TMP/SMX Tablets Double strength (DS: 160/800mg): TMP/SMX viên nén dạng liều gấp đôi; **HAV** (Hepatitis A virus): Virus gây viêm gan A; **HBV** (Hepatitis B virus): Virus gây viêm gan B; **HCV** Hepatitis C virus): Virus gây viêm gan; **HBV** vaccine: Vaccin chống virus viêm gan B; **HBIG** (Hepatitis B immune globulin): Globulin miễn dịch đối với virus viêm gan B; **VZIG** (varicella-zoster immune globulin): Globulin miễn dịch đối với virus thủy đậu; **NGU** (Non-gonococcal urethritis): Viêm niệu đạo không do cầu khuẩn lậu gây nên; **VZV**(Varicella zoster virus): virus thủy đậu.

Bảng 6.3. Kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm (tiếp)

Tiếp xúc với	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Bệnh lây từ động vật sang người (dịch hạch, bệnh than)	*B. anthracis* *Y. pestis*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần trong thời gian phơi nhiễm.	Bất kỳ một quinolon dùng đường uống nào trong thời gian phơi nhiễm.	Tiếp tục dùng kháng sinh dự phòng trong suốt khoảng thời gian phơi nhiễm mắc phải xảy ra một cách tự nhiên/trong đợt bùng phát dịch. Xem thêm trang 363 về các khuyến cáo đối với thảm họa bệnh dịch than/ khủng bố sinh học.
Bệnh dại	Virus dại	<u>Chưa tiêm phòng vaccin trước đó:</u> Huyết thanh kháng virus dại (HRIG) 20 IU/ kg** ***cộng với:*** PCEC 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta ***hoặc*** RVA 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta ***hoặc*** HDCV 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta. PCEC, RVA, HDCV được dùng vào các ngày 0, 3, 7, 14 và 28 sau phơi nhiễm.	<u>Đã tiêm vaccin và có miễn dịch từ trước:</u> PCEC 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta các ngày 0 và 3 ***hoặc*** RVA 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta các ngày 0 và 3 ***hoặc*** HDCV 1 mL (Tiêm bắp) vào cơ delta các ngày 0 và 3.	Theo dõi nếu bị chó hoặc mèo nghi ngờ bị nhiễm virus dại hoặc đột nhiên cắn chủ, cần tiêm phòng dại ngay nếu con vật nuôi xuất hiện biểu hiện dại trong giai đoạn 10 ngày theo dõi. Nếu chó/ hoặc mèo cắn nghi đang bị dại, cần bắt đầu tiêm ngay vaccin theo phác đồ. Một số động vật hoang dại khác: gấu trúc Mỹ, chồn hôi, dơi, cáo và hầu hết các thú ăn thịt hoang dã khác cắn người cần được coi như bị chó dại cắn và nạn nhân bị cắn cần được tiêm vaccin chống dại ngay lập tức (liên lạc với cơ sở phòng chống dịch địa phương để biết được nguy cơ mắc bệnh dại của các động vật tại địa phương). Tất cả các vết thương tiềm ẩn nguy cơ truyền virus dại cần được rửa bằng xà phòng và nước ngay lập tức một cách kỹ lưỡng. Không tiêm vaccin chống dại đường tĩnh mạch (có thể gây tụt huyết áp/ sốc). Bệnh huyết thanh có thể xảy ra khi dùng HDCV.

** *Nên tiêm toàn bộ hoặc gần như cả liều globulin miễn dịch kháng dại dùng cho người (HRIG) vào*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

vết thương và phần huyết thanh còn lại được tiêm bắp vào cơ delta. Không được tiêm globulin miễn dịch kháng dại tại cùng vị trí hoặc dùn cùng một bơm tiêm với các loại vaccin dại khác (PCEC, RVA hoặc HDCV).

***Các từ viết tắt*: HDCV** (human diploid cell vaccine): Vaccin sản xuất từ tế bào lưỡng bội của người; **HRIG** (human rabies immune globulin): Globulin miễn dịch kháng dại dùng cho người; **PCEC** (purified chick embryo cells): Tế bào phôi gà tinh chế; **RVA** (rabies vaccine Absorbed): Vaccin dại hấp phụ.

Bảng 6.3. Dự phòng sau phơi nhiễm (tiếp)

Tiếp xúc với	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Các chất khủng bố sinh học				
Bệnh than (Anthrax) Lây qua đường hít/ hoặc qua da	*B. anthracis*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x60 ngày ***hoặc*** Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần x60 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x60 ngày.	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 8h/lần x60 ngày.	Khoảng thời gian dùng kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm đối với bệnh than được dựa trên giai đoạn ủ bệnh dài nhất đối với các bào tử của vi khuẩn được hít vào trong các lỗ mũi của người bị tác động.
Viêm phổi tularemia	*F. tularensis*	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x2 tuần.	Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần x2 tuần ***hoặc*** Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h x2 tuần.	Khoảng thời gian dùng kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm đối với bệnh tularmia là 2 tuần, mà không phải là 1 tuần như đối với dịch hạch.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dịch hạch phổi (Pneumonic plague)	*Y. pestis*	Doxycyclin 100mg. (uống) mỗi 12h/lần x7 ngày ***hoặc*** Ciprofloxacin 500mg (uống) mỗi 12h/lần x7 ngày ***hoặc*** Levofloxacin 500 mg (uống) mỗi 24hx7 ngày.	Chloramphenicol 500mg (uống) mỗi 6h/lần x7 ngày.	Dịch hạch phổi cần được xem xét như một trường hợp bị khủng bố sinh học do hầu hết các trường hợp dịch hạch phổi tự nhiên đều nằm trong bệnh cảnh bệnh dịch hạch (bubonic plague).
Đậu mùa	Variola virus	Tiêm phòng vaccin đậu mùa nếu tiếp xúc trong vòng 4 ngày.	Không.	Vaccin đậu mùa có tác dụng bảo vệ khi được pha loãng 1:5.
Xuất huyết do virus	Sốt Lassa	Ribavarin liều nạp 35mg/kg (uống) (tổng liều không quá 2,5 g), sau đó dùng liều duy trì 15mg/kg (uống) (tổng liều không quá 1g) mỗi 8h/lần x 10 ngày	Không.	Giảm liều duy trì xuống 7,5 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần nếu CrCl < 50/ mL/phút.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

DỰ PHÒNG TRONG CÁC BỆNH LÝ MẠN TÍNH (*BẢNG 6.4*)

Một số bệnh nhiễm khuẩn mạn tính có xu hướng tái phát/ hoặc mắc lại do vậy liệu pháp điều trị ức chế lâu dài/ hoặc ngắt quãng (intermittent or chronic suppressive therapy) có thể mang lại lợi ích nhất định. Mục tiêu của điều trị dự phòng lâu dài là nhằm để giảm thiểu tần suất mắc cũng như mức độ nặng của các đợt nhiễm khuẩn tái phát.

Bảng 6.4. Dự phòng trong bệnh lý nội khoa mạn tính

Rối loạn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Dự phòng được ưu tiên chọn dùng	Điều trị dự phòng thay thế	Bình luận
Không có lách/ suy giảm chức năng lách	*S. pneumoniae* *H. influenzae* *N. meningitidis*	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 24h/lần, thời gian dùng kéo dài chưa được xác định.	Quinolon đường hô hấp* (uống) mỗi 24h/lần, thời gian dùng kéo dài chưa được xác định.	Dự phòng dài ngày có hiệu quả. Có thể dùng vaccin song không phải lúc nào cũng có tác dụng bảo vệ hiệu quả. Dùng amoxicillin cho trẻ em.
Nhiễm khuẩn tiết niệu (tái phát)	Trực khuẩn Gram (-) Cầu khuẩn ruột (Enterococci)	Nitrofurantoin 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 6 tháng.	Amoxicillin 500mg (uống) mỗi 24h/lần x6 tháng ***hoặc*** TMP–SMX 1 viên nén tiêu chuẩn (SS tablet) (uống) mỗi 24h/lần x6 tháng.	Dự phòng đối với các nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát (nếu tái phát ≥3 đợt/năm). Các trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu bị mắc lại cần được thăm dò tìm sỏi, ápxe hoặc có các bất thường về cấu trúc hệ tiết niệu.
Có vi khuẩn niệu (bacteriuria) không có triệu chứng ở phụ nữ có thai	Trực khuẩn Gram (-)	Nitrofurantoin 100mg (uống) mỗi 24h/lần x1 tuần.	Amoxicillin 1g (uống) mỗi 24h/lần x1 tuần.	Kháng sinh dự phòng nhằm mục đích ngăn ngừa các nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu chứng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dự phòng nhiễm khuẩn nấm ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt[†]	*Candida albicans* *Candida không phải albicans* Aspergillus	Posaconazol 200mg (uống) mỗi 8h/lần ***hoặc*** Itraconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần.		Duy trì kháng sinh dự phòng đến khi hết tình trạng giảm bạch cầu hạt (số lượng tuyệt đối bạch cầu hạt ≥500 /mm^3).
Nhiễm Herpes sinh dục tái phát (< 6 đợt/ năm)	*H. simplex* (HSV-2)	Famciclovir 125mg (uống) mỗi 12h/lần x5 ngày ***hoặc*** Valacyclovir 500mg (uống) mỗi 24h/lần x5 ngày.	Acyclovir 200mg (uống) x 5 lần/ngày x 5 ngày.	Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt sau khi tổn thương xuất hiện (đối với bệnh nhân nhiễm HIV, xem thêm chương V) Famciclovir 1 g (uống) mỗi 12 giờ/lần x1 ngày. có thể giảm tiến triển tổn thương trong 2 ngày.
Nhiễm Herpes sinh dục tái phát (>6 đợt/năm)	*H. simplex* (HSV-2)	Famciclovir 250mg (uống) mỗi 12h/lần x1 năm ***hoặc*** Valacyclovir 1g (uống) mỗi 24h/lần x1 năm.	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 12h/lần x1 năm.	Điều trị ức chế được chỉ định đối với các bệnh nhân thường xuyên bị tái phát (đối với bệnh nhân nhiễm HIV, ***xem thêm chương V)***.
Đợt tiến triển nặng cấp của viêm phế quản mạn tính (AECB)	*S. pneumoniae* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Moxifloxacin 400mg hoặc levofloxacin 500mg hoặc gatifloxacin 400mg hoặc gemifloxacin 320mg (uống) mỗi 24h/lần x5 ngày ***hoặc*** Amoxicillin/ acid clavulanic XR 2 viên nén (uống) mỗi 12h/lần x5 ngày ***hoặc*** Clarithromycin XL 1g (uống) mỗi 24h/lần x5 ngày ***hoặc*** Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 12h/lần x5 ngày ***hoặc*** Azithromycin 500mg (uống) x3 ngày.		Điều trị từng đợt bệnh tiến triển riêng biệt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Thấp khớp cấp (ARF)	Liên cầu nhóm A	Benzathin penicillin 1,2 triệu đơn vị (Tiêm bắp) 1 tháng/lần tới khi bệnh nhân 30 tuổi.	Amoxicillin 500mg (uống) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Azithromycin 500 mg (uống) mỗi 72h/lần tới khi bệnh nhân 30 tuổi.	Viêm họng và thấp tim cấp do liên cầu nhóm A nói chung ít gặp sau tuổi 30.
Nhiễm khuẩn do liên cầu nhóm B ở trẻ sơ sinh (dự phòng tiên phát)	Liên cầu nhóm B	Ampicillin 2 g (TM) mỗi 4h/ lần vào khi sản phụ bắt đầu chuyển dạ tới khi thai ra.	Clindamycin 600 mg (TM) mỗi 8 giờ/ lần khi sản phụ bắt đầu chuyển dạ tới khi thai ra ***hoặc*** Vancomycin 1g (TM) mỗi 12h/lần khi sản phụ bắt đầu chuyển dạ tới khi thai ra.	Chỉ định: sản phụ có con trước bị nhiễm khuẩn do liên cầu nhóm B; người mẹ có vi khuẩn cư ngụ / hoặc nhiễm khuẩn liên cầu nhóm B trong khi có thai; cấy dịch âm đạo/ hoặc trực tràng mọc liên cầu nhóm B sau tuần 35 của thai kỳ; thai ra ≤ 37 tuần của thai kỳ mà không có chuyển dạ/ hoặc rách màng ối; có vỡ ối ≥12 giờ; hoặc nhiệt độ trong cuộc đẻ ≥ 38°C.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Levofloxacin 500mg (uống) mỗi 24h/lần hoặc moxifloxacin 400mg (uống).*

† *Trong khi điều trị hóa chất chống ung thư đối với laxêmi cấp thể tủy hoặc hội chứng rối loạn sinh tủy.*

Các từ viết tắt: **AECB** (Acute exacerbation of chronic bronchitis): Đợt tiến triển nặng cấp của viêm phế quản mạn; **ARF** (Acute rheumatic fever): Thấp tim cấp.

Bảng 6.5. Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (Pre-Exposure Prophylaxis)

Phơi nhiễm	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Các phơi nhiễm lặp lại nhiều lần với đối tượng tiềm tàng nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)	HIV	Truvada 1 viên (uống) mỗi 24 giờ/ lần x 90 ngày (kiểm tra lại tình trạng nhiễm HIV).		Tránh dùng thuốc nếu CrCl < 60 mL/ phút. Tránh dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

Bảng 6.6. Dự phòng sau phơi nhiễm HIV

Phơi nhiễm	Phác đồ được ưu tiên chọn dùng	Phác đồ được khuyến cáo	Phác đồ thay thế được khuyến cáo	Bình luận
HIV	**Truvada** 1 viên (uống) mỗi 24 h/ lần [tenofovir 300mg (uống) mỗi 24h/lần + emtricitibin 200mg (uống) mỗi 24h/lần] x4 tuần ***cộng với*** Raltagravir 400mg (uống) mỗi 12h/lần x 4 tuần.	**Truvada** 1 viên (uống) mỗi 24h/lần [tenofovir 300mg (Uống) mỗi 24h/lần + emtricitibin 200mg (uống) mỗi 24h/lần] x 4 tuần ***cộng với*** (một trong các thuốc sau) Darunavir 800mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 tuần ***hoặc*** Atazanavir 300mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 tuần ***hoặc*** Fosamprevir 1400 mg (uống) mỗi 24h/ lần x 4 tuần ***cộng với*** Ritonavir 100mg (uống) mỗi 24h/lần x 4 tuần.	**Truvada** 1 viên (uống) mỗi 24h/lần [tenofovir 300mg (uống) mỗi 24h/ lần + emtricitibin 200mg (uống) mỗi 24h/lần] x 4 tuần ***cộng với*** Zidovudin 300mg (uống) mỗi 12h/lần x 4 tuần ***hoặc*** **Truvada** 1 viên (uống) mỗi 24h/lần [tenofovir 300mg (uống) mỗi 24h/ lần + emtricitibin 200mg (Uống) mỗi 24h/lần] x 4 tuần ***cộng với*** **Kaletra** 2 viên (uống) mỗi 12h/lần [lopinavir 200mg (uống) mỗi 12h/ lần + ritonavir 50mg (uống) mỗi 12h/lần] x4 tuần	Nhanh chóng rửa sạch vị trí tiếp xúc bằng xà phòng và nước sạch (chạm vào vết thương hở hoặc kim tiêm), xối rửa niêm mạc bằng nước sạch nếu tiếp xúc vào niêm mạc. Liệu pháp dự phòng sau phơi nhiễm thực hiện càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong 2 giờ và không quá 36 giờ. Xét nghiệm HIV tại tháng thứ 1, 3 và 6 sau phơi nhiễm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.7: HIV: Dự phòng các nhiễm khuẩn cơ hội

Bệnh lý	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Chỉ định dự phòng	Biện pháp
HIV	PCP	$CD_4 < 200/mm^3$.	TMP-SMX: uống 1 viên liều đơn chuẩn (SS tablet) hoặc 1 viên liều gấp đôi (DS tablet) mỗi 24h/lần ***hoặc*** Atovaquone 1500mg (uống) mỗi 24h/lần.
	Lao	Test bì với tuberculin (PPD) >5mm (hiện tại hoặc trong quá khứ) hoặc có tiếp xúc với những trường hợp bệnh lao hoạt động.	INH: 300mg (uống) mỗi 24h/lần x9 tháng. Rifabutin: Liều được dựa trên phác đồ điều trị thuốc chống retrovirus hiện đang dùng x4 tháng.
	Toxoplasma	IgG (+) và $CD_4 < 100/mm^3$.	TMP-SMX: Uống 1 viên liều gấp đôi (DS tablet) mỗi 24h/lần.
	Nhiễm *Mycobacterium avium* nội bào (MAI)	$CD_4 < 50/mm^3$.	Azithromycin: 1200mg (uống) mỗi tuần /lần.
	Phế cầu *(S. pneumoniae)*	$CD_4 > 200/mm^3$.	Vaccin chống phế cầu.
	Viêm gan B (HBV)	Các bệnh nhân nhạy cảm.	vaccin viêm gan B.
	Viêm gan A (HAV)	Các bệnh nhân nhạy cảm.	vaccin viêm gan A.
	Influenza	Tất cả bệnh nhân.	Tiêm vaccin cúm hàng năm.
	VZV	$CD_4 > 200/mm^3$, kháng thể kháng VZV âm tính.	vaccin chống virus thủy đậu (VZV).

Các từ viết tắt: **PCP** (*Pneumocystis [carinii] jiroveci pneumonia*): Viêm phổi do *pneumocystis (carinii) jiroveci*; **TMP/SMX** Tablets Single strength (SS: 80/mg/400 mg): TMP/SMX dạng viên nén liều đơn; **TMP/SMX** Tablets Double strength (DS: 160/800mg): TMP/SMX viên nén dạng liều gấp đôi; **PPD** (tuberculin skin test): Test da với tuberculin hay phản ứng Mantoux; **MAI** (Mycobacterium avium intracellulaire): Nhiễm Mycobacterium avium nội tế bào; **HBV** (Hepatitis B virus): Virus gây viêm gan B; **HAV** (Hepatitis A virus): Virus gây viêm gan A; **VZV** (Varicella zoster virus): Virus thủy đậu.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.8. Dự phòng ở bệnh nhân ghép tạng (ghép tủy xương/ghép tạng đặc)

Phơi nhiễm	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị được ưu tiên chọn dùng	Điều trị thay thế	Bình luận
Herpes simplex (HSV)	*Herpes simplex*	*Nhiễm HSV < 6 đợt tái phát / năm* Valacyclovir 500mg (uống) mỗi 24h/lần ×30 ngày ***hoặc*** Famciclovir 1 g (uống) mỗi 12h/lần ×30 ngày. *Nhiễm HSV > 6 đợt tái phát/năm* Valacyclovir 1g (uống) mỗi 24h/lần × 90 ngày ***hoặc*** Famciclovir 250mg (uống) mỗi 12h/lần ×30 ngày.	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần × 30 ngày sau ghép tủy xương. Acyclovir 400mg (uống) 8h/lần× 90 ngày sau ghép tủy.	*Dự phòng cấp:* Hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn do HSV sau ghép xảy ra dưới 1 tháng. Người được ghép tạng được dự phòng nhiễm CMV bằng ganciclovir hoặc valganciclovir cũng được bảo vệ đối với HSV (Xem thêm dự phòng CMV). *Dự phòng dài ngày* Valacyclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Famciclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần ***hoặc*** Acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Virus thủy đậu (Varicella zoster virus [VZV])	Virus thủy đậu [VZV]	*Người nhận có xét nghiệm huyết thanh học với VZV dương tính* Valacyclovir 500mg (uống) mỗi 12h/lần sau ghép x 4 – 24 tháng.	Acyclovir 400mg (uống) mỗi 8h/lần sau ghép x 4 – 24 tháng.	Các nhiễm khuẩn do VZV sau ghép xảy ra muộn hơn so với do nhiễm HSV. Trên 95% người trưởng thành có xét nghiệm huyết thanh học với VZV dương tính. Ở người được ghép tạng, hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn do VZV do virus tái hoạt động (reactivation) hơn là do nhiễm khuẩn tiên phát. Bệnh nhân có thể xuất hiện bệnh zona sau khi ngừng điều trị dự phòng.
		Người nhận có xét nghiệm huyết thanh học với VZV âm tính (tạng ghép có huyết thanh học với VZV dương tính) Valacyclovir 1g (uống) mỗi 8h/lần sau ghép x 4 – 24 tháng.	Acyclovir 800mg (uống) 5 lần/ngày sau ghép x 4 – 24 tháng.	Người nhận tạng ghép nếu đang điều trị dự phòng CMV bằng gangcyclovir hoặc valganciclovir không cần dự phòng đối với VZV.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cytomegalo-virus (CMV)	Ghép tạng đặc Người cho (+)/ người nhận (-); người cho (+)/ người nhận (+); người cho (-) / người nhận (+)	Valganciclovir 900mg (uống) mỗi 24h/lần x 3–6 tháng.	Ganciclovir 5mg/kg (TM) mỗi 24h/lần x 3 – 6 tháng.	Ngoài dự phòng, điều trị ngăn chặn trước (preemptive therapy) cũng có thể được dùng. Khi định lượng CMV theo kỹ thuật PCR/ nồng độ kháng nguyên pp65 trong máu trở nên dương tính hoặc tăng lên. Người cho (-)/người nhận (-): Bệnh nhân nên được truyền máu có CMV âm tính và hồng cầu đã được làm sạch bạch cầu (leukocyte depleted RBCs), song không cần điều trị thuốc kháng virus dự phòng.
PCP	Ghép tủy/ ghép tạng đặc (với bệnh mảnh ghép chống lại cơ thể vật chủ [GVHD])	TMP-SMX: Uống 1 viên liều đôi (DS tablet) 1 tuần/lần x ×12 tháng.	TMP-SMX: Uống 1 viên liều đơn (SS tablet mỗi 24h/lần x 12 tháng ***hoặc*** Atovaquone 1500mg (uống) mỗi 24h/lần ×12 tháng (trong bữa ăn).	Xem phần tóm tắt về thuốc để biết các tương tác thuốc.
Toxoplasma	Ghép tim	TMP-SMX uống 1 viên liều đôi (viên nén dạng DS) mỗi 24h/lần.	Atovaquone 1500 mg (uống) mỗi 24h/lần (trong bữa ăn).	Xem thêm phần tóm tắt về thuốc để biết các tương tác thuốc.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Candida sp.	Ghép gan/ tụy	Fluconazol 400mg (TM/ Uống) mỗi 24h/ lần ×4 tuần.	Posaconazol 200mg (uống) mỗi 8h/lần ×4 tuần.	Xem thêm phần tóm tắt về thuốc để biết các tương tác thuốc.
Aspergillus sp.	Ghép tủy xương/ Ghép phổi lấy từ người hiến tạng (Allogeneic transplants)	Voriconazol 200mg (uống) mỗi 12h/lần.	Posaconazol 200mg (uống) mỗi 8h/lần.	Cho đến lúc tủy xương được ghép hoạt động chức năng bình thường; thời gian dùng thuốc trong ghép phổi chưa xác định. Xem thêm phần tóm tắt về thuốc để biết các tương tác thuốc.

Từ viết tắt: GVHD graft vs. host disease: Bệnh mảnh ghép chống lại cơ thể vật chủ; **HSV** (Herpes simplex): virus Herpes simplex; **CMV**: Cytomegalovirus; **PCP** (*Pneumocystis [carinii] jiroveci*): Viêm phổi do *Pneumocystis (carinii) jiroveci.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

DỰ PHÒNG TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC (CÁC BẢNG TỪ 6.9 ĐẾN 6.11)

Dự phòng viêm nội tâm mạc hiện tại chỉ được khuyến cáo đối với các trường hợp có viêm nội tâm mạc từ trước, phẫu thuật thay van tim nhân tạo, một số bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh có tím song chưa được tiến hành sửa chữa, bao gồm đặt shunt và đường dẫn làm giảm triệu chứng (palliative shunts and conduits), các khuyết tật tim bẩm sinh được sửa chữa hoàn chỉnh bằng chất liệu/thiết bị nhân tạo (được thực hiện bằng cách phẫu thuật hoặc bằng can thiệp qua catheter trong vòng 6 tháng đầu sau thủ thuật), bệnh tim bẩm sinh đã được sửa chữa song có các khuyết tật tồn dư nằm gần với vị trí đặt tấm vá/thiết bị bộ phận giả và ghép tim ở trường hợp có bệnh lý van tim.

Bảng 6.9. Các chỉ định trước đây để điều trị dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn *

Bệnh lý	Các dự phòng được khuyến cáo (Cột A)	Các dự phòng không khuyến cáo (Cột B)
Tim mạch	• Thông liên nhĩ lỗ thông tiên phát (ostium primum). • Van tim nhân tạo, bao gồm cả van nhân tạo sinh học (bioprosthetic valves) và ghép van tim đồng loại (homograft valves). • Tiền sử bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. • Hầu hết các dị tật tim bẩm sinh. • Bệnh van tim do thấp tim. • Bệnh cơ tim phì đại. • Sa van hai lá (MVP) kèm theo tình trạng hở van hai lá có ý nghĩa. • Hẹp động mạch chủ canxi hóa.	• Thông liên nhĩ lỗ thông thứ phát (ostium secundum) đơn độc. • Thông liên nhĩ lỗ thông thứ phát hoặc còn ống động mạch đã được phẫu thuật sửa chữa và không còn khuyết tật tồn dư quá 6 tháng. • Tiền sử phẫu thuật làm cầu nối động mạch vành. • Sa van hai lá (MVP) không có tình trạng hở van hai lá. • Các tiếng thổi sinh lý, chức năng hoặc không có biểu hiện lâm sàng. • Tiền sử bị bệnh lý tim mạch do bệnh Kawasaki hoặc thấp tim song không có bệnh lý van tim.
Thủ thuật	• Các thủ thuật nha khoa được biết có thể gây chảy máu lợi/ chảy máu niêm mạc, kể cả làm vệ sinh răng lấy cao răng. • Cắt amiđan hoặc nạo VA. • Các phẫu thuật tác động đến niêm mạc ruột hoặc hô hấp. • Soi bàng quang hoặc nong niệu đạo. • Đặt catheter niệu đạo hoặc phẫu thuật đường tiết niệu nếu có nhiễm khuẩn tiết niệu. • Phẫu thuật tiền liệt tuyến. • Chích rạch và dẫn lưu mô bị nhiễm khuẩn. • Sinh thiết niêm mạc hô hấp bị nhiễm khuẩn hoặc da/mô mềm bị nhiễm khuẩn. • Tất cả các loại thủ thuật ngoại khoa can thiệp vào trường nhiễm khuẩn.	• Các thủ thuật nha khoa không có khả năng gây chảy máu lợi. • Đặt ống mở màng nhĩ. • Soi phế quản ống mềm ± sinh thiết. • Đặt ống nội khí quản. • Nội soi tiêu hóa ± sinh thiết. • Mổ lấy thai. • Nong và nạo cổ tử cung (D&C), đặt/ tháo bỏ dụng cụ tử cung hoặc đình chỉ thai nghén khi không có nhiễm khuẩn. • Đặt máy tạo nhịp tim/ hoặc máy khử rung tim tự động. • Đặt stent mạch vành. • Can thiệp mạch vành qua da (PTCA). • Thông tim.

* *Wilson W, et al. Prevention of Infective Endocarditis. Circulation 116:1736–1754, 2007.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các từ tiếng Anh viết tắt: D & C (dilatation and curettage): Nong và nạo cổ tử cung; I & D (incision and drain): Trích rạch và dẫn lưu, **MVP** (mitral valve prolapse): Sa van ba lá; PDA (patent ductus arteriosus): Còn ống động mạch.

* *Dự phòng được chỉ định cho những bệnh nhân có bệnh lý tim thuộc cột A được tiến hành các thủ thuật trong cột A. Không khuyến cáo dự phòng cho các bệnh nhân ở cột B hoặc khi làm các thủ thuật trong cột B. Xem thêm* ***bảng 6.10 và 6.11*** *về phác đồ dự phòng khi thực hiện các thủ thuật phía trên và phía dưới eo.*

Bảng 6.10. Dự phòng viêm nội tâm khi thực hiện các thủ thuật phía trên eo (răng, miệng, thực quản, đường hô hấp) *

Dự phòng**	Phản ứng với Penicillin.	Phác đồ kháng sinh
Dự phòng theo đường uống.	Không bị.	Amoxicillin 2g (uống) 1 giờ trước khi làm thủ thuật.†
	Không phải là phản vệ.	Cephalexin 1g (uống) 1 giờ trước khi làm thủ thuật.
	Phản ứng phản vệ.	Clindamycin 300 mg (uống) 1 giờ trước khi làm thủ thuật. ††
Dự phòng theo đường tĩnh mạch	Không bị.	Ampicillin 2g (TM) 30 phút trước khi làm thủ thuật.
	Không phải là phản vệ.	Cefazolin 1g (TM) 15 phút trước khi làm thủ thuật.
	Phản ứng phản vệ.	Clindamycin 600mg (TM) 30 phút trước khi làm thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Dự phòng viêm nội tâm mạc hướng trực tiếp đến liên cầu viridans (viridants streptococci), một tác nhân gây bệnh thường gặp của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp khu vực phía trên eo Phác đồ dùng kháng sinh nhóm macrolid hiệu quả kém hơn so với các phác đồ điều trị khác; Phác đồ điều trị bằng clarithromycin/ azithromycin (500mg uống 1 giờ trước khi làm thủ thuật) không chứng minh là có hiệu quả.*

** *Ưu tiên dùng thuốc dự phòng đường uống hơn dùng đường tĩnh mạch. Ngoại trừ các bệnh nhân đã có tiền sử viêm nội tâm mạc từ trước, có shunt hoặc phẫu thuật thay van tim.*

† *Một số tác giả khuyến cáo là với liều 3 g được cho là quá cao so với mức nhạy cảm được biết của liên cầu viridants với amoxicillin.*

†† *Một số tác giả khuyến cáo dùng clindamycin liều 600 mg, tuy nhiên liều 300 mg đã đạt được một nồng độ thuốc trong máu thỏa đáng và được bệnh nhân dung nạp tốt hơn (gây ỉa chảy ít hơn).*

Bảng 6.11. Dự phòng viêm nội tâm mạc khi thực hiện các thủ thuật phía dưới eo (niệu sinh dục, dạ dày-ruột) có tác động tới trường nhiễm khuẩn. *†

Dự phòng**	Phản ứng với Penicillin	Phác đồ kháng sinh
Dự phòng theo đường uống	Không bị	Amoxicillin 2g (uống) 1 giờ trước khi làm thủ thuật.
	Có hoặc không có phản ứng phản vệ.	Linezolid 600mg (uống) 1 giờ trước khi làm thủ thuật.
Dự phòng theo đường tĩnh mạch.	Không bị	Ampicillin 2g (TM) 30 phút trước khi làm thủ thuật ***cộng với*** Gentamicin 80mg (Tiêm bắp) hoặc (TM) trong vòng 1 giờ, 60 phút trước khi làm thủ thuật.
	Có hoặc không có phản ứng phản vệ.	Vancomycin 1g (TM) trong vòng 1 giờ, 60 phút trước khi làm thủ thuật ***cộng với*** Gentamicin 80mg (Tiêm bắp) hoặc (TM) trong vòng 1 giờ, 60 phút trước khi làm thủ thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

* *Thuốc dự phòng viêm nội tâm mạc hướng trực tiếp đến E. faecalis, tác nhân gây bệnh thường gặp đối với viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn khi thực hiện các thủ thuật phía dưới eo.*

** *Ưu tiên dùng thuốc dự phòng đường uống hơn dùng đường tĩnh mạch. Ngoại trừ các bệnh nhân đã có tiền sử viêm nội tâm mạc từ trước, có shunt hoặc phẫu thuật thay van tim.*

† ***Seto TB.*** *The case for infectious endocarditis prophylaxis. Arch Intern Med 167:327–330, 2007;* ***Harrison JL, Hoen B, Prendergast BD.*** *Antibiotic Prophylaxis for Infective Endocarditis. Lancet 371:1317–1319, 2008.*

DỰ PHÒNG KHI ĐI DU LỊCH

Khách du lịch có thể mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn do ăn/uống phải các thức ăn/ nước bị nhiễm bẩn phân; tiếp xúc trao đổi với chất tiết của một cơ thể bị nhiễm khuẩn, hít phải các hạt/giọt nhỏ bắn từ đường hô hấp của người mang bệnh; truyền bệnh trực tiếp qua vết đốt của côn trùng hoặc do tiếp xúc gần với các loài động vật/chim bị nhiễm khuẩn. Các khuyến cáo dự phòng nhiễm khuẩn cho khách du lịch bao gồm các cảnh báo chung khi đi du lịch (***bảng 6.12***) và các phác đồ dự phòng đặc hiệu đối với từng loại du lịch khác nhau (***bảng 6.1***).

Bảng 6.12. Cảnh báo chung về các các bệnh lý nhiễm khuẩn cho khách du lịch.

Nguồn phơi nhiễm	Nguy cơ	Thận trọng
Nước không an toàn (nhiễm bẩn từ phân)	Ỉa chảy/lỵ, viêm gan do virus (virus gây viêm gan A).	• Tránh uống nước không đóng chai/ nước không thể uống trực tiếp từ vòi. Cần đảm bảo chắc chắn là nước đóng chai chưa bị mở nắp chai và không bị đổ nước từ vòi nước thường vào để tái sử dụng. • Tránh sử dụng đá cục sản xuất từ nước không rõ nguồn gốc/ hoặc bị các bàn tay bẩn sờ vào và uống từ các cốc đựng nước không sạch. • Chỉ uống nước đóng chai đảm bảo vô khuẩn. Cần đảm bảo chắc chắn là chai nước hoặc hộp đựng nước được chính tay bạn mở hoặc người khác mở chai trước mặt bạn. • Tránh uống các loại sữa không tiệt khuẩn/ sữa ấm; bia, rượu vang và các đồ uống chứa cồn nguyên chất được coi là đồ uống an toàn. • Chỉ ăn các loại trái cây đóng hộp hoặc trái cây tươi do chính bạn gọt vỏ hoặc người khác gọt vỏ bằng một dụng cụ sạch dưới sự chứng kiến của bạn . • Tránh ăn các loại pho mát mềm. • Tránh ăn cà chua sống/ rau chưa nấu chín do các thực phẩm này có thể đã tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm bẩn. • Tránh sử dụng nước trong khách sạn để đánh răng hoặc xúc miệng trừ khi biết chắc đó là nước sạch. Nhiều khách sạn dùng đường nước chung để cấp nước cho nhà tắm/ bồn tắm và loại nước này không thich hợp cho sử dụng để uống được. • Tránh lội/hoặc bơi/ tắm trong sông/hoặc hồ.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ngộ độc thực phẩm (nhiễm bẩn từ phân)	Tiêu chảy/lỵ.	• Chỉ ăn hải sản/thịt/ thịt gia cầm được chế biến đảm bảo vệ sinh và ăn khi đồ ăn còn tươi và nóng. Tránh ăn thức ăn đường phố hoặc các quán cóc tại địa phương có vẻ không đảm bảo vệ sinh. • Hãy luôn nhớ :" Luộc kỹ, bóc vỏ hoặc không dùng ".
Dịch tiết của cơ thể	Virus viêm gan (HBV, HCV...), bệnh lây qua đường tình dục (HIV/các virus sao mã ngược khác).	• Không dùng chung ống hút/cốc/đồ dùng cá nhân hoặc sử dụng các dụng cụ trên vào các "hành vi nguy cơ cao" liên quan với tiếp xúc -trao đổi với các chất tiết cơ thể. • Tránh truyền máu (sử dụng các loại dịch thay thế máu). • Điều trị các vấn đề răng miệng trước khi đi du lịch.
Động vật cắn	Nhiễm trùng liên quan đến vết cắn của động vật.	• Không chơi đùa với chó/mèo bị lạc hoặc không có chủ. Bệnh dại và một số bệnh nhiễm khuẩn khác thường gặp ở động vật hoang dã (và một số vật nuôi ở đô thị).
Các loại côn trùng biết bay	Sốt rét, nhiễm trùng do các loại tiết túc.	• Tránh bị côn trùng có cánh đốt bằng cách mặc các loại quần áo bảo vệ sẫm màu (quần, áo dài kín tay, chân) và sử dụng các chất đuổi côn trùng bôi trên quần áo/da bị phơi nhiễm, đặc biệt vào các giờ buổi tối. • Hạn chế các hoạt độpg ngoài trời trong thời gian từ lúc mặt trời lặn đến lúc bình minh. • Sử dụng màn hoặc kính chống muỗi nếu có thể. • Không dùng nước hoa, các nước thơm bôi sau khi cạo râu hoặc các thuốc khử mùi vì có thể thu hút côn trùng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.13. Các phác đồ dự phòng khi đi du lịch.

Phơi nhiễm	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Phác đồ dự phòng	Bình luận
Ỉa chảy ở khách du lịch	*E. coli* Salmonella Trực khuẩn lỵ (Shigella) Phẩy khuẩn tả (*V. cholerae*) *Vibrios non-cholera vibrios* Aeromonas Plesiomonas Rotavirus Norwalk virus *Giardia lamblia* Campylobacter Vi khuẩn dịch hạch (Yersinia) Cryptosporidium Cyclospora Enteroviruses Bệnh do amip	Doxycyclin 100mg (uống) mỗi 24h/lần trong khoảng thời gian phơi nhiễm ***hoặc*** Bất kỳ một quinolon nào (uống) trong khoảng thời gian phơi nhiễm ***hoặc*** TMP–SMX 1 viên liều đơn (uống) mỗi 24h/lần trong khoảng thời gian phơi nhiễm.	Chỉ cần theo dõi mà không cần dự phòng. Điều trị đối với các trường hợp ỉa chảy nhẹ có triệu chứng bằng loperamid (2 mg). Các đối tượng có tình trạng bệnh lý nội khoa bị tác động không mong muốn khi bị mất nước do ỉa chảy gây ra có thể bắt đầu điều trị dự phòng sau khi tới nơi du lịch và tiếp tục thêm 1 ngày nữa sau khi đã quay về nước. Nếu xảy ra tình trạng ỉa chảy/lỵ nặng cần tiếp tục dùng/ hoặc chuyển sang dùng một quinolon uống, đảm bảo việc bổi phụ nước và điện giải tối ưu theo đường uống và tới khám bác sĩ nếu có thể. Có thể dùng thuốc chống co thắt để làm giảm triệu chứng của các ỉa chảy nhẹ, phân nước song thuốc bị chống chỉ định đối với các trường hợp ỉa chảy nặng/hội chứng lỵ nặng. Bismuth subsalicylat có hiệu quả kém hơn so với kháng sinh dự phòng. Hầu hết các trường hợp là do nhiễm *E. coli* sinh độc tố ruột (enterotoxigenic E.coli). TMP–SMX có hoạt tính chống lại một số vi khuẩn gây bệnh và Cyclospora nhưng không có hoạt tính đối với tác nhân gây bệnh bệnh là *E. histolytica* hoặc các virus gây bệnh đường ruột (ví dụ: Rotavirus, Norwalk). Doxycyclin có hoạt tính đối với hầu hết các tác nhân gây bệnh là vi khuẩn và *E. histolytica*, nhưng thuốc không có tác dụng đối với Campylobacter, Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia và các virus gây bệnh đường ruột (enteroviral pathogens). Rifaxamin chỉ có hoạt tính đối với *E.coli*. Các kháng sinh không có tác dụng đối với tác nhân gây bệnh là virus/ký sinh trùng gây ra tình trạng ỉa chảy.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não do não mô cầu (meningococus)	*N. meningitidis*	Dự phòng trước khi đi du lịch: Vaccin liên hợp phòng não mô cầu 0,5mL (Tiêm bắp) ≥1 tháng trước khi đi du lịch đến vùng có dịch bùng phát. Dự phòng sau phơi nhiễm: ***Xem trang 584***.	Các trường hợp mắc phải do tiếp xúc gần mặt đối mặt (lây do phơi nhiễm qua giọt nhỏ /hít phải qua đường không khí). Tiêm phòng vacccin có khả năng bảo vệ cao đối với não mô cầu thuộc typ huyết thanh A, C, Y và W-135, nhưng không có tác dụng đối với serotype B.
Viêm gan A	Virus viêm gan A	Vaccin đối với virus viêm gan A (HAV) 1mL (Tiêm bắp) trước khi đi du lịch, sau đó tiêm nhắc lại sau 3, 6 tháng.	Để dự phòng, vaccin HAV có hiệu quả cao hơn so với globulin miễn dịch. Cần chú ý để tránh dùng trực tiếp/gián tiếp nước bị nhiễm bẩn phân. Vaccin HAV được khuyến cáo khi du lịch đến các nước đang phát triển. Hiệu giá kháng thể có tác dụng bảo vệ xuất hiện sau 2 tuần.
Sốt thương hàn	*S. typhi*	Vaccin ViCPS 0,5mL (Tiêm bắp). Nhắc lại mỗi 2 năm nếu đi du lịch thường xuyên. ***hoặc*** Vaccin Ty21a 1 viên nang (uống) mỗi 48h/lần×4 liều. Nhắc lại mỗi 5 năm nếu đi du lịch thường xuyên.	Đối với vaccin uống, không dùng chung với thuốc kháng sinh. Chống chỉ định ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch và trẻ em dưới 6 tuổi. Uống viên nang vaccin với nước lạnh. Mức độ tạo ra miễn dịch bảo vệ của vaccin có nhiều hạn chế. Một số tác giả ưu tiên lựa chọn kháng sinh dự phòng trong trường hợp là chảy cấp khi đi du lịch ở trên (**trang 610**).
Sốt vàng	Virus sốt vàng (Yellow fever virus)	Vaccin virus sốt vàng 0,5mL (Tiêm dưới da). Nhắc lại mỗi 10 năm nếu đi du lịch thường xuyên.	Thường cần tiêm vaccin cho các đối tượng đi du lịch tới hoặc quay về từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ hoặc vùng nhiệt đới Trung phi. Nên tiêm cách các vaccin sống khác 1 tháng. Chống chỉ định ở trẻ < 4 tháng tuổi; thận trọng ở trẻ < 1 năm tuổi. Phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở người có tiền sử dị ứng với trứng. Tính miễn dịch có thể đạt được trong suốt cuộc đời người tiêm chủng, song cần tiêm mới lại sau mỗi 10 năm để có được chứng nhận đã tiêm phòng theo quy định của một số quốc gia.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não Nhật Bản	Virus viêm não Nhật Bản	Vaccin virus viêm não nhật bản 1mL (Tiêm dưới da) vào các ngày 0, 7 và 14 hoặc 30. Chương trình tiêm nhắc lại không được xác nhận.	Được khuyến cáo đối với các trường hợp du lịch theo kế hoạch có thời gian lưu trú kéo dài (> 3 tuần) trong mùa mưa ở các vùng hẻo lánh và các vùng châu Á có dịch lưu hành tại địa phương (ví dụ: miền đông nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc đại lục, Đông Nam Á, Thái Lan, Triều Tiên, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Philippin). Tiêm vaccin trước khi du lịch 2, 3 tuần. Trẻ < 3 tuổi có thể được dùng nửa liều: 0,5mL (Tiêm dưới da) với lịch tiêm chủng giống người lớn.
Bệnh dại	Virus dại	Các loại vaccin: HDCV, PCEC, RVA 1mL (Tiêm bắp) vào các ngày 0, 7 và 21 hoặc 28 trước khi đi du lịch ***hoặc*** HDCV 0,1mL (tiêm dưới da) vào các ngày 0, 7 và 21 hoặc 28 trước khi đi du lịch.	Tránh tiếp xúc với chó/động vật hoang dã trong khi đi du lịch. Liều của vaccin dại đối với người lớn và trẻ em là như nhau. Khuyến cáo tiêm nhắc lại một liều mới thêm trước khi đi du lịch nếu xét nghiệm nồng độ kháng thể thấy thấp.
Uốn ván Bạch hầu Ho gà	*C. tetani* *C. diphtheriae* *B. pertussis*	Vaccin Tdap 0,5mL (Tiêm bắp)	Vaccin Tdap được ưu tiên chọn dùng hơn so với Td vì Tdap cũng mối thêm tình trạng miễn dịch đối với ho gà.

Từ viết tắt: **HDCV** (human diploid cell vaccine): vaccin sản xuất từ tế bào lưỡng bội của người, **PCEC** (purified chick embryo cells): Tế bào phôi gà tinh chế; **RVA** (Rabies Vaccine Abshorb): Vaccin dại hấp phụ; **RIG**: globulin miễn dịch kháng dại.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 6.14. Dự phòng sốt rét.

Thuốc	Vùng phơi nhiễm	Liều cho người lớn	Bình luận
Atovaquone/ proguanil (Malarone)	Dự phòng ở tất cả các khu vực có bệnh sốt rét lưu hành.	1 viên dùng cho người lớn chứa 250mg atovaquone và 100mg proguanil hydrochlorid. Uống 1 viên dùng cho người lớn mỗi ngày.	Uống 1-2 ngày trước khi đi du lịch tới vùng có bệnh sốt rét lưu hành. Uống thuốc hàng ngày vào cùng một giờ trong ngày trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp thêm 7 ngày sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành. Chống chỉ định ở người bị suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30 mL/ phút). Nên uống atovaquone/proguanil trong bữa ăn hoặc pha trong sữa. Không khuyến cáo dự phòng đối với phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.
Chloroquin phosphat (Aralen và thuốc chứa hoạtchất gốc)	Dự phòng chỉ ở các vùng ký sinh trùng sốt rét còn nhạy cảm với Chloroquin.	300mg dạng kiềm (500mg dạng muối), 1 lần/tuần.	Bắt đầu uống 1–2 tuần trước khi đi du lịch đến vùng có bệnh sốt rét lưu hành. Uống một lần mỗi tuần vào một ngày nhất định trong tuần trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp 4 tuần sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành.
Doxycyclin	Dự phòng ở tất cả các khu vực có bệnh sốt rét lưu hành.	100mg (uống) (trong bữa ăn).	Bắt đầu uống 1–2 ngày trước đi du lịch đến vùng có bệnh sốt rét lưu hành. Uống thuốc hàng ngày vào cùng một giờ trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp thêm 4 tuần sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành. Thuốc bị chống chỉ định ở trẻ dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai.
Hydroxy-chloroquin sulfat (Plaquenil)	Một thuốc thay thế cho chloroquin để dự phòng chỉ ở các vùng ký sinh trùng sốt rét còn nhạy cảm với chloroquin.	Viên 310mg dạng kiềm (viên 400mg dạng muối) (uống) x 1 lần/ tuần.	Bắt đầu uống 1–2 tuần trước khi đi du lịch đến vùng có bệnh sốt rét lưu hành. Uống một lần mỗi tuần vào một ngày nhất định trong tuần trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp 4 tuần sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mefloquin (Larium)	Dự phòng ở các vùng có ký sinh trùng sốt rét nhạy cảm với mefloquin (Ký sinh trùng sốt rét đã kháng lại mefloquin ở khu vực Đông Nam Á).	Viên 228mg dạng kiềm (250mg dạng muối) (uống) x 1 lần/tuần.	Bắt đầu uống trước khi đi du lịch đến vùng có bệnh sốt rét lưu hành tối thiểu 2 tuần. Uống một lần mỗi tuần vào một ngày nhất định trong tuần trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp 4 tuần sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành. Thuốc bị chống chỉ định ở các đối tượng bị dị ứng với mefloquin hoặc các chế phẩm liên quan (Vd: quinin, quinidin) và ở các đối tượng đang bị trầm cảm hoặc có tiền sử gần đây bị trầm cảm, các rối loạn lo âu lan tỏa, loạn thần, tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần nặng khác hoặc co giật. Cần sử dụng thuốc thận trọng ở những đối tượng người có rối loạn tâm lý hoặc tiền sử bị trầm cảm trước đây. Không được khuyến cáo dùng cho các đối tượng có bất thường dẫn truyền cơ tim.
Primaquin†	Dự phòng khi du lịch trong thời gian ngắn tới vùng mà ký sinh trùng sốt rét lưu hành chủ yếu là *P. vivax*.	viên 30mg dạng kiềm (viên 52,6mg dạng muối) (uống) x 1 lần/ ngày.	Uống 1-2 ngày trước khi đi du lịch tới vùng có bệnh sốt rét lưu hành. Uống thuốc hàng ngày vào cùng một giờ trong ngày trong thời gian lưu trú tại vùng dịch tễ và dùng tiếp thêm 7 ngày sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ có bệnh sốt rét lưu hành. Chống chỉ định ở người bị thiếu hụt enzym G_6PD, phụ nữ có thai và đang cho con bú, trừ trường hợp trẻ đang bú mẹ được xét nghiệm nồng độ G_6PD bình thường.
Primaquin	Được dùng để điều trị chống tái phát sớm (pre-sumptive antirelapse therapy) (hay còn được gọi là dự phòng bắt đầu khi kết thúc thời gian phơi nhiễm [terminal prophylaxis] để làm giảm nguy cơ tái phát lại nhiễm *P.vivax* và *P. ovale*.	30mg dạng base (52,6 mg dạng muối) dùng đường uống, 1 lần/ ngày trong 14 ngày sau khi đã rời khỏi vùng dịch tễ sốt rét.	Được chỉ định cho những đối tượng phơi nhiễm trong thời gian kéo dài với P. vivax và P. ovale hoặc cả hai. Bị chống chỉ định ở người bị thiếu hụt enzym G_6PD†. Thuốc cũng bị chống chỉ định ở phụ nữ trong thời gian mang thai và đang cho con bú trừ trường hợp các trẻ bú mẹ được xét nghiệm khẳng định có nồng độ G_6PD bình thường.

† *G_6PD: Glucose-6-phosphate dehydrogenase. Những người dùng primaquin cần được kiểm tra để xác nhận là có nồng độ G_6PD bình thường trước khi bắt đầu dùng thuốc.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

DỰ PHÒNG UỐN VÁN

Những thông tin gần đây gợi ý rằng sau khi tiêm vaccin dự phòng uốn ván có thể đạt được tính miễn dịch kéo dài trong nhiều chục năm/suốt cuộc đời người được tiêm chủng. Không nên tiêm mũi tiêm phòng uốn ván mỗi lại một cách thường quy đối với trường hợp bị vết thương nhỏ, mặc dù mũi tiêm mỗi lại này được khuyến cáo áp dụng đối với các vết thương tiềm ẩn nguy cơ cao bị uốn ván (ví dụ: vết thương nghiền nát lớn, vết thương nhiễm bẩn từ đất hoặc vết thương xuyên thấu vào sâu).

Bảng 6.15. Dự phòng uốn ván trong xử trí thường quy các vết thương

Tiền sử tiêm chủng giải độc tố uốn ván hấp phụ (Adsorbed tetanus toxoid)	Đặc điểm vết thương	Khuyến cáo
Không biết hoặc tiêm dưới < 3 liều.	Các vết thương nhỏ, sạch	Td[‡] hoặc Tdap[‡]
	Các vết thương dễ có khả năng gây uốn ván[†]	(Td[‡] hoặc Tdap[‡]) cộng với globulin miễn dịch
Tiêm ≥3 liều.	Các vết thương nhỏ, sạch	Không dự phòng
	Các vết thương dễ có khả năng gây uốn ván [†]	Td[‡] nếu tiêm vaccin quá 10 năm[*]

Từ viết tắt: **DT** (diphtheria & tetanus toxoids adsorbed): Giải độc tố bạch hầu và uốn ván hấp phụ (dùng trong nhi khoa); **DTP** (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine adsorbed): Vaccin ho gà và giải độc tố bạch hầu, uốn ván hấp phụ; **Td** (tetanus and diphtheria toxoids adsorbed): Vaccin giải độc tố uốn ván và bạch hầu hấp phụ (dùng cho người lớn); **Tdap** (tetanus and diphtheria toxoids and pertussis vaccine absorbed): Vaccin ho gà và giải độc tố uốn ván, bạch hầu hấp phụ; **TIG**: globulin miễn dịch chống uốn ván của người.

[†] *Vết thương dễ có khả năng gây uốn ván: các vết thương nghiền nát lớn, các vết thương nhiễm bẩn từ đất, nước, phân, nước bọt; vết thương xuyên thấu sâu hoặc vết bỏng nóng/lạnh diện rộng.*

[‡] *Với trẻ em < 7 tuổi, DTP (hoặc DT nếu có chống chỉ định với vaccin ho gà) được ưu tiên dùng hơn vaccin giải độc tố uốn ván đơn độc. Đối với người lớn và trẻ ≥7 tuổi Tdap được ưu tiên hơn Td hay giải độc tố uốn ván đơn thuần.*

[*] *Không cần thiết phải tiêm các liều vaccin mỗi lại thường xuyên hơn và có thể làm tăng tác dụng phụ. Khả năng bảo vệ thường kéo dài hơn >20 năm. Được chấp nhận bởi Trung tâm kiểm soát và dự phòng dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) (MMWR Rep 40 (RR-10):1–28. 1991).*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TIÊM CHỦNG

Tiêm chủng được thực hiện với mục đích làm giảm tình trạng nhiễm khuẩn trong cộng đồng dân cư lớn, đồng thời có thể dự phòng/ hoặc làm giảm mức độ nghiêm trọng khi nhiễm khuẩn cho các đối tượng không được gây miễn dịch. Những đối tượng bị suy giảm miễn dịch với hệ miễn dịch bị biến đổi có thể không hình thành được đủ hiệu giá kháng thể bảo vệ đối với thành phần kháng nguyên của các vaccin khác nhau. ***Tiêm chủng không có tác dụng bảo vệ đầy đủ, song được khuyến cáo*** (tùy thuộc vào vaccin) cho hầu hết các vật chủ bình thường, do đạt được một tình trạng bảo vệ nào đó vẫn tốt hơn là không có gì.

Bảng 6.16. Tiêm chủng ở người lớn

Vaccin	Các chỉ định	Liều dùng	Bình luận
Bacille Calmette Guérin (BCG)	Có thể có ích đối với người trưởng thành có nguy cơ nhiễm lao kháng nhiều thuốc.	Dự phòng cấp một: 1 liều (tiêm trong da). Liều mồi lại không được khuyến cáo.	Vaccin sống giảm độc lực tạo ra phản ứng da dương tính với lao (PPD test) và phản ứng da này có thể vẫn dương tính trong nhiều năm/hoặc suốt đời bệnh nhân. Bị chống chỉ định ở các đối tượng suy giảm miễn dịch. Nhiễm khuẩn tại vị trí tiêm hoặc nhiễm khuẩn lan tỏa hiếm khi xảy ra.
Hemophilus influenzae (typ B)	Xem xét dùng cho bệnh nhân có rối loạn chức năng lách.	Dự phòng cấp một: liều 0, mL (tiêm bắp). Liều mồi lại không được khuyến cáo.	Polysaccharid vỏ liên hợp đối với độc tố (toxoid) bạch hầu. Hiệu quả không chắc chắn. Tính an toàn ở phụ nữ có thai không được biết rõ.Phản ứng tại chỗ nhẹ gặp ở 10% các trường hợp tiêm phòng.
Viêm gan virus A (HAV)	Tất cả các trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 23 tháng tuổi và người trưởng thành cơ gia tăng bị nhiễm virus gây viêm gan A (HAV).	Dự phòng cấp một: Liều 1mL (tiêm bắp). Một mũi tiêm mồi lại duy nhất sau 6 tháng. Các mũi tiêm mồi lại thường quy không được khuyến cáo.	Virus toàn thể được làm bất hoạt. Nguy cơ đối với phụ nữ có thai chưa được đánh giá đầy đủ. Tình trạng đau nhẹ tại vị trí tiêm. Đôi khi gặp đau đầu và/ tình trạng khó chịu sau tiêm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm gan virus B (HBV)	Tiếp xúc với người mang virus viama gan B trong sinh hoạt hàng ngày / hoặc qua đường tình dục, người nghiện thuốc qua đường tĩnh mạch, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình khác giới, nam giới quan hệ đồng tính nam, được truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu, phơi nhiễm do nghề nghiệp với máu hoặc chế phẩm máu, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở chăm sóc giúp đỡ người tàn tật, trong trại giam, cư trú ≥6 tháng ở các vùng dịch tễ có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B cao và những người có nguy cơ cao khác.	Dự phòng cấp một (tiêm một loạt 3 liều) Recombivax 10 µg (1mL) hoặc Engerix-B 20 µg (1mL) tiêm bắp vào cơ delta vào các tháng 0, 1 và 6. Phác đồ dự phòng thay thế bằng Engerix-B: tiêm một loạt 4 liều vào các tháng: 0, 1, 2 và 12. Các mũi tiêm mồi lại thường quy không được khuyến cáo.	Vaccin tái tổ hợp chứa kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Đối tượng bị suy giảm miễn dịch (bao gồm cả bệnh nhân lọc máu), sử dụng Recombivax được đóng gói chuyên biệt liều cao 40 µg/mL (ống 1 mL chứa 40 µg/mL). Cần định lượng hiệu giá nồng độ kháng thể HBs 6 tháng sau loạt liều 3 mũi dự phòng cấp một. Những người chưa đạt được hiệu giá kháng thể có hiệu quả bảo vệ (≤10 mIU/mL) cần được tiêm 1 mũi/tháng, tới tối đa 3 mũi và kiểm tra lại hiệu giá kháng thể HBsAB. Có thai không phải là chống chỉ định tiêm vaccin viêm gan B ở các phụ nữ có nguy cơ cao. Phản ứng nhẹ tại chỗ xảy ra ở 10–20% các trường hợp. Đôi khi gặp sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn. Twinrix 1mL (Tiêm bắp) (kết hợp giữa vaccin viêm gan A bất hoạt và vaccin viêm gan B tái tổ hợp) hiện có trên thị trường để dùng cho người trưởng thành có thể dùng cho người trưởng thành theo phác đồ liều vào các tháng 0, 1 và 6 hoặc phác đồ 4 mũi vào các thời điểm 0, 7 ngày, 21–30 ngày và 12 tháng sau.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Herpes zoster (VZV)	Ở người ≥60 tuổi để làm giảm tần suất bị zona thần kinh/đau thần kinh sau nhiễm Herpes. Sử dụng cho các đối tượng có tiền sử bị nhiễm Herpes zoster trước đó còn chưa được xác nhận. Hiệu quả dự phòng tốt nhất ở nhóm đối tượng 60-69 tuổi. Hiệu quả giảm đi ở các nhóm tuổi cao hơn.	Dự phòng cấp một: 0,65 mL (tiêm dưới da). Nhu cầu cần tiêm chủng nhắc lại còn chưa được xác nhận. Vaccin phải được bảo quản trong môi trường đông lạnh và được sử dụng trong vòng 30 phút sau khi làm tan đông.	Khoảng thời gian bảo vệ của vaccin kéo dài ít nhất 4 năm. Các phản ứng tại vị trí tiêm ở 48% các trường hợp. Thuốc bị chống chỉ định ở những đối tượng suy giảm miễn dịch (với các rối loạn gây ức chế miễn dịch hoặc ở người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch) hoặc bệnh nhân đang mắc bệnh lao không được điều trị. Không được chỉ định để điều trị nhiễm *H. zoster* hoặc đau thần kinh sau nhiễm Herpes.
Cúm (Influenza)	Tất cả người trưởng thành.	Vaccin tiêm hàng năm. Liều đơn 0,5mL (tiêm bắp) trước mùa cúm là tối ưu, tuy nhiên có thể tiêm bất kể lúc nào trong suốt mùa cúm. Vaccin bất hoạt liều cao được chỉ định cho người ≥ 65 tuổi.	Vaccin là virus toàn thể hoặc một phần được làm bất hoạt gồm 3 chủng virus. Các chống chỉ định tiêm vaccin cúm bao gồm người có phản ứng phản vệ với trứng hoặc nhạy cảm với thimerosal. Phản ứng nhẹ tại chỗ được gặp ở tới 30% số người được tiêm chủng. Đôi khi gặp mệt mỏi/ đau cơ bắt đầu xảy ra sau tiêm 6–12 giờ. Các phản ứng dị ứng và thần kinh hiếm gặp. Đối với phụ nữ có thai, tiêm vào mùa cúm trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Một dạng vaccin được bào chế từ virus cúm sống giảm độc lực đường dùng qua đường niêm mạc mũi đã được phê chuẩn sử dụng cho các đối tượng là người khỏe mạnh tuổi từ 5-49 tuổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sởi	Những người sinh sau năm 1956 không được tiêm vaccin virus sởi sống hoặc đã từng mắc sởi được bác sĩ chẩn đoán hoặc test miễn dịch sởi dương tính. Cũng được chỉ định để tiêm chủng lại cho các đối tượng đã được tiêm vaccin bào chế từ virus sởi đã bị diệt chết trong thập niên 1963–67.	Dự phòng cấp một: Liều 0,5mL (tiêm dưới da). Liều thứ 2 (sau liều thứ nhất 1 tháng) được khuyến cáo cho một số đối tượng người trưởng thành có gia tăng nguy cơ phơi nhiễm với virus sởi (ví dụ: nhân viên y tế, người đi du lịch đến các nước đang phát triển). Không khuyến cáo tiêm mồi lại thường quy cho mọi đối tượng.	Vaccin được bào chế từ virus sống (thường được cho dưới dạng vaccin phòng sởi- quai bị -rubella). Bị chống chỉ định ở các đối tượng suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai hoặc người có tiền sử bị phản ứng phản vệ với trứng hoặc neomycin. Không hiệu quả nếu tiêm vaccin trong thời gian 3–11 tháng sau truyền máu. Các tác dụng phụ bao gồm sốt nhẹ trong khoảng thời gian 5–21 ngày sau tiêm chủng (5–15%), ban đỏ thoáng qua (5%) và phản ứng tại chỗ 4–55% ở những người có tiền sử trước đó đã tiêm vaccin virus chết (trong khoảng thập niên 1963–67).
Não mô cầu (Meningococcus) (bệnh xâm lấn)	Các bệnh nhân bị rối loạn chức năng lách hoặc có khiếm khuyết con đường hoạt hóa bổ thể tận, nhân viên phòng xét nghiệm.	Vaccin liên hợp não mô cầu 0,5 mL (tiêm bắp).	Cũng được dùng để kiểm soát dịch do não mô cầu nhóm huyết thanh A,C,Y và W-135.
Quai bị	Người trưởng thành chưa có miễn dịch.	Dự phòng cấp một: 0,5mL (tiêm dưới da). Không tiêm chủng mồi lại thường quy.	Vaccin được bào chế từ virus sống giảm độc lực (thường được cho dưới dạng vaccin phòng sởi- quai bị -rubella). Bị chống chỉ định ở các đối tượng suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai hoặc tiền sử bị phản ứng phản với trứng hoặc neomycin. Các tác dụng phụ bao gồm phản ứng dị ứng nhẹ (không thường gặp), viêm tuyến mang tai (hiếm gặp).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Virus Papilloma người (Papilloma human virus [HPV])	Các phụ nữ tới tuổi 26. Bị chống chỉ định ở phụ nữ có thai. Được gợi ý dùng cho nam giới tới 26 tuổi.	Dự phòng cấp một: 0,5 mL (Tiêm bắp). Liều thứ hai: 2 tháng sau liều thứ nhất. Liều thứ 3: 6 tháng sau liều thứ nhất.	Vaccin chứa 4 chủng HPV được dùng để dự phòng bệnh mào gà sinh dục, ung thư cổ tử cung và các bệnh khác như AIS, CIN, VIN, VaIN do các typ HPV 6, 11, 16, 18 gây ra. Không được chỉ định để điều trị bệnh mào gà sinh dục đang hoạt động, ung thư cổ tử cung, CIN, VIN hoặc VaIN.
Ho gà	Dùng Tdap thay vì là Td cho liều tiêm mồi lại.	Một liều đơn Tdap tiêm mồi lại 0,5 mL (Tiêm bắp). Lịch tiêm mồi lại theo lịch của các vaccin khác.	Được khuyến cáo do người trưởng thành có thể mắc ho gà hoặc truyền bệnh cho các trẻ nhạy cảm.
Phế cầu (Pneumococcus) (*S. neumoniae*)	Đối tượng có chức năng miễn dịch bình thường ≥65 tuổi hoặc trên >2 tuổi bị đái tháo đường, rò dịch não tủy hoặc có bệnh tim, bệnh gan hoặc bệnh phổi mạn tính. Cũng được chỉ định cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch trên 2 tuổi với không có lách/ giảm chức năng lách, bệnh nhân loxêmi, u lympho, đa u tủy xương, bệnh lý ác tính lan tràn, suy thận mạn, ghép tủy xương hoặc ghép tạng hoặc đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch/steroid.	Dự phòng cấp một: Liều 0,5 mL (tiêm dưới da hoặc tiêm bắp). Khuyến cáo tiêm mồi lại một liều sau 5 năm cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch trên 2 tuổi và đối với các đối tượng đã được tiêm chủng vaccin trước tuổi 65 và có kèm các bệnh lý nguy cơ cao.	Vaccin đa giá chống lại 23 chủng phế cầu khuẩn. Các nghiên cứu còn chưa đủ để ủng hộ việc tiêm chủng nhắc lại thường quy. Thầy thuốc thực hành cần quyết định theo quan điểm của cá nhân mình.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Rubella	Người trưởng thành chưa có miễn dịch nhất là các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.	Dự phòng cấp một: Liều 0,5 mL (tiêm dưới da). Không cần tiêm mối lại thường quy.	Vaccin được bào chế từ virus sống (chủng RA 27/3) (thường được cho dưới dạng vaccin phòng sởi- quai bị -rubella). Bị chống chỉ định ở các đối tượng suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, có tiền sử bị phản ứng phản vệ với neomycin. Đau khớp thoáng qua có thể gặp ở 40% số người tiêm chủng, bắt đầu 3–25 ngày sau tiêm chủng và kéo dài 1–11 ngày; viêm khớp thực sự được gặp ở <2% người được tiêm chủng.
Uốn ván- Bạch hầu	Người trưởng thành.	Dự phòng cấp một: 2 liều Td 0,5mL (tiêm bắp) cách nhau 1–2 tháng; liều thứ 3 sau liều thứ hai 6–12 tháng. Liều mối lại: khuyến cáo dùng một liều đơn Tdap 0,5 mL (Tiêm bắp). Nên dùng 1 liều Tdap thay cho 1 liều Td trong lịch tiêm chủng 3 lần tiêm nói trên.	Vaccin giải độc tố hấp phụ. Bị chống chỉ định nếu có tình trạng tăng mẫn cảm/phản ứng thần kinh hoặc phản ứng tại chỗ nặng với các liều tiêm trước đó. Các tác dụng phụ bao gồm phản ứng tại chỗ, đôi khi là sốt, triệu chứng toàn thân, phản ứng kiểu Arthus (phản ứng dị ứng typ 3) ở những đối tượng được tiêm mối lại nhiều lần trước đó và bị phản ứng dị ứng toàn thân (hiếm gặp).
Thủy đậu (*Varicella zoster* [VZV])	Người trưởng thành và trẻ vị thành niên chưa có miễn dịch, nhất là các nhân viên y tế và các đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm cao.	Dự phòng cấp một: hai liều 0,5 mL (tiêm dưới da) cách nhau 4–8 tuần. Vaccin phải được bảo quản động lạnh và được sử dụng trong vòng 30 phút sau khi rã đông. Không cần tiêm mối lại thường quy.	Vaccin sống giảm độc lực. Các chống chỉ định bao gồm phụ nữ có thai, bệnh lao hoạt không được điều trị, đối tượng bị suy giảm miễn dịch, bệnh lý ác tính của tủy xương hoặc hệ lympho, phản ứng phản vệ với gelatin/neomycin hoặc được truyền máu trong vòng 6 tháng trở lại đây (có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ). Tình trạng sốt nhẹ gặp ở 10% số người tiêm chủng, biểu hiện tại vết tiêm ở 25–30% trường hợp (ban tại chỗ 3%). Ban da lan tỏa nhẹ gặp ở 5% số trường hợp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI GỢI Ý ĐỌC THÊM

Andrews WW, Kimberlin DF, Whitley R, Cliver S, Ramsey PS. Valacyclovir therapy to reduce recurrent genital herpes in pregnant women. *Am J Obstet Gynecol* 194: 774–81, 2006.

Antrum RM, Solomkin JS. A review of antibiotic prophylaxis for open fractures. Orthop Rev 16: 246–54, 1987.

Batiuk TD, Bodziak KA, Goldman M. Infectious disease prophylaxis in renal transplant patient: a survey of US transplant centers. Clin Transplant 16: 1–8, 2002.

Baum SG. Oseltamivir and the influenza alphabet. Clin Infect Dis 43: 445–6, 2006.

Bennett JE, Echinocandins for Candidemia in Adults without Neutropenia. New Engl J Med 355: 1154–9, 2006.

Bow EJ, Rotstein C, Noskin GA, et al. A Randomized, Open-Label, Multicenter Comparative Study of the Efficacy and Safety of Piperacillin-Tazobactam and Cefepime for the Empirical Treatment of Febrile Neutropenic Episodes in patient with Hematologic Malignancies. Clin Infect Dis 43: 447–59, 2006.

Brantley JS, Hicks L, Sra K, Tyring SK. Valacyclovir for the treatment of genital herpes. Expert Rev Anti-Infect Ther 4: 367–76, 2006.

Camann W, Tuomala R. Antibiotic prophylaxis for cesarean delivery: always before skin incision! Int J Obstet Anesth 20:1–2, 2011.

Caple J. Varicella-Zoster Virus vaccine: a review of its use in the prevention of Herpes Zoster in older adults. Drugs of Today 42: 249–54, 2006.

Carratala J. Role of antibiotic prophylaxis for the prevention of intravascular catheter-related infection. Clin Microbiol Infect 7 (Suppl 4): 83–90, 2001.

Centers for Disease Control, Recommended Adult Immunization Schedule: United States, 2010. MMWR , 59:1–4, 2010.

Chen LH, Wilson ME, Schlagenhauf P. Prevention of Malaria in Long-term Travelers. JAMA 296: 2234–44, 2006.

Chattopadhyay B. Splenectomy pneumococcal vaccination and antibiotic prophylaxis. Br J Hosp Med 41: 172–4, 1989.

Colizza S, Rossi S. Antibiotic prophylaxis and treatment of surgical abdominal sepsis. J Chemother 13: 193–201, 2001.

Craig AS, Schaffner W. Prevention of Viêm gan A with the HAV vaccine. N Engl J Med 350: 476–81, 2004.

Cullen M, Steven N, Billingham L, et al. Antibacterial prophylaxis after chemotherapy for solid tumors and lymphomas. N Engl J Med 353: 988–98, 2005.

Cunha BA, Gossling HR, Nightingale CH, et al. Penetration of cefazolin and cefradine into bone in patient undergoing total knee arthroplasty. Infection 2: 80–84, 1984.

Cunha BA. Antibiotic tissue penetration. Bulletin of the New York Academy of Medicine 59: 443–449, 1983.

Cunha BA, Ristuccia A, Jonas M, et al. Penetration of ceftizoxime and cefazolin into bile and gallbladder. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 10: 117–120, 1982.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cunha BA, Pyrtek LJ, Quintiliani R. Prophylactic antibiotics in cholecystectomy. Lancet 1: 207–8, 1979.

Cunha BA, Gossling HR, Nightingale C, et al. Penetration characteristics of cefazolin, cephalothin, and cephradine into bone in patient undergoing total hip replacement. Journal of Bone and Surgery 59: 856–859, 1977.

Darouiche RG. Treatment of infections associated with surgical implants. N Engl J Med 350: 1422–9, 2004.

De Lall F. Antibiotic prophylaxis in Orthopedic prosthetic surgery. J Chemother 13 Spec No 1: 48–53, 2001.

De la Camara R. Antifungal prophylaxis in haematology patient. 12: S65–76, 2006.

Diaz-Pedroche C, Lumbreras C, San Juan R, et al. Valganciclovir preemptive therapy for the prevention of cytomegalovirus disease in high-risk seropositive solid-organ transplant recipients. Transplantation 82: 30–5, 2006.

Dietrich ES, Bieser U, Frank U, et al. Ceftriaxone versus other cephalosporins for perioperative antibiotic prophylaxis: a meta analysis of 43 randomized controlled trials. Chemotherapy 48: 49–56, 2002.

Drew RH, Perfect JR. Use of Polyenes for Prophylaxis for Invasive Fungal Infections. Infections in Medicine 23: S12–24, 2006.

Esposito S. Is single-dose antibiotic prophylaxis sufficient for any surgical procedure? J Chemother 11: 556, 2000.

Faix, RG. Immunization during pregnancy. Clin Obstet Gynecol 45: 42–58, 2002.

Fennessy BG, O'Sullivan MJ, Fulton GJ, et al. Prospective Study of Use of Perioperative Antimicrobial Therapy in General Surgery. Surgical Infections 7: 355–60, 2006.

Fritze D, Englesbe MJ, Campbell DA Jr. Oral antibiotics to prevent surgical site infections following colon surgery. Adv Surg 45:141–153, 2011.

Fry DE. Colon preparation and surgical site infection. Am J Surg 202:225–232, 2011.

Gardner P, Eickhoff T. Immunization in adults in the 1990s. Curr Clin To Infect Dis 15: 271–300, 1995.

Gardner P, Peter G. Recommended schedules for routine immunization of children and adults. Infect Dis Clin North Am 15: 1–8, 2001.

Gardner P, Schaffner W. Immunization of adults. N Engl J Med 328: 1252–8, 1993.

Grabe M. Perioperative antibiotic prophylaxis in urology. Curr Opin Urol 11: 81–5, 2001.

Guaschino S, De Santo D, De Seta F. New perspectives in antibiotic prophylaxis for obstetric and gynecological surgery. J Hosp Infect 50 (Suppl A): SS13–6, 2002.

Haines SJ. Antibiotic prophylaxis in neurosurgery. The controlled trials. Neurosurg Clin N Am 3: 355–8, 1992.

Hartman BJ. Selective aspects of infective endocarditis: considerations on diagnosis, risk factors, treatment and prophylaxis. Adv Cardiol 39: 195–202, 2002.

Hasin T, Davidovitch N, Cohen R, et al. Postexposure Treatment with Doxycycline for the Prevention of Tick-Borne Relapsing Fever. N Engl J Med 355: 147–55, 2006.

Hiemenz J, Cagnoni P, et al. Pharmacokinetic and maximum tolerated dose study of micafungin in combination with fluconazole versus

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

fluconazole alone for prophylaxis of fungal infections in adult patient undergoing a bone marrow or peripheral stem cell transplant. Antimicrob Agents Chemother 49: 1331–6, 2005.

Higuchi Y, Takesue Y, Yamada Y, et al. A single-dose regimen for antimicrobial prophylaxis to prevent perioperative infection in urological clean and clean- contaminated surgery. J Infect Chemother 17:219–223, 2011.

Hill DR, Ericsson CD, Pearson RD, Keystone JS, et al. The Practice of Travel Medicine: Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 43: 1499–539, 2006.

Hornberger H, Robertus K. Cost-Effectiveness of a Vaccine To Prevent Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults. 145: 317–25, 2006.

Howdieshell TF, Heffernan D, Dipiro JT. Surgical Infection Society Guidelines for Vaccination after Traumatic Injury. Surgical Infections 7: 275–303, 2006.

Jackson LA, Neuzil KM, Yu O et al. Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. N Engl J Med 348: 1747–55, 2003.

Jacobson RM. Vaccine safety. Immunol Allergy Clin North Am 23: 589–603, 2003.

KambaroudisAG, Papadopoulos S, Christodoulidou M, et al. Perioperative use of antibiotics in intra-abdominal surgical infections. Surg Infect (Larchmt) 11:535–544, 2011.

Khoury JA, Storch GA, Bohl DL, et al. Prophylactic verus preemptive Oral valganciclovir for the management of cytomegalovirus infection in adult renal transplant recipients. Am J Transplant 6: 2134–43, 2006.

Klein A, Miller KB, Sprague K, et al. A randomized, double-blind, placebo controlled trial of valacyclovir prophylaxis to prevent zoster recurrence from month 4 to 24 after BMT. Bone Marrow Transplant, 26:1–6, 2010.

Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. International concensus guidelines on the management cytomegalovirus in solid organ transplanation. Transplantation 89:779–795, 2010

Laftavi MR, Rostami R, Feng L, et al. The role of antibiotic prophylaxis in the new era of immunosuppression. Transplant Proc 43:533–535, 2011.

Lewis RT. Oral versus systemic antibiotic prophylaxis in elective colon surgery: a randomized study and metaanalysis send a message from the 1990s. Can J Surg 45: 173–80, 2002.

Musher DM, Rueda-Jaimes AM, Graviss EA, RodriguezBarradas MC. Effect of Pneumococcal Vaccination: A Comparison of Vaccination Rates in patient with Bactermic and Nonbacteremic Pneumococcal Pneumonia. Clin Infect Dis 43: 1004–08, 2006.

National center for immunization and respiratory diseases. General recommendations on immunization—recommendations of the advisory committee on immunization practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 6:1–61, 2011.

Paul M, Yahav D, Fraser A, et al. Empirical antibiotic monotherapy for febrile neutropenia: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 57: 176–89, 2006.

Pham H, Geraci SA, Burton MJ. Adult immunizations: update on recommendations. Am J Med 124:698–201, 2011.

Phillips P, Chan K, Hogg R, et al.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Azithromycin prophylaxis for Mycobacterium avium complex during the era of highly active antiretroviral therapy: evaluation of a provincial program. Clin Infect Dis 34: 371–8, 2002.

Pratesi C, Russo D, Dorigo W, et al. Antibiotic prophylaxis in clean surgery: vascular surgery. J Chemother 13 (Spec 1): 123–8, 2001.

Rex JH, Sobel JD. Prophylactic antifungal therapy in the intensive care unit. Clin Infect Dis 32: 1191–200, 2001.

Rolston KVI, Bodey GP. Comment on: Empirical antibiotic monotherapy for febrile neutropenia:

Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 58: 478–9, 2006.

Rupprecht CE, Gibbons RV. Prophylaxis against rabies. N Engl J Med 351: 2626–35, 2004.

Segreti J. Is antibiotic prophylaxis necessary for preventing prosthetic device infection. Infect Dis Clin North Am 13: 871–7, 1999.

Seto TB. The case for infectious endocarditis prophylaxis. Arch Intern Med 167: 327–330, 2007.

Seymour RA, Whitworth JM. Antibiotic prophylaxis for endocarditis, prosthetic joints, and surgery. Dent Clin North Am 46: 635–51, 2002.

Shiffman ML, Suter F, Bacon BR, et al. Peginterferon alfa-2a and ribavirin for 16 or 24 week in HCV genotype 2 or 3. N Engl J Med 357: 124–134, 2007.

Small TN, Cowan MJ. Immunization of hematopoietic stem cell transplant recipients against vaccinepreventable diseases. Expert Rev Clin Immunol 7:193–203, 2011.

Snydman DR. Cytomegalovirus prevention strategies: The case for prophylaxis. Am J Transplant 9:1254, 2009.

Snydman DR. Prevention of cytomegalovirus (CMV) infection and CMV disease in recipients of solid Organ transplants: the case for prophylaxis. Clin Infect Dis 40: 709–12, 2005.

Sobel JD, Rex JH. Invasive Andidiasis: Turning risk into a practical prevention policy? Clin Infect Dis 33: 187–190, 2001.

Spira AM. Yellow Fever: An Update on Risks, Presentation, and Prevention. Infections in Medicine 23: 385–89, 2006.

Syndman DR. Use of valganciclovir for prevention and treatment of cytomegalovirus disease. Clin Infect Dis, 46:28–29, 2008.

Taub DD, Ershler WB, Janowski M, et al. Immunity from Smtất cảpox Vaccine Persists for Decades: A Longitudinal Study. Am J Med 121:1058–1064, 2008.

Vazquez M, LaRussa PS, Gershon AA, et al. The effectiveness of the varicella vaccine in clinical practice. N Engl J Med 344: 955–60, 2001.

Victor JC, Mourfi AS, Sundina TY, et al. HAV vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 357: 1685–1694, 2007.

Wingard JR. Antifungal chemoprophylaxis after blood and marrow transplantation. Clin Infect Dis 34: 1386–90, 2002.

Winston DJ, Busuttil RW. Randomized controlled trial of Oral itraconazole solution versus intravenous/Oral fluconazole for prevention of fungal infections in liver transplant recipients. Transplantation 74: 688–95, 2002.

Wistrom J, Norrby R. Antibiotic prophylaxis of travellers' diarrhoea. Scand J Infect Dis Suppl 70: 111–29, 1990.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Zelenitsky SA, Ariano RE, Harding GK, et al. Antibiotic pharmacodynamics in surgical prophylaxis: an association between intraoperative antibiotic concentrations and efficacy. Antimicrob Agents Chemother 46: 3026–30, 2002.

GUIDELINES

CDC. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. MMWR, 59:1–31, 2010.

Dykewicz CA. Summary of the guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 33: 139–44, 2001.

Hauser CJ, Adams CA, Eachempati SR. Prophylactic Antibiotic Use in Open Fractures: An Evidence-Based Guideline. Surgical Infections 7: 379–405, 2006.

Medical Letter Antimicrobial Prophylaxis for Surgery. Guidelines. Medical Letter 7:47–50, 2009

TEXTBOOKS

Antibiotic Prophylaxis for Surgical Site Infection Prevention in Adults, 4th ed. Institute for Clinical Systems Improvement, October, 2010.

Brunette GW, Kozarsky PE, Magill AJ, et al. CDC Health Information for International Travel 2010, Mosby Elsevier, 2010.

Brunette GW, Kozarsky P, Magill A. The Yellow Book CDC Health Information for International Travel 2012. Oxford University Press, 2012.

Brusch JL, Endocarditis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.

Gorbach SL, Bartlett JG. Blacklow NR Infectious (eds). Diseases, 3rd edition, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004.

Hawker J, Begg N, Blair I, et al. Communicable Disease Control Handbook, 2nd edition, Malden, Massachusetts, Blackwell Publishing, 2005.

Heymann DL. Control of Communicable Disease Manual, 19th edition, American Public Health Association, 2008.

Keystone JS, Kozarski PE, Freedman DO, et al. Travel Medicine. Mosby, Edinburgh, 2004.

Koff R. Hepatitis Essentials. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2011.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th edition, Philadelphia, Elsevier, 2010.

Plotkin SA, Orenstein WA Vaccines, 5th edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 2004.

Sax PE, Cohen CJ, Kuritzkes DR. HIV Essentials, 5th edition. Jones & Bartlett, Sudbury, MA, 2012.

Yu VL, Merigan Jr, TC, Barriere SL. Antimicrobial Therapy and Vaccines, 2nd edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 2005.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương VII

CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM VÀ CÁC TÓM TẮT VỀ THUỐC DÙNG TRONG NHI KHOA

Leonard R. Krilov, MD
George H. McCracken, Jr, MD

NGƯỜI DỊCH:

TS. DS. Cấn Tuyết Nga
Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai
TS. Mai Duy Tôn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương	628
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn ở vùng đầu-mặt-cổ	635
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới	644
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn mạch máu	653
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn dạ dày-ruột	403
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa	656
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn xương và khớp	661
Điều trị theo kinh nghiệm đối với các nhiễm khuẩn da và mô mềm	668
Các thuốc kháng sinh thường dùng trong nhi khoa.	674
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	685

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương này trình bày các bệnh nhiễm khuẩn và các thuốc kháng sinh dùng cho bệnh nhân nhi khoa. Nội dung của chương được sắp xếp theo hội chứng lâm sàng, nhóm đối tượng bệnh nhân và trong một số trường hợp là vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu. Các tóm tắt lâm sàng tiếp theo ngay sau cột điều trị. Các khuyến cáo điều trị được dựa trên hiệu quả điều trị của kháng sinh, độ tin cậy, giá thành, độ an toàn và nguy cơ để kháng kháng sinh khi dùng thuốc. ***Các thuốc kháng sinh và thời gian điều trị được liệt kê trong cột điều trị, liều dùng thuốc tương ứng được đề cập trong các trang 674-684 và phản ánh liều thường dùng khi trẻ có chức năng thận và gan bình thường***. Các liều dùng thuốc ở nhũ nhi/ trẻ em nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể của trẻ, tăng tới liều dùng ở người lớn như liều tối đa. ***Đối với bất kỳ loại điều trị nào, ví dụ như điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên chọn dùng, điều trị đường tĩnh mạch thay thế hay điều trị đường uống, các thuốc được khuyến cáo có hiệu quả tương đương nhau và không được phân cấp độ theo mức ưu tiên***. Để nghị độc giả xem thêm các tài liệu tham khảo khác về thuốc dùng cho nhi khoa và các tờ thông tin về thuốc cài trong hộp thuốc do nhà sản xuất cung cấp để biết về điều chỉnh liều, các tác dụng không mong muốn, các tương tác thuốc và các thông tin kê đơn quan trọng khác.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mục "chuyển từ điều trị đường tĩnh mạch sang đường uống" trong cột cuối cùng của hàng tiêu đề trong mỗi cột điều trị chỉ dẫn các hội chứng lâm sàng có thể được điều trị hoặc bằng đường tĩnh mạch đơn độc hoặc từ điều trị đường tĩnh mạch được tiếp theo bằng điều trị đường uống, song không phải là điều trị đơn độc theo đường uống. Mục "điều trị đường uống hoặc chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống" chỉ dẫn các hội chứng lâm sàng có thể được điều trị đơn độc bằng đường tĩnh mạch, điều trị đơn độc bằng đường uống hoặc điều trị bằng đường tĩnh mạch được tiếp theo bằng điều trị đường uống (trừ khi được chỉ dẫn khác ở phần chú thích ở cuối trang dưới mỗi ô điều trị). Hầu hết các bệnh nhân khi đang được điều trị bằng đường tĩnh mạch song có thể uống được thuốc nên chuyển sang điều trị bằng đường uống với liều tương đương sau khi có cải thiện lâm sàng.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Viêm màng não cấp do vi khuẩn (Acute Bacterial Meningitis)

Đối tượng (tuổi)	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †
Trẻ sơ sinh (0–30 ngày)	Liên cầu nhóm B *E. coli* *Listeria monocytogenes* Các vi khuẩn Gram (-) (ví dụ: Citrobacter, Serratia) và Gram (+) khác (ví dụ: cầu khuẩn ruột).	Ampicillin ***cộng với*** cefotaxim*	Ampicillin ***cộng với*** gentamicin*
1–3 tháng	Chồng lấp giữa các tác nhân gây bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ > 3 tháng tuổi.	Vancomycin ***cộng với hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon*	Ampicillin ***cộng với hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon*
> 3 tháng	Phế cầu (*S. pneumoniae*) Não mô cầu (*N. meningitidis*) *H. influenzae* (rất hiếm) *H. influenzae* không phân typ được (hiếm gặp).	**Trước khi có kết quả nuôi cấy** Vancomycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim* **Sau khi có kết quả nuôi cấy** Ngừng dùng vancomycin nếu phân lập được phế cầu nhạy với penicillin, não mô cầu hoặc H. influenza.	Meropenem* *Dị ứng nặng với penicillin* Vancomycin ***cộng với hoặc*** rifampin ***hoặc*** chloramphenicol*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương sau đặt shunt (Điều trị khởi đầu đối với *S. epidermidis*; nếu sau đó vi khuẩn phân lập được là tụ cầu vàng nhạy với methicillin, điều trị một cách phù hợp)	*S. epidermidis* *S. aureus* (Tụ cầu vàng kháng lại methicillin).	Vancomycin ***phối hợp hoặc không phối hợp với*** rifampin 10mg/kg (TM hoặc uống) mỗi 12 h/lần ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.	Linezolid ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt. *Nếu phân lập được tụ cầu vàng nhạy với methicillin* Nafcillin ***phối hợp hoặc không phối hợp với*** rifampin 10mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.
	S. aureus (Tụ cầu vàng nhạy với methicillin).	Nafcillin ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.	Vancomycin ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.
	Họ vi khuẩn đường ruột (*Enterobacteriaceae*).	Cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.	Meropenem ×7–10 ngày sau khi rút bỏ shunt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

***Các từ viết tắt*: MRSA/MSSA** (methicillin-resistant/sensitive *S. aureus*): Tụ cầu vàng kháng lại/nhạy với methicillin.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường TM song có thể uống được thuốc nên chuyển sang điều trị bằng đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684** để biết liều dùng của thuốc.*

* *Thời gian điều trị: Đối với liên cầu nhóm B ≥ 14 ngày (đối với viêm não thất 4 tuần); E. coli, Citrobacter, Serratia ≥ 21 ngày; Listeria 10–14 ngày; Cầu khuẩn ruột ≥ 14 ngày; Phế cầu 10–14 ngày; H. influenza ≥ 10 ngày; Não mô cầu 4–7 ngày.*

Viêm màng não cấp do vi khuẩn (đối tượng người bình thường)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, đau đầu, gáy cứng (hoặc phồng thóp trước ở trẻ sơ sinh), trẻ dễ bị kích thích, nôn, ngủ lịm, tiến triển qua nhiều giờ tới 1–2 ngày. Trẻ càng nhỏ tuổi, biểu hiện lâm sàng càng không đặc hiệu (Ví dụ: dễ bị kích thích, ngủ lịm, sốt, bỏ bú).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên các thay đổi thành phần sinh hóa trong dịch não tủy, nhuộm Gram, nuôi cấy. Các dấu hiệu dịch não tủy cũng tương tự như các bất thường được gặp ở người lớn: tăng số lượng tế bào trong dịch não tủy (100–5000 bạch cầu/mm^3; chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính), tăng protein, → glucose. Giá trị bình thường của các thành phần dịch não tủy khác biệt theo tuổi:

	Số lượng bạch cầu/mm^3 (khoảng dao động) **% bạch cầu đa nhân trung tính**	**Protein mg/dL (khoảng dao động)**	**Glucose, mg/dL (khoảng dao động)**
Trẻ đẻ non	9 (0-25); 57% bạch cầu đa nhân trung tính	115 (65-150)	50 (24-63)
Trẻ sơ sinh đủ tháng	8 (0-22); 61% bạch cầu đa nhân trung tính	90 (20-170)	52 (34-119)
Trẻ nhỏ	0 (0-7), 0% bạch cầu đa nhân trung tính	(5-40)	(40-80)

Phỏng theo *The Harriet Lane handbook, ấn bản lần thứ 15.*

Lưu ý: Trẻ càng nhỏ tuổi, biểu hiện càng không đặc hiệu. Khi trẻ đã dùng kháng sinh trước đó (ví dụ: điều trị đường uống đối với viêm tai giữa), có thể gây ra tình trạng viêm màng não đã được điều trị một phần (partially-treated meningitis); các xét nghiệm bổ sung thêm như test tìm kháng nguyên của vi khuẩn hoặc test điện di miễn dịch đối lưu (CIE tests) có thể có giá trị chẩn đoán trong bối cảnh này. Đặc biệt là vào mùa hạ, chẩn đoán nhanh virus (nhất là kỹ thuật khuếch đại gen [PCR] đối với enterovirus) có thể giúp loại trừ viêm màng não cấp do vi khuẩn và tránh phải cho bệnh nhân nhập viện và sử dụng kháng sinh không cần thiết. Xét nghiệm khuếch đại gen [PCR] đối với virus Herpes simplex cũng có thể hữu ích trong loại trừ viêm màng não cấp do vi khuẩn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Cần dùng kháng sinh với liều cho màng não trong toàn bộ quá trình điều trị. Chọc lại dịch não tủy được chỉ định sau 24-48 giờ nếu không thấy có đáp ứng lâm sàng hoặc trong tình huống nghi vấn vi khuẩn kháng thuốc (Vd: phế cầu kháng lại penicillin hoặc trẻ sơ sinh bị viêm màng não do trực khuẩn Gram âm). Dexamethason (0,3mg/kg TM mỗi 12 h/lần ×2 ngày) có thể giúp làm giảm di chứng thần kinh (Vd: điếc) ở trẻ ≥ 6 tuần tuổi khi được cho trước/ cùng với liều kháng sinh đầu tiên.

Tiên lượng: Thay đổi theo tác nhân gây bệnh và tuổi của bệnh khi có biểu hiện lâm sàng. Tỷ lệ tử vong toàn bộ < 5% tại Hoa Kỳ (tỷ lệ tử vong cao hơn ở các nước đang phát triển). Tỷ lệ tàn phế là 30–35% với tình trạng giảm thính lực là di chứng thần kinh thường gặp nhất. Tần suất mắc các di chứng thần kinh: do phế cầu > do *H. influenzae* > do não mô cầu. Sử dụng vaccin liên hợp phòng *H. influenzae* (typ B) và phế cầu khuẩn trong chương trình tiêm chủng thường quy cho trẻ đã giúp làm giảm tỷ lệ mắc mới của viêm màng não do các tác nhân gây bệnh nói trên gây ra, song sự nổi lên gần đây của phế cầu có typ huyết thanh 19A là thủ phạm gây ra nhiều trường hợp viêm màng não do não mô cầu xảy ra liên tiếp. Trẻ sơ sinh có gia tăng nguy cơ tử vong và bị các di chứng thần kinh nặng nề và có tỷ lệ cao bị áp xe não ở các trẻ sơ sinh bị viêm màng não do vi khuẩn Gram âm (nhất là nhiễm khuẩn do Citrobacter và Serratia).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm màng não cấp do vi khuẩn (Các nhiễm khuẩn shunt hệ thần kinh trung ương)

Biểu hiện lâm sàng: Âm thầm (trẻ có tình trạng ngủ lịm, dễ bị kích thích, nôn) hoặc cấp tính (sốt cao, tình trạng ý thức suy giảm).

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng nhuộm Gram/nuôi cấy dịch não tủy, thường bệnh phẩm được lấy bằng cách lấy dịch não tủy chảy qua shunt.

Lưu ý: Cấy máu thường âm tính đối với tác nhân gây nhiễm khuẩn shunt và số lượng bạch cầu trong dịch não tủy có thể thấp.

Xem xét điều trị: Nhiễm khuẩn do tụ cầu coagulase âm tính có nguy cơ cao bị kháng lại đối với nafcillin. Phối hợp thêm rifampin với vancomycin có thể cải thiện khả năng thanh lọc vi khuẩn. Để đạt được điều trị triệt để nhiễm khuẩn thường cần phải rút bỏ shunt đặt trong hệ thần kinh trung ương.

Tiên lượng: Tốt, khi thiết bị nhân tạo đặt trong hệ thần kinh trung ương (shunt) được rút bỏ.

Viêm não

Đối tượng	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch†	Chuyển từ đường TM sang đường Uống†
Herpes	HSV-1	Acyclovir ×14–21 ngày	Chỉ điều trị đường TM
Arbovirus	WNV, SLE, viêm não Powassan (Powassan encephalitis), EEE, WEE, VEE, JE, CE	Không có điều trị đặc hiệu	
Mycoplasma	*M. pneumoniae*	Doxycyclin ***hoặc*** minocyclin ×2–4 tuần	Doxycyclin ***hoặc*** minocyclin ×2–4 tuần
Các virus hô hấp	*Influenza, enterovirus*, sởi	Không có điều trị đặc hiệu	

***Các từ viết tắt*: HSV-1**(*Herpes simplex virus*-1): *Virus Herpes simplex*-1; **WNV** (West Nile Virus): Virus vùng bờ tây sông Nil; **SLE** (St. Louis encephalitis): Viêm não St Louis; **EEE** (Eastern equine encephalitis): Viêm não ngựa vùng miền Đông; **WEE** (Western equine encephalitis): Viêm não ngựa vùng miền Tây; **VEE** (Venezuelan equine encephalitis): Viêm não ngựa Venezuela; **JE** (Japanese encephalitis): Viêm não Nhật bản; **CE** (California encephalitis): Viêm não California.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường TM song có thể uống được thuốc nên chuyển sang điều trị bằng đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684*** để biết liều dùng của thuốc.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm não do Herpes (HSV-1)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và thay đổi tình trạng ý thức/ thay đổi hành vi của trẻ. Tình trạng sốt cao với co giật không đáp ứng với điều trị bằng thuốc chống co giật và trung tâm thần kinh cảm giác bị ức chế nặng nề có thể là các biểu hiện ưu thế trong bệnh cảnh lâm sàng.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán bằng xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) tìm HSV-1 trong dịch não tủy. Các dấu hiệu biến đổi dịch não tủy bao gồm tăng hồng cầu/bạch cầu, giảm nồng độ glucose và tăng nhiều protein. Các thay đổi điện não đồ kinh điển với các đỉnh sóng nhọn ở thùy thái dương (temporal lobe spikes) có thể được biểu hiện sớm. Sinh thiết não hiếm khi cần được chỉ định.

Lưu ý: Hình ảnh chụp CT/MRI có thể bình thường lúc khởi đầu. Chậm trễ chẩn đoán và điều trị gây các kết cục bất lợi cho bệnh nhân.

Xem xét điều trị: Virus *Herpes simplex* là viêm não do virus duy nhất có thể điều trị được ở các đối tượng là người bình thường.

Tiên lượng: Điều trị bằng thuốc chống virus giúp cải thiện tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, song tùy thuộc vào mức ý thức khi bệnh nhân biểu hiện bệnh, tỷ lệ tử vong vẫn còn vào khoảng 10–20%.

Viêm não do arbovirus

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt, đau đầu, biến đổi tình trạng ý thức. Thường xảy ra theo mùa (thường gặp hơn vào mùa hè/mùa thu), dựa trên tiền sử du lịch/ tiếp xúc với côn trùng trung gian truyền bệnh. Có thể rất nặng với tỷ lệ tử vong cao. Viêm não miền Tây sông Nil có biểu hiện triệu chứng hiếm gặp ở trẻ em.

Xem xét chẩn đoán: Huyết thanh học là biện pháp chính để chẩn đoán bệnh. Xét nghiệm khuếch đại gen "tìm các virus gây viêm não" (PCR "encephalitis panels") đang được phát triển để phục vụ cho sử dụng lâm sàng.

Xem xét điều trị: Không có điều trị virus đặc hiệu. Điều trị hỗ trợ là chính.

Lưu ý: Cần bảo đảm là đã khai thác tiền sử phơi nhiễm tiềm tàng/ du lịch của các trẻ bị sốt/biến đổi tình trạng ý thức.

Tiên lượng: Thay đổi theo tác nhân gây bệnh. Có thể xảy ra tỷ lệ tử vong cao và để lại các khiếm khuyết thần kinh tồn dư nghiêm trọng, nhất là với viêm não ngựa miền Đông nước Mỹ (Eastern Equine encephalitis).

Viêm não do Mycoplasma

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và thay đổi tình trạng ý thức. Các dấu hiệu tiền triệu với ho, đau họng, triệu chứng hô hấp có thể xảy ra.

Xem xét chẩn đoán: Dịch não tủy cho thấy có tăng nhẹ số lượng tế bào với ưu thế tế bào đơn nhân, nồng độ glucose bình thường hoặc giảm nhẹ và tăng nhẹ protein. Hiệu giá IgG/IgM đối với mycoplasma tăng cao.

Lưu ý: Dấu hiệu dịch não tủy có thể bị nhầm với viêm não do virus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Tình trạng bệnh lý thường tự khỏi ngay cả khi bệnh nhân không được điều trị bằng kháng sinh. Doxycyclin hoặc minocyclin thâm nhập được vào hệ thần kinh trung ương và có thể dùng cho trẻ > 8 tuổi. Macrolid có thể điều trị được nhiễm khuẩn phối song không thâm nhập được vào hệ thần kinh trung ương.

Tiên lượng: Tốt. Hiếm gặp các di chứng thần kinh.

Viêm não do virus hô hấp

Biểu hiện lâm sàng: Viêm não có thể xảy ra trong hoặc ngay sau một bệnh lý hô hấp cấp. Viêm não do cúm (*Influenzae encephalitis*), mặc dù hiếm gặp, song có thể cực kỳ nặng với nhiều trường hợp tử vong được báo cáo hàng năm ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Xem xét chẩn đoán: Adenovirus một cách hãn hữu có thể phát hiện được từ dịch não tủy hoặc từ não ở các trường hợp viêm não. Viêm não cũng đã được mô tả mặc dù rất hiếm gặp liên quan với nhiễm khuẩn do virus hợp bào đường hô hấp (RSV) cũng như nhiễm khuẩn parainfluenza.

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp viêm não không được chẩn đoán, một phần do thất bại trong nghĩ tới và xét nghiệm tìm virus hô hấp.

Xem xét điều trị: Cho tới hiện tại không có bằng chứng gợi ý lợi ích của điều trị chống cúm cho bệnh nhân viêm não do cúm.

Tiên lượng: Nói chung bệnh tự khỏi và hồi phục hoàn toàn, song các trường hợp tử vong đã được báo cáo đối với viêm não do cúm. Viêm não do Adenovirus ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch cũng có thể rất nặng.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN VÙNG ĐẦU-MẶT-CỔ

Viêm mô tế bào quanh hốc mắt/ Viêm mô tế bào vùng hốc mắt

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †	Chuyển từ đường TM sang đường uống†
Viêm mô tế bào quanh hốc mắt (Periorbital cellulitis)	Phế cầu *H. influenzae* *M. catarrhalis* Tụ cầu vàng	**Điều trị kết hợp bằng** Nafcillin* ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim ×10–14 ngày.	Ampicillin-sulbactam ×10–14 ngày.	Amoxicillin-clavulant **hoặc** cefuroxim **hoặc** cefpodoxim ***hoặc*** cefdinir × 10–14 ngày.
Viêm mô tế bào vùng hốc mắt	Phế cầu *H. influenzae* *M. catarrhalis* Tụ cầu vàng Các vi khuẩn kỵ khí Liên cầu nhóm A	***Điều trị kết hợp bằng*** Nafcillin ***cộng với*** ceftriaxon ×10–14 ngày.	Piperacillin tazobactam ***hoặc*** ampicillin sulbactam ***hoặc*** ticarcillin-clavulanat ×10–14 ngày.	Amoxicillin clavulanat ***hoặc*** cefuroxim ***hoặc*** cefpodoxim ***hoặc*** cefdinir ×10–14 ngày.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường TM song có thể uống được thuốc nên chuyển sang điều trị bằng đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

** Hoặc vancomycin nếu nhiều khả năng tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng kháng methicillin.*

*† **Xem trang 674-684** để biết liều dùng của thuốc.*

Biểu hiện lâm sàng: Viêm mô tế bào quanh hốc mắt (hay trước vách hốc mắt) và viêm mô tế bào vùng hốc mắt là các nhiễm khuẩn do vi khuẩn. Sốt, phù mi mắt và viêm đỏ da quanh mắt thường cùng chung với viêm xoang cấp. Trong viêm mô tế bào quanh hốc mắt, tình trạng nhiễm khuẩn ở phía trước so với

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

vách hốc mắt (orbital septum). Viêm mô tế bào hốc mắt tác động tới chính bản thân hốc mắt, các cơ/thần kinh ngoài mắt và có thể cả thần kinh thị giác. Lồi mắt (proptosis) và hạn chế vận động nhãn cầu giúp xác nhận tình trạng viêm mô tế bào hốc mắt.

Xem xét chẩn đoán: Sử dụng chụp CT để chẩn đoán phân biệt giữa viêm mô tế bào trước vách hốc mắt (preseptal cellilitis) với viêm mô tế bào quanh hốc mắt (periorbital cellulitis) và giúp phát hiện được mức độ tác động tới ổ mắt khi có tình trạng này.

Lưu ý: Không phát hiện được tổn thương xâm phạm vào hốc mắt dẫn tới tình trạng tổn hại thần kinh thị giác hoặc tổn thương lan rộng tới hệ thần kinh trung ương/ huyết khối xoang tĩnh mạch hang. Chụp cắt lớp vi tính không thể phân biệt được tình trạng viêm tấy với áp xe.

Xem xét điều trị: Viêm mô tế bào hốc mắt là tình trạng cấp cứu hơn so với viêm mô tế bào quanh hốc mắt và cần được điều trị ngay từ đầu bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Có thể có chỉ định dẫn lưu bằng phẫu thuật nếu có ổ áp xe được xác định chắc chắn hoặc đối với các tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Tiên lượng: Tốt khi được điều trị ngay bằng kháng sinh và phẫu thuật nhãn khoa nếu cần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xoang

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch† (Cho bệnh nhân nằm viện)	Điều trị đường Uống hoặc Chuyển từ đường uống sang đường tĩnh mạch † (điều trị ngoại trú)
Cấp tính	Phế cầu *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Ceftriaxon ***hoặc*** cefuroxim ×1–2 tuần.	Amoxicillin ***hoặc*** amoxicillin/ acid clavulanic ***hoặc*** cephalosporin ***hoặc*** clarithromycin* ×10–14 ngày ***hoặc*** azithromycin* ×5 ngày.
Mạn tính	Giống như đối với thể cấp tính + vi khuẩn kỵ khí ở khoang miệng.	Đòi hỏi phải điều trị kháng sinh dài ngày hơn (2- 4 tuần).	

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường TM+ đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang được điều trị theo đường TM song có thể uống được

thuốc nên chuyển sang điều trị bằng đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng (thường < 72 giờ).

* *Macrolid có thể có hiệu quả kém hơn và nên được dành để sử dụng cho các bệnh nhân bị dị ứng với penicillin và cephalosporin.*

† ***Xem trang 674-684*** để biết liều dùng của thuốc.

Biểu hiện lâm sàng: Chảy nước mũi và ho thường gặp với đau đầu, đau vùng mặt và sốt với mức tăng nhiệt độ không cao kéo dài > 10–14 ngày. Bệnh cũng có thể biểu hiện cấp tính với sốt cao (≥ 104°F) và chảy mủ mũi ± đau đầu dữ dội kéo dài ≥ 3 ngày .

Xem xét chẩn đoán: Viêm xoang cấp là một chẩn đoán lâm sàng. Các thăm dò hình ảnh học không được chỉ định thường quy trên lâm sàng. Có tình trạng chồng lấp với nhiễm khuẩn do virus cấp và các triệu chứng dị ứng có thể khiến chẩn đoán gặp khó khăn.

Lưu ý: Khám xoang bằng chiếu sáng xuyên mô (transillumination), sưng đau vùng xoang khi gõ vào trong lúc thăm khám và màu sắc của chất tiết mũi là các chỉ dẫn không đáng tin cậy để chẩn đoán viêm xoang.

Xem xét điều trị: Vi khuẩn học/ kháng sinh tương tự như đối với viêm tai giữa cấp, song thời gian điều trị kéo dài 10–14 ngày. Không thấy có đáp ứng với điều trị kháng sinh khởi đầu gợi ý tác nhân gây bệnh đề kháng lại với kháng sinh hoặc cần một chẩn đoán thay thế khác. Không có đủ dữ liệu ủng hộ cho quan điểm điều trị kháng sinh dài ngày. Quinolon không được phê chuẩn để điều trị viêm xoang .

Tiên lượng: Tốt. Đối với tình trạng tái phát xảy ra thường xuyên, xem xét chỉ định các thăm dò hình ảnh học và hội chẩn bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng/ dị ứng.

Viêm ống tai ngoài

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị tại chỗ
"Tai của người đi bơi" ("Swimmer's ear")	*Pseudomonas sp.* Họ vi khuẩn đường ruột (Entero-bacteriaceae) Tụ cầu vàng (*S. aureus*)	Polymyxin B cộng với neomycin ***cộng với*** hydrocortison (thuốc nhỏ tai) mỗi 6h/lần ×7–10 ngày ***hoặc*** Ofloxacin (dung dịch nhỏ tai 3%) mỗi 12h/lần ×7–10 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Đau tai, ngứa và cảm giác tăng vọng âm thanh. Tình trạng đau bị gia tăng thêm khi kéo vùng loa tai (pinna) hoặc gờ bình nhĩ (tragus) của ống tai ngoài. Xuất tiết dịch mủ có thể được thấy ở ống tai ngoài. Sốt thường không được thấy.

Xem xét chẩn đoán: Viêm tai ngoài là một chẩn đoán lâm sàng. Thường khai thác được tiền sử gần đây bệnh nhân đi bơi hoặc lấy ráy tai bằng tăm bông ngoáy tai. Viêm tai ngoài ác tính (malignant otitis externa) được gặp ở bệnh nhân người lớn có tuổi bị đái tháo đường, cực kỳ hiếm ở trẻ em song có thể được gặp ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Lưu ý: Không phát hiện ra được thủng màng nhĩ có thể dẫn tới chẩn đoán sai viêm tai ngoài dựa trên sự hiện diện mủ trong ống tai.

Xem xét điều trị: Làm sách tại chỗ (VD: bằng acid acetic 2%) và điều trị tại chỗ bằng dịch treo bao gồm corticosporin-polymixin B-neomycin thường là đủ. Nên cân nhắc dùng kháng sinh đường uống để điều trị sốt/viêm hạch vùng cổ.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt. Làm sạch tai bằng thuốc nhỏ tai loại acid acetic 2% sau khi bơi giúp dự phòng tái phát viêm ống tai ngoài.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm tai giữa cấp tính

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tiêm bắp †	Điều trị đường uống †
Nhiễm khuẩn khởi đầu không biến chứng do vi khuẩn	*S. pneumoniae* *H. influenzae* *M. catarrhalis*	Ceftriaxon ×1 liều.	Amoxicillin×10 ngày ***hoặc*** cefdinir ×10 ngày** ***hoặc*** azithromycin (theo phác đồ điều trị 1, 3 hoặc 5 ngày) ***hoặc*** erythromycin-sulfisoxazol ×10 ngày** ***hoặc*** TMP–SMX ×10 ngày**
Thất bại điều trị hoặc vi khuẩn kháng thuốc*	Phế cầu kháng thuốc (DRSP) *H. influenzae* với beta-lactamase (+)	Ceftriaxon mỗi 24 h/ lần ×3 liều.	Amoxicillin/ acid clavulanic ***hoặc*** ES-600 ††× 10 ngày** ***hoặc*** cephalosporin ×10 ngày†*

***Các từ viết tắt*: DRSP** (drug-resistant *S. pneumoniae*): Phế cầu kháng thuốc. Liều dùng cho nhi khoa được cung cấp; Viêm tai giữa cấp tính không thường gặp ở người lớn. Đối với viêm tai giữa mạn tính, cần điều trị kháng sinh kéo dài.

* *Được coi là điều trị thất bại khi: các triệu chứng tiếp diễn và bất thường khi soi tai tiếp tục tồn tại*

48–72 giờ sau khi tiến hành điều trị bằng kháng sinh. Về các yếu tố nguy cơ đối với phế cầu kháng thuốc (DRSP), xem phần ***Xem xét điều trị*** *ở dưới. Nếu vẫn tiếp tục thất bại với điều trị sau khi áp dụng điều trị được khuyến cáo, xem xét khả năng phế cầu kháng clindamycin hoặc chọc màng nhĩ hút dịch (tympanocentesis) để lấy bệnh phẩm nhuộm Gram và nuôi cấy.*

** *Ở trẻ > 6 tuổi bị viêm tai giữa cấp mức độ từ nhẹ tới vừa, một liệu trình điều trị bằng kháng sinh kéo dài 5–7 ngày có thể thỏa đáng về phương diện lý thuyết.*

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều dùng của thuốc.*

†† *ES-600 = 600mg amoxicillin/5mL.*

‡ *Liệu trình điều trị kéo dài 10 ngày bằng cefuroxim axetil 15mg/kg (uống) mỗi 12h/ lần hoặc cefdinir 7 mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần hoặc 14mg/kg (uống) mỗi 24h/lần hoặc cefpodoxim 5mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần có thể được dùng.*

Biểu hiện lâm sàng: Sốt, đau tai, mất thính lực. Biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu thường gặp hơn ở các trẻ càng nhỏ tuổi (dễ bị kích thích, sốt). Yếu tố chính để chẩn đoán là khám màng nhĩ của trẻ. Viêm tai giữa cấp đòi hỏi phải có bằng chứng viêm và ứ dịch trong hòm nhĩ. Không thường gặp ở người lớn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán dựa trên dấu hiệu màng nhĩ lồi lên, mờ đục và xung huyết với mất các điểm mốc và giảm di động khi khám tai bằng ống soi tai khí (pneumatic otoscopy).

Lưu ý: Không lấy bỏ được ráy tai (không nhìn thấy rõ màng nhĩ) và dựa vào tiền sử đau tai/đau khi kéo mạnh tai là các yếu tố chính liên quan với chẩn đoán quá mức đối với viêm tai giữa. Viêm tai giữa ứ dịch (tức là màng nhĩ bị co lại hoặc ở vị trí bình thường song giảm tính di động hoặc di động khi có áp lực âm; dịch hiện diện trong hòm nhĩ song có màu sắc bình thường) thường thuyên giảm tự nhiên và không cần điều trị bằng kháng sinh.

Xem xét điều trị: Các yếu tố nguy cơ đối với nhiễm khuẩn phế cầu kháng thuốc (DRSP) bao gồm đã điều trị bằng kháng sinh trong vòng 30 ngày trước đó, không thấy có đáp ứng điều trị trong vòng 48–72 giờ điều trị, được điều trị ngoại trú tại các phòng khám bệnh viện và điều trị dự phòng kháng sinh. Sử dụng macrolid và TMP–SMX có thể dễ dẫn tới nhiễm khuẩn do phế cầu kháng thuốc và 25% các chủng phế cầu có tình trạng đề kháng tự nhiên với macrolid. Quinolon không được phê chuẩn để điều trị.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt, song có khuynh hướng tái phát. Viêm tai giữa mạn tính, viêm tai có cholesteatoma, viêm xương chũm là các biến chứng hiếm gặp. Rạch màng nhĩ đặt ống dẫn lưu dịch (tympanostomy tubes)/cắt VA (adenoidectomy) đối với viêm tai giữa thường xuyên tái phát là thủ thuật ngoại khoa hàng đầu ở trẻ em.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xương chũm

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn[†]	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế[†]	Điều trị đường Uống hoặc chuyển từ đường TM sang đường Uống[†]
Cấp tính	Phế cầu (*S. pneumoniae*) Tụ cầu vàng (*S.aureus*) Liên cầu nhóm A *H. influenzae*	Nafcillin ***hoặc*** vancomycin (nếu nghi vẫn nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin [MRSA]) ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim ×10–14 ngày.	Ampicillin-sulbactam ×10–14 ngày.	Amoxicillin–clavulanat ***hoặc*** cefpodoxim hoặc cefdinirx10–14 ngày.
Mạn tính	Nhiều loại vi khuẩn bao gồm: *P. aeruginosa*, *S.aureus*, vi khuẩn kỵ khí, họ vi khuẩn đường ruột (Entero-bacteriacea).	Piperacillin ***hoặc*** ticarcillin ×10–14 ngày.	Meropenem ***hoặc*** imipenem × 10–14 ngày.	Không có.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường TM + đường uống hoặc đường uống. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

[†] ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

Biểu hiện lâm sàng: Sốt và đau tai với tình trạng sưng /viêm đỏ da vùng sau tai đẩy vành tai lên phía trên và sang bên. Biểu hiện lâm sàng có thể kín đáo hơn (tức là tình trạng nhiễm trùng -nhiễm độc ít hơn, ít sưng nề, chỉ có dấu hiệu liệt Bell đơn độc) ở trẻ lớn được điều trị một phần bằng kháng sinh. Hiếm gặp viêm tai giữa đi kèm đồng thời.

Xem xét chẩn đoán: Viêm xương chũm cấp được chẩn đoán bằng lâm sàng, song chụp cắt lớp vi tính giúp khẳng định chẩn đoán. Chọc màng nhĩ (tympanocentesis) qua trống tai còn nguyên vẹn để hút dịch và đặt dẫn lưu qua chỗ chọc màng nhĩ (tympanostomy tube) hữu ích để xét nghiệm vi khuẩn và dẫn lưu dịch. Viêm xương chũm mạn thường do nhiều loại vi khuẩn gây ra, kể cả các vi khuẩn kỵ khí và trực khuẩn mủ xanh (*P. aeruginosa*). Lao hiếm khi được

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

biểu hiện như một tình trạng viêm xương chũm mạn tính.

Lưu ý: Không được bỏ sót tình trạng viêm xương chũm ở trẻ lớn tuổi có tình trạng viêm tai không đáp ứng với điều trị. Tác động tới ổ mắt có thể dẫn tới tổn thương thần kinh thị giác hoặc lan rộng tới hệ thần kinh trung ương/ huyết khối xoang hang .

Xem xét điều trị: Điều trị dựa trên kết quả vi khuẩn học và cần điều trị kháng sinh ít nhất 3 tuần.

Tiên lượng: Tốt, nếu được điều trị sớm.

Viêm họng

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch hoặc đường tiêm bắp†	Điều trị theo đường Uống hoặc Chuyển từ đường TM sang đường Uống†
Xuất tiết (có nuôi cấy)	Liên cầu nhóm A	Benzathin penicillin tiêm bắp ×1 liều.	Penicillin V ***hoặc*** amoxicillin × 10 ngày. ***Điều trị thay thế***: azithromycin 12mg/kg/ngày ×5 ngày ***hoặc*** cephalexin ***hoặc*** cefadroxil ***hoặc*** erythromycin ***hoặc*** clarithromycin ***hoặc*** clindamycin ×10 ngày.
Người mang không có triệu chứng	Liên cầu nhóm A	Không chỉ định điều trị.	Không chỉ định điều trị.
Bệnh tái phát/ tiếp diễn dai dẳng	Liên cầu nhóm A	Clindamycin.	Amoxicillin-clavulanat ×10 ngày ***điều trị kết hợp với hoặc*** penicillin V ***hoặc*** amoxicillin ×10 ngày cộng với rifampin bổ sung thêm vào ngày 7–10.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xuất tiết, liên quan với quan hệ tình dục	Lậu cầu (*N. gonorrhoeae*)	Ceftriaxon (tiêm bắp). ×1 liều	Quinolon*
Hội chứng Lemierre (viêm tĩnh mạch huyết khối tĩnh mạch cảnh do septic [Jugular vein septic thrombo-phlebitis]) ‡	*Fusobacterium necrophorum*	Clindamycin (TM) ***hoặc*** penicillin G (TM) ×4–6 tuần.	Clindamycin hoặc penicillin VK × 4–6 tuần.
Viêm họng có bọng nước, loét	Các Enterovirus HSV1 hoặc 2	Nhiễm virus Herpes simplex tiên phát: Acyclovir ×5–7 ngày.	Nhiễm virus Herpes simplex tiên phát: Acyclovir ***hoặc*** valacyclovir ×5–7 ngày.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, tiêm bắp, đường TM + đường uống hoặc đường uống. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

* *Dường như phù hợp đối với trẻ vị thành niên mặc dù thuốc chỉ được cấp phép sử dụng cho các đối tượng > 18 tuổi. Xem chương dành cho người lớn để biết thêm thông tin và thuốc và liều dùng.*

‡ *Chỉ dùng đường tĩnh mạch hoặc chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Đau họng cấp và sốt kèm với viêm sưng đau hạch bạch huyết vùng cổ. Xem xét lâm sàng chính là cần phân biệt giữa viêm họng do liên cầu nhóm A (Group A streptococci) với viêm họng do virus/ nguyên nhân khác (VD: adenovirus, enterovirus, virus hô hấp, các nhóm liên cầu khác [C, G], *Arcanobacterium hemolyticum*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, EBV). Ít khả năng là viêm họng do liên cầu nhóm A khi có kèm biểu hiện sổ mũi, viêm kết mạc mắt, khàn tiếng, ho, viêm miệng cấp, loét miệng thành các ổ riêng rẽ (discrete oral ulcerations) hoặc ỉa chảy- trẻ có các biểu hiện này không cần tiến hành thường quy nuôi cấy dịch họng.

Xem xét chẩn đoán: Các xét nghiệm cận lâm sàng để xác định đối với liên cầu nhóm A được khuyến cáo, do lâm sàng không thể phân biệt được nhiễm khuẩn do liên cầu nhóm A với viêm họng do virus. Test nhanh tìm kháng nguyên liên cầu nhóm A được coi là tin cậy với độ đặc hiệu cực kỳ cao, song do độ nhạy của test có thể thay đổi, khi kết quả test nhanh âm tính cần khẳng định lại bằng kết

quả cấy dịch hầu họng. Độ chính xác của test tìm kháng nguyên và cấy dịch họng phụ thuộc vào kỹ thuật ngoáy họng đúng để thu được bệnh phẩm là chất tiết của họng hầu/ amydal.

Lưu ý: Cần đảm bảo chắc chắn là lấy được bệnh phẩm dịch họng bằng ngoáy họng đúng kỹ thuật. Thường không khuyến cáo tiến hành xét nghiệm lại sau điều trị trừ khi bệnh nhân có nguy cơ cao bị thấp tim (VD: tiền sử gia đình, đang xảy ra dịch) hoặc vẫn còn biểu hiện triệu chứng sau 10 ngày điều trị. Người mang liên cầu nhóm A không có triệu chứng không cần phải điều trị bằng kháng sinh, song phát hiện được các đối tượng là "người mang thực sự" ("true carrier") có thể khó khăn. Nên xem xét điều trị triệt để đối với người mang liên cầu nhóm A trong các tình huống sau: đang trong đợt bùng phát của tình trạng thấp tim cấp hoặc viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn liên cầu; đợt bùng phát của nhiễm khuẩn liên cầu nhóm A tại một cộng đồng có nhiều người sống gần nhau; tiền sử gia đình bị thấp tim; có nhiều đợt nhiễm khuẩn do liên cầu nhóm A trong một gia đình trong nhiều tuần mặc dù có điều trị; tình trạng lo lắng của gia đình về sự hiện diện của liên cầu nhóm A ở một người mang trong gia đình; hoặc đang cân nhắc chỉ định thủ thuật cắt amydal cho một người mang vi khuẩn dai dẳng. Đạt được điều trị triệt để bằng cách sử dụng cùng phác đồ điều trị kháng sinh như đối với "tình trạng bệnh tiếp diễn kéo dài/ tái phát" (*xem cột điều trị ở trang 395*).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét điều trị: Penicillin V (hoặc amoxicillin) là thuốc được chọn dùng để điều trị viêm họng do liên cầu nhóm A. Erythromycin vẫn được xem xét dùng cho các đối tượng bị dị ứng penicillin, mặc dù các chủng liên cầu nhóm A kháng với macrolid đang được báo cáo. Các cephalosporin thế hệ thứ nhất cũng là một điều trị thay thế hữu ích. Các kháng sinh có phổ tác dụng rộng hơn, mặc dù nhiều khả năng có hiệu quả điều trị, song không nên dùng thường quy. Tetracyclin và sulfonamid không điều trị triệt để được tình trạng viêm họng do liên cầu nhóm A. Khi có chỉ định điều trị triệt để nguồn vi khuẩn của người mang như được đề cập ở trên, clindamycin đơn độc hoặc penicillin cộng với rifampin có thể hữu ích.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt. Hiện tại hiếm gặp bệnh thấp tim ở Hoa Kỳ.

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (Community-Acquired Pneumonia)

Loại nhiễm khuẩn (tuổi)	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch†	Điều trị đường uống hoặc chuyển từ đường TM sang đường uống†
Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng *Từ khi sinh tới 20 ngày*	Liên cầu nhóm B, trực khuẩn Gram âm đường ruột (Gram –negative enteric bacteria), CMV.	Ampicillin ***cộng với hoặc*** gentamicin ***hoặc*** cefotaxim ×10–21 ngày.	Không áp dụng.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường TM+ đường uống. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (Community-Acquired Pneumonia) (tiếp)

Phân loại (tuổi)	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch†	Điều trị đường uống hoặc chuyển từ đường TM sang đường uống†
3 tuần đến 3 tháng	Virus hợp bào hô hấp (RSV) Human Para-influenza Metapneumovirus (hmpv)	Không có (điều trị hỗ trợ).	Không có.
	C. trachomatis Phế cầu (*S. pneumoniae*) *B. pertussis* Tụ cầu vàng (*S. aureus*)	Cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon ×10–14 ngày* **Điều trị thay thế:** Ampicillin ***hoặc*** clindamycin*	**Bệnh nhi không sốt:** Erythromycin ×14 ngày **hoặc** azithromycin ×5–7 ngày. **Viêm thùy phổi, bệnh nhi sốt:** Amoxicillin ***hoặc*** amoxicillin/acid clavulanic ***hoặc*** cefdinir ***hoặc*** cefuroxim ***hoặc*** cefpodoxim ×10–14 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

> 3 tháng đến < 5 tuổi	Virus (Virus hợp bào hô hấp [RSV], para-influenza, influenza, adenovirus, rhinoviruses)	**Virus hợp bào hô hấp (RSV)**: Xem xét dùng ribavirin[§] Đối với các trẻ có nguy cơ cao nhất bị nhiễm khuẩn nặng do virus hợp bào hô hấp, xem xét dùng palivizumab 15 mg/kg/tháng ×1–2 mùa để dự phòng. **Virus cúm**: Oseltamivir (Cúm A, B)[¶] Tiêm chủng phòng bệnh thường quy đối với tất cả các trẻ > 6 tháng tuổi.	
	Phế cầu (*S. pneumoniae*) *H. influenzae* *M. pneumoniae*	Ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ertapenem ×10–14 ngày*	Amoxicillin ***hoặc*** amoxicillin-clavulanat ***hoặc*** clarithromycin ***hoặc*** azithromycin ×10–14 ngày.
5–15 tuổi	*M. pneumoniae* *C. pneumoniae* Phế cầu (*S. pneumoniae*)	Ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ertapenem ×10–14 ngày.	Erythromycin ***hoặc*** clarithromycin ***hoặc*** azithromycin ***hoặc*** doxycyclin (> 8 tuổi) ×10–14 ngày.
Ho gà	*Bordetella spp*[‡] Một số adenovirus *M. pneumoniae* *C. trachomatis* Phế cầu (*C. pneumoniae*)	Azithromycin ×5 ngày ***hoặc*** erythromycin × 14 ngày.	Erythromycin estolat ×14 ngày ***hoặc*** clarithromycin ×7 ngày ***hoặc*** azithromycin ×5 ngày. Nếu bệnh nhân dung nạp với macrolid: TMP–SMX ×14 ngày.
Lao	*M. tuberculosis*	*Xem trang 586*	*Xem trang 586*

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

* *Nếu ho mạn tính khởi phát âm ỉ hơn, xem xét phối hợp thêm macrolid đường tĩnh mạch hoặc đường uống (azithromycin, clarithromycin, erythromycin) để bao phủ các vi khuẩn ho gà /C.trachomatis (đối với trẻ từ 3 tuần đến 3 tháng tuổi), Mycoplasma (đối với trẻ từ 3 tháng đến 5 tuổi) hoặc Mycoplasma/C. pneumoniae (đối với trẻ 5–15 tuổi).*

‡ *B. pertussis, B.parapertussis, B.bronchiseptica.*

§ *Việc sử dụng nên hạn chế cho các trường hợp bệnh nghiêm trọng nhất do virus hợp bào hô hấp (RSV), VD: ở bệnh nhân ghép tạng.*

¶ *Các chủng cúm A lưu hành trong các năm 2011–2012 đều có tình trạng kháng amantadin.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (Community-Acquired Pneumonia)

Biểu hiện lâm sàng: Sốt ± khó thở, ho, thở nhanh với hình ảnh thâm nhiễm trên phim Xquang ngực.

Xem xét chẩn đoán: Các tác nhân gây bệnh thường gặp khác biệt tùy theo tuổi của bệnh nhi. Ở trẻ sơ sinh, viêm phổi điển hình thường lan tỏa và là một phần của tình trạng sepsis khởi phát sớm. Ở trẻ nhỏ tuổi, có tình trạng trùng lấp đáng kể giữa các dấu hiệu và triệu chứng của viêm tiểu phế quản (chủ yếu do virus hợp bào hô hấp) và viêm phổi. Viêm phổi nặng thường do nhiễm khuẩn căn nguyên vi khuẩn, mặc dù thường không phân lập được vi khuẩn gây bệnh (VD: cấy máu dương tính chỉ được gặp ở 10–20% các trẻ < 2 tuổi bị viêm phổi do vi khuẩn). Ở trẻ nhỏ tuổi, có thể phát hiện được *Chlamydia trachomatis* bằng xét nghiệm tìm kháng thể (antigen assay) hoặc nuôi cấy chất tiết mũi họng. Viêm phổi do Mycoplasma được chẩn đoán bằng xét nghiệm tìm ngưng kết tố lạnh (cold agglutinins) và huyết thanh học tìm IgG/IgM, với các đỉnh ở độ tuổi 5–15, mặc dù các trường hợp trẻ < 5 tuổi bị mắc cũng đã được báo cáo. Các virus hô hấp (virus hợp bào hô hấp [RSV], cúm, adenovirus, virus parainfluenza, metapneumovirus người [hmpv]) cũng có thể được phát hiện trong chất tiết mũi họng. Nếu trẻ sống ở những vùng có tỷ lệ mắc lao cao, cần xem xét khả năng bị lao trong chẩn đoán phân biệt đối với một trường hợp viêm phổi tiên phát.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Dựa trên mẫu bệnh phẩm chất tiết đường hô hấp trên để nhuộm Gram/nuôi cấy tìm vi khuẩn dẫn tới chẩn đoán sai và điều trị sai, do hiếm khi có thể thu được ở trẻ nhỏ một mẫu bệnh phẩm đờm sâu thực sự.

Xem xét điều trị: Điều trị chủ yếu theo kinh nghiệm dựa trên tuổi của bệnh nhi, các đặc điểm lâm sàng/dịch tễ học và hình ảnh chụp Xquang phổi. Mycoplasma đòi hỏi phải điều trị 2–3 tuần; *C. pneumoniae* có thể cần điều trị tới 6 tuần. Sử dụng thường quy vaccin phòng phế cầu liên hợp (Prevnar) đã làm giảm tần suất mới mắc các viêm phổi do phế cầu.

Tiên lượng: Thay đổi tùy theo tác nhân gây bệnh, tình trạng lâm sàng khi biểu hiện bệnh và tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhi. Tiên lượng kém ở các trẻ bị bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, bệnh thần kinh-cơ và có hemoglobin bất thường .

Các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do các virus hô hấp

Biểu hiện lâm sàng: Các virus gây ra hầu hết các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ở trẻ em. **Virus hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus [RVR])** là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ở các trẻ nhỏ tuổi và được biểu hiện bằng tình trạng viêm tiểu phế quản/viêm phổi do virus và gây ra các vụ dịch hàng năm vào giữa mùa đông . Nguy cơ bị nhiễm khuẩn thứ phát do vi khuẩn (các nhiễm khuẩn khác ngoài viêm tai giữa) rất thấp. Sốt điển hình ở mức độ nhẹ và thường cải thiện trong vòng 3- 5 ngày, ngay cả ở các trẻ cần nhập viện. Virus cúm là một nguyên nhân quan trọng khác gây các vụ dịch viêm đường hô hấp dưới vào mùa đông ở trẻ em thuộc mọi lứa tuổi. Tỷ lệ cần nhập viện đối với trẻ < 1 tuổi cũng tương tự như tỷ lệ được gặp ở quần thể người > 65 tuổi. Các dấu hiệu đặc trưng bao gồm sốt cao và tình trạng viêm đường thở lan tỏa. Các trẻ nhỏ tuổi có thể có các triệu chứng tiêu hóa nổi trội. Nhiễm khuẩn thứ phát do vi khuẩn (viêm tai giữa, viêm phổi, nhiễm trùng máu) là các biến chứng thường gặp sau cúm. Viêm phổi tiên phát do virus cúm, viêm não và viêm cơ tim hiếm gặp và là các biến chứng nặng. Các virus hô hấp khác có liên quan với nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ở trẻ em bao gồm parainfluenza typ 3 (viêm phổi do virus), parainfluenza typ 1và 2 (bạch hầu thanh quản), adenovirus và các metapneumovirus người (hmpv) mới được phát hiện gần đây. Cúm lợn (H_1N_1) ở trẻ em cũng gần giống như bệnh ở người lớn với một số khác biệt quan trọng. Ở người lớn và trẻ em, tăng bạch cầu thay vì giảm bạch cầu luôn gặp, trong khi đó giảm tương đối bạch cầu lympho (tỷ lệ phần trăm) không có nguyên nhân khác giải thích là một dấu hiệu chính ở người lớn song lại không thường gặp ở trẻ em. Ở trẻ em, tăng số lượng bạch cầu lympho thường gặp. Có các bạch cầu lympho không điển hình thường gặp ở trẻ em, song không được thấy ở người lớn bị nhiễm H_1N_1. Giảm số lượng tiểu cầu thường gặp ở cả trẻ em và người lớn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Các hội chứng nhiễm virus thường được chẩn đoán dựa trên đánh giá lâm sàng đơn thuần. Để khẳng định chẩn đoán hoặc ở các trường hợp nặng hơn, chẩn đoán nhanh bằng test phát hiện kháng nguyên (nhuộm kháng thể huỳnh quang trực tiếp [direct fluorescent antibody staining], sử dụng kỹ thuật ELISA, phản ứng khuyếch đại gen [PCR]) và/hoặc nuôi cấy virus hiện nay có thể áp dụng.

Lưu ý: Sử dụng thường quy corticosteroid hoặc thuốc giãn phế quản trong viêm tiểu phế quản do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) không được các bằng chứng lâm sàng ủng hộ. Lạm dụng chẩn đoán thuật ngữ "cúm" ("flu") (ví dụ như tình trạng viêm dạ dày-ruột do virus [viral gastroenteritis] được gọi một cách văn vẻ là "cúm dạ dày" [stomach flu] hay "cúm 24 giờ" [24-hour flu], cúm mùa hè

[summer flu]) đã dẫn tới việc đánh giá mờ nhạt đối với tình trạng cúm thực sự và mức độ nặng của chúng. Tiêm vaccin phòng cúm ở trẻ em đã không còn thường xuyên sử dụng như trước đây. Cũng như đối với người lớn, một test chẩn đoán cúm nhanh cho kết quả âm tính không đủ để loại trừ tình trạng cúm.

Xem xét điều trị: Đối với hầu hết các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do virus, điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ (Ví dụ: bổi phụ dịch thỏa đáng, kiểm soát sốt, cho thở oxy đối với các bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng). Ribavirin được phê chuẩn để điều trị đối với nhiễm khuẩn do virus hợp bào hô hấp, tuy nhiên điều trị này rất hiếm khi được sử dụng do lợi ích lâm sàng không chắc chắn, chi phí điều trị cao và cách dùng thuốc phiền nhiễu (cần khí dung kéo dài). Đối với các bệnh nhi có nguy cơ cao nhất bị bệnh nặng do virus hợp bào hô hấp (ví dụ: các trẻ đẻ non, trẻ có bệnh lý phổi mạn tính hoặc có bệnh tim bẩm sinh nền), dự phòng hàng tháng bằng palivizumab (Synagis) 15mg/kg/tháng (tiêm bắp) giúp làm giảm tỷ lệ nhập viện do nhiễm khuẩn virus hợp bào hô hấp. Theo hướng dẫn điều trị của Viện Hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ, palivizumab được chỉ định cho các trẻ ≤ 24 tháng tuổi có bệnh phổi mạn hoặc bệnh tim bẩm sinh và bắt đầu dùng vào mùa nhiễm khuẩn virus hợp bào hô hấp. Đối với các trẻ đẻ non, palivizumab được xem xét dựa trên sự kết hợp giữa tuổi thai (gestational age [GA]) và tuổi thực tế (chronological age [CA]): Tuổi thai (GA) ≤ 28 tuần cộng với tuổi thực tế (CA) ≤ 12 tháng; Tuổi thai (GA) 29–32 tuần cộng với tuổi thực tế (CA) ≤ 6 tháng, Tuổi thai (GA) 33–35 tuần cộng với Tuổi thực tế (CA) ≤ 3 tháng cộng với anh chị em ruột < 5 tuổi hoặc tại các nhà trông trẻ ban ngày. Đối với nhóm đối tượng cuối cùng khuyến cáo dùng tối đa 3 liều và ngừng lại vào 90 ngày tuổi của trẻ. Đối với các nhóm trẻ có nguy cơ cao khác, khuyến cáo dùng tối đa 5 liều trong suốt mùa đông.

Tiêm phòng vaccin cúm hàng năm được chỉ định cho tất cả các đối tượng > 6 tháng tuổi. Tất cả các chủng cúm A lưu hành đều kháng lại amantadin. Các thuốc ức chế neuraminidase như oseltamivir và zanamivir có chỉ định dùng trong nhi khoa để điều trị và dự phòng cúm (***Bảng 7.1***).

Tiên lượng: Hầu hết các trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do virus đều tiến triển tốt và hồi phục không có di chứng. Các trẻ được nhập viện do nhiễm khuẩn virus hợp bào hô hấp có tỷ lệ bị các đợt thở có cử kiểu hen cao hơn trong vòng 10 năm tiếp theo. Tỷ lệ nhập viện cao nhất do nhiễm cúm gặp ở các trẻ < 2 tuổi và ở người cao tuổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bảng 7.1. Các khuyến cáo về liều dùng thuốc điều trị virus cúm A

Thuốc điều trị virus		Điều trị	Điều trị dự phòng
Oseltamivir*			
Người lớn		Viên nhộng 75mg x 2 lần/ ngày x 5 ngày.	Viên nhộng 75mg x 1 lần/ ngày x 10 ngày.
Trẻ em (bệnh nhi có tuổi ≥ 12 tháng) và có trọng lượng:	≤ 15 kg	60mg mỗi ngày chia thành 2 liều.	30mg x 1 lần/ngày.
	15–23 kg	90mg mỗi ngày chia thành 2 liều.	45mg x 1 lần/ngày.
	24–40 kg	120mg mỗi ngày chia thành 2 liều.	60mg x 1 lần/ngày.
	> 40 kg	150mg mỗi ngày chia thành 2 liều.	75mg x 1 lần/ngày.
Zanamivir			
Người lớn		Hai lần hít 5mg (tổng liều 10mg) x 2 lần/ngày.	Hai lần hít 5mg (tổng liều 10mg) x 1 lần/ngày.
Trẻ em		Hai lần hít 5 mg (tổng liều 10 mg) x 2 lần/ngày (bệnh nhi có tuổi ≥ 7).	Hai lần hít 5mg (tổng liều 10mg) x 1 lần/ngày (bệnh nhi có tuổi ≥ 5).

** Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo dùng oseltamivir liều 3 mg/ kg (uống) mỗi 12 h/lần x 5 ngày cho các trẻ < 12 tháng có tình trạng bệnh nặng.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ho gà

Biểu hiện lâm sàng: Các triệu chứng đường hô hấp trên (congestion, rhinorrhea) trong vòng 1–2 tuần (giai đoạn viêm xuất tiết) tiến triển tới các cơn ho kịch phát (giai đoạn kịch phát) kéo dài 2–4 tuần, thường đặc trưng bởi thở ngắc ngứ khi hít vào, tiếp theo bằng giai đoạn hồi phục trong 1–2 tuần, trong giai đoạn này các cơn ho kịch phát giảm dần về tần suất và mức độ nặng. Sốt thường nhẹ hoặc không sốt. Ở trẻ < 6 tháng tuổi, thường không có tình trạng thở ngắc, tuy nhiên ngừng thở có thể xảy ra. Thời gian bị bệnh ho gà kinh điển là 6–10 tuần. Trẻ lớn tuổi hơn và người lớn có thể có biểu hiện tình trạng ho dai dẳng (không có thở ngắc) kéo dài 2–6 tuần. Các biến chứng bao gồm co giật, viêm phổi thứ phát do vi khuẩn, bệnh não, tử vong. Nguy cơ bị biến chứng lớn nhất là ở các trẻ < 1 tuổi.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán thường được dựa trên bản chất của tình trạng ho và thời gian biểu hiện triệu chứng. Chẩn đoán cận lâm sàng có thể khó. Kết quả nuôi cấy tìm *Bordetella pertussis* dương tính từ bệnh phẩm ngoáy mũi họng đảm bảo vô trùng và sau 3-4 tuần của bệnh kết quả nuôi cấy có thể âm tính. Nhuộm huỳnh quang chất tiết mũi họng tìm kháng nguyên trực tiếp (Direct fluorescent antibody [DFA] staining of nasopharyngeal secretions) có thể áp dụng, song độ nhạy/độ đặc hiệu thay đổi tới rất kém. Xét nghiệm PCR chất tiết mũi là test chẩn đoán nhanh tốt nhất đối với ho gà.

Lưu ý: Cần đảm bảo chắc chắn đã xem xét khả năng bị ho gà ở các trẻ lớn tuổi và người lớn có tình trạng ho kéo dài. Các tiếp xúc trong gia đình với một trường hợp bị ho gà được chẩn đoán xác định phải được dự phòng kháng sinh sau phơi nhiễm. Gần như tất cả các trẻ em phải được tiêm phòng vaccin chống ho gà. Một liều tiêm phòng nhắc lại duy nhất loại vaccin chống ho gà không chứa tế bào (acellular pertussis) được khuyến cáo vào độ tuổi 11–12 (hướng dẫn điều trị thêm để bắt nhịp được với lịch tiêm chủng của trẻ lớn tuổi hơn và người lớn tới 64 tuổi). "sống biệt lập" ("Cocconing") để bảo vệ các trẻ nhỏ khỏi bị ho gà bao gồm gây miễn dịch chống ho gà cho bố mẹ /ông bà của trẻ (> 65 tuổi) và cả những người tham gia chăm sóc trẻ và những người trong gia đình. Các chống chỉ định hiếm gặp cho chỉ định tiêm phòng vaccin ho gà bao gồm có tình trạng phản vệ ở lần tiêm phòng trước đó hoặc xảy ra bệnh não trong vòng 7 ngày sau khi tiêm phòng. Các thận trọng tương đối cần chú ý khi cần tiêm phòng ho gà bổ sung thêm bao gồm: co giật trong vòng 3 ngày sau liều tiêm phòng; trẻ có tình trạng khóc không dỗ được, nặng nề và kéo dài dai dẳng quá ≥ 3 giờ trong vòng 48 giờ sau liều tiêm phòng; sốc hoặc suy sụp đột ngột trong vòng 48 giờ sau liều tiêm phòng; hoặc thân nhiệt ≥ 40,5°C mà không có các nguyên nhân khác trong vòng 48 giờ sau liều tiêm phòng.

Xem xét điều trị: Các trẻ < 6 tháng tuổi thường cần được nhập viện điều trị. Vào giai đoạn kịch phát của bệnh, kháng sinh có tác động khiêm tốn trên tiến triển của bệnh song vẫn được chỉ định để làm giảm nguy cơ lây truyền bệnh. Một kết hợp đã được áp dụng giữa erythromycin dùng đường uống cho các trẻ < 6 tuần tuổi bị hẹp môn vị phì đại bẩm sinh (infantile hypertrophic pyloric stenosis); xem xét dùng một macrolid thay thế (Ví dụ: azithromycin hoặc clarithromycin) cho các trường hợp này.

Tiên lượng: Tốt, mặc dù tiến triển bệnh kéo dài, các di chứng phổi dài hạn chưa được báo cáo sau ho gà. Trẻ < 1 tuổi có nguy cơ lớn nhất bị tàn phế và tử vong, mặc dù tỷ lệ tử vong vẫn rất thấp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lao

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh	Điều trị đường Uống hoặc đường Tiêm bắp (Xem chú thích cuối trang để biết liều thuốc dùng)
Nhiễm khuẩn tiềm tàng (xét nghiệm Mantoux dương tính, tình trạng lâm sàng tốt, chụp Xquang ngực âm tính)	*M. tuberculosis*	INH ×9 tháng ***hoặc*** rifampin × 6 tháng (nếu kháng INH).
Lao phổi và ngoài phổi (ngoại trừ lao màng não)	*M. tuberculosis*	INH ***cộng với*** rifampin ***cộng với*** PZA ×2 tháng tiếp theo bằng INH ***cộng với*** rifampin ×4 tháng. †
Viêm màng não	*M. tuberculosis*	INH ***cộng với*** rifampin ***cộng với*** PZA ***cộng với hoặc*** streptomycin (tiêm bắp) ***hoặc*** ethionamid ×2 tháng, sau đó bằng INH ***cộng với*** rifampin ×7–10 tháng (tức là tổng thời gian điều trị kéo dài 9–12 tháng).‡
Bẩm sinh	*M. tuberculosis*	INH **cộng với** rifampin **cộng với** PZA **cộng với** streptomycin (tiêm bắp).

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† Nếu lo ngại có tình trạng kháng thuốc, EMB hoặc streptomycin (tiêm bắp) được bổ sung thêm (phác đồ điều trị 4 thuốc ở các vùng có tần suất cao trực khuẩn lao kháng nhiều thuốc) vào phác đồ điều trị khởi đầu tới khi test đánh giá độ nhạy của trực khuẩn lao với thuốc được xác định.

‡ Cộng với steroid.

Thuốc chống lao	Liều dùng hàng ngày (mg/kg)	Liều dùng hai lần/tuần (mg/kg)
Isoniazid (INH)	10–15	20–30
Rifampin	10–20	10–20
Ethambutol (EMB)	15–25	50
Pyrazinamid (PZA)	20–40	50
Streptomycin	20–40 (IM)	–
Ethionamid	15–20 (chia thành 2–3 liều nhỏ/ngày)	–

Các thuốc dùng thay thế (capreomycin, ciprofloxacin, levofloxacin, cycloserin, kanamycin, para-aminosalicylic acid) ít thường được sử dụng và chỉ nên dùng các thuốc này sau khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa điều trị lao.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lao

Biểu hiện lâm sàng: Hầu hết các trẻ được chẩn đoán bị nhiễm lao có tình trạng nhiễm khuẩn không có triệu chứng được phát hiện bằng test da với tuberculin (hay phản ứng Mantoux). Bệnh gây triệu chứng được biểu hiện điển hình 1–6 tháng sau nhiễm khuẩn bằng sốt, chậm lớn, mất cân, ra mồ hôi đêm và ho. Các tác động ngoài phổi có thể được biểu hiện bằng viêm màng não, viêm xương chũm mạn tính, hạch to, tổn thương xương, khớp hoặc da. Lao thận và bệnh lý tạo tổn thương hang ở phổi do vi khuẩn lao tái hoạt động (reactivation cavitary disease) hiếm gặp ở trẻ em song có thể được gặp ở trẻ vị thành niên.

Xem xét chẩn đoán: Một test da với tuberculin dương tính (phản ứng Mantoux) chỉ dẫn nhiều khả dương tính năng nhiễm khuẩn do M. tuberculosis. Phản ứng bì với tuberculin dương tính trở lại (tuberculin reactivity) xuất hiện từ 2–12 tuần sau nhiễm khuẩn. Xác định được một phản ứng bì với tubeculin dương tính dựa trên tuổi, tình trạng miễn dịch, nguy cơ phơi nhiễm và mức độ nghi vấn bị bệnh lao. Trẻ < 8 tuổi không thể khạc được đờm để nhuộm và nuôi cấy tìm trực khuẩn lao; thu mẫu bệnh phẩm để phân tích có thể được thực hiện bằng cách lấy 3 mẫu bệnh phẩm là dịch dạ dày vào buổi sáng trong ba ngày liên tiếp.

Lưu ý: Có thể bỏ sót bệnh lao nếu không xem xét chẩn đoán này ở các trẻ có yếu tố dịch tễ bị gia tăng nguy cơ phơi nhiễm. Viêm màng não do lao thường được biểu hiện một cách âm thầm với các biểu hiện không đặc hiệu như dễ bị kích thích và thờ ơ nhiều tuần trước khi xuất hiện khiếm khuyết thần kinh rõ ràng.

Xem xét điều trị: Lựa chọn điều trị ban đầu phụ thuộc vào tình trạng bệnh và khả năng kháng thuốc của trực khuẩn lao (được dựa trên các ca bệnh xác định, phân vùng dịch tễ mắc bệnh lao). Đối với các bệnh nhân bị nhiễm HIV, khoảng thời gian điều trị được kéo dài ≥ 12 tháng. Đối với viêm màng não do lao và bệnh lao kê, phối hợp thêm corticosteroids với điều trị chống lao mang lại lợi ích cho bệnh nhân.

Tiên lượng: Thay đổi theo mức độ của bệnh, tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn lao và tình trạng bệnh lý miễn dịch nền, song nhìn chung bệnh phổi ở trẻ em có tiên lượng tốt. Nhiễm khuẩn xương có thể gây các di chứng về chỉnh hình (VD: bệnh lao cột sống [Pott's disease of the spine] gây xẹp đốt sống). Tiên lượng đối với viêm màng não trở nên dè dặt một khi xảy ra khiếm khuyết thần kinh thành ổ và tình trạng ức chế tâm thần kinh tiếp diễn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN MẠCH MÁU

Các nhiễm khuẩn catheter tĩnh mạch trung tâm (với các loại catheter Broviac, Hickman, Mediport)

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †
Điều trị theo kinh nghiệm; vật chủ bị suy giảm miễn dịch‡	*S. epidermidis* Tụ cầu vàng *(S. aureus)*¶ Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) Pseudomonas Viridans Liên cầu (Streptococci) Cầu khuẩn ruột (Enterococcus)	Meropenem ***hoặc*** piperacillin/ tazobactam ***hoặc*** cefepim ×7–14 ngày.	Piperacillin/ tazobactam ***cộng với*** một aminoglycosid × 7–14 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Trên cơ sở phân lập được vi khuẩn	Tụ cầu vàng (*S. aureus*) Tụ cầu vàng nhạy với methicillin (MSSA)	Nafcillin ***hoặc*** oxacillin trong ≥ 2 tuần.	Cefazolin ***hoặc*** vancomycin (được ưu tiên chọn nếu bệnh nhân có tình trạng dị ứng nặng với betalactam) trong ≥ 2 tuần
	Tụ cầu vàng kháng với methicillin (MRSA)	Vancomycin ***kèm hoặc không kèm với*** gentamicin (để có tác dụng hiệp đồng) trong ≥ 2 tuần.	Linezolid ***hoặc*** quinupristin/ dalfopristin trong ≥ 2 tuần (phối hợp thêm rifampin có thể mang lại lợi ích, đối với tụ cầu vàng kháng lại methicillin [MRSA]).
	Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) Pseudomonas	Piperacillin ***hoặc*** ticarcillin ***kèm hoặc không kèm với*** một aminoglycosid* trong ≥ 2 tuần.	Meropenem ***hoặc*** imipenem ***kèm hoặc không kèm với*** một aminoglycosid* trong ≥ 2 tuần.
	Trực khuẩn Gram âm sinh enzym β-lactamase phổ rộng (ESBL-producing gram-negative bacilli)	Meropenem ***hoặc*** imipenem kèm hoặc không kèm với một aminoglycosid* trong ≥ 2 tuần.	–
	Candida	Amphotericin B ×2–6 tuần.‡	Fluconazol ***hoặc*** caspofungin ***hoặc*** liposomal amphotericin B (nếu có rối loạn chức năng thận) ×2–6 tuần.‡

Từ viết tắt: MSSA/MRSA (methicillin-sensitive/resistant *S. aureus*): Tụ cầu vàng nhạy với /kháng lại methicillin.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

* *Gentamicin, tobramycin hoặc amikacin.*

‡ *Được dựa trên: việc rút bỏ đường truyền tĩnh mạch được thực hiện nhanh tới mức nào, hết vi khuẩn khi cấy máu, bằng chứng ổ nhiễm khuẩn đi bệnh cải thiện.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

[1] *Nếu tình trạng bệnh nặng hoặc nghi vấn nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) dựa trên dịch tễ học tại cơ sở, dùng thêm vancomycin trong phác đồ điều trị khởi đầu trong khi chờ kết quả nuôi cấy vi khuẩn.*

Biểu hiện lâm sàng: Sốt ± sưng đau vị trí chọc catheter khi khám, viêm đỏ da (erythema).

Xem xét chẩn đoán: Cấy máu định lượng vi khuẩn (quantitative blood cultures) từ bệnh phẩm máu ngoại biên/catheter tĩnh mạch được sử dụng tốt nhất để chẩn đoán. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng, các kỹ thuật này không thường xuyên được thực hiện và chẩn đoán được dựa trên kết quả nuôi cấy kết hợp với ≥ 1 bằng chứng sau: viêm tắc mạch tại chỗ hoặc tình trạng viêm tại vị trí chọc catheter; bệnh lý thuyên tắc mạch xa so với vị trí chọc catheter; tình trạng sepsis không đáp ứng với điều trị thích hợp; thuyên giảm sốt sau khi rút bỏ catheter; hoặc các nhiễm khuẩn tụ họp lại được gây ra bởi các vi khuẩn liên quan với đường truyền tĩnh mạch.

Lưu ý: Có thể khó phân biệt với nhiễm khuẩn từ tình trạng nhiễm bẩn trong khi tiến hành cấy máu, nhất là với tụ cầu có coagulase âm tính. Cấy máu dương tính nhiều lần với cùng một tác nhân gây bệnh và/hoặc có các đặc điểm lâm sàng ghi nhận ở trên gợi ý nhiễm khuẩn mà không phải là vi khuẩn cư trú (colonization). Nuôi cấy bán định lượng (Semiquantitative culture) đầu catheter mọc ≥ 15 cụm khuẩn lạc (colonies) cũng có thể hữu ích để khẳng định chẩn đoán và đòi hỏi phải rút bỏ catheter tĩnh mạch trung tâm.

Xem xét điều trị: Các chỉ dẫn cần rút bỏ catheter bao gồm: tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn đường hầm, không đáp ứng trong vòng 48–72 giờ với điều trị hoặc nhiễm khuẩn do Candida, mycobacteria không điển hình hoặc có thể bị nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng. Ngoài ra, có thể cố thử duy trì catheter trong khi điều trị bằng kháng sinh. Nhiễm khuẩn tại chỗ ở vị trí luồn catheter qua da (viêm đỏ da vùng chọc kim, cứng, đau khi chạm vào, chảy mủ) trong phạm vi 2 cm quanh vị trí luồn catheter qua da nên được điều trị tại chỗ (Vd: bôi Neosporin, Bacitracin, Bactroban) kết hợp với điều trị toàn thân.

Tiên lượng: Các biến chứng chính (thuyên tắc mạch do nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc, viêm mạch) hiếm gặp với điều trị tích cực. Nhiễm khuẩn tái diễn có thể xảy ra sau điều trị/ sau khi đã làm sạch được ổ nhiễm khuẩn và thường có thể được điều trị thành công bằng các đợt điều trị kháng sinh thêm. Tình trạng nhiễm khuẩn tiếp diễn dai dẳng cuối cùng sẽ cần phải rút bỏ đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Các hội chứng ỉa chảy cấp (Viêm dạ dày-ruột [Gastroenteritis])

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị thay thế †
Mắc phải từ cộng đồng	Virus (Rotavirus, tác nhân Norwalk [Norwalk agent], adenovirus ruột, enterovirus)	Không có điều trị đặc hiệu được chỉ định.	Không có điều trị đặc hiệu được chỉ định.
	Salmonella không phải là typhi	Ceftriaxon (TM) ***hoặc*** cefotaxim (TM) ×10–14 ngày*	TMP–SMX (TM hoặc uống) ***hoặc*** amoxicillin (uống) ***hoặc*** cefixim (uống) ×10–14 ngày.
	Shigella	Ceftriaxon (TM) ***hoặc*** azithromycin (uống) × 5 ngày	TMP–SMX (uống) ***hoặc*** cefixim (uống) ***hoặc*** ampicillin (uống) ×5 ngày.
	Campylobacter	Erythromycin (uống) ×7 ngày ***hoặc*** azithromycin (uống) ×5 ngày.	Doxycyclin (uống) (trẻ > 8 tuổi) ×7 ngày.
	Yersinia enterocolitica	TMP–SMX (uống) ×5–7 ngày.	Cefotaxim (TM) ***hoặc*** tetracyclin (uống) ***hoặc*** doxycyclin (uống) ×5–7 ngày.
Ỉa chảy xảy ra ở người đi du lịch (Traveler's diarrhea)	*E. coli*	TMP–SMX (uống) ×3 ngày.	Azithromycin (uống) ×3 ngày
Bệnh thương hàn (thể ruột)	*Salmonella typhi*	Ceftriaxon (TM) ***hoặc*** cefotaxim (TM) × 10–14 ngày.	TMP–SMX (TM hoặc uống) ***hoặc*** amoxicillin (uống) ***hoặc*** cefixim (uống) ×10–14 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm đại tràng liên quan với kháng sinh	*Clostridium difficile*	Metronidazol (uống) ×7–10 ngày ***hoặc*** nitazoxanid (uống) × 3 ngày.	Vancomycin (uống) ×7–10 ngày.
Ỉa chảy phân nước mạn tính	*Giardia lamblia* ‡	Metronidazol (uống) ×5–7 ngày ***hoặc*** nitazoxanid (uống) ×3 ngày.	Tinidazol (uống) ×1 liều ***hoặc*** furazolidon (uống) ×7–10 ngày ***hoặc*** albendazol ×5–7 ngày
	Cryptosporidia ‡	Nitazoxanid (uống) ×3 ngày	Globulin miễn dịch người (uống) hoặc colostrum bò (uống) cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.
Hội chứng lỵ cấp	*E. histolytica*	Metronidazol (uống) ×10 ngày ***sau đó bằng hoặc là*** iodoquinol (uống) ×20 ngày ***hoặc*** paromomycin (uống) ×7 ngày.	Tinidazol (uống) ×3–5 ngày ***tiếp theo bằng hoặc bằng*** iodoquinol (uống) ×20 ngày ***hoặc*** paromomycin (uống) ×7 ngày.
	Shigella**	Ceftriaxon (TM) ***hoặc*** azithromycin (uống) ×5 ngày.	TMP–SMX (uống) ***hoặc*** cefixim (uống) ***hoặc*** ampicillin (uống) ×5 ngày.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

* *Chỉ chỉ định điều trị cho các trẻ < 3 đến 6 tháng tuổi, đối tượng bị suy giảm miễn dịch hoặc các trẻ có biểu hiện nhiễm độc tố vi khuẩn (toxic appearing child).*

** *Các trường hợp nhẹ không cần điều trị kháng sinh. Tuy nhiên, điều trị kháng sinh giúp làm rút ngắn thời gian có triệu chứng bệnh và làm giảm thời gian ỉa chảy.*

‡ *Cũng có thể được biểu hiện như một ỉa chảy phân nước cấp tính.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm dạ dày-ruột cấp mắc phải từ cộng đồng (Acute Gastroenteritis [Community-Acquired])

Biểu hiện lâm sàng: Được biểu hiện điển hình bằng tình trạng ỉa chảy khởi phát cấp kèm với sốt. Có hay không có sốt không phải là một chỉ dẫn chỉ định cần điều trị kháng sinh trừ khi tình trạng bệnh nặng (≥ 6 lần đi ngoài phân không thành khuôn/ngày, sốt ≥ 102°F, phân máu). Tiền sử du lịch liên quan với nguy cơ tiềm ẩn bị nhiễm khuẩn do *E.coli* và phơi nhiễm với ký sinh trùng rất quan trọng.

Xem xét chẩn đoán: Khi không có máu trong phân, virus là nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm dạ dày-ruột mắc phải từ cộng đồng. Các rotavirus là nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm dạ dày-ruột cấp tính ở các trẻ từ 4–24 tháng tuổi. Adenovirus ruột (enteric adenoviruses), tác nhân Norwalk (Norwalk-agent), enterovirus và astrovirus là các nguyên nhân thường gặp gây viêm dạ dày-ruột ở các trẻ lớn tuổi hơn. Các test tìm kháng nguyên hiện có bán trên thị trường sử dụng kỹ thuật ELISA hoặc kỹ thuật ngưng kết latex hoàn toàn có thể dùng để phát hiện rotavirus. Các test để phát hiện các tác nhân virus khác có thể không có sẵn để sử dụng. Các biến đổi viêm (có các tế bào bạch cầu và/hoặc máu) trong phân là các bằng chứng phù hợp hơn đối với nhiễm khuẩn do vi khuẩn. Khi chỉ định cấy phân cho bệnh nhân, có thể cần thiết chỉ định các điều kiện/môi trường nuôi cấy chuyên biệt để phát hiện Yersinia hoặc *E.coli* O157.

Lưu ý: Dùng thuốc chống nhu động ruột có thể làm diễn biến bệnh ở trẻ bị viêm đại tràng tồi đi. Điều trị theo kinh nghiệm bằng kháng sinh có thể làm kéo dài tình trạng mang Salmonella hoặc làm tăng nguy cơ xuất hiện hội chứng tan máu tăng urê huyết (hemolytic uremic syndrome [HUS]) khi nhiễm khuẩn do *E.coli* O157. Lợi ích của kháng sinh trong điều trị ỉa chảy do Yersinia gây nên cũng không được chứng minh. Vì vậy, không có chỉ định điều trị kháng sinh thường quy trước khi có kết quả nuôi cấy trong hầu hết các trường hợp ỉa chảy, nhất là do hầu hết các nhiễm khuẩn này thường tự khỏi.

Xem xét điều trị: Như trình bày ở trên, trong khi chờ kết quả nuôi cấy và khi không có các triệu chứng nặng hoặc biểu hiện hội chứng lỵ, có lẽ kháng sinh không có chỉ định. Về tổng thể, các fluoroquinolon có phổ tác dụng hầu như bao phủ hoàn toàn đối với hầu hết các mầm bệnh gây ỉa chảy nhiễm khuẩn, song hiện tại còn chưa được phê chuẩn để sử dụng cho các trẻ < 18 tuổi.

Tiên lượng: Tốt. Có tới 5–10% các trẻ bị nhiễm khuẩn do *E.coli* phân typ O157 có nguy cơ bị hội chứng tan máu tăng urê huyết.

Bệnh do *Giardia lamblia* (Giardiasis)

Biểu hiện lâm sàng: *Giardia lamblia* là ký sinh trùng thường gặp nhất gây bệnh ỉa chảy ở trẻ em. Bệnh do nhiễm giardia có thể được biểu hiện bằng tình trạng ỉa chảy phân nước cấp với đau bụng và trướng bụng hoặc như một tình trạng bệnh mạn tính, xảy ra từng lúc, với phân có mùi hôi, trướng bụng và chán ăn.

Xem xét chẩn đoán: Thể tư dưỡng (trophozoites) hoặc nang trùng (cysts) của *Giardia lamblia* có thể được phát hiện khi khám trực tiếp phân bị nhiễm ký sinh

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trùng với độ nhạy 75%–95% trên một bệnh phẩm đơn lẻ. Xét nghiệm ≥ 3 mẫu phân sẽ làm tăng thêm độ nhạy của test phát hiện giardia. Nếu nghi vấn nhiễm khuẩn do giardia song xét nghiệm phân âm tính, xét nghiệm dịch tá tràng để tìm giardia (Entero- hay string test) có thể hữu ích.

Lưu ý: Nhiễm khuẩn không có triệu chứng thường được gặp ở trẻ em tại các nhà trông trẻ, vì vậy, các chỉ định điều trị phải xem xét cả kết quả xét nghiệm phân và dấu hiệu lâm sàng.

Xem xét điều trị: Thất bại điều trị thường xuyên xảy ra và điều trị lại bằng cùng thuốc điều trị ban đầu được khuyến cáo. Furazolidon chế phẩm duy nhất được bào chế dưới dạng dung dịch dùng trong nhi khoa hiện có trên thị trường để điều trị tình trạng nhiễm giardia ở trẻ < 3 tuổi.

Tiên lượng: Tốt.

Bệnh nhiễm ký sinh trùng Cryptosporidia (Cryptosporidiosis)

Biểu hiện lâm sàng: Thường được biểu hiện bằng sốt, nôn và ỉa chảy phân nước song không có máu. Nhiễm khuẩn cũng có thể không có triệu chứng. Các nhiễm khuẩn nặng và mạn tính hơn được gặp ở các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: nhiễm HIV). Ký sinh trùng Cryptosporidia đề kháng với chlorit (thuốc sát khuẩn Javen) và có thể được lây truyền trong các bể bơi. Lây truyền bệnh cũng có thể xảy ra từ các vật nuôi và gây bùng phát dịch quan trọng thông qua nhiễm bẩn nguồn nước cấp công cộng cũng đã được báo cáo.

Xem xét chẩn đoán: Các nang cryptosporidia được phát hiện bằng cách soi vi thể bệnh phẩm phân được nhuộm Kinyoun bằng cách sử dụng phương pháp tách đãi bằng sucrose (a sucrose floatation method) hoặc phương pháp dùng formalin-ethyl acetat để tập trung các nang noãn (oocysts) của ký sinh trùng. Test này không phải là một phần của xét nghiệm thường quy tìm trứng và ký sinh trùng trong phân và phải được yêu cầu riêng. Ký sinh trùng và trứng được thải qua phân không liên tục; vì vậy cần tiến hành xét nghiệm 3 mẫu phân để có được khả năng phát hiện ký sinh trùng tối ưu.

Lưu ý: Các nang noãn (oocysts) của cryptosporidia nhỏ và có thể bị các kỹ thuật viên không có kinh nghiệm bỏ qua. Một bộ test ELISA hiện đang có bán trên thị trường có thể được áp dụng, song test có thể cho kết quả dương tính giả và âm tính giả.

Xem xét điều trị: Thất bại với điều trị thường gặp. Ở các đối tượng bị suy giảm

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

miễn dịch dùng globulin miễn dịch người và colostrum bò đường uống mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Cải thiện số lượng CD_4 bằng điều trị với thuốc chống retrovirus ở bệnh nhân nhiễm HIV giúp rút ngắn diễn biến lâm sàng của bệnh.

Tiên lượng: Tốt, tình trạng phục hồi có thể cần tới nhiều tháng.

Bệnh nhiễm ký sinh trùng amip (*Entamoeba histolytica*)

Biểu hiện lâm sàng: *E. histolytica* có thể dẫn tới một phổ rộng các bệnh lý lâm sàng đi từ nhiễm khuẩn không có triệu chứng đến hội chứng lỵ cấp và tới viêm đại tràng bùng phát (fulminant colitis). Tình trạng bệnh lan tràn, được biểu hiện chủ yếu bằng áp xe gan cũng có thể xảy ra. *E. histolytica* là một tác nhân gây bệnh rất thường gặp ở các nước đang phát triển và được truyền bệnh theo con đường phân-miệng.

Xem xét chẩn đoán: Có thể phát hiện được thể tư dưỡng (trophozoites) hoặc các nang trùng (cysts) của *E. histolytica* trong các mẫu bệnh phẩm phân. Trong các thể bệnh nặng hơn (Ví dụ: viêm đại tràng do amip, ápxe gan do amip), có thể phát hiện được kháng thể trong huyết thanh.

Lưu ý: Điều trị bằng steroids hoặc thuốc cầm ỉa có thể làm các triệu chứng tồi đi và không nên sử dụng.

Xem xét điều trị: Điều trị thành hai giai đoạn để loại bỏ các thể tự dưỡng xâm lấn mô (tissue-invading trophozoites) và các vi sinh vật trong lòng ruột. Dẫn lưu bằng phẫu thuật các ổ áp xe gan lớn có thể mang lại lợi ích.

Tiên lượng: Tốt.

Viêm đại tràng do *Clostridium difficile*

Biểu hiện lâm sàng: Xảy ra một cách kinh điển ở trẻ đang được điều trị kháng sinh và được biểu hiện bằng ỉa chảy, đau quặn bụng, phân máu/nhày, đau bụng khi khám, sốt và nhiễm độc. Bệnh cũng có thể được biểu hiện sau khi đã ngừng liệu trình kháng sinh nhiều tuần.

Xem xét chẩn đoán: Độc tố *C.difficile* có thể đươc phát hiện bằng các test miễn dịch hiện có bán trên thị trường. Dấu hiệu nội soi viêm đại tràng giả màng nhày là một bằng chứng chẩn đoán xác định mặc dù hiếm khi được chỉ định.

Lưu ý: *C.difficile* có thể là một thành phần trong vi khuẩn chí bình thường ở các

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

trẻ < 1 tuổi và có lẽ không gây tình trạng bệnh ở nhóm tuổi này. Phát hiện được độc tố C.difficile toxin ở trẻ không luôn đồng nghĩa với nguyên nhân gây la chảy và cần áp dụng thêm các đánh giá khác. Thuốc chống nhu động ruột có thể là triệu chứng tồi đi và nên tránh sử dụng cho trẻ.

Xem xét điều trị: Ngừng sử dụng kháng sinh được khuyến cáo nếu có thể khi có tình trạng viêm đại tràng có ý nghĩa do *C. difficile*. Các bệnh nhân có triệu chứng nặng hoặc la chảy tiếp diễn ×2–3 ngày sau khi ngừng dùng kháng sinh khi đó nên được điều trị bằng metronidazol hoặc vancomycin đường uống. Có tới ~ 25% tái phát sau khi sử dụng một liệu trình kháng sinh duy nhất cho bệnh nhân. Điều trị lại bằng cách sử dụng cùng kháng sinh đã sử dụng lúc khởi đầu được khuyến cáo. Đối với tình trạng nhiễm khuẩn tiếp diễn dai dẳng, các điều trị thay thế như nitazoxanid, rifaximin, tinidazol, điều trị globulin miễn dịch đường uống, chất gắn độc tố vi khuẩn hoặc phục hồi lại vi khuẩn chí bình thường trong lòng ruột có thể được xem xét áp dụng.

Tiên lượng: Tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN XƯƠNG VÀ KHỚP

Viêm khớp nhiễm khuẩn (Septic Arthritis)

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†*	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †*	Chuyển từ đường TM sang đường uống†*
Trẻ sơ sinh (≤ 3 tháng)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*)‡ Liên cầu nhóm B Họ vi khuẩn đường ruột (Entero-bacteriaceae) Lậu cầu (*N. gonorrhea*)	***Điều trị kết hợp với*** nafcillin ***hoặc*** vancomycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim*	***Điều trị kết hợp với*** vancomycin ***hoặc*** clindamycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** gentamicin ***hoặc*** tobramycin*	Không áp dụng.

Trẻ nhỏ (> 3 tháng đến 14 tuổi)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*)‡ Liên cầu nhóm A Phế cầu (*S. pneumoniae*) Trực khuẩn Gram âm Não mô cầu (*N. meningitidis*) (*H. influenza* typ b ở kỷ nguyên trước khi có tiêm phòng vaccin) Kingella	***Điều trị kết hợp với*** nafcillin ***hoặc*** vancomycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim*	***Điều trị kết hợp với*** vancomycin ***hoặc*** clindamycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim*	Dicloxacillin ***hoặc*** cephalexin ***hoặc*** clindamycin (uống) sau 1 tuần điều trị theo đường tĩnh mạch*
Trẻ vị thành niên (có hoạt động tình dục)	Như ở trên cộng với lậu cầu khuẩn (*N. gonorrhoeae*) (điển hình ra 2 hoặc 3 khớp bị tác động)	***Điều trị kết hợp với*** nafcillin ***hoặc*** vancomycin ***cộng với hoặc*** ceftriaxon ***hoặc*** cefotaxim*	**Nếu phân lập được lậu cầu khuẩn và bệnh nhân dị ứng với penicillin:** Ciprofloxacin ***hoặc*** ofloxacin ***hoặc*** spectinomycin.	Viêm khớp do lậu cầu và có đáp ứng tức khắc với điều trị bằng đường TM có thể được chuyển sang ciprofloxacin ***hoặc*** ofloxacin ***hoặc*** cefixim để hoàn chỉnh tổng liệu trình kéo dài 7 ngày.

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM hoặc đường TM + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

Giảm liều điều trị thuốc tùy theo cá thể một khi phân lập được vi khuẩn và có được kết quả test đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng sinh.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

* *Tổng thời gian điều trị đối với viêm khớp nhiễm khuẩn huyết không do lậu cầu (non-gonococcal septic arthritis) ≥ 3 tuần dựa trên đáp ứng lâm sàng.*

‡ *Nếu nghi vấn nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) dựa trên biểu hiện lâm sàng/dịch tễ tại cơ sở, xem xét điều trị bao phủ theo kinh nghiệm đối với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) bằng clindamycin, TMP–SMX, doxycyclin hoặc vancomycin trong khi chờ kết quả nuôi cấy.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Biểu hiện lâm sàng: Thay đổi theo tuổi của trẻ. Biểu hiện thường không đặc hiệu ở nhũ nhi (ví dụ: sốt, trẻ bỏ bú, nhịp tim nhanh). Các dấu hiệu khi khám thực thể có thể kín đáo: mất đối xứng các nếp nhăn của mô, sưng một bên của một chi, các biến đổi kín đáo ở chi/tư thế khớp. Ở các trẻ lớn tuổi hơn, các dấu hiệu và triệu chứng khu trú hơn đối với khớp bị tác động. Các khớp thường bị tổn thương là: háng, khuỷu tay, khớp gối.

Xem xét chẩn đoán: Hút dịch khớp (bằng kim có khẩu kính lớn) cho thấy có 50.000–250.000 tế bào bạch cầu/mm^3 với bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế rõ rệt. Nhuộm Gram/ nuôi cấy dịch khớp giúp khẳng định chẩn đoán. Viêm màng hoạt dịch khớp do độc tố của vi khuẩn (toxic synovitis), viêm khớp trong bệnh Lyme, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp chấn thương (traumatic arthritis) và tràn dịch khớp cận ổ viêm (sympathetic effusion) từ một viêm xương-tủy xương kế cận khớp có thể có biểu hiện lâm sàng giống với viêm khớp nhiễm khuẩn, song trong các trường hợp nói trên dịch khớp có số lượng bạch cầu đa nhân trung tính ít hơn và nuôi cấy dịch âm tính. Tác động tới nhiều khớp là điểm điển hình thường gặp hơn trong bệnh thấp tim/bệnh Lyme. Ở các trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi, còn tồn tại động mạch nuôi tủy xương (the nutrient artery) có thể dẫn tới viêm xương- tủy xương (osteomyelitis) và viêm khớp nhiễm khuẩn.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Lưu ý: Viêm khớp nhiễm khuẩn đối với khớp háng là một tình trạng cấp cứu đồng diễn đòi hỏi phải tiến hành chọc hút dịch khớp và rửa khớp ngay để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ hoại tử đầu xương đùi, do tình trạng này có thể xảy ra trong vòng 24 giờ. Viêm màng hoạt dịch do độc tố của vi khuẩn (toxic synovitis) đối với khớp háng được điều trị bằng thuốc chống viêm và theo dõi. Tình trạng này thường gây sốt, đau và tăng bạch cầu ít hơn so với viêm khớp nhiễm khuẩn, tuy nhiên đôi khi không thể phân biệt được hai tình trạng nói trên và cần chỉ định chọc hút dịch khớp. Ở các thiếu niên có hoạt động tình dục, cần xem xét khả năng viêm khớp do lậu cầu và chỉ định chọc hút dịch khớp để nuôi cấy vi khuẩn.

Xem xét điều trị: Điều trị đường tĩnh mạch được khuyến cáo trong ít nhất 3-4 tuần, tiếp theo bằng điều trị đường uống để hoàn thành liệu trình kháng sinh kéo dài 4–6 tuần dựa trên đáp ứng lâm sàng và các thông số cận lâm sàng (bạch cầu, tốc độ lắng hồng cầu, nồng độ protein- C phản ứng). Điều trị nội khớp không giúp ích gì. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm bao phủ phải rộng hơn so với điều trị viêm xương-tủy xương ở trẻ em.

Tiên lượng: Tốt khi tiến hành hút ngay dịch khớp và điều trị kháng sinh trong tối thiểu 3 tuần.

Viêm xương-tủy xương cấp, viêm xương-sụn, viêm đĩa đệm đốt sống

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †	Chuyển từ đường TM sang đường uống hoặc điều trị đường uống†
Viêm xương-tủy cấp tính (Acute osteomyelitis) *Trẻ sơ sinh* *(0–3 tháng)*	Tụ cầu vàng (*S. aureus*)[5] Trực khuẩn Gram âm Liên cầu nhóm B	***Điều trị kết hợp bằng*** nafcillin ***hoặc*** oxacillin ***cộng với hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon x 4-6 tuần.	Vancomycin ***cộng với hoặc*** cefotaxim ***hoặc*** ceftriaxon x4–6 tuần.	Không thể áp dụng.
*> 3 tháng**	Tụ cầu vàng (*S. aureus*)[5] Liên cầu nhóm A Vi khuẩn Gram âm (hiếm gặp) Salmonella (bệnh hồng cầu hình liềm)	Nafcillin ***hoặc*** oxacillin ***hoặc*** cefazolin x4–6 tuần.	Clindamycin ***hoặc*** ampicillin-sulbactam ***hoặc*** vancomycin x 4–6 tuần.	Cephalexin ***hoặc*** clindamycin ***hoặc*** cefadroxil x4–6 tuần.
Viêm xương-sụn (Osteochondritis)	*P. aeruginosa* Tụ cầu vàng (*S. aureus*)[5]	Ticarcillin-clavulanat x7–10 ngày sau phẫu thuật ***hoặc điều trị kết hợp bằng*** nafcillin cộng với ceftazidim x7–10 ngày sau phẫu thuật.	Piperacillin ***hoặc*** ciprofloxacin x 7–10 ngày sau phẫu thuật.	Ciprofloxacin** x7-10 ngày sau phẫu thuật.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm đĩa đệm cột sống (Diskitis)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*), *K. kingae* Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) Phế cầu (*S. pneumoniae*) *S. epidermidis*	**Điều trị đường uống**: Cephalexin ***hoặc*** cefadroxil ***hoặc*** clindamycin × 3–4 tuần hoặc khi kết quả tốc độ lắng hồng cầu trở về mức bình thường††

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường uống hoặc đường tĩnh mạch + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

* *Chỉ điều trị theo đường tĩnh mạch hoặc chuyển từ đường tĩnh mạch sang đường uống.*

** *Không được phê chuẩn cho trẻ em song có thể xem xét sử dụng cho trẻ vị thành niên.*

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

†† *Phối hợp thêm kháng sinh bao phủ vi khuẩn Gram âm chỉ khi kết quả nuôi cấy xác nhận vi khuẩn gây bệnh.*

§ *Nếu nghi vấn nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) dựa trên biểu hiện lâm sàng/dịch tễ tại cơ sở, xem xét dùng kháng sinh kinh nghiệm bao phủ đối với tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA) là clindamycin, TMP–SMX, doxycyclin hoặc vancomycin trong khi chờ kết quả nuôi cấy.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xương-tủy xương cấp (Acute Osteomyelitis)

Biểu hiện lâm sàng: Khởi phát cấp tính với sốt và đau/giảm vận động quanh vùng bị nhiễm khuẩn. Có thể khó định khu tổn thương, nhất là ở các trẻ nhỏ tuổi. Xảy ra chủ yếu qua lan truyền theo đường máu (trái ngược với cấy truyền trực tiếp vi khuẩn) tới sụn tiếp hợp (metaphysis) của xương dài.

Xem xét chẩn đoán: Các chất phản ứng pha cấp tăng cao (tốc độ lắng hồng cầu, protein-C phản ứng, số lượng tế bào bạch cầu). Hình ảnh chụp Xquang có thể không cho thấy tổn thương tiêu xương trong vòng 7 ngày bị bệnh, song sưng mô mềm và phản ứng màng xương (periosteal reaction) có thể được thấy sớm ngay vào ngày thứ 3. Chụp xạ hình/ cộng hưởng từ xương cho thấy có các thay đổi ngay trong vòng 24 giờ đầu, song chụp xạ hình xương không nhạy đối với trẻ sơ sinh. Cấy máu có thể dương tính, nhất là ở các trẻ nhỏ tuổi. Chẩn đoán khẳng định bằng chọc hút xương lấy bệnh phẩm nhuộm Gram và nuôi cấy,

song điều trị theo kinh nghiệm thường được bắt đầu dựa trên khai thác tiền sử lâm sàng và có tổn thương tiêu xương cấp trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ, xạ hình hoặc Xquang xương.

Lưu ý: Các thay đổi xương trên phim chụp Xquang có thể không được biểu hiện lúc khởi đầu. Có thể khó phân biệt giữa viêm mô tế bào với viêm xương-tủy xương, ngay cả bằng chụp xạ hình xương.

Xem xét điều trị: Điều trị theo kinh nghiệm khởi đầu theo đường tĩnh mạch. Cần điều trị ≥ 4 tuần, song các trẻ có gia đình tuân thủ điều trị có thể hoàn thành được liệu trình điều trị với kháng sinh dùng đường uống liều cao. Khi điều trị thỏa đáng, nồng độ protein C phản ứng trở lại mức bình thường trong vòng 2 tuần và tốc độ lắng hồng cầu trở lại mức bình thường trong vòng 4 tuần.

Tiên lượng: Tốt với tổng thời gian điều trị kéo dài 4–6 tuần. Phát triển lâu dài của xương bị tác động có thể bị suy giảm.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm xương – sụn của bàn chân (Osteochondritis of the Foot) hay " viêm xương-tủy xương do vết thương đâm thủng" ("Puncture Wound Osteomyelitis")

Biểu hiện lâm sàng: Sưng và đau khi khám, viêm đỏ ngoài da, từ vài ngày tới vài tuần sau khi bị thương do đinh đâm xuyên qua giày đánh tennis hoặc giầy vải (*Pseudomonas* được tìm thấy trong lớp xốp giữa đế và lớp lót của giày). Hiếm gặp sốt và các than phiền toàn thân khác. Xuất hiện ở 1–2% các vết thương đâm thủng ở bàn chân.

Xem xét chẩn đoán: *P. aeruginosa* là tác nhân gây bệnh chính yếu, mặc dù nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng (*S. aureus*) cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Lưu ý: Kháng sinh và ngoại khoa đối với sụn bị hoại tử.

Xem xét điều trị: Khi được cắt lọc ngay mô bị hoại tử, điều trị kháng sinh trong vòng 7–10 ngày thường là đủ.

Tiên lượng: Tốt khi được tiến hành cắt lọc mô bị hoại tử và điều trị kháng sinh.

Viêm đĩa đệm đốt sống (Diskitis)

Biểu hiện lâm sàng: Tác động điển hình tới vùng cột sống thắt lưng và xảy ra ở trẻ < 6 tuổi. Được biểu hiện bằng một khởi phát từ từ (trong vòng nhiều tuần) với tình trạng trẻ dễ bị kích thích và trẻ tránh đi lại. Sốt ở mức độ nhẹ hoặc không sốt. Các trẻ lớn tuổi hơn có thể định khu được tình trạng đau ở lưng, khớp háng hoặc bụng. Đau bị tăng nặng thêm khi trẻ cử động cột sống và có thể được định khu bằng thao tác gõ lên thân đốt sống khi khám.

Xem xét chẩn đoán: Tốc độ lắng hồng cầu tăng lên, song số lượng bạch cầu vẫn bình thường. Hình ảnh Xquang lúc khởi đầu thường bình thường, song ở giai đoạn muộn hơn sẽ bộc lộ tình trạng hẹp khoang đĩa đệm cột sống và xơ hóa đốt sống. Khoang đĩa đệm tăng bắt giữ chất đánh dấu có thể được thấy trên hình ảnh chụp xạ hình xương. Chụp cộng hưởng từ rất nhạy để đánh giá tình trạng tác động tới khoang đĩa đệm cột sống.

Xem xét điều trị: Viêm đĩa đệm đốt sống có thể là một nhiễm khuẩn do vi khuẩn ở cấp độ thấp, song vai trò của điều trị kháng sinh không rõ ràng. Cho bệnh nhân nghỉ tại giường và dùng thuốc chống viêm vẫn là nền tảng của điều trị. Có thể cần chỉ định cho trẻ bất động đối với các trường hợp nặng. Kháng sinh đường uống được cho trong vòng 3–4 tuần hoặc tới khi tốc độ lắng hồng cầu trở về giá trị bình thường.

Lưu ý: Khó phân lập được vi khuẩn gây bệnh, ngay cả với chọc hút bằng kim vào khoang đĩa đệm. Tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất, song viêm đĩa đệm đốt sống cũng có thể do tụ cầu coagulase âm tính, *K. kingae*, *coliforms*, phế cầu gây nên.

Tiên lượng: Các đốt sống bị tổn thương có thể dính lại với nhau khi tình trạng nhiễm khuẩn thuyên giảm. Song, tiên lượng nói chung là tốt.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

Các nhiễm khuẩn da và mô mềm

Phân loại	Tác nhân gây bệnh thường gặp	Điều trị đường tĩnh mạch được ưu tiên lựa chọn†	Điều trị đường tĩnh mạch thay thế †	Điều trị đường Uống hoặc Chuyển từ đường TM sang đường uống†
Viêm mô tế bào, bệnh chốc lở (impetigo)	Tụ cầu vàng (*S. aureus*) Liên cầu nhóm A	Cefazolin ***hoặc*** nafcillin ***hoặc*** oxacillinx7–10 ngày.	Clindamycin† x7–10 ngày.	Cephalexin ***hoặc*** cefadroxil ***hoặc*** dicloxacillin ***hoặc*** clindamycin ***hoặc*** amoxicillin-acid clavulanic ***hoặc*** erythromycin ***hoặc*** azithromycin x7–10 ngày.
Ápxe, viêm mủ da (pyoderma) nặng	Tụ cầu vàng kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (CA-MRSA)	Vancomycin ***cộng với*** Clindamycin x 7–14 ngày.	Vancomycin ***hoặc*** linezolid x 7–14 ngày.	TMP–SMX ***hoặc*** doxycyclin x7–14 ngày.**
Các vết thương do con vật cắn (chó/ mèo)	Liên cầu nhóm A *P. multocida* Capnocytophaga Tụ cầu vàng *(S.aureus)*	Ampicillin-sulbactam x 7–10 ngày.	Piperacillin ***hoặc*** ticarcillinx7–10 ngày. **Bệnh nhân dị ứng penicillin:** Clindamycin ***cộng với*** TMP–SMX x7–10 ngày (chó cắn); doxycyclin ***hoặc*** cefuroxim x 7–10 ngày (mèo cắn).	Amoxicillin-acid clavulanic ***hoặc*** doxycyclin x7–10 ngày.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các vết thương do người cắn	Vi khuẩn kỵ khí ở khoang miệng *E. corrodens* Liên cầu nhóm A Tụ cầu vàng *(S.aureus)*	Ampicillin-sulbactam ×5–7 ngày.	Piperacillin ***hoặc*** ticarcillin ×5–7 ngày. **Bệnh nhân dị ứng penicillin:** Clindamycin ***cộng với*** TMP–SMX ×5–7 ngày.	Amoxicillin-acid clavulanic ***hoặc*** doxycyclin ×5–7 ngày.
Bệnh mèo cào (Cat scratch disease)*	*Bartonella henselae*	Gentamicin ×10–14 ngày.	—	Azithromycin × 5 ngày ***hoặc*** TMP–SMX ***hoặc*** ciprofloxacin ***hoặc*** rifampin ×10–14 ngày.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

** *Ở trẻ > 8 tuổi.*

* *Không có các thử nghiệm có nhóm chứng tốt về điều trị kháng sinh đối với bệnh mèo cào để chứng minh lợi ích của điều trị.*

‡ *Điều trị được ưu tiên chọn dùng cho các bệnh nhân ở các vùng địa lý có tỷ lệ mắc tụ cầu vàng kháng methicillin cao hoặc cho các đối tượng bị dị ứng penicillin/cephalosporin.*

Các nhiễm khuẩn da và mô mềm (tiếp)

Loại nhiễm khuẩn	Tác nhân gây bệnh	Điều trị đường tĩnh mạch†	Điều trị đường uống hoặc chuyển từ đường TM sang đường uống†
Bệnh thủy đậu *Đối tượng bị suy giảm miễn dịch*	Virus thủy đậu (VZV)	Acyclovir ×7–10 ngày.	Acyclovir ***hoặc*** valacyclovir ×7–10 ngày.
Đối tượng không bị suy giảm miễn dịch	Virus thủy đậu (VZV)	Acyclovir ×5 ngày.	Acyclovir ***hoặc*** valacyclovir ×5 ngày.
H. zoster (bệnh zona)	Virus thủy đậu (VZV)	Giống như đối với bệnh thủy đậu.	Acyclovir ***hoặc*** valacyclovir ×10 ngày (cho các đối tượng ≥ 12 tuổi).

Thời gian điều trị phản ánh tổng thời gian điều trị theo đường TM, đường Uống hoặc đường Tĩnh mạch + đường uống. Hầu hết các bệnh nhân khi đang điều trị theo đường TM có thể uống được thuốc nên được chuyển sang điều trị theo đường uống ngay sau khi có cải thiện lâm sàng.

† ***Xem trang 674-684*** *để biết liều thuốc dùng.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm mô tế bào (Cellulitis)

Biểu hiện lâm sàng: Viêm đỏ da, da ấm và đau khi khám. Chốc lở được đặc trưng bằng ban dạng mụn nước- sẩn (vesiculopapular rash) với xuất tiết có màu như mật ong.

Xem xét chẩn đoán: Chủ yếu là chẩn đoán lâm sàng. Liên cầu nhóm A và tụ cầu là tác nhân gây bệnh chính ở các trẻ khỏe mạnh. Nên cấy chất xuất tiết từ vết thương hoặc bờ gồ lên của tổn thương và nhuộm Gram có thể hữu ích.

Lưu ý: Chẩn đoán phân biệt của viêm mô tế bào có thể bao gồm tình trạng tăng quá mẫn với vết chích của côn trùng. Chín mé do virus Herpes (Herpetic whitlow) có thể bị nhầm với nhiễm khuẩn da do vi khuẩn hoặc viêm quanh móng do nhiễm khuẩn (paronychial infection).

Xem xét điều trị: Các cephalosporin thế hệ thứ nhất hoặc penicillin bán tổng hợp có hoạt tính chống tụ cầu (tức là dicloxacillin, nafcillin, oxacillin) là các thuốc được chọn. Gia tăng tỷ lệ bị tụ cầu kháng methicillin mắc phải từ cộng đồng (community-acquired MRSA) có thể có tác động tới quyết định điều trị.

Tiên lượng: Cực kỳ tốt. Chốc lở có thể chỉ cần điều trị tại chỗ/ bôi mỡ mupirocin.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Vết thương do bị cắn (Bite Wounds)

Biểu hiện lâm sàng: 80% các vết thương do động vật cắn ở trẻ em là do chó cắn và 15-50% các vết chó cắn sẽ trở nên nhiễm khuẩn. Trên 50% các vết mèo cắn trở nên bị nhiễm khuẩn và do răng mèo dài, có một gia tăng nguy cơ cấy truyền vi khuẩn vào xương/ khớp với xuất hiện viêm xương-tủy xương/viêm khớp nhiễm khuẩn. Vết thương do người cắn rất dễ có khuynh hướng bị nhiễm khuẩn và 75%–90% các vết thương do người cắn trở nên nhiễm khuẩn.

Xem xét chẩn đoán: Chẩn đoán lâm sàng. Nuôi cấy dịch tiết vết thương có thể cho biết vi sinh vật gây bệnh.

Lưu ý: Khó đánh giá độ sâu của nhiễm khuẩn, đặc biệt là với vết thương do mèo cắn, có thể gây chậm trễ trong phát hiện nhiễm khuẩn xương/khớp. Macrolid không có hiệu quả đối với *P. multocida*.

Xem xét điều trị: Điều quan trọng là phải điều trị bao phủ đối với vi khuẩn kỵ khí ở miệng, tụ cầu vàng và liên cầu nhóm A trong vết thương do người cắn. P. multocida là một tác nhân gây bệnh quan trọng đối với vết thương

do mèo và chó cắn. Các tổn thương ở mặt và tay đòi hỏi phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể cần phải tiến hành cắt lọc tổ chức hoại tử tái phát, nhất là với các nhiễm khuẩn vết thương bàn tay do người cắn. Đánh giá tình trạng tiêm phòng uốn ván đối với tất cả vết thương do bị cắn (trang 377). Đối với vết thương do người cắn cần xem xét nguy cơ nhiễm HIV và viêm gan B. Đối với vết chó cắn cần xem xét nguy cơ bị dại. Điều trị kháng sinh được bắt đầu trong vòng 8 giờ sau khi bị cắn và dùng trong vòng 2–3 ngày có thể làm giảm tỷ lệ bị nhiễm khuẩn.

Tiên lượng: Tốt khi được tiến hành cắt lọc tổ chức hoại tử và dùng kháng sinh sớm.

Bệnh do mèo cào (Cat Scratch Disease)

Biểu hiện lâm sàng: Biểu hiện kinh điển là một tổn thương sẩn (papular lesion) tại vị trí vết cào của mèo với viêm bạch mạch ở vùng dẫn lưu (nách, khuỷu tay, bẹn, cổ rất thường gặp). Thường kết hợp với sốt/tình trạng khó ở 1–2 tuần sau khi bị mèo cào. Nhiễm khuẩn có thể được biểu hiện bằng viêm kết mạc và nổi hạch vùng trước tai cùng bên (hội chứng mắt- hạch của Parinaud [Parinaud oculoglandular syndrome]). Các biểu hiện không thường gặp ở vật chủ bình thường bao gồm viêm não, viêm gan, vi áp xe ở gan/lách, sốt không rõ căn nguyên, các tổn thương tiêu xương.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Rất thường gặp thứ phát do bị mèo cào truyền vi khuẩn *Bartonella henselae*. Được chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học đặc hiệu tìm kháng thể đối với *B. henselae*. Test da với kháng nguyên đối với bệnh mèo cào được bào chế từ mủ hút ra từ hạch bạch huyết của bệnh nhân bị bệnh mèo cào không được cấp phép sử dụng và không nên sử dụng để chẩn đoán bệnh.

Lưu ý: Bỏ qua việc thu thập tiền sử có tiếp xúc với mèo. Nói chung là không cần tiến hành phẫu thuật chích rạch hạch bạch huyết viêm.

Xem xét điều trị: Hầu hết các tổn thương sẽ tự khỏi và thoái triển trong vòng 2–4 tháng. Còn chưa có các nghiên cứu có nhóm chứng tốt, song điều trị kháng sinh có thể hữu ích đối với các trường hợp nặng với gan lách to. Doxycyclin, erythromycin hoặc azithromycin hữu ích ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

Tiên lượng: Rất tốt với tình trạng thuyên giảm tự nhiên trong vòng 2-4 tháng.

Bệnh thủy đậu/ bệnh zona (Chicken Pox/Shingles, VZV)

Biểu hiện lâm sàng: Bệnh lý tiên phát là thủy đậu (chicken pox), một tình trạng phát ban bọng nước, ngứa toàn thân với sốt và tổn thương bùng nổ như ngô rang trong vòng 3–5 ngày và được tiếp theo bằng tình trạng tổn thương đóng vảy và hồi phục. Các biến chứng bao gồm bội nhiễm vi khuẩn đối với các tổn thương da, nhiễm trùng máu, thất điều tiểu não (cerebellar ataxia), giảm tiểu cầu, viêm gan, viêm phổi và viêm não. Bệnh có xu hướng bị nặng hơn ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành, đặc biệt là ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch. Nhiễm khuẩn tiên phát sớm ở phụ nữ có thai một cách hãn hữu có thể gây tình trạng bệnh não của thai nhi do varicella (varicella embryopathy) với teo và bất thường hệ thần kinh trung ương ở trẻ sơ sinh. Bệnh tái hoạt động (Reactivation disease) (bệnh zona) có thể xảy ra ở trẻ em và các đối tượng bình thường và khu trú ở một vùng da được chi phối bởi các sợi thần kinh của một rễ sau tủy sống duy nhất (dermatome). Tình trạng đau thần kinh sau nhiễm Herpes (Post-herpetic neuralgia) ít xảy ra ở trẻ em hơn so với người lớn. Bệnh tái hoạt động (reactivation disease) ở các đối tượng bị suy giảm miễn dịch có thể lan tràn và gieo rắc lại virus.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Xem xét chẩn đoán: Tình trạng phát ban đặc trưng của thủy đậu xảy ra thành từng đợt, nhiều giai đoạn tổn thương xuất hiện vào cùng một thời gian, từ các sẩn và bọng nước mới tới các tổn thương thành vẩy và lớn hơn ở giai đoạn muộn hơn và chỉ duy nhất gặp trong thủy đậu. Nhuộm kháng thể huỳnh quang trực tiếp đối với tổn thương thành vẩy có thể giúp khẳng định chẩn đoán.

Lưu ý: Các tổn thương khởi đầu có thể là một tổn thương sẩn tiên phát và nếu chẩn đoán không được xem xét, phơi nhiễm cho các đối tượng khác có thể xảy ra.

Xem xét điều trị: Điều trị chống virus bằng acyclovir, được bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi phát ban nên được xem xét cho các trẻ > 12 tuổi, thuộc đối tượng đang được điều trị steroid hoặc salicylat và các đối tượng có bệnh lý da, bệnh lý phổi nền mạn tính hoặc có tình trạng ức chế miễn dịch. Dùng thuốc theo đường uống có thể được chấp nhận, mặc dù điều trị đường tĩnh mạch thường được ưu tiên chọn dùng cho đối tượng bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ bị bệnh lan tràn. Bệnh thủy đậu nặng nề hơn đã được thấy ở các đối tượng mắc phải nhiễm khuẩn do tiếp xúc trong cùng gia đình, được thừa nhận là do cấy truyền virus cao hơn do tiếp xúc gần gũi hơn với đối tượng mắc bệnh; có thể xem xét điều trị bằng acyclovir cho các người trong cùng gia đình tiếp xúc với bệnh nhi vào lúc tình trạng phát ban ở trẻ khởi phát. Ngoài ra, các cá thể ≥ 13 tuổi có thể xuất hiện tình trạng thủy đậu lan rộng hơn so với trẻ nhỏ tuổi hơn.

Các trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc phụ nữ có thai không có tiền sử bị thủy đậu hoặc chưa được tiêm chủng có thể có lợi ích nhờ tiêm phòng bằng globulin miễn dịch đối với virus thủy đậu (varicella zoster immune globulin [VZIG]) sau tiếp xúc với thủy đậu trong vòng 96 giờ. Trẻ sơ sinh từ các bà mẹ xuất hiện bệnh thủy đậu trong vòng 5 ngày trước hoặc 48 giờ sau khi sinh và các trẻ đẻ non bị phơi nhiễm cũng là các ứng viên để chỉ định dùng globulin miễn dịch đối với virus thủy đậu (VZIG). Một vaccin giống virus thủy đậu giảm độc tính đã được cấp phép sử dụng từ năm 1995 cho các đối tượng ≥ 12 tháng tuổi chưa bị thủy đậu. Chương trình tiêm hai liều vaccin được khuyến cáo cho các trẻ ≥ 12 tháng tuổi.

Tiên lượng: Tiên lượng toàn thể nói chung là tốt với tình trạng hồi phục hoàn toàn và nguy cơ bị sẹo hóa rất nhỏ trừ khi đối tượng bị suy giảm miễn dịch với tình trạng bệnh lan tràn. Mặc dù hiếm gặp, hội chứng sốc do độc tố của liên cầu nhóm A (Group A streptococcal toxic shock syndrome) (được biểu hiện như tình trạng viêm mô tế bào hoặc kết nối với viêm cân cơ hoại tử là biến chứng của tổn thương da do thủy đậu) và nhiễm khuẩn huyết do liên cầu nhóm A, có thể xảy ra khi không có tổn thương da bị nhiễm khuẩn thứ phát rõ rệt, có thể là biến chứng gây tử vong của thủy đậu ở các trẻ bình thường.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

CÁC THUỐC KHÁNG SINH THƯỜNG DÙNG TRONG NHI KHOA

Thuốc	Liều dùng cho trẻ sơ sinh	Liều dùng cho nhũ nhi/ trẻ nhỏ*
Acyclovir	20 mg/kg (TM) mỗi 8 h/lần ×14–21 ngày. Có thể cần tăng khoảng thời gian dùng liều đối với trẻ đẻ non có tuổi sau kỳ kinh cuối cùng (post-menstrual age) < 34 tuần (*Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng = Tuổi thai [GA] + Tuổi thực tế [CA]*) hoặc nếu có suy thận hoặc suy gan có ý nghĩa. **Ức chế lâu dài**: 75mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.	**Viêm não do virus Herpes simplex**: 10 mg/kg (TM) mỗi 8 h/lần ×12–21 ngày. **Nhiễm khuẩn tiên phát do virus Herpes simplex**: 10–20 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần ×5–10 ngày ***hoặc*** 5mg/kg/liều (TM) mỗi 8h/lần ×5 ngày. **Thủy đậu ở đối tượng bị suy giảm miễn dịch**: 10 mg/kg (TM) mỗi 8 h/lần ×7–10 ngày. **Thủy đậu ở đối tượng không bị suy giảm miễn dịch**: 20mg/kg (uống) mỗi 6 h/lần ×5 ngày (tối đa là 800mg/liều).
Albendazol	Không được áp dụng.	400mg (uống) mỗi 24 h/lần.
Amikacin**	**Trong tuần đầu sau sinh** liều dùng được dựa trên Tuổi thai (GA) (dùng liều TM trong vòng 30 phút) • ≤ 27 tuần (hoặc bị ngạt, còn ống động mạch hoặc indomethacin): 18mg/kg (TM) mỗi 48 h/lần. • 28–30 tuần: 18mg/kg (TM) mỗi 36h/lần. • 31–33 tuần: 16mg/kg (TM) mỗi 36h/lần. • ≥ 34 tuần: 15 mg/kg (TM) mỗi 24h/lần. **Sau tuần đầu của trẻ sơ sinh**: Liều khởi đầu là 15 mg/kg, sau đó lấy máu định lượng nồng độ thuốc trong huyết thanh 30 phút sau khi kết thúc truyền (nồng độ đỉnh) và 12–24 h/lần sau đó (nồng độ đáy) để xác định khoảng thời gian dùng liều. Nhằm đạt được đích nồng độ đỉnh 20–30 µg/mL và nồng độ đáy 2–5 µg/mL.	5–7,5 mg/kg (TM hoặc tiêm bắp) mỗi 8 h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

<table>
<tr><td>Amoxicillin</td><td colspan="3">Không được chỉ định.</td><td>22,5–45 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.</td></tr>
<tr><td>Amoxicillin/acid clavulanic</td><td colspan="3">Không được chỉ định.</td><td>22,5–45 mg/kg (đối với thành phần amoxicillin) (uống) mỗi 12h/lần.</td></tr>
<tr><td>Amphotericin B (theo quy ước)</td><td colspan="4">0,5–1 mg/kg (TM trong vòng 2–6 giờ) mỗi 24–48 h/lần (một số tác giả khuyến cáo dùng một liều test khởi đầu 0,1–0,5 mg/kg TM trong vòng 2–6 giờ).</td></tr>
<tr><td>Ampicillin</td><td colspan="3">25–50 mg/kg/liều (TM hoặc TB).
Sepsis nặng do liên cầu nhóm B: 100 mg/ kg/liều. Khoảng thời gian dùng liều được dựa trên tuổi thai (GA) và tuổi thực tế (CA).</td><td>25–50 mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6h/ lần.</td></tr>
<tr><td></td><td>GA + CA (tuần)</td><td>CA (ngày)</td><td>Khoảng thời gian dùng liều (giờ)</td><td rowspan="6">Ghi chú: "Tuổi thai- Gestational age" (GA) (hay "tuổi kinh- menstrual age"): là thời gian giữa ngày đầu tiên của kỳ kinh bình thường cuối cùng và ngày sinh.
"Tuổi thực tế- Chronological age" (CA) (hay "tuổi sau sinh- Postnatal age) là thời gian tính từ sau ngày sinh.
"Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng- Post-menstrual age" là thời gian tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối đến ngày sinh (tuổi thai) cộng thêm thời gian sau sinh (tuổi thực tế).</td></tr>
<tr><td></td><td>≤29</td><td>0–28
> 28</td><td>12
8</td></tr>
<tr><td></td><td>30–36</td><td>0–14
> 14</td><td>12
8</td></tr>
<tr><td></td><td>≥37</td><td>0–7
> 7</td><td>12
8</td></tr>
</table>

** Liều dùng nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể trẻ (mg/kg), đạt tới liều tối đa như ở người lớn.*

*** Thuốc có thể được cho theo đường tiêm bắp song hấp thu thuốc có thể thay đổi.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ampicillin/ sulbactam	Không được chỉ định.	25–50 mg/kg (đối với thành phần ampicillin) (TM) mỗi 6 h/lần.
Azithromycin	Không được chỉ định.	**Viêm tai giữa/viêm xoang**: 30mg/kg (uống) x1 liều ***hoặc*** 10 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x3 ngày ***hoặc*** 10 mg/kg (uống) vào ngày thứ nhất, tiếp sau đó với liều 5 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần vào ngày 2–5. **Viêm họng/viêm amydal**: 12mg/kg (uống) mỗi 24h/lần x5 ngày. **Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng** (không được chỉ định đối với các trường hợp bệnh vừa hoặc nặng): 10 mg/kg (uống) x 5 ngày ***hoặc*** 10 mg/kg (TM hoặc uống) vào ngày thứ nhất, tiếp sau đó với liều 5 mg/kg (TM hoặc uống) mỗi 24 h/lần vào các ngày 2-5. **Các nhiễm khuẩn da/ mô mềm** (bao gồm cả bệnh do mèo cào): 10 mg/kg (uống) vào ngày thứ nhất và tiếp sau đó với liều 5 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần vào ngày thứ 2-5.
Aztreonam	30 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp). ***Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều*** (trang 675).	30 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 6-8 h/lần.
Capofungin	Liều nạp là 70 mg/m², sau đó 50 mg/m² (TM) mỗi 24h/lần.	Liều nạp là 70 mg/m², sau đó 50 mg/m² (TM) mỗi 24 h/lần.
Cefadroxil	Không được chỉ định.	15 mg/kg (uống) mỗi 12 h/lần.
Cefazolin	25 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp). ***Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều*** (trang 675).	25–100 mg/kg/ngày (TM hoặc Tiêm bắp) chia nhỏ liều và dùng mỗi 8h/lần.
Cefdinir	Không được chỉ định.	7 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần hoặc 14mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần.
Cefepim	50 mg/kg (TM) mỗi 8-12h/lần.	33,3–50 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 8h/lần
Cefotaxim	50 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp). (25mg/kg/liều là thỏa đáng để điều trị nhiễm khuẩn do lậu cầu). ***Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều*** (trang 675).	25–50 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 6–8h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cefotetan	Không được chỉ định.	20–40 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 12h/lần.
Cefoxitin	25–33mg/kg/liều (TM hoặc TB). ***Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều*** (trang 675).	80–160 mg/kg/ngày (TM hoặc TB) chia nhỏ liều và dùng mỗi 4–8 h/lần.
Cefpodoxim	Không được chỉ định.	5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.
Cefprozil	Không được chỉ định.	15 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.
Ceftazidim	30mg/kg/liều (TM hoặc Tiêm bắp). ***Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều*** (trang 675).	25–50 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 8h/lần.
Ceftibuten	Không được chỉ định.	9 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần.
Ceftizoxim	Không được chỉ định.	50 mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6–8h/lần.
Ceftriaxon‡	**Sepsis và nhiễm khuẩn lậu cầu lan tỏa**: 50mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 24 h/lần. **Viêm màng não**: 100mg/kg liều nạp được tiếp sau đó bằng liều 80mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 24h/lần. **Viêm mắt (Ophthalmia) do lậu cầu không biến chứng**: 50mg/kg (liều tối đa 125mg) với một liều duy nhất (TM hoặc TB).	50 mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 24h/lần. **Viêm màng não**: 50mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 12h/lần hoặc 100mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 24h/lần. Viêm tai giữa cấp tính: 50 mg/kg (TB) ×1 liều (hoặc 3 liều tiêm bắp mỗi 24h/lần ở các bệnh nhân có nguy cơ cao).
Cefuroxim	Không được chỉ định.	10–15 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần. 25–50 mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 8h/lần.
Cephalexin	Không được chỉ định.	6,25–25 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần.
Cephalothin	Không được chỉ định.	25 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 4-6h/lần.
Cephalothin	Không được chỉ định.	25 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 4-6h/lần.
Clarithromycin	Không được chỉ định.	7,5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.

** Liều dùng nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể trẻ (mg/kg), đạt tới liều người lớn như liều tối đa.*

‡ Không dùng khi có tình trạng tăng bilirubin máu.

Clindamycin	5,0–7,5 mg (TM hoặc uống). Khoảng thời gian dùng liều được dựa trên Tuổi thai (GA) và Tuổi thực tế (CA) của trẻ:	5–10 mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 6-8h/lần hoặc 10–30 mg/kg/ngày (uống) chia nhỏ liều và dùng mỗi 6-8h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

	GA + CA (tuần)	CA (ngày)	Khoảng thời gian dùng liều (giờ)	*Ghi chú*: "Tuổi thai- Gestational age" (GA) (hay "Tuổi kinh- menstrual age"): là thời gian giữa ngày đầu tiên của kỳ kinh bình thường cuối cùng và ngày sinh. "Tuổi thực tế- Chronological age" (CA) (hay "Tuổi sau sinh- Postnatal age") là thời gian tính từ sau ngày sinh. "Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng- Post-menstrual age" là thời gian tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối đến ngày sinh (tuổi thai) cộng thêm thời gian sau sinh (tuổi thực tế).
	< 29	0–28	12	
		> 28	8	
	30–36	0–14	12	
		> 14	8	
	37–44	0–7	8	
		> 7	6	
Dicloxacillin	Không được chỉ định.			3,125–25 mg/kg (uống) mỗi 6h/lần.
Doxycyclin	Bị chống chỉ định.			> 45 kg: 100 mg (uống) mỗi 12h/lần. ≤ 45kg:1,1–2,5 mg/kg (uống) mỗi 12h/lần. Chỉ dùng cho trẻ > 8 tuổi (trừ để điều trị đối với bệnh sốt phát ban vùng núi đá [RMSF]) 1–2 mg/kg (TM) mỗi 12–24h/lần.

* *Liều dùng nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể trẻ (mg/kg), tới liều tối đa như liều người lớn.*

** *Thuốc có thể được cho theo đường tiêm bắp song hấp thu thuốc có thể thay đổi.*

‡ *Không dùng khi có tình trạng tăng nồng độ bilirubin máu.*

Thuốc	Liều dùng ở trẻ sơ sinh	Liều dùng ở nhũ nhi/ trẻ nhỏ*
Erythromycin	**Viêm phổi/viêm kết mạc do Chlamydia hoặc ho gà**: 12,5mg/kg (uống) mỗi 6h/lần (Erythromycin estolat được ưu tiên chọn dùng). **Các nhiễm khuẩn khác**: Erythromycin estolat 10mg/kg (uống) mỗi 8h/lần hoặc Erythromycin ethylsuccinat 10 mg/kg (uống) mỗi 6 h/lần. **Các nhiễm khuẩn nặng và bệnh nhân không thể uống được**: 5–10mg/kg (TM trong vòng ≥ 60 phút) mỗi 6h/lần.	10–12,5mg/kg (uống) mỗi 6–8 h/lần. 5–12,5mg/kg (TM) mỗi 6h/lần.
Ertapenem	Không được chỉ định.	15mg/kg (TM) mỗi 12h/lần (không vượt quá liều 1g/ngày).
Ethambutol	*Xem trang 586*	*Xem trang 586*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

<table>
<tr><td>Ethionamid</td><td colspan="3">Xem trang 586</td><td>Xem trang 586</td></tr>
<tr><td>Fluconazol</td><td colspan="3">Nhiễm khuẩn hệ thống hoặc viêm màng não: 12mg/kg (TM trong vòng 30 phút hoặc uống) x1 liều, sau đó 6mg/kg/liều (TM hoặc uống) với khoảng thời gian dùng liều được dựa trên tuổi thai (GA) và tuổi thực tế (CA) của trẻ (xem ở dưới).

Dự phòng (Vd: các trẻ có trọng lượng khi sinh cực kỳ thấp đang nằm tại phòng hồi sức tích cực sơ sinh có tỷ lệ bị nhiễm khuẩn do nấm cao): 3 mg/kg/liều (TM hoặc uống) theo cột hướng dẫn khoảng dùng liều (ở dưới).

Tưa lưỡi: 6mg/kg (uống) x1 liều, sau đó 3 mg/kg (uống) mỗi 24 h/lần.</td><td>Liều nạp là 10mg/kg (TM hoặc uống) tiếp theo bằng liều 3–6mg/kg (TM hoặc uống) mỗi 24h/lần.</td></tr>
<tr><td></td><td>GA +CA (tuần)</td><td>CA (ngày)</td><td>Khoảng thời gian dùng liều (tuần)</td><td rowspan="4"><u>Ghi chú</u>: "Tuổi thai- Gestational age" (GA) (hay "Tuổi kinh-menstrual age"): là thời gian giữa ngày đầu tiên của kỳ kinh bình thường cuối cùng và ngày sinh.

"Tuổi thực tế- Chronological age" (CA) (hay "tuổi sau sinh-Postnatal age) là thời gian tính từ sau ngày sinh.

"Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng-Post-menstrual age" là thời gian tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối đến ngày sinh (tuổi thai) cộng thêm thời gian sau sinh (tuổi thực tế).</td></tr>
<tr><td></td><td>≤29</td><td>0–14
>14</td><td>72
48</td></tr>
<tr><td></td><td>30–36</td><td>0–14
>14</td><td>48
24</td></tr>
<tr><td></td><td>37–44</td><td>0–7
>7</td><td>48
24</td></tr>
</table>

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Gentamicin**	***Trong tuần đầu sau sinh*** liều dùng dựa trên tuổi thai (GA) (dùng liều tĩnh mạch trong vòng 30 phút): • ≤ 29 tuần (hoặc ngạt, còn ống động mạch hoặc indomethacin): 5mg/kg (TM) mỗi 48h/lần. • 30–33 tuần: 4,5mg/kg (TM) mỗi 48h/lần. • 34–37 tuần: 4mg/kg (TM) mỗi 36h/lần. • ≥ 38 tuần: 4 mg/kg (TM) mỗi 24 h/lần. ***Sau sinh trên một tuần*** : Liều khởi đầu là 4 mg/kg, sau đó lấy máu để định lượng nồng độ thuốc trong huyết thanh 30 phút sau khi kết thúc truyền (nồng độ đỉnh) và 12–24 giờ sau đó (nồng độ đáy) để xác định khoảng thời gian dùng liều. Nhằm đạt được nồng độ đỉnh 5–12 µg/mL và nồng độ đáy 0,5–1 µg/mL.	2–2,5mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 8h/lần.
Imipenem	20–25mg/kg (TM) mỗi 12h/lần.	15–25mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6h/lần.
Iodoquinol	10–13,3 mg/kg (uống) mỗi 8 h/lần.	10–13,3mg/kg (uống) mỗi 8h/lần.
Isoniazid	*Xem trang 586*	*Xem trang 586*
Linezolid	10mg/kg (TM) mỗi 12 h/lần.	10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần.
Các dạng bào chế của Amphotericin-Liposomal/ phức hợp lipid	1–5mg/kg (TM trong vòng 2 h/lần) mỗi 24h/lần.	3–6mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.
Meropenem	20mg/kg (TM) mỗi 12h/lần.	10mg/kg (TM) mỗi 8h/lần (da); 20mg/kg (TM) mỗi 8h/lần (trong ổ bụng); 40mg/kg (TM) mỗi 8h/lần (viêm màng não).
Methenamin mandelat	Không được chỉ định.	15–25 mg (uống) mỗi 6–8 h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

<table>
<tr><td>Metronidazol</td><td colspan="3">15mg/kg (TM hoặc uống) ×1 liều, sau đó 7,5mg/kg/liều (TM hoặc uống) với khoảng thời gian dùng liều được dựa trên tuổi thai (GA) và Tuổi thực tế (CA) của trẻ:</td><td>5–12,5 mg/kg (uống) mỗi 8h/lần.

15 mg/kg (TM) ×1 liều và được tiếp sau đó bằng liều 7,5mg/kg (TM) mỗi 6h/lần.</td></tr>
<tr><td></td><td>GA + CA (tuần)</td><td>CA (ngày)</td><td>Khoảng thời gian dùng liều (giờ)</td><td rowspan="4"><u>Ghi chú</u>: "Tuổi thai- Gestational age" (GA) (hay "Tuổi kinh-menstrual age"): là thời gian giữa ngày đầu tiên của kỳ kinh bình thường cuối cùng và ngày sinh.

"Tuổi thực tế- Chronological age" (CA) (hay "Tuổi sau sinh-Postnatal age) là thời gian tính từ sau ngày sinh.

"Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng- Post-menstrual age" là thời gian tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối đến ngày sinh (tuổi thai) cộng thêm thời gian sau sinh (tuổi thực tế).</td></tr>
<tr><td></td><td>≤ 29</td><td>0–28
> 28</td><td>24
48</td></tr>
<tr><td></td><td>30–36</td><td>0–14
> 14</td><td>24
12</td></tr>
<tr><td></td><td>37–44</td><td>0–7
> 7</td><td>24
12</td></tr>
</table>

* *Liều dùng nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể trẻ (mg/kg), tới liều tối đa như liều người lớn.*

** *Thuốc có thể được cho theo đường Tiêm bắp song hấp thu thuốc có thể thay đổi.*

Thuốc	Liều dùng ở trẻ sơ sinh	Liều dùng ở nhũ nhi/ trẻ nhỏ*
Micafungin	Không được áp dụng.	4–12mg/kg (TM) mỗi 24h/lần (liều cao hơn đối với các bệnh nhân < 8 tuổi).
Mupirocin	Không được chỉ định.	Kem bôi mũi: ½ tuýp loại dùng một lần duy nhất vào mỗi lỗ mũi mỗi 12h/lần ×5 ngày; Kem thoa: Dùng mỗi 8h/lần × 5–190 ngày.
Nafcillin	25–50mg/kg/liều (TM). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675).	12,5–50mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6h/lần.
Nitazoxanid	Không được áp dụng.	Trẻ 1–3 tuổi: 100mg (uống) mỗi 12h/lần; trẻ 4–11 tuổi: 200 mg (uống) mỗi 12h/lần.
Nitrofurantoin	Không được chỉ định.	**Điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu**: 1,25–1,75mg/kg (uống) mỗi 6 h/lần. **Dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu**: 1–2 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nystatin	**Đường uống**: 1mL (trẻ đẻ non) đến 2mL (trẻ đẻ thường) loại nhũ dịch 100.000 đơn vị/mL được tẩm vào tăm bông bôi vào mỗi bên miệng mỗi 6 h/lần tới 3 ngày sau khi tổn thương thoái triển. **Tại chỗ**: Bôi mỡ hoặc kem thoa lên vùng bị tác động mỗi 6h/lần tới 3 ngày sau khi tổn thương thoái triển.	**Nhũ dịch**: 4–6mL súc miệng và nuốt x 4 lần/ngày. **Viên ngậm**: 1–2 viên ngậm x 4-5 lần/ngày.
Oxacillin	25–50mg/kg/liều (TM). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (*trang 675*).	25–50mg/kg (TM hoặc Tiêm bắp) mỗi 6h/lần.
Paromomycin	Không được áp dụng.	10mg/kg (uống) mỗi 8h/lần.
Penicillin G	25.000–50.000 đơn vị quốc tế/kg/liều (TM). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675). *Viêm màng não*: 75.000-100.000 đơn vị quốc tế/ kg (TM) trong viêm màng não†. mỗi 8–12h/lần dựa trên tuổi sau kỳ kinh cuối cùng = Tuổi thai (GA) + Tuổi thực tế (CA). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675). Penicillin G dạng tinh thể: Tiêm bắp: procain penicillin G mỗi 24h/lần. *Giang mai bẩm sinh*: Penicillin G tan trong nước 50.000 đơn vị quốc tế/kg (tiêm chậm TM) mỗi 12 h/lần x7 ngày, sau đó mỗi 8 h/lần tới khi hoàn thành liệu trình điều trị kéo dài 10–14 ngày ***hoặc*** procain penicillin G 50.000 IU/kg (TB) mỗi 24h/lần x10-14 ngày.	12.500–75.000 đơn vị/kg (TM hoặc TB) mỗi 4–6 h/lần.
Penicillin V	Không được chỉ định.	25–50mg/kg (uống) mỗi 6-8h/lần.
Piperacillin	50–100mg/kg/liều (TM hoặc TB). ***Xem ampicillin*** để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675).	25–75mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6h/lần; có thể tăng liều mỗi 4 h/lần đối với các nhiễm khuẩn nặng, nhất là đối với nhiễm khuẩn do Pseudomonas.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Piperacillin/ tazobactam	Không được chỉ định.	100–300mg/kg/ngày (TM) (đối với thành phần piperacillin) chia nhỏ liều và dùng mỗi 6-8h/ lần.
Pyrazinamid	***Xem trang 586***	***Xem trang 586***
Quinupristin/ dalfopristin	7,5 mg/kg (TM) mỗi 12h/lần.	7,5mg/kg (TM) mỗi 12h/lần.
Rifampin	10–20mg/kg (uống) mỗi 24h/ lần hoặc 5–10mg/kg (TM) mỗi 24h/lần.	20 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần hoặc 10mg/kg (uống) mỗi 12h/lần. 10–20mg/kg/ngày (TM) chia nhỏ liều và dùng mỗi 12–24h/lần.
Streptomycin	Xem trang 586	Xem trang 586
Sulfisoxazol	Bị chống chỉ định.	30–35mg/kg (uống) mỗi 6h/lần. *Dự phòng viêm tai giữa:* 37,5mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.
Tetracyclin	Bị chống chỉ định.	5–12,5mg/kg (uống) mỗi 6h/lần. Chỉ dùng cho trẻ > 8 tuổi.
Ticarcillin	75–100mg/kg/liều (TM). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675).	25–75mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 6 h/lần.
Ticarcillin/acid clavulanic	75–100 mg/kg/liều (đối với thành phần ticarcillin) (TM). Xem ampicillin để biết khoảng thời gian dùng liều (trang 675)	25–75 mg/kg (đối với thành phần ticarcillin) (TM hoặc TB) mỗi 6 h/lần.
Tinidazol	Không được áp dụng.	50–60 mg/kg (uống) mỗi 24h/lần.
Tobramycin	Cũng giống như gentamicin (trang 680).	2–2,5mg/kg (TM hoặc TB) mỗi 8h/lần.
Trimethoprim-sulfameth-oxazole (TMP – SMX)	Bị chống chỉ định.	**Nhiễm khuẩn đường tiết niệu**: 4-5mg/kg (đối với thành phần trimethoprim) (uống) mỗi 12h/lần. **Viêm phổi do pneumocystis carinii (PCP)** 5mg/kg (uống) mỗi 6h/lần (thường sau khi điều trị khởi đầu bằng đường tĩnh mạch). **Dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu**: 2-4mg/kg (uống) mỗi 24h/lần liều tĩnh mạch. **Viêm phổi do pneumocytis carinii hoặc nhiễm khuẩn nặng**: 5mg/kg (đối với thành phần trimethoprim) (TM) mỗi 6h/lần. **Nhiễm khuẩn nhẹ**: 4–6mg/kg (đối với thành phần trimethoprim) (TM) mỗi 12h/lần.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

<table>
<tr><td>Vancomycin</td><td colspan="3">Vãng khuẩn huyết: 10mg/kg/liều (TM).

Viêm màng não: 15mg/kg/liều (TM). Dùng liều TM trong vòng 60 phút. Khoảng dùng liều được dựa trên Tuổi thai (GA) và tuổi thực tế (CA) của trẻ:</td><td>10–15mg/kg (TM) mỗi 6h/lần.</td></tr>
<tr><td></td><td>GA + CA (tuần)</td><td>CA (ngày)</td><td>Khoảng thời gian dùng liều (tuần)</td><td rowspan="4">Ghi chú: "Tuổi thai- Gestational age" (GA) (hay "Tuổi kinh- menstrual age"): là thời gian giữa ngày đầu tiên của kỳ kinh bình thường cuối cùng và ngày sinh.

"Tuổi thực tế- Chronological age" (CA) (hay "Tuổi sau sinh- Postnatal age) là thời gian tính từ sau ngày sinh.

"Tuổi sau kỳ kinh cuối cùng- Post-menstrual age" là thời gian tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối đến ngày sinh (tuổi thai) cộng thêm thời gian sau sinh (tuổi thực tế).</td></tr>
<tr><td></td><td>≤ 29</td><td>0–14
> 14</td><td>18
12</td></tr>
<tr><td></td><td>30–36</td><td>0–14
> 14</td><td>12
8</td></tr>
<tr><td></td><td>37–44</td><td>0–7
> 7</td><td>12
8</td></tr>
<tr><td>Voriconazol</td><td colspan="3">Không được áp dụng.</td><td>7mg/kg (TM) mỗi 12h/lần.

8mg/kg (uống) mỗi 12h/lần ×1 ngày, sau đó 7mg/kg (uống) mỗi 12h/lần.</td></tr>
</table>

* *Liều dùng nói chung được dựa trên trọng lượng cơ thể trẻ (mg/kg), tới liều tối đa như ở người lớn.*

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI GỢI Ý ĐỌC THÊM

Betts R, Glasmacher A, Maertens J, et al. Efficacy of caspofungin against invasive Candida or invasive Aspergillus infections in neutropenic patients. Cancer 106: 466–73, 2006.

Bisno AL, Kaplan EL. Strep throat over and over: How frequent? How real? Mayo Clin Proc 81: 1153–4, 2006.

CDC. Outbreak of Swine-Origin Influenza A (H_1N_1) Virus Infection—Mexico, March–April 2009, MMWR Dispatch 58: April 30, 2009.

CDC. Use of rapid influenza diagnostic tests for patients with influenza-like illness during the novel H_1N_1 influenza virus (Swine Flu) outbreak. Swine Influenza Bulletin June 12, 2009.

Cheng VCC, Lau Y-K, Lee K-l, et al. Fatal co-infection with swine origin influenza virus A/H1N1 and community acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus. J Infection (Epub ahead of print): 1–5, 2009.

Committee of Infectious Disease. Prevention of varicella: Recommendations for use of varicella vaccine in children, including a recommendation for a routine 2-dose varicella immunization schedule. Pediatrics 120: 221–231, 2007.

Dominguez-Cherit G, Lapinsky SE, Macias AE, et al. Critically ill Patients with 2009 Influenza A (H1N1) in Mexico. JAMA 302: 1872–1879, 2009.

Ellis JM, Kuti JL, Nicolau DP. Pharmacodynamic evaluation of meropenem and cefotaxime for pediatric meningitis: a report from the OPTAMA program. Pediatr Drugs 8: 131–8, 2006.

Fox JW, Marcon MJ, Bonsu BK. Diagnosis of streptococcal pharyngitis by detection of Streptococcus pyogenes in posterior pharyngeal vs oral cavity specimens. Journal of Clin Microbiology 44: 2593–94, 2006.

Groll AH, Attarbasehi A, Schuster FR, et al. Treatment with caspofungin in immunocompromised paediatric patients: a multicentre survey. A Antimicrob Chemother 57: 527–35, 2006.

Hidron AI, Low CE, Honig EG, et al. Emergence of community-acquired methicillin- resistant Staphylococcus aureus strain USA300 as a cause of necrotizing community-onset pneumonia. Lancet Infect Dis 9: 384–392, 2009.

Kaplan SL, Afghani B, Lopez P, et al. Linezolid for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in children. Pediatric Infect Disease 22: S178–185, 2003.

Lehtinen P, Jartti T, Virkki R, et al. Bacterial coinfections in children with viral wheezing. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 25: 463–9, 2006.

Lorente L, Lorenzo L, Martin MM, Jimenez A, Mora ML.

Meropenem by continuous versus intermittent infusion in ventilator-associated pneumonia due to gram negative bacilli. Ann Pharmacother 40: 219–23, 2006.

Louie JK, Acosta M, Winter K, et al. Factors Associated with death or hospitalization due to pandemic 2009 influenza (H1N1) infection in California. JAMA 302: 1896–1902, 2009.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Mathys J, DeMeyere M. Acute pharyngitis: no reliability of rapid streptococcal tests and clinical findings. Arch Intern Med 166: 2285–86, 2006.

Saiman L, Goldfarb J, Kaplan SL, et al. Safety and tolerability of linezolid in children. Pediatric Infect Disease 22: S193–200, 2003.

GUIDELINES

Bradley J, Byington C, Shah S, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases. 53: 617–630, 2011.

CDC Prevention and Control of Influenza with Vaccines.

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization. Practices (ACIP); MMWR 60: 1128–1132, 2011.

CDC Antiviral Agents for Treatment and Chemoprophylaxis of Influenza, MMWR 60: 1–24, 2011.

CDC Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from CDC, 2010. MMWR 59: 1–32, 2010.

CDC Hospitalized patients with novel influenza A (H1N1) infection—California, MMWR 2009. 58: 536–541, 2009.

CDC Intensive-care patients with severe novel influenza (H1N1) virus infection—Michigan, MMWR 2009. 58: 749–752, 2009.

CDC Recommended childhood and adolescent immunization schedule-United States, 2007. MMWR 55: Q1–Q4, January 5, 2007.

Committee of infectious Disease. Prevention of varicella: Recommendations for use of varicella vaccine inchildren, including a recommendation for a routine 2-dose varicella immunization schedule. Pediatrics 120: 221–231, 2007.

Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: Guidelines by the Surgical

Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 50: 133–164, 2010.

TEXTBOOKS

Feigin RD, Cherry JD, Demmler GJ, Kaplan SL (eds). Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 6th Edition, Philadelphia, Saunders, 2009.

McMillan JA, DeAngelis CD, Feigin RD, Warshaw JB (eds.)

Oski's Pediatrics, Principles and Practice. 3rd

Edition, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999.

Pickering LK (ed.) Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases. American Academy of Pediatrics, 26th Edition, Elk Grove Village, IL, 2009.

Remington JS, Klein JO (eds) Infectious Diseases of the Fetus and Newborn 6th Edition, WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2006.

Shah S. Pediatric Infectious Disease Practice. New York: McGraw-Hill, 2009.

Siberry GK, Iannone R. The Harriet Lane Handbook. 18th Edition, Mosby, St. Louis, MO, 2008.

Steele RW. Clinical Handbook of Pediatric Infectious Disease 3rd Edition, Informa Healthcare, New York, 2007.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Chương VIII

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN DỰA TRÊN HÌNH ẢNH PHIM XQUANG PHỔI

Burke A. Cunha, MD
Douglas S.Katz, MD
Robert Moore, MD
Daniel S. Siegal, MD

NGƯỜI DỊCH:

ThS. Lê Văn Ký
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
TS. Đỗ Ngọc Sơn
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

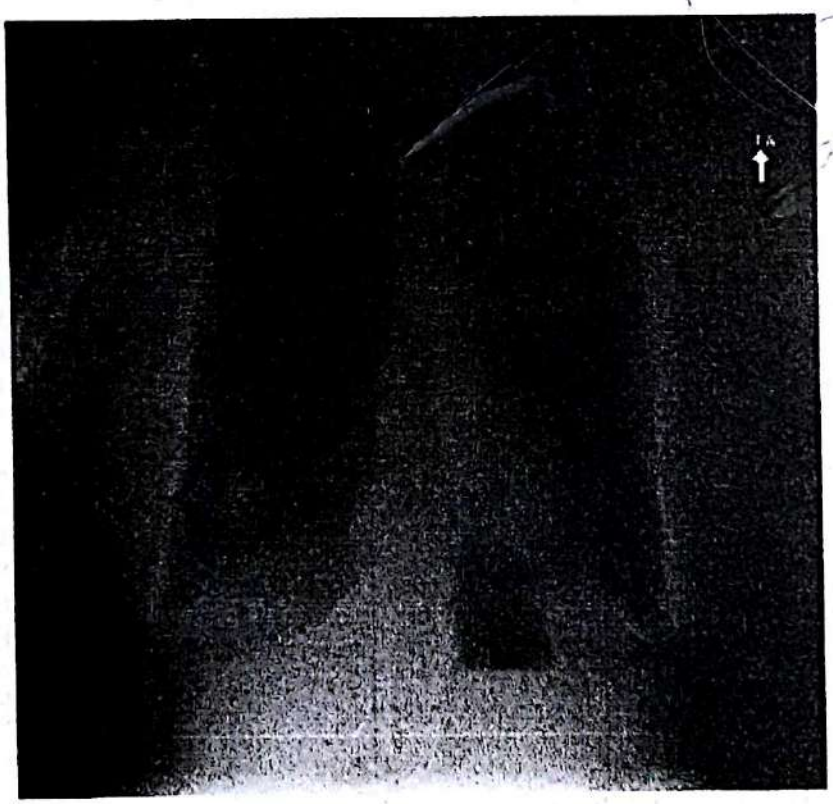
Dạng hình ảnh chụp Xquang ngực

Xâm nhiễm thùy/tiểu thùy khu trú một bên không có tràn dịch màng phổi (Unilateral Focal Segmental/Lobar Infiltrate Without Effusion)	689
Xâm nhiễm thùy/tiểu thùy khu trú một bên có tràn dịch màng phổi (Unilateral Focal Segmental/Lobar Infiltrate With Effusion)	694
Xâm nhiễm một bên ranh giới khó xác định không có tràn dịch màng phổi (Unilateral Ill-Defined Infiltrates Without Effusion)	700
Xâm nhiễm một bên ranh giới khó xác định có tràn dịch màng phổi (Unilateral Ill-Defined Infiltrates With Effusion)	707
Xâm nhiễm hai bên không có tràn dịch màng phổi (Bilateral Infiltrates Without Effusion)	712
Xâm nhiễm hai bên không có tràn dịch màng phổi (Bilateral Infiltrates With Effusion)	721
Xâm nhiễm dạng hang (Cavitary Infiltrates) thành dày (Thick-Walled)	726
Xâm nhiễm dạng hang (Cavitary Infiltrates) thành mỏng (Thin-Walled)	734
Tài liệu tham khảo và các bài gợi ý đọc thêm	738

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cuốn atlas này được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân có triệu chứng hô hấp và bất thường trên hình ảnh Xquang ngực. Tám dạng hình ảnh Xquang ngực thường gặp được trình bày. Các căn nguyên nhiễm khuẩn và không do nhiễm khuẩn thường gặp được trình bày sau phần đặc điểm lâm sàng, nhờ đó có thể được sử dụng để xác định chẩn đoán và giúp hướng dẫn điều trị đặc hiệu và điều trị theo kinh nghiệm cho bệnh nhân.

XÂM NHIỄM THÙY HOẶC TIỂU THÙY KHU TRÚ MỘT BÊN KHÔNG CÓ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Phế cầu (*S.pneumoniae*)	Người có tuổi, người hút thuốc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm miễn dịch thể dịch (Vd: đau tủy xương, lupus ban đỏ hệ thống, loxemi kinh dòng lympho, giảm chức năng lách).	Sốt, rét run, không có nhịp tim chậm tương đối. Dấu hiệu thực thể khi khám phổi liên quan với mức độ lan rộng của tình trạng đông đặc phổi.	Tăng bạch cầu, giảm tiểu cầu (nhiễm khuẩn nặng/ giảm chức năng lách), xét nghiệm chức năng gan bình thường. Đờm có rất nhiều bạch cầu đa nhân trung tính và song cầu Gram dương. Cấy máu thường dương tính.	Vùng đông đặc thường khu trú ở một thùy phổi (thường gặp nhất thùy dưới phổi phải) ± phế quản khí. Tràn dịch màng phổi rất ít gặp. Tràn mủ màng phổi không phải là ngoại lệ. Không có hình hang ở phổi.
H. influenzae	Tiếp xúc gần đây với nhiễm khuẩn đường hô hấp trên do *H. influenzae*	Sốt, rét run	Tăng bạch cầu. Đờm/ dịch màng phổi có trực khuẩn Gram âm đa hình thể. Cấy máu thường dương tính.	Thường gặp ở thùy dưới phổi phải với tràn dịch màng phổi mức độ ít/ vừa. Không có tràn mủ màng phổi. Không có hình hang ở phổi.
M. catarrhalis	Người nghiện thuốc lá nặng/ mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.	Không đặc hiệu	Đờm có song cầu Gram âm/ song cầu có thể thay đổi. Cấy máu âm tính.	Thường ở thùy dưới phổi ± đông đặc phổi. Không có tràn dịch màng phổi hoặc hình hang ở phổi.
K. pneumoniae	Viêm phổi bệnh viện hoặc tiền sử nghiện rượu ở bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng	Sốt, rét run, dấu hiệu thực thể của xơ gan do rượu, dấu hiệu đông đặc trên thùy phổi bị tác động.	Tăng bạch cầu, giảm tiểu cầu, tăng SGOT/ SGPT (do nghiện rượu). Đờm có màu "thạch đỏ" với bạch cầu đa nhân trung tính và trực khuẩn Gram âm có vỏ bọc.	Dấu hiệu "Rãnh liên thùy phồng ra" ("bulging fissure") thứ phát do tăng thể tích thùy phổi. Mủ màng phổi thường gặp hơn tràn dịch màng phổi. Hình hang được tạo sau 5-7 ngày (thành dày).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường gặp ở người già. Có thể bị ỉa chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức.	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/lách to loại trừ chẩn đoán. Giảm rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi.	Tăng số lượng bạch cầu, tăng SGOT/SGPT, giảm PO_4^-, giảm Na^+, tăng CPK, tăng tốc độ lắng hồng cầu, tăng CRP, tăng nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên. *Lpneumophilia* trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp. (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. Tăng hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục.	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang.
Sốt vẹt (psittacosis)	Gần đây có tiếp xúc với vẹt. Đau đầu nặng.	Sốt/ớn lạnh ± nhịp chậm tương đối, đốm Horder trên mặt, chảy máu cam, ± lách to. Dấu hiệu đông đặc phổi thường gặp.	Tăng bạch cầu/bạch cầu bình thường, tăng các xét nghiệm chức năng gan. Đờm có một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Tăng hiệu giá với *C. psittaci.*	Xâm nhiễm đậm đặc. Đông đặc phổi thường gặp. Tràn dịch màng phổi/hình hang hiếm gặp.
Sốt Q	Gần đây có tiếp xúc với cừu hoặc mèo đẻ.	Sốt/ớn lạnh,± nhịp chậm tương đối, lách to ± gan to.	Tăng bạch cầu /bạch cầu bình thường, tăng các xét nghiệm chức năng gan. Đờm không có vi khuẩn/có một vài bạch cầu đa nhân trung tính (thận trọng – nguy cơ phơi nhiễm sinh học). Sốt Q cấp với tăng trong pha 2 ELISA tìm kháng nguyên.	Đông đặc. Hình hang/ tràn dịch màng phổi hiếm gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

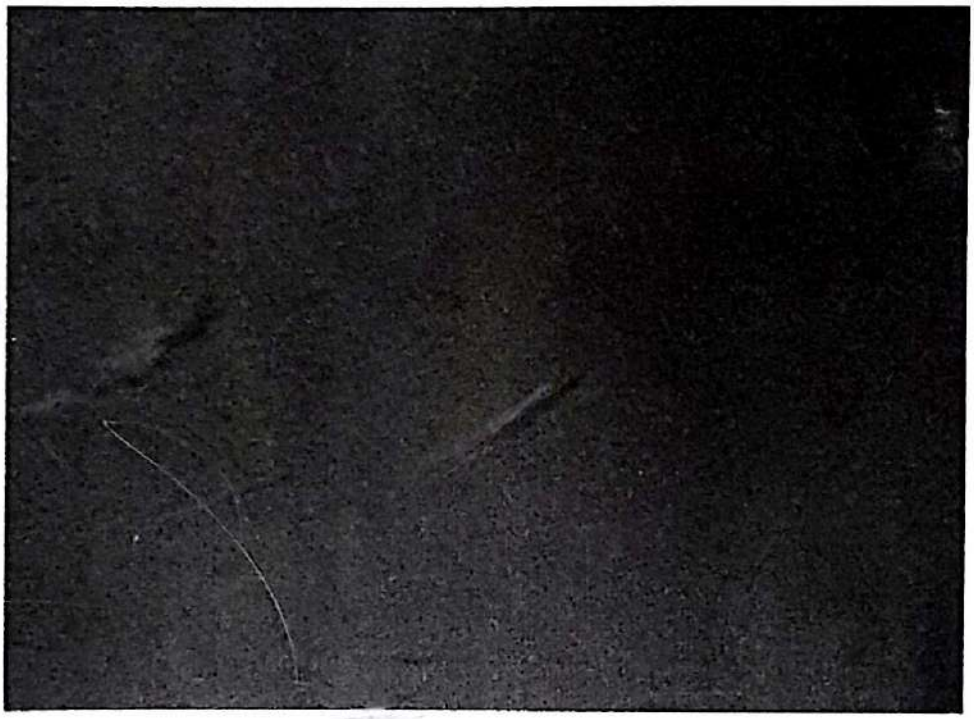
Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Xẹp phổi	Ho xuất tiết tái diễn không hiệu quả đặc trưng cho tình trạng xẹp phổi sau mổ	Sốt ≤ 39°C. Nếu lớn sẽ có các dấu hiệu giảm thể tích phổi (↓ di động thành ngực, cơ hoành nâng cao, trung thất bị dịch chuyển về phía phổi xẹp). Nếu nhỏ: Giảm rì rào phế nang ở vùng/thùy phổi bị tổn thương.	tăng bạch cầu (công thức bạch cầu công thức bạch cầu chuyển trái), tiểu cầu bình thường. Các kết quả cận lâm sàng khác liên quan với nguyên nhân nền gây xẹp phổi.	Xâm nhiễm phân thùy phổi. Xẹp thùy trên phổi phải/thùy giữa phổi phải làm mờ bờ tim phải. Trong xẹp thùy trên phổi trái, có thể thấy xâm nhiễm hình tam giác mở rộng đến phần trung thất trước trên trông giống tổn thương ác tính. Xẹp phổi thùy thùy dưới phổi trái gây ↑ đậm độ bóng tim. Không có hình ảnh hang hoặc tràn dịch màng phổi.
Tắc mạch phổi/ nhồi máu phổi	Khó thở khởi phát cấp tính/ đau ngực kiểu màng phổi. Tiền sử chấn thương chi dưới, tình trạng ứ trệ tuần hoàn hoặc các rối loạn tăng đông.	Tăng tần số mạch/ tần số thở	Tăng sản phẩm thoái giáng fibrin và D-dimer ± tăng bilirrubin toàn phần. Tràn máu màng phổi. Điện tâm đồ có tăng gánh thất phải/sóng P-phế (nhồi máu phổi lớn). Chụp xạ hình phổi đánh giá thông khí-tưới máu (V/Q scan) và chụp CT mạch phổi cho kết quả dương tính.	Bình thường hoặc cho thấy có xâm nhiễm đáy- màng phổi không đặc hiệu, giống như xẹp phổi. Tăng sáng thùy/ tiểu thùy (dấu hiệu Westermark) gặp ở một số bệnh nhân. Dấu hiệu "Bướu Hampton" của vùng nhồi máu. Nhồi máu thoái triển kích thước giảm đi song vẫn duy trì hình dạng/mật độ ("khối đá đang tan").

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

U lympho (lymphoma)	Sốt, giảm ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt.	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, tăng bạch cầu ái kiềm, tăngbạch cầu ái toan, giảm bạch cầu lympho, tăng tiểu cầu, tăng tốc độ lắng hồng cầu, tăng phosphatase kiềm, tăng $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh.	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.
Ung thư biểu mô tế bào phế nang (Alveolar cell carcinoma)	Sốt, tăng ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm.	± vùng gõ đục trên thùy phổi khi tổn thương toàn bộ thùy dưới.	Tế bào học dịch rửa phế quản/sinh thiết phổi dương tính.	Xâm nhiễm vùng ngoại vi hình tròn ranh giới rõ/không rõ ± phế quản khí. Có thể có nhiều ổ/ nhiều thùy. Có hạch to vùng rốn phổi. Hướng về rốn phổi (dấu hiệu "đuôi màng phổi") ± tràn dịch màng phổi nếu xâm nhiễm thùy dưới phổi. Không có hình ảnh hang.
Viêm phổi do hít (Aspiration pneumonia)	Rối loạn nuốt thứ phát do bệnh lý TKTW/ đường tiêu hóa; suy giảm ý thức. Hít phải phổi thứ phát gần đây do thủ thuật hô hấp, đường tiêu hóa trên, răng miệng.	Không đáng kể	Tăng bạch cầu , tăng tốc độ lắng hồng cầu.	Xâm nhiễm thường ở phần trên của thùy dưới (hoặc phần dưới của thùy trên nếu tình trạng hít vào phổi xảy ra khi bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa). Khởi đầu xâm nhiễm khu trú, sau đó tạo hang/áp xe phổi vào ngày thứ 7 trở đi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM THÙY HOẶC TIỂU THÙY KHU TRÚ MỘT BÊN CÓ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Klebsiella pneumoniae	Viêm phổi bệnh viện hoặc tiền sử nghiện rượu ở bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải từ cộng đồng.	Sốt, ớn lạnh, các dấu hiệu xơ gan do rượu, dấu hiệu đông đặc phổi trên thùy phổi bị tác động.	Tăng bạch cầu, giảm tiểu cầu, thay đổi SGOT/ SGPT (thứ phát do nghiện rượu). Đờm "mẩu thạch đỏ" với bạch cầu đa nhân trung tính và trực khuẩn Gram âm tạo vỏ bọc.	Dấu hiệu "rãnh liên thùy phồng lên" thứ phát do tăng thể tích thùy phổi. Mủ màng phổi thường gặp hơn tràn dịch màng phổi. Thường tạo hang trong 5-7 ngày (thành dày).

H. influenzae	Gần đây có tiếp xúc với viêm đường hô hấp trên do *H. influenzae*	Sốt, ớn lạnh.	↑ bạch cầu, đờm/ dịch màng phổi dương tính với trực khuẩn Gram âm đa hình thái. Cấy máu thường dương tính.	Thường tác động tới thùy dưới phổi phải với tràn dịch màng phổi mức độ ít/ vừa. Không tràn mủ màng phổi, không tạo hang.
Lao (nguyên phát)	Gần đây có tiếp xúc với trực khuẩn lao.	Đục thùy dưới một bên liên quan với kích thước tràn dịch màng phổi.	Test tuberculin da (-)/ mất đáp ứng miễn dịch (anergic). Tràn dịch màng phổi loại dịch tiết (dịch màng phổi có ↑ bạch cầu lympho, ↑ glucose, ± hồng cầu).	Xâm nhiễm thùy dưới phổi với tràn dịch màng phổi mức độ ít/vừa. Không tạo hang hoặc xâm nhiễm đỉnh phổi. Hạch rốn phổi nếu có thường không đối xứng.
Bệnh nấm *Coccidioides immitis* (mạn tính)	Phơi nhiễm trước đó trong vùng dịch tễ có bệnh nấm coccidioides. Không có triệu chứng.	± hồng ban nút	Bạch cầu bình thường, không có ↑ bạch cầu ái toan ở pha mạn tính. Hiệu giá IgG cố định bổ thể ≥ 1:32 chỉ dẫn bệnh ở giai đoạn hoạt động.	Hang thành dày/ mỏng < 3cm ± vôi hóa. Hiếm gặp mức nước mức hơi trừ khi bị nhiễm khuẩn thứ phát. Các hang thường ở tiểu thùy trước của thùy trên (so với tiểu thùy phía sau trong lao). Không có phản ứng mô xung quanh. Tràn dịch màng phổi thường gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh Tularemia hay bệnh Fancis	Tiền sử gần đây có tiếp xúc với ruồi hươu, thỏ hoặc bọ chét. Viêm phổi do tularemia có thể là biến chứng của tất cả các thể lâm sàng của bệnh tularemia.	Sốt, ớn lạnh, không có nhịp chậm tương đối. Triệu chứng ngực thường được phát hiện là xâm nhiễm/ đông đặc và tràn dịch màng phổi.	↑ bạch cầu/ bạch cầu bình thường, xét nghiệm chức năng gan bình thường. Đờm/dịch màng phổi dương tính với cầu-trực khuẩn Gram âm (lưu ý nguy cơ phơi nhiễm sinh học). Tràn dịch màng phổi. Huyết thanh học với tularemia cho thấy ↑ hiệu giá micro agglutination ≥ 1:160 trong giai đoạn cấp và ≥ ↑ 4 lần giữa hiệu giá cấp và hiệu giá ở giai đoạn hồi phục.	Tràn dịch màng phổi ± hạch trung thất.
Adenovirus	Gần đây bị nhiễm khuẩn hô hấp trên	Sốt, ớn lạnh, đau cơ. Đau họng và viêm kết mạc không phải lúc nào gặp trong viêm phổi do adenovirus. Khám phổi có thể thấy dấu hiệu đông đặc phổi ±	↑ hiệu giá kháng thể đối với adenovirus và nuôi cấy adenovirus dương tính trong chất tiết đường hô hấp. Xét nghiệm dịch phế quản (+) với adenovirus.	Xâm nhiễm không rõ ranh giới không tạo hang ± tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường gặp ở người già. Có thể bị la chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức.	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/ lách to loại trừ chẩn đoán. ↓ rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi.	↑ số lượng bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, ↓ PO_4^-, ↓ Na^+, ↑ CPK, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ CRP, ↑ nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên *L.pneumophilia* trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. ↑ hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục.	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang.
Liên cầu nhóm A	Gần đây có phơi nhiễm hoặc bị chấn thương ngực kín ± đau ngực.	Sốt/ớn lạnh. Khám thực thể liên quan với kích thước của tràn dịch màng phổi.	↑ bạch cầu. Dịch màng phổi là dịch thanh tơ huyết. Đờm/dịch màng phổi tìm thấy cầu khuẩn Gram dương xếp thành đôi/ chuỗi. Cấy máu/ dịch màng phổi dương tính.	Xâm nhiễm một bên có thể bị che khuất do dịch màng phổi. Không có ứ mủ màng phổi. Không tạo hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Rhodococcus equi	Khởi phát âm ỉ với sốt, khó thở đau ngực ± ho ra máu. Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch với ↓ miễn dịch qua trung gian tế bào hoặc phơi nhiễm với gia súc, ngựa và lợn.	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường/ ↑ bạch cầu. Đờm/ dịch màng phổi dương tính với trực khuẩn kháng nhẹ cồn–acid, Gram dương đa hình thái. Đờm, dịch màng phổi, cấy máu dương tính với *R.equi*.	Xâm nhiễm tiểu thùy ở thùy trên của phổi chiếm ưu thế ± tạo hang. Mức nước mức hơi và tràn dịch màng phổi thường gặp.

Các nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

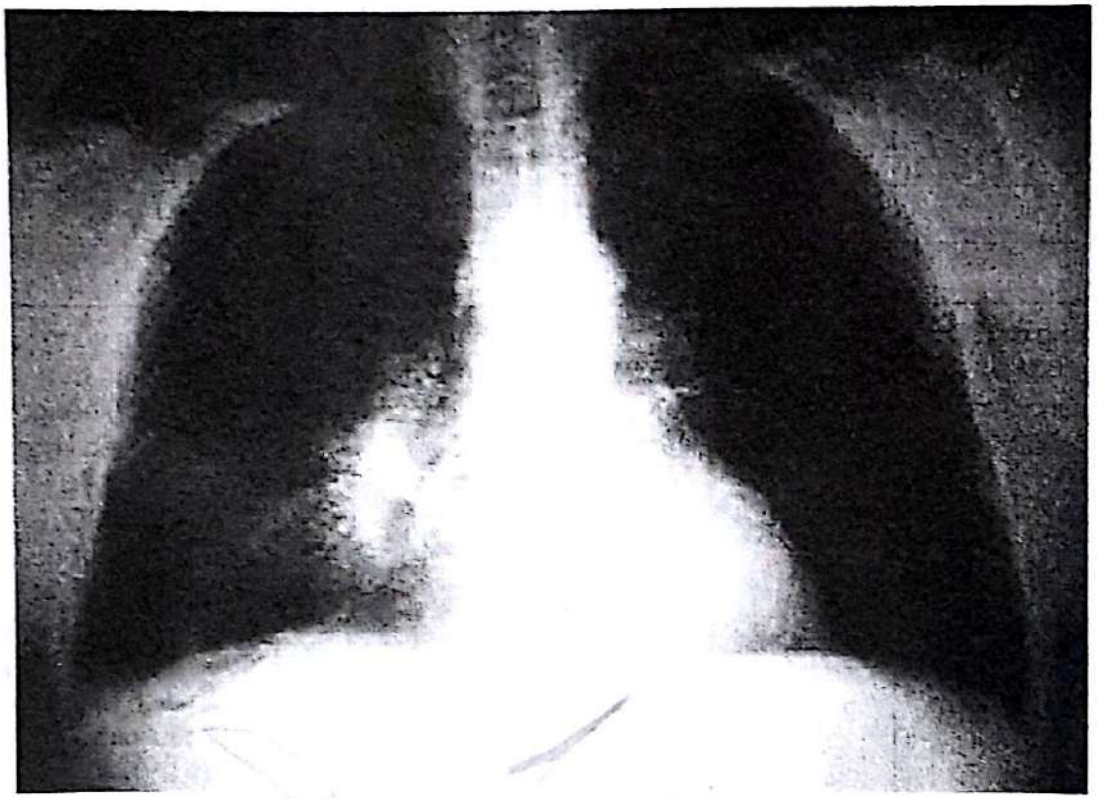
Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	**Khám thực thể**	**Xét nghiệm**	**Hình ảnh Xquang ngực**
Tắc mạch phổi/ nhồi máu phổi	Khó thở khởi phát cấp tính/ đau ngực kiểu màng phổi. Tiền sử chấn thương chi dưới, tình trạng ứ trệ tuần hoàn hoặc rối loạn tăng đông.	↑ tần số mạch/ tần số thở.	↑ sản phẩm thoái giáng fibrin và D-dimer ± ↑ bilirrubin toàn phần. Tràn máu màng phổi. Điện tâm đồ có tăng gánh thất phải/ sóng P-phế (nhồi máu phổi lớn). Chụp xạ hình phổi đánh giá thông khí-tưới máu (V/Q scan) và chụp cắt lớp vi tính mạch phổi cho kết quả dương tính.	Bình thường hoặc cho thấy có xâm nhiễm đáy-màng phổi không đặc hiệu, giống như xẹp phổi. Tăng sáng thùy/tiểu thùy phổi (dấu hiệu Westermark) gặp ở một số bệnh nhân. Dấu hiệu "Bướu Hampton" của vùng nhồi máu. Nhồi máu thoái triển kích thước ↓ đi song vẫn duy trì hình dạng/mật độ ("khối đá đang tan").

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt.	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓ bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh.	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.
Ung thư biểu mô tế bào phế nang (Alveolar cellcarcinoma)	Sốt, ↑ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm.	± vùng gõ đục trên thùy phổi khi có tổn thương toàn bộ thùy dưới	Tế bào học dịch rửa phế quản/sinh thiết phổi dương tính	Xâm nhiễm vùng ngoại vi hình tròn ranhgiới rõ/không rõ ± phế quản khí. Có thể có nhiều ổ/nhiều thùy. Có hạch to vùng rốn phổi. Hướng về rốn phổi (dấu hiệu "đuôi màng phổi") ± tràn dịch màng phổi nếu xâm nhiễm thùy dưới phổi. Không có hình ảnh hang.
Phế viêm do tia xạ (Radiation pneumonitis)	Tiền sử xạ trị diện rộng để điều trị u lympho, ung thư phổi hoặc ung thư vú.	Không đặc hiệu	Không đặc hiệu	Các xâm nhiễm đối xứng tương ứng với vùng xạ trị sau thời gian 1 tháng. Xâm nhiễm có "bờ thẳng" ± phế quản khí. Tình trạng xơ hóa thường gặp trên trường tia xạ sau 9-12 tháng. Thường không có tràn dịch màng phổi (nếu có thường ít).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM RANH GIỚI KHÔNG RÕ MỘT BÊN KHÔNG CÓ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Viêm phổi do Mycoplasma (*Mycoplasma pneumoniae*)	Ho không có đờm/ho khan kéo dài. Không có viêm thanh quản. Đau họng/ đau tai nhẹ. Ỉa chảy phân nước.	Thường sốt ≤ 39°C mà không có nhịp chậm tương đối. Đau cơ, viêm màng nhĩ tạo bọng nước (bullous myringitis) hoặc viêm tai giữa, viêm họng không xuất tiết, hồng ban đa dạng. Khám ngực phát hiện được rales phổi và không có dấu hiệu đông đặc hoặc tràn dịch màng phổi	↑ bạch cầu/ bạch cầu bình thường, tiểu cầu bình thường, cũng như xét nghiệm chức năng gan, PO_4^-, CPK. ↑ ngưng kết lạnh (sớm), ↑ hiệu giá kháng thể IgM (mà không phải IgG) với *M. pneumoniae*. Nuôi cấy chất tiết đường hô hấp dương tính với *M. pneumoniae*	Xâm nhiễm thùy dưới ranh giới không rõ ràng. Không có đông đặc phổi hoặc phế quản khí. Tràn dịch màng phổi ít hoặc không có tràn dịch màng phổi.

Chlamydophilia (*Chlamydia pneumoniae*)	Bệnh kéo dài "giống nhiễm trùng do mycoplasma" với viêm thanh quản	Sốt mức độ thấp, đau cơ, viêm họng hầu không xuất tiết, viêm thanh quản. Không có nhịp tim chậm tương đối, không có dấu hiệu tai hoặc phát ban. Khám ngực không có dấu hiệu đông đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi	↑ bạch cầu, tiểu cầu bình thường, xét nghiệm chức năng gan bình thường. Không có ngưng kết lạnh. ↑ hiệu giá IgM (không phải IgG) đối với C.pneumoniae. Nuôi cấy chất tiết đường hô hấp dương tính với *C.pneumoniae*	Xâm nhiễm thường ở thùy dưới ranh giới không rõ. Có thể "hình phễu". Không có đông đặc phổi, không tạo hang, hoặc tràn dịch màng phổi
Adenovirus	Gần đây bị nhiễm khuẩn hô hấp trên	Sốt, ớn lạnh, đau cơ. Đau họng và viêm kết mạc không phải lúc nào cũng gặp trong viêm phổi do adenovirus. Khám ngực ± dấu hiệu đông đặc phổi	↑ hiệu giá kháng thể với adenovirus và nuôi cấy adenovirus dương tính trong chất tiết đường hô hấp. Xét nghiệm dịch phế quản dương tính với adenovirus	Xâm nhiễm không rõ ranh giới không tạo hang ± tràn dịch màng phổi
Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường gặp ở người già. Có thể bị ỉa chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/lách to loại trừ chẩn đoán. ↓ rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi	↑ số lượng bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, ↓ PO_4, ↓ Na^+, ↑ CPK, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ CRP, ↑ nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên *L.pneumophilia* trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. ↑ hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Sốt vẹt (psittacosis)	Gần đây tiếp xúc với vẹt. Đau đầu nặng	Sốt/ớn lạnh, ± nhịp chậm tương đối, các nốt Horder trên mặt, chảy máu cam, ± lách to. Dấu hiệu đông đặc phổi thường gặp	↑ bạch cầu/bạch cầu bình thường, ↑ các xét nghiệm chức năng gan. Đờm có một vài bạch cầu đa nhân trung tính. ↑ hiệu giá với *C.psittaci*	Xâm nhiễm đậm đặc. Đông đặc phổi thường gặp. Tràn dịch màng phổi/ hình hang hiếm gặp
Sốt Q	Gần đây có tiếp xúc với cừu hoặc mèo sắp đẻ	Sốt/ớn lạnh, ± nhịp chậm tương đối, lách to ± gan to	↑ bạch cầu/ bạch cầu bình thường, ↑ các xét nghiệm chức năng gan. Đờm không có vi khuẩn/ có một vài bạch cầu đa nhân trung tính (thận trọng-nguy cơ phơi nhiễm sinh học). Sốt Q cấp với ↑ kháng nguyên ELISA pha II	Đông đặc. Hình hang/tràn dịch màng phổi hiếm gặp
Nocardia	Sốt, ra mồ hôi đêm, mệt mỏi, ↓ miễn dịch qua trung gian tế bào (ví dụ: nhiễm HIV, ghép tạng, bệnh tích tụ protein phế nang phổi (PAP), điều trị ức chế miễn dịch)	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường hoặc ↑, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm dương tính với trực khuẩn kháng acid (AFB)	Xâm nhiễm rộng đậm đặc. Có thể thành hang và giống với lao, u lympho hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy. Không có vôi hóa ± tràn dịch màng phổi
Bệnh nấm actinomyces (Actinomycosis)	Chữa răng gần đây	± Đường rò ở thành ngực	Bạch cầu bình thường hoặc ↑, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm có trực khuẩn hình sợi Gram dương	Xâm nhiễm đặc lan rộng đến thành ngực. Không có hạch rốn phổi. Hiếm gặp tạo hang ± tràn dịch màng phổi nhưng hiếm gặp

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh nấm *Cryptococcus neoformans*	Phơi nhiễm với máy điều hòa nhiệt độ hoặc chim bồ câu	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường. Huyết thanh chẩn đoán tìm cryptococcus có ↑ nồng độ kháng nguyên *C. neoformans*	Tổn thương khối đông đặc thùy dưới. Không có vôi hóa và không tạo hang. ± Tràn dịch màng phổi
Viêm phổi do hít (Aspiration pneumonia)	Rối loạn nuốt thứ phát do bệnh lý TKTW/ đường tiêu hóa; suy giảm ý thức. Hít phải phổi thứ phát gần đây do thủ thuật hô hấp, đường tiêu hóa trên, răng miệng	Không đáng kể	↑ bạch cầu , ↑ tốc độ lắng hồng cầu	Xâm nhiễm thường ở tiểu thùy trên của thùy dưới phổi (hoặc tiểu thùy sau của thùy trên phổi nếu tình trạng hít vào phổi xảy ra khi bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa). Xâm nhiễm khu trú lúc khởi đầu, và tình trạng này có thể được kế tiếp từ ngày thứ 7 trở đi bằng tạo hang/ áp xe phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Các nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Ung thư biểu mô phế quản (Bronchogenic carcinoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với mất cân, ho ± ho ra máu. Ho khạc đờm dạng nhầy/ đờm trong dính trong ung thư biểu mô không biệt hóa tế bào lớn. Nguy cơ gia tăng ở người nghiện thuốc lá, thợ khai thác mỏ nhôm/ uranium, bệnh phổi tạo hang (ung thư biểu mô tuyến [adeno-carcinoma]), trước đó được điều trị tia xạ do u lympho, ung thư vú	Hội chứng cận ung thư nhất là với ung thư phổi tế bào nhỏ (oat cell)/ung thư biểu mô tế bào vảy ± bệnh xương khớp phì đại do phổi (hypertrophic pulmonary osteo-arthropathy)	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, các dấu hiệu liên quan với bệnh lý ác tính nền, ± ngón tay khum	Ung thư biểu mô tế bào nhỏ/tế bào vảy được biểu hiện bằng các tổn thương trung tâm/những khối u vùng rốn phổi. Ung thư biểu mô tuyến/ ung thư biểu mô không biệt hóa tế bào lớn thường khởi đầu từ vùng ngoại vi. "Các tua của khối u" ("Tumor tendrils") mở rộng tới mô phổi xung quanh là điểm đặc trưng. Không có vôi hóa (có thể biểu hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực). Tạo hang với ung thư biểu mô tế bào vảy ± tràn dịch màng phổi
Di căn hệ bạch huyết (Lymphangitic metastases)	Tiền sử ung thư biểu mô vú, tuyến giáp, tụy, cổ tử cung, tuyến tiền liệt hoặc phổi	Dấu hiệu liên quan với bệnh lý ung thư nền	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu	Xâm nhiễm phổi kẽ không chuyên biệt (có thể có dạng lưới nốt) ưu thế ở thùy dưới. Thường ở một bên song có thể cả hai bên. Không có đông đặc phổi hoặc tạo hang ± tràn dịch màng phổi
Đụng giập phổi	Chấn thương ngực kín gần đây, đau ngực	Tổn thương đụng giập thành ngực trên vùng xâm nhiễm	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái)	Xâm nhiễm không rõ ranh giới ± gẫy xương sườn/ tràn khí màng phổi ở vung xâm nhiễm. Xâm nhiễm hết sau 1 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

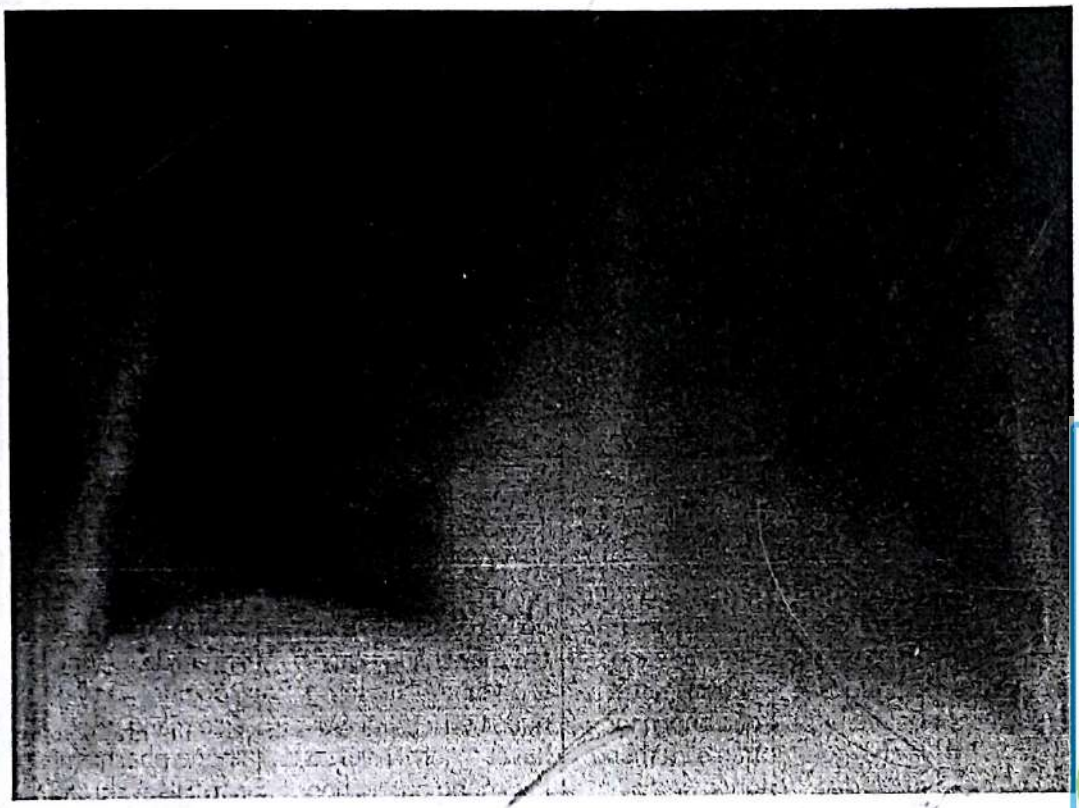
Suy tim ứ huyết	Bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim	Không sốt/sốt nhẹ, ↑ tần số mạch và tần số thở, tĩnh mạch cổ nổi và phản hồi gan tĩnh mạch cảnh dương tính, tim to, S3, cổ trướng, gan to, phù mu chân	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), tiểu cầu bình thường, ↑ nhẹ SGOT/SGPT	Tim to, tràn dịch màng phổi (phải > phải + trái > trái). Đường Kerley B kèm tái phân bố mạch máu tới thùy trên. Điển hình xảy ra cả hai bên thay vì một bên
Ung thư tế bào phế nang (Alveolar cell carcinoma)	Sốt, ↑ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm	± vùng gõ đục trên thùy phổi khi có tổn thương lớn ở thùy phía dưới	Tế bào học dương tính trên sinh thiết phổi/dịch rửa phế quản phế nang	Xâm nhiễm vùng ngoại vi hình tròn ranh giới rõ/không rõ ± phế quản khí. Có thể có nhiều ổ/nhiều thùy. Có hạch to vùng rốn phổi. Hướng về rốn phổi (dấu hiệu "đuôi màng phổi") ± tràn dịch màng phổi nếu xâm nhiễm thùy dưới phổi. Không có hình ảnh hang
U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓ bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp
Chảy máu phổi	Tiền sử chấn thương ngực kín hoặc rối loạn chảy máu	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↑ tần số mạch và tần số thở. Các dấu hiệu của chấn thương ngực kín	Thiếu máu cộng với các dấu hiệu thứ phát do rối loạn chảy máu nền.	Xâm nhiễm phế nang khu trú hoặc lan tỏa. Không tạo hang, đông đặc hoặc tràn dịch màng phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống	Mệt mỏi, đau ngực. Tiền sử bị lupus ban đỏ hệ thống.	Sốt/ đau cơ, rụng tóc, phát ban gò má, "thể cytoid" trong võng mạc, loét miệng không đau, viêm màng hoạt dịch, lách to, hạch to toàn thân, hiện tượng Raynaud	↑ ANA, ↑ ds-DNA, ↓ C_3, ↑ gamma globulin đa dòng trên điện di protein huyết thanh (SPEP), ↑ ferritin. Dịch màng phổi có ↑ ANA, ↓ C_3 bổ thể	Xâm nhiễm không theo phân thùy không có ranh giới rõ và có tính di chuyển ± tràn dịch màng phổi mức độ ít. Không có đông đặc hoặc tạo hang
Viêm phổi do hít vào phổi	Rối loạn nuốt thứ phát do bệnh lý TKTW/ đường tiêu hóa; suy giảm ý thức, gần đây hít phải phổi thứ phát do thủ thuật hô hấp, đường tiêu hóa trên, răng miệng	Không đáng kể	↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu	Xâm nhiễm thường ở tiểu thùy trên của thùy dưới (hoặc tiểu thùy sau của thùy trên nếu tình trạng hít vào phổi xảy ra khi bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa). Xâm nhiễm khư trú khởi đầu, kế tiếp từ ngày thứ 7 trở đi bằng tạo hang/áp xe phổi

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM MỘT BÊN RANH GIỚI KHÔNG RÕ KÈM TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Lao (nguyên phát)	Gần đây có tiếp xúc với trực khuẩn lao	Gõ đục thùy dưới một bên liên quan với kích thước tràn dịch màng phổi	Test tuberculin da âm tính/ mất đáp ứng miễn dịch (anergic). Tràn dịch màng phổi loại dịch tiết (dịch màng phổi có ↑ bạch cầu lympho, ↑ glucose, ± hồng cầu)	Xâm nhiễm thùy dưới phổi với tràn dịch màng phổi mức độ ít/vừa. Không tạo hang hoặc xâm nhiễm đỉnh phổi. Hạch rốn phổi nếu có thì không đối xứng

Nocardia	Sốt, ra mồ hôi đêm, mệt mỏi, ↓ tính miễn dịch trung gian qua tế bào (ví dụ: HIV, ghép tạng, bệnh tích tụ protein phế nang phổi (PAP), điều trị ức chế miễn dịch)	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường hoặc ↑, ↑ tốc độ lắng hồng cầu. Đờm dương tính với trực khuẩn kháng toan (AFB).	Xâm nhiễm rộng đậm đặc. Có thể thành hang và giống với lao, u lympho hoặc ung thư biểu mô tế bào vẩy. Không có vôi hóa ± tràn dịch màng phổi.
Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường gặp ở người già. Có thể bị ỉa chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/lách to loại trừ chẩn đoán. ↓ rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi.	↑ số lượng bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, ↓ PO_4^-, ↓ Na^+, ↑ CPK, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ CRP, ↑ nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên L. pneumophilia trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. ↑ hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục.	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Di căn hệ bạch huyết (Lymphangitic metastases)	Tiền sử carcinoma vú, tuyến giáp, tụy, cổ tử cung, tuyến tiền liệt hoặc phổi	Dấu hiệu liên quan với bệnh lý ung thư nền.	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu.	Xâm nhiễm phổi kẽ không chuyên biệt (có thể dạng lưới nốt) chủ yếu thùy dưới. Thường ở một bên song có thể cả hai bên. Không có đông đặc phổi hoặc tạo hang ± tràn dịch màng phổi.
Tắc mạch phổi/ nhồi máu phổi	Khó thở khởi phát cấp tính/ đau ngực kiểu màng phổi. Tiền sử chấn thương chi dưới, tình trạng ứ trệ tuần hoàn hoặc rối loạn tăng đông	↑ tần số mạch/ tần số thở	↑ sản phẩm thoái giáng fibrin và D-dimer ± ↑ bilirrubin toàn phần. Tràn máu màng phổi. Điện tâm đồ có tăng gánh thất phải/ sóng P-phế (nhồi máu phổi lớn). Chụp xạ hình phổi đánh giá thông khí-tưới máu (V/Q scan) và chụp cắt lớp vi tính mạch phổi cho kết quả dương tính.	Bình thường hoặc cho thấy có xâm nhiễm đáy-màng phổi không đặc hiệu, giống như xẹp phổi. Tăng sáng thùy/ tiểu thùy (dấu hiệu Westermark) gặp ở một số bệnh nhân. Dấu hiệu "Bướu Hampton" của vùng nhồi máu. Nhồi máu thoái triển kích thước ↓ đi song vẫn duy trì hình dạng/ mật độ ("khối đá đang tan").
U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh (SPEP).	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

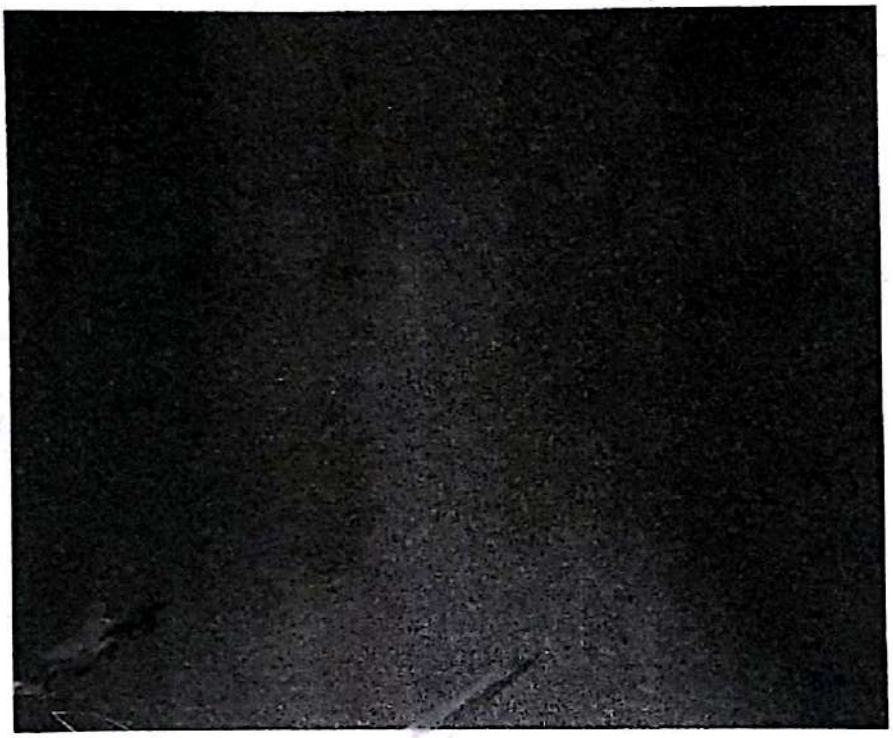
Ung thư biểu mô phế quản (Bronchogenic carcinoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với mất cân, ho ± ho ra máu. Ho khạc đờm dạng nhầy/ đờm trong dính trong ung thư biểu mô không biệt hóa tế bào lớn. Nguy cơ gia tăng ở người nghiện thuốc lá, thợ khai thác mỏ nhôm/ uranium, bệnh phổi tạo hang (ung thư biểu mô tuyến [adenocarcinoma]), trước đó được điều trị tia xạ do u lympho, ung thư vú.	Hội chứng cận ung thư nhất là với ung thư tế bào nhỏ (oat cell) /ung thư biểu mô tế bào vẩy ± bệnh xương-khớp phì đại (hypertrophic pulmonary osteo-arthropathy).	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, các dấu hiệu liên quan với bệnh lý ác tính nền, ± ngón tay khum.	Ung thư biểu mô tế bào nhỏ/tế bào vẩy được biểu hiện bằng các tổn thương trung tâm/ khối u vùng rốn phổi. Ung thư biểu mô tuyến/ ung thư biểu mô không biệt hóa tế bào lớn thường khởi đầu từ vùng ngoại vi. "Các tua của khối u" "Tumor tendrils" mở rộng tới mô phổi xung quanh là điểm đặc trưng. Không có vôi hóa (có thể biểu hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực). Tạo hang với ung thư biểu mô tế bào vẩy ± tràn dịch màng phổi.
Ung thư tế bào phế nang (Alveolar cell carcinoma)	Sốt, ↑ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm	± gõ đục trung thùy phổi khi có tổn thương thùy lớn phía dưới	Tế bào học dương tính trên sinh thiết phổi/ dịch rửa phế quản phế nang	Xâm nhiễm vùng ngoại vi hình tròn ranh giới rõ/không rõ ± phế quản khí. Có thể có nhiều ổ/ nhiều thùy. Có hạch to vùng rốn phổi. Hướng về rốn phổi (dấu hiệu "đuôi màng phổi") ± tràn dịch màng phổi nếu xâm nhiễm thùy dưới phổi. Không có hình ảnh hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Ung thư biểu mô di căn (Metastatic carcinoma).	Tiền sử ung thư vú, tuyến giáp, tế bào thận, đại tràng, tụy hoặc sarcoma nguồn gốc xương (osteogenic sarcoma).	Các dấu hiệu liên quan với bệnh lý ác tính nền và khi có biểu hiện di căn trên xương, gan và TKTW.	Thứ phát do các tác động của u tân sinh tiên phát, di căn, hội chứng cận ung thư.	Tổn thương dạng khối nhỏ có kích thước thay đổi. Các tổn thương di căn thường có hình tròn ranh giới rõ chủ yếu ở thùy dưới. Thường không có tắc nghẽn phế quản (tình trạng tắc nghẽn phế quản gợi ý di căn từ đại tràng, thận hoặc u tế bào sắc tố). Thường không tạo hang (trừ di căn ung thư tế bào vẩy). Vôi hóa thường gợi ý sarcoma xương (hiếm gặp với ung thư biểu mô). Tràn dịch màng phổi hiếm gặp (ngoại trừ ung thư vú).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM HAI BÊN KHÔNG KÈM TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Cúm (người, gia cầm, lợn)	Khởi phát cấp với sốt, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi, ho khan, ± đau ngực kiểu màng phổi.	↑ tần số thở, tím tái trong các trường hợp nặng	↓ bạch cầu, ↓ tiểu cầu, có một vài/ không có bạch cầu lympho không điển hình, ↑ gradient nồng độ oxy động mạch-phế nang. Phát hiện được virus cúm trong chất tiết đường hô hấp bằng phương pháp nuôi cấy/ sử dụng PhimArray panel để phát hiện virus (viral FA panel).	Hình ảnh Xquang phổi bình thường/ gần bình thường ở giai đoạn sớm (< 48 giờ). Muộn hơn (> 48 giờ) xâm nhiễm mô kẽ lốm đốm lan tỏa. Không có xâm nhiễm thùy/tiểu thùy phổi trừ khi có viêm phổi thứ phát do vi khuẩn ± tràn dịch màng phổi mức độ ít.

Bệnh SARS	Khởi phát cấp tính với sốt, đau cơ, ho khan ± ỉa chảy	↑ tần số hô hấp, tím trong các trường hợp nặng.	Bạch cầu bình thường/↓ bạch cầu, tiểu cầu bình thường/↓ tiểu cầu, ↓ pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang .	Nuôi cấy mọc virus gây bệnh SARS-(Corona virus) từ chất tiết hô hấp.
Herpes- simplex virus typ 1 (HSV-1)	Sốt, thường biểu hiện ở đối tượng người bình thường khi cai máy thở bị thất bại.	Không có gì nổi bật	↑ số lượng bạch cầu, ↓ pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang. Tìm thấy HSV-1 trong chất tiết đường hô hấp bằng nuôi cấy/sử dụng PhimArray panel để phát hiện virus (viral FA panel). Tế bào học dương tính với tác động gây nhược tế bào vật chủ (cytopathic effects) của HSV.	Xâm nhiễm lan tỏa hai bên mức độ nhẹ không tạo hang hoặc gây tràn dịch màng phổi.
Virus cự bào hô hấp (Respiratory syncytial virus [RSV])	Tiếp xúc gần đây với người có viêm đường hô hấp trên, ho khan, thở rít.	Tình trạng nhiễm khuẩn nhẹ đường hô hấp dưới ở người bình thường. Viêm phổi vừa/nặng ở bệnh nhân ghép tạng.	Số lượng bạch cầu bình thường, ↓ pO_2/ ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang đối với các trường hợp nhiễm trùng nặng do RSV. Tìm thấy RSV trong chất tiết hô hấp bằng nuôi cấy/ sử dụng PhimArray panel để phát hiện virus (viral FA panel).	Phim Xquang phổi gần như bình thường hoặc xâm nhiễm lốm đốm đối xứng hai bên. Đông đặc phổi không thường gặp. Không tạo hang hoặc tràn dịch màng phổi.
Virus thủy đậu (VZV)	Viêm phổi do virus thủy đậu xảy ra 2-3 ngày sau phát ban. ↑ nguy cơ ở phụ nữ có thai, người hút thuốc.	Phỏng nước đang lành, ho khan. Viêm phổi nhẹ ở đối tượng có chức năng miễn dịchbình thường. Viêm phổi vừa/ nặng ở người sau ghép tạng.	↑ số lượng bạch cầu, ↑ tiểu cầu, ↑ bạch cầu ái kiềm; ↓ pO_2/↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang trong viêm phổi nặng do thủy đậu. ↑ hiệu giá với VZV.	Xâm nhiễm mô kẽ lan tỏa dạng bụi bông kín đáo. Vôi hóa nhỏ lan tỏa có thể xuất hiện vào các năm sau này. Không có vôi hóa hạch rốn phổi (trái ngược với lao/ nhiễm histoplasma).

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Cytomegalovirus (CMV)	↓ tính miễn dịch qua trung gian tế bào (nhiễm HIV, người ghép tạng, điều trị ức chế miễn dịch). Tình trạng khó thở tăng lên trong vòng 1 tuần.	Sốt ≤ 39°C	↓ pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang, ↑ LDH (viêm phổi do PCP). Kén *P. (carinii) jiroveci* hoặc thể vùi CMV "thể vùi hình mắt cú" ("Cowdry Owl eye") trong chất tiết hô hấp hoặc bệnh phẩm sinh thiết phổi mở/ xuyên phế quản.	Hầu hết bệnh nhân nhiễm HIV bị viêm phổi do *P. (carinii) jiroveci* cũng bị nhiễm CMV nền. Người ghép tạng nhiễm CMV thường không có *P. (carinii) jiroveci* (PCP) nền.
P. (carinii) jiroveci (PCP)	↓ tính miễn dịch qua trung gian tế bào (nhiễm HIV, điều trị ức chế miễn dịch). Tình trạng khó thở tăng lên trong vòng 1 tuần. Đau ngực với thở đoản hơi gợi ý tràn khí màng phổi.	↓ rì rào phế nang cả hai bên. Các dấu hiệu khác phụ thuộc vào mức độ/khu trú của tràn dịch màng phổi (nếu có tình trạng này).	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↑ bạch cầu lympho, ↑ LDH, ↓ pO_2, ↓ DL_{CO}, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang. Kén *P. (carinii) jiroveci* (PCP) trong đờm/chất tiết hô hấp.	Xâm nhiễm mờ đối xứng hai bên rốn phổi ± tràn khí màng phổi. Không có vôi hóa, tạo hang, hoặc tràn dịch màng phổi.
Lao (tái hoạt động)	Sốt, ra mồ hôi đêm, tình trạng ngon miệng bình thường song vẫn sút cân, ho ± ho ra máu.	± Gõ đục hai bên	Bạch cầu bình thường, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu (≤ 70 mm/giờ). Test da với tuberculin (phản ứng Mantoux) dương tính. Tìm thấy trực khuẩn kháng toan (AFB) trong bệnh phẩm đờm / nuôi cấy.	Xâm nhiễm cả hai bên phổi tiến triển chậm. Không có tràn dịch màng phổi. Thường tác động tới tiểu thùy đỉnh của các thùy dưới hoặc tiểu thùy đỉnh/tiểu thùy sau của các thùy trên. Vôi hóa thường gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường ở người già. Có thể bị la chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức.	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/ lách to loại trừ chẩn đoán. ↓ rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi.	↑ số lượng bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, ↓ PO_4^-, ↓ Na^+, ↑ CPK, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ CRP, ↑ nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên L. pneumophilia trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. ↑ hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang.
Sốt vẹt (psittacosis)	Tiếp xúc với vẹt gần đây. Đau đầu nặng.	Sốt/ ớn lạnh, ± nhịp chậm tương đối, đốm Horder trên mặt, chảy máu cam, ± lách to. Dấu hiệu đông đặc phổi thường gặp.	↑ bạch cầu/bạch cầu bình thường, ↑ các xét nghiệm chức năng gan. Đờm có một vài bạch cầu đa nhân trung tính. ↑ hiệu giá với *C. psittaci.*	Xâm nhiễm đậm đặc. Đông đặc phổi thường gặp. Tràn dịch màng phổi/tạo hang hiếm gặp.
Sốt Q	Gần đây có tiếp xúc với cừu hoặc mèo đẻ	Sốt/ ớn lạnh, ± nhịp chậm tương đối, lách to ± gan to.	↑ bạch cầu/ bạch cầu bình thường, ↑ các xét nghiệm chức năng gan. Đờm không có vi khuẩn/có một vài bạch cầu đa nhân trung tính (thận trọng- nguy cơ phơi nhiễm sinh học). Sốt Q cấp với ↑ kháng nguyên ELISA pha II.	Đông đặc. Hình hang/tràn dịch màng phổi hiếm gặp.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Viêm phổi bệnh viện (nhiễm theo đường máu)	Sốt/ các triệu chứng phổi ≥ 7 ngày trong khi nằm bệnh viện. Nguy cơ gia tăng ở bệnh nhân bị suy tim trong vòng 1-2 tuần trước đó.	Rales phổi hai bên ± chất tiết hô hấp dạng mủ (viêm khí-phế quản).	↑ số lượng bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái). Cấy máu dương tính đối với vi khuẩn gây bệnh ở phổi. Chất tiết hô hấp có bạch cầu ± nuôi cấy dương tính với *P.aeruginosa*, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella hoặc Serratia (thể hiện các vi khuẩn cư trú, không phải vi sinh vật gây bệnh của phổi/ đường hô hấp dưới). Chẩn đoán khẳng định bằng sinh thiết phổi hoặc nuôi cấy.	Xâm nhiễm lan tỏa đối xứng hai bên. Có thể thành ổ/tiểu thùy trong viêm phổi bệnh viện do hít vào phổi. ↑ thể tích phổi (trái ngược so với ARDS). Tạo hang do Klebsiella trong vòng 3-5 ngày; tạo hang do *P.aeruginosa* trong vòng 72 giờ. Không có tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân không do nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS)	Đặt ống nội khí quản và thở máy, suy đa tạng	± rales ở phổi	↑ số lượng bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), tốc độ lắng hồng cầu bình thường, ↓ pO_2, ↓ D_LCO, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang (A-a gradient).	Xâm nhiễm mờ hai bên xuất hiện ≥ 12 giờ sau tình trạng giảm oxy máu nặng. Không có tim to hoặc tràn dịch màng phổi. Giảm các thể tích phổi (khác với viêm phổi mắc phải trong bệnh viện hoặc suy tim ứ huyết). Đông đặc hai bên phổi ≥ 48 giờ sau xuất hiện các xâm nhiễm phổi.

Hội chứng Goodpasture	Thường có tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp trên đi trước. Rất thường gặp ở người lớn 20-30 tuổi. Sốt, sút cân, mệt mỏi, ho, ho ra máu, đái máu.	Các dấu hiệu thứ phát do thiếu máu do thiếu sắt.	↑ bạch cầu, thiếu máu, ↑ creatinin máu, nước tiểu có hồng cầu/trụ hồng cầu. Test pANCA dương tính. Lắng đọng IgG dạng hình vạch thẳng ở màng đáy cầu thận/phế nang.	Xâm nhiễm lưới nốt mịn hai bên ưu thế ở các thùy dưới phổi. Không tạo hang.
U hạt Wegener (Wegener's granulomatosis)	Rất thường gặp ở người lớn tuổi trung niên. Ho, sốt, mệt mỏi	Dấu hiệu viêm xoang mãn, xuất tiết mũi có máu.	↑ bạch cầu, thiếu máu, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ yếu tố dạng thấp, ANA âm tính, protein niệu. Test tìm cANCA dương tính.	Xâm nhiễm dạng nốt không đối xứng với kích thước khác nhau và bờ không đều. Hình hang thường gặp. Bờ trong của các hang không đều. ± tràn dịch màng phổi. Không có tình trạng vôi hóa.
Chảy máu phổi	Tiền sử chấn thương ngực kín hoặc rối loạn chảy máu.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↑ tần số mạch và tần số thở. Các dấu hiệu của chấn thương ngực kín.	Thiếu máu cộng với các dấu hiệu thứ phát do rối loạn chảy máu nền.	Xâm nhiễm phế nang khu trú hoặc lan tỏa. Không tạo hang, đông đặc hoặc tràn dịch màng phổi.
Suy thận mạn	Suy thận mạn và đang được lọc máu chu kỳ.	Các dấu hiệu có liên quan với hội chứng urê máu cao.	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái) cộng với các dấu hiệu liên quan với suy thận.	Xâm nhiễm quanh rốn phổi đối xứng (dạng cánh bướm) ± tràn dịch màng phổi. Không có tim to (khác với suy tim ứ huyết) song tràn dịch màng ngoài tim nhiều có thể tạo ra hình ảnh giống như hình ảnh tim to.
Đụng giập phổi	Chấn thương ngực kín gần đây, đau ngực	Tổn thương đụng giập thành ngực trên vùng xâm nhiễm.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái).	Xâm nhiễm không rõ ranh giới ± gãy xương sườn/ tràn khí màng phổi ở vùng xâm nhiễm. Xâm nhiễm hết sau 1 tuần

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Tắc mạc do mỡ (Fat emboli)	1-2 ngày sau khi bị gẫy xương dài / chấn thương.	↑ tần số thở	Phân tích nước tiểu có dấu hiệu hình chữ thập ("Maltese crosses").	Xâm nhiễm cả hai bên ưu thế ở vùng ngoại biên thùy dưới phổi. Thường sạch trong vòng 1 tuần.
Hội chứng Loefler	Do thuốc hoặc phơi nhiễm với ký sinh trùng.	Không có gì nổi bật.	Bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái toan, ↑ tốc độ lắng hồng cầu	Kiểu "cánh dơi đảo ngược" điển hình (tức là xâm nhiễm ngoại biên). Ưu thế ở thùy trên của phổi
Bệnh sarcoidose (giai đoạn III)	Khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi.	Ban sần như sáp/mầu hơi vàng trên mặt/ phần trên của thân mình. Soi đáy mắt có hình ảnh "giọt sáp nến" ["candle wax drippings"].	↑ tốc độ lắng hồng cầu, test chức năng gan bình thường, ↑ creatinin máu (nếu thận bị tác động), ↑ nồng độ ACE, ↑ nồng độ canxi niệu, ↑ nồng độ canxi máu, bệnh tăng gamma đa dòng trên điện di protein huyết thanh. Suy nhược.	Xâm nhiễm dạng nốt nhỏ hai bên với kích thước thay đổi song không có bệnh lý hạch rốn phổi. Tạo hang/tràn dịch màng phổi hiếm gặp.
Ung thư tế bào phế nang (Alveolar cell carcinoma)	Sốt, ↑ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm.	± gõ đục trung thùy phổi khi có tổn thương thùy lớn phía dưới.	Tế bào học dương tính trên sinh thiết phổi/dịch rửa phế quản phế nang.	Xâm nhiễm vùng ngoại vi hình tròn ranh giới rõ/không rõ ± phế quản khí. Có thể có nhiều ổ/nhiều thùy. Có hạch to vùng rốn phổi. Hướng về rốn phổi (dấu hiệu "đuôi màng phổi") ± tràn dịch màng phổi nếu xâm nhiễm thùy dưới phổi. Không có hình ảnh hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

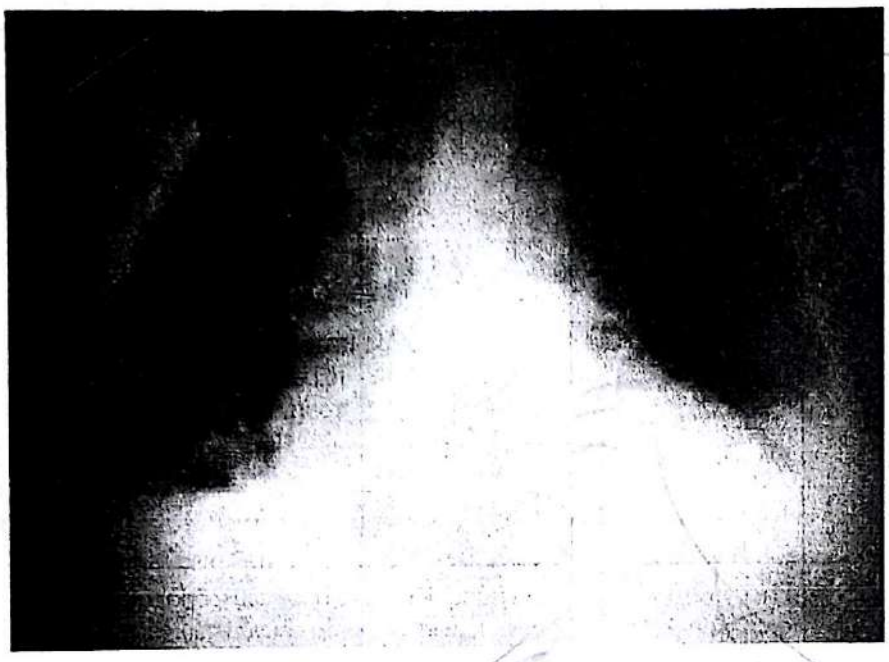
Ung thư biểu mô di căn (Metastatic carcinoma)	Tiền sử ung thư vú, tuyến giáp, tế bào thận, đại tràng, tụy hoặc u xương (osteogenic sarcoma).	Các dấu hiệu liên quan với bệnh lý ác tính nền và khi có biểu hiện di căn trên xương, gan và thần kinh trung ương.	Thứ phát do các tác động của u tân sinh tiên phát, di căn, hội chứng cận ung thư.	Tổn thương dạng khối nhỏ có kích thước thay đổi. Các tổn thương di căn thường có hình tròn ranh giới rõ chủ yếu ở thùy dưới. Thường không có tắc nghẽn phế quản (tình trạng tắc nghẽn phế quản gợi ý di căn từ đại tràng, thận hoặc u tế bào sắc tố). Thường không tạo hang (trừ di căn ung thư tế bào vẩy). Vôi hóa thường gợi ý sarcoma xương (hiếm gặp với ung thư biểu mô). Tràn dịch màng phổi hiếm gặp (ngoại trừ ung thư vú).
U lympho (lymphoma)	Sốt, ↓ ngon miệng với sút cân, ra mồ hôi đêm, mệt.	Hạch to ± lách to	Số lượng bạch cầu bình thường, ↑ bạch cầu ái kiềm, ↑ bạch cầu ái toan, ↓ bạch cầu lympho, ↑ tiểu cầu, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ phosphatase kiềm, ↑ $\mu_{1,2}$ globulin trên điện di protein huyết thanh (SPEP).	Bệnh hạch rốn phổi một bên hoặc hai bên không đối xứng. Xâm nhiễm phổi có thể xuất hiện kế tiếp với hạch rốn phổi. Không có kênh nối rõ ràng giữa trung thất và hạch rốn phổi. Tràn dịch màng phổi nhỏ hiếm gặp.
Tắc mạch do tăng số lượng bạch cầu quá mức trong bệnh loxêmi cấp dòng tủy (Leukostasis)	Bệnh loxêmi cấp dòng tủy (AML) không được điều trị.	Sốt, tức sau xương ức, chấm xuất huyết, mảng xuất huyết	↑ bạch cầu (≥ 100 K/mm³) với các nguyên bào trên tiêu bản phiến đồ máu ngoại vi/tủy xương, ↓ tiểu cầu.	Xâm nhiễm mờ đối xứng lan tỏa không kèm theo tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Do thuốc gây ra	Tiếp xúc với các thuốc hóa trị (Vd: BCNU, busulfan, methotrexat, cyclophosphamid bleomycin) hoặc các thuốc khác (Vd: nitrofurantoin, sulfasalazin, amiodaron, dẫn xuất nhóm opi, cocain)	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường ± ↑ bạch cầu ái toan, tốc độ lắng hồng cầu/ test chức năng gan bình thường/↑ bạch cầu ái toan trong dịch tràn màng phổi.	Xâm nhiễm/xơ hóa từng đám đối xứng hai bên ± tràn dịch màng phổi. Hạch rốn phổi chỉ thấy trong giả u lympho do thuốc (thứ phát do dilantin). Không tạo hang.
Nhiễm hemosiderin phổi vô căn (Idiopathic pulmonary hemosiderosis)	Ho ra máu ± ho	Các dấu hiệu của thiếu máu do thiếu sắt.	Thiếu máu do thiếu sắt. Hemosiderin lắng đọng trong các đại thực bào phế nang và nước tiểu.	Đám mờ ranh giới không rõ lan tỏa hai bên hoặc nhiều vùng xâm nhiễm có hình "sao" biến mất giữa các đợt cấp. Hình ảnh xuất huyết gần đây có thể chồng lên trên kiểu tổn thương dạng lưới mịn xảy ra sau khi chảy máu nhiều lần tái phát.
Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn với viêm phổi tỳ hóa (Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia [BOOP])	Sốt, khó thở, ho	Không có gì nổi bật	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↑ LDH, ↓ pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang (A-a gradient).	Xâm nhiễm ngoại vi từng đám hai bên kinh điển. Thường ưu thế ở thùy dưới của phổi. Không tạo hang hoặc tràn dịch màng phổi.
Bệnh tích tụ protein phế nang phổi (Pulmonary alveolar proteinosis [PAP])	Không có triệu chứng nếu không bị nhiễm khuẩn Nocardia.	Không đáng kể	Bạch cầu bình thường/↑ bạch cầu, ↑ LDH.	Xâm nhiễm ngoại biên hoặc nang dưới dạng cánh bướm. Không có hạch rốn phổi to, bóng tim to, hoặc tràn dịch màng phổi.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

XÂM NHIỄM HAI BÊN KÈM TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI



Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Nguyên nhân nhiễm khuẩn

Nguyên nhân	Đặc điểm (có thể có một số, không có hoặc có tất cả các đặc điểm này)			
	Bệnh sử	Khám thực thể	Xét nghiệm	Hình ảnh Xquang ngực
Legionella	Gần đây có tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm Legionella. Thường gặp ở người già. Có thể bị la chảy tóe nước, đau bụng, rối loạn ý thức.	Sốt/ớn lạnh, nhịp tim chậm tương đối. Gan/lách to loại trừ chẩn đoán. ↓ rì rào phế nang nếu xảy ra kết đặc phổi hoặc tràn dịch màng phổi.	↑ số lượng bạch cầu, ↑ SGOT/SGPT, ↓ PO_4^-, ↓ Na^+, ↑ CPK, ↑ tốc độ lắng hồng cầu, ↑ CRP, ↑ nồng độ ferritin, đái máu vi thể, tìm thấy kháng nguyên *L. pneumophilia* trong nước tiểu (chỉ với typ huyết thanh 01-06) có thể không dương tính ở giai đoạn sớm. Đờm nhầy/đờm mủ với một vài bạch cầu đa nhân trung tính. Cấy đờm tìm legionella hoặc làm test kháng thể huỳnh quang trực tiếp (DFA) đờm (trước khi điều trị) có giá trị chẩn đoán. ↑ hiệu giá kháng thể kháng Legionella ≥ 1:256 hoặc ≥ 4 lần giữa hiệu giá đợt cấp và giai đoạn bình phục.	Các xâm nhiễm phổi không đối xứng tiến triển nhanh là các bằng chứng gợi ý nhiễm khuẩn do Legionella. Đông đặc và tràn dịch màng phổi không phải hiếm gặp. Hiếm khi tạo hang.

Hantavirus (HPS)	Khởi phát bán cấp, thở đoản hơi, khó chịu sau xương ức. Cải thiện đôi chút sau đó tối đi rất nhanh.	↑ tần số thở, tím ở các trường hợp nặng.	↓ bạch cầu, ↓ tiểu cầu, ↓ pO_2, ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang (A-a gradient). ↑ hiệu giá với hantavirus .	Tràn dịch màng phổi nhiều
Sởi	Gần đây tiếp xúc với nguồn nhiễm bệnh.	Ban dạng sởi, chấm Koplik (Koplik's spots).	Bạch cầu bình thường/↑ (công thức bạch cầu chuyển trái), tiểu cầu bình thường/↓ tiểu cầu, ↑ test chức năng gan, ↑ CPK, pO_2 bình thường hoặc ↓. Nếu ↓ pO_2, khi đó ↑ gradient nồng độ oxy máu động mạch-phế nang (A-a gradient). ↑ hiệu giá kháng sởi loại IgM. Tế bào Warthin-Finkeldey trong chất tiết hô hấp.	Xâm nhiễm lưới – nốt lan tỏa hai bên ± hạch rốn phổi. Ưu thế ở thùy dưới của phổi. Đông đặc/ tràn dịch phổi không thường gặp. Không tạo hang. Thâm nhiễm khu trú chỉ dẫn viêm phổi do vi khuẩn chồng thêm vào.
Bệnh nhiễm giun lươn (Strongyloides)	Phơi nhiễm với giun lươn. 1/3 trường hợp không có triệu chứng; 2/3 có biểu hiện sốt, khó thở, ho. Hội chứng siêu nhiễm khuẩn (hyperinfection syndrome) với đau bụng, ỉa chảy ± chảy máu tiêu hóa.	Hội chứng siêu nhiễm khuẩn (hyperinfection syndrome), sốt, tụt huyết áp, đau bụng ± phản ứng thành bụng, ± viêm màng não.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), ↑ bạch cầu ái toan, ± thiếu máu. Nuôi cấy máu/ dịch não tủy dương tính với trực khuẩn Gram âm đường ruột. Tìm thấy các ấu trùng giai đoạn 1 (Rhabditiform larvae) trong đờm/ phân.	Xâm nhiễm từng đám nốt phổi lan tỏa không có đông đặc hoặc tạo hang. Tràn dịch màng phổi. ↑ tăng bạch cầu ái toan thường gặp.
Suy tim ứ huyết	Bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim.	Không sốt/sốt nhẹ, ↑ mạch và tần số thở, tĩnh mạch cổ nổi và phản hồi gan tĩnh mạch cảnh dương tính, tim to, S3, cổ trướng, gan to, phù mu chân.	↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái), tiểu cầu bình thường, ↑ nhẹ SGOT/ SGPT.	Tim to, tràn dịch màng phổi (phải > phải + trái > trái). Đường Kerley B kèm tái phân bố mạch máu lên thùy trên. Điển hình xảy ra cả hai bên thay vì một bên.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075

Suy thận mạn	Suy thận mạn và đang được lọc máu chu kỳ.	Các dấu hiệu có liên quan với hội chứng urê máu cao.	Bạch cầu bình thường/ ↑ bạch cầu (công thức bạch cầu chuyển trái) cộng với các dấu hiệu liên quan với suy thận.	Xâm nhiễm cạnh rốn phổi đối xứng hai bên (dạng cánh bướm) ± tràn dịch màng phổi. Không có tim to (khác với suy tim ứ huyết) song tràn dịch màng ngoài tim nhiều có thể giống như hình ảnh tim to.
Bệnh lupus ban đỏ hệ thống	Mệt mỏi, đau ngực. Tiền sử bị lupus ban đỏ hệ thống.	Sốt/ đau cơ, rụng tóc, phát ban gò má, "thể cytoid" trong võng mạc, loét miệng không đau, viêm màng hoạt dịch, lách to, hạch to toàn thân, hiện tượng Raynaud.	↑ ANA, ↑ ds-DNA, ↓ C_3, ↑ gamma globulin đa dòng trên điện di protein huyết thanh (SPEP), ↑ ferritin. Dịch màng phổi có ↑ ANA, ↓ C_3 bổ thể.	Xâm nhiễm không theo phân thùy không có ranh giới rõ và có tính di chuyển ± tràn dịch màng phổi mức độ ít. Không có đông đặc hoặc tạo hang.
Hội chứng Goodpasture	Thường khởi phát bởi nhiễm khuẩn hô hấp trên. Rất thường gặp ở người lớn 20-30 tuổi. Sốt, sút cân, mệt mỏi, ho, ho ra máu, đái máu (hematuria).	Các dấu hiệu thứ phát do thiếu máu do thiếu sắt.	↑ bạch cầu, thiếu máu, ↑ creatinin máu, nước tiểu có hồng cầu/trụ hồng cầu. Test pANCA dương tính. Lắng đọng IgG dạng vạch thẳng ở màng đáy cầu thận/phế nang.	Xâm nhiễm lưới nốt mịn hai bên ưu thế ở các thùy dưới phổi. Không tạo hang.

Dr Huy Dũng
GROUP DỮ LIỆU Y HỌC
0978.336.075